حُزمة تدريبية إقليمية حول

الرعاية المتكاملة لصحة ونماء المواليد والأطفال دون سنّ الخامسة في المنزل



دليل المُيسّر

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

حُزمة تدريبية إقليمية حول

الرعاية المتكاملة لصحة ونَماء المواليد والأطفال دون سنّ الخامسة في المنزل

دليل المُيسِّر

ملاحظة: هذا المنشور هو نسخة مأخوذة بتصرُّف من المنشورات الأصلية الصادرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان:

Regional training package on integrated care for health and development of newborns and children under five at home: facilitator guide

منظمة الصحة العالمية

إقليم شرق المتوسط

حُزمة تدريبية إقليمية حول الرعاية المتكاملة لصحة ونَماء المواليد والأطفال دون سنِّ الخامسة في المنزل: دليل المُيسِّر

Regional training package on integrated care for health and development of newborns and children under five at home: Facilitator guide

ISBN 978-92-9274-807-4 (النسخة الإلكترونية)

ISBN 978-92-9274-806-7 (النسخة المطبوعة)

صدر هذا المنشور في الأصل بالرقم الدولي المعياري (ISBN) الآتي: 978-92-9021-004-7، 978-92-9021-003-0

© منظمة الصحة العالمية 2025

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 3.0 IGO؛ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز أن تنسخوا المصنف وتعيدوا توزيعه وتحوروه للأغراض غير التجارية، وذلك شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتعديل المصنف فيجب عندئذٍ أن تحصلوا على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي Creative Commons licence أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة (WHO) غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار الأصل الإنكليزي هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الاقتباس المقترح. حُزمة تدريبية إقليمية حول الرعاية المتكاملة لصحة ونَماء المواليد والأطفال دون سنِّ الخامسة في المنزل. دليل المُيسِّر. القاهرة: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ 2025 . الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط http://apps.who.int/iris.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات الخاصة بالحقوق والترخيص انظر الرابط http://www.who.int/about/licensing.

مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام هذه أم لا، وعن الحصول على الإذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده أية مخاطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنصر يملكه طرف ثالث في المصنف.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. التسميات المستعملة في هذا المطبوع، وطريقة عرض المواد الواردة فيه، لا تعبر ضمناً عن أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك فإن المواد المنشورة تُوزع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد. والمنظمة (WHO) ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

تمهيد ه
شكر وتقدير و
مقدمة عامة ز
حُزمة تدريبية إقليمية حول الرعاية المتكاملة لصحة ونَماء المواليد والأطفال دون سن الخامسة ز
الدورة التدريبية ي
الوحدة الأولى. مقدمة عن الدورة التدريبية 1
الجلسة 1: مقدمة عن الدورة التدريبية 1
الوحدة الثانية. مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟ 5
الجلسة 2: مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟ 5
الوحدة الثالثة. مهارات التواصُل 8
الجلسة 3: مهارات التواصُل الجيد 8
الوحدة الرابعة. العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل 20
الجلسة 4: مقدمة 21
الجلسة 5: تقديم المشورة حول الحفاظ على دفء المواليد 25
الجلسة 6: تقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة 34
الجلسة 7: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين 42
الجلسة 8: تقديم المشورة حول العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري 67
الجلسة 9: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية 71
الجلسة 10: تقديم المشورة حول التغذية (الرضاعة) 78
الجلسة 11: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية 84
الجلسة 12: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع المواليد وصغار الرضع) 92
الجلسة 13: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات 96
الجلسة 14: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف 99
الزيارات المنزلية للمواليد وصغار الرضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين 103
الوحدة الخامسة. العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر 104
الجلسة 15: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرُّضَّع في عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر 105
الجلسة 16: تقديم المشورة حول التغذية 116
الجلسة 17: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية 123
الجلسة 18: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية 129
الجلسة 19: تقديم المشورة حول العناية من أجل النَّماء (اللعب والتواصل مع الرضّع) 134
الجلسة 20: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات 136
الجلسة 21: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف 138
الزيارات المنزلية للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر 141

الوحدة السادسة. العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد في المنزل **142**
الجلسة 22: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد 143
الجلسة 23: تقديم المشورة حول التغذية 151
الجلسة 24: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية 162
الجلسة 25: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية 165
الجلسة 26: تقديم المشورة حول العناية من أجل النَّماء (اللعب والتواصل مع الرضّع) 170
الجلسة 27: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات 174
الجلسة 28: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف 177
الزيارات المنزلية للرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد 179
الوحدة السابعة. العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين في المنزل **180**
الجلسة 29: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال في عمر عام واحد حتى أقل من عامين 181
الجلسة 30: تقديم المشورة حول التغذية 185
الجلسة 31: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية 190
الجلسة 32: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية 193
الجلسة 33: تقديم المشورة حول العناية من أجل النَّماء (اللعب والتواصل مع الطفل) 197
الجلسة 34: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات 200
الجلسة 35: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف 203
الزيارات المنزلية للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين 205
الوحدة الثامنة. العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام في المنزل **206**
الجلسة 36: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام 207
الجلسة 37: تقديم المشورة حول التغذية 211
الجلسة 38: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية 217
الجلسة 39: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية 222
الجلسة 40: تقديم المشورة حول العناية من أجل النَّماء (اللعب والتواصل مع الطفل) 224
الجلسة 41: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات 226
الجلسة 42: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف 229
الزيارات المنزلية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام 231
الوحدة الحادية عشرة. العناية بصحة الأمهات في المنزل **232**
الجلسة 43: تقديم المشورة حول العناية بالنساء الحوامل 233
الجلسة 44: تقديم المشورة حول العناية بالأمهات بعد الوَضع 241
الزيارات المنزلية وسير الجلسات 252
المرفق 1: دليل الجلسات السريرية **253**
المرفق 2: دليل الزيارات المنزلية **260**



تمهيد

تضطلع الأسر بدور حيوي لما تقدمه من رعاية أساسية للمواليد وصغار الأطفال، ولا سيما في البيئات الصعبة التي يتعذَّر فيها الحصول على الخِدْمات الصحية. ولكي تؤدي الأُسر هذا الدور بفعالية وعلى نحوٍ يضمن عافية أطفالها، فإنها تحتاج إلى التوجيه، والإمداد بالمهارات العملية، والشعور بالثقة، والحصول على الموارد الأساسية. ومن الضروري بمكان تعزيز الرعاية المنزلية والتدخلات المجتمعية لسد الثغرات في النظام الصحي، والوصول إلى الأطفال الذين قد لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الوقائية والعلاجية في الوقت المناسب.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، أعد فريق منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط هذه الحزمة التدريبية الإقليمية بشأن الرعاية المتكاملة لصحة ونماء المواليد والأطفال دون سن الخامسة في المنزل، بهدف تزويد العاملين أو المرشدين في مجال صحة المجتمع بالمهارات والمعارف اللازمة لدعم الأسر في تقديم الرعاية الأساسية في المنزل. وتؤكد البيِّنات العلمية أن مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة حاسمة يمكن أن يكون فيها للتدخلات آثار دائمة، تشكل ملامح صحة الفرد وعافيته وإمكاناته المعرفية طوال حياته.

وتهدف هذه الحزمة التدريبية إلى تعزيز دور العاملين في مجال صحة المجتمع بوصفهم مُرشدين صحيين ومستشارين ومناصرين للصحة والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وهي تتضمن إرشادات عملية وحديثة يمكن تطويعها لتعزيز الممارسات الأسرية المثلى، والوقاية من اعتلالات الأطفال وإصاباتهم، وضمان أساس قوي لعافيتهم مدى الحياة. وتتسق هذه الحزمة مع الأولويات الاستراتيجية العالمية والإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، على النحو المنصوص عليه في خطتنا التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط، 2025-2028. وهي جزء أصيل من مبادرتنا الرئيسية لبناء قوى عاملة صحية أكثر قدرة على الصمود في جميع أنحاء الإقليم، وتستكمل أيضًا دليل التنفيذ الإقليمي لصحة المواليد والأطفال والمراهقين ونمائهم.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم البلدان في توسيع نطاق تطبيق النُّهُج المجتمعية المتكاملة لصحة الطفل. وأشجِّع جميع الأطراف المعنية -وعلى رأسها وزارات الصحة وراسمو السياسات والمُدرِّبون ومقدمو الرعاية- على الاستفادة من هذه الحزمة باعتبارها أداة لبناء القدرات الوطنية، وتعزيز نُظُم الرعاية الصحية، والنهوض بصحة الطفل ونمائه في الإقليم. وبالعمل معًا، يمكننا أن نضمن أن تتاح لكل طفل فرصة النجاة، والازدهار، واستغلال كامل إمكاناته.

الدكتورة حنان حسن بلخي
مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط



شكر وتقدير

أعد الفريق المعني بصحة الأطفال والمراهقين بمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط هذا المنشور بتوجيه عام من الدكتورة جميلة الراعبي والدكتور خالد صديق. ونتوجه بشكر خاص للدكتورة سوزان فرهود، الخبيرة المعنية بصحة المواليد والأطفال والمراهقين، على إسهامها الكبير في الحزمة التدريبية. وكان من بين المستشارين والمراجعين الدكتور زين العابدين عبد الرحيم كرار، والدكتورة شذى سيد أحمد محمد (السودان)، والدكتورة عزيزة لغفوري (المغرب)، والدكتور ناند لال موربياني (باكستان)، والدكتورة منى رخا والدكتور محمد عبد المنعم (مصر)، والدكتورة أروى بيدر (اليونيسف). وتعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها لجميع المشاركين في الاختبار الميداني لهذه الحزمة في المغرب، وكذلك للمشاركين في التدريب الذين ساعدوا بوقتهم وتعليقاتهم المهمة في صقل محتواها.



مقدمة عامة

يُعتبر الحصول على الرعاية الصحية للأطفال إحدى المشاكل الصحية الرئيسية في العديد من البلدان. وحتى عندما تكون الرعاية الصحية للأطفال متاحة، يَنصب التركيز أساسًا على التدبير العلاجي للأطفال المرضى، مع إعطاء قدرٍ ضئيل من الاهتمام أو عدم إعطاء أي اهتمام على الإطلاق لضمان النمو الصحي، والنَّماء، والتنشئة للمواليد والأطفال دون سن الخامسة.

وتُشير جميع البيِّنات المتاحة إلى أن الطفولة المبكرة ليست مجرد فترة تستلزم مراعاة عوامل الخطورة بشكل خاص، ولكنها أيضًا فترة حَرِجة تتضاعف خلالها فوائد التدخلات المبكرة، كما يمكن الحدُّ خلالها بشكل كبير من الآثار السلبية للمخاطر. كما أن معظم التجارب التي تُكوِّن شخصية صغار الأطفال وعقليتهم تنبع من رعاية التنشئة التي يتلقونها من الآباء، وأفراد الأسرة الآخرين، ومُقدمي الرعاية، والخدمات المجتمعية.

ويبدأ النَّماء مع مرحلة الحَمل، وقد تؤدي البدايات السيئة في الحياة إلى سوء الصحة والتغذية وقصور التعلُّم، مما يؤدي إلى تدني إمكانات الكسب لدى البالغين، الأمر الذي لا يؤثر فقط على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال القادمة أيضًا.

وتؤثر عدة عوامل على اكتساب الكفاءات والمهارات. وتشمل هذه العوامل: الصحة، والتغذية، والأمن، والسلامة، وتقديم الرعاية التي تستجيب لاحتياجات نمو الطفل والتعلُّم المبكر. ويُعتبر كلٌّ منها مكونًا أساسيًا لرعاية التنشئة. وتقلل هذه الرعاية بدورها من الآثار الضارة على بنية المخ ووظائفه، كما تُحسن من صحة الأطفال، ونموهم، ونَمائهم.

وتتميز رعاية التنشئة ببيئة مستقرة يمكن فيها للتفاعلات والعلاقات العاطفية أن تُعزِّز الصحة والتغذية، وتحمي الأطفال من التهديدات، وتمنحهم فرصًا للتعلُّم المبكر، وتحمي عملية التعلُّم المبكر. وتُعتبر منافع هذه الرعاية ممتدة طوال الحياة: وتشمل، على سبيل المثال، تحسين الصحة والرفاهية والقدرة على التعلُّم، مما يصب بدوره في إمكانات الكسب فيما بعد.

وقد أعد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط هذه الحُزمة من المواد لدعم دور العاملين الصحيين المجتمعيين في تعزيز الصحة.

وقد صُمِّمت هذه الحُزمة من المواد التدريبية المتكاملة حول صحة ونَماء المواليد والأطفال دون سن الخامسة لبناء قدرات العاملين الصحيين المجتمعيين لتمكينهم على نحو أفضل من تقريب الرعاية إلى المجتمع. وعلى الرغم من أن التركيز ينصب أساسًا على تعزيز الرعاية الوقائية للمواليد والأطفال دون سن الخامسة، فإن الحُزمة تتناول أيضًا التدابير التعزيزية والوقائية لصحة الأمهات أثناء الحمل وبعد الوضع، وذلك إقرارًا بالعلاقة الوثيقة بين صحة الأمهات وصحة الرُّضَّع.

حُزمة تدريبية إقليمية حول الرعاية المتكاملة لصحة ونَماء المواليد والأطفال دون سن الخامسة

تهدف هذه الحُزمة التدريبية حول الرعاية المتكاملة للمواليد والأطفال في المنزل إلى تعزيز:

- الممارسات المُثلى للأسر في العناية بصحة ونماء المواليد والأطفال؛
- التغذية السليمة للمواليد والأطفال؛
- نمو المواليد والأطفال ونماؤهم بشكل صحي؛
- دور الآباء في تحفيز النَّماء النفسي للمواليد والأطفال.

وتهدف إلى الوقاية مما يلي:

- المرض؛
- سوء المعاملة، والإهمال، والعنف ضد المواليد والأطفال؛
- الإصابات والحوادث.

وقد صُمِّمت هذه الحُزمة لتيسير عمل العاملين الصحيين المجتمعيين، وبناء قدراتهم بوصفهم المسؤولين عن تعزيز الصحة. كما تهدف إلى إكسابهم المهارات الضرورية للكشف المبكر عن علامات الخطورة، وتقديم المشورة إلى الأمهات ومساعدتهن لتقديم الرعاية الصحية في المنزل إلى أطفالهن المواليد والأطفال دون سن الخامسة.

وتتبع الحُزمة التدريبية نهجًا جيدًا موحَّدًا. فهي تقدم مواد وأدوات مرجعية إقليمية شاملة تغطي جميع مكونات الرعاية من أجل مواليد وأطفال أصحاء، وعناصر الرعاية من أجل صحة الأمهات. ويمكن أن تختار منها البلدان مكونات الرعاية التي تُناسب ظروفها واحتياجاتها وأولوياتها وتقوم بتكييفها طبقا لذلك.

وتشمل الحُزمة التدريبية:

- دليل المُيسِّر: يقود المُيسِّر هذه الدورة التدريبية، ويوفر دليل المُيسِّر وصفًا تفصيليًا للدورة التدريبية خُطوةً بخطوة لضمان إدارتها بطريقة موحَّدة؛
- دليل المشاركين: ويتضمن نصًا موجزًا يُستخدَم كمرجع أثناء الدورة التدريبية وبعدها؛
- استمارتي تسجيل:
  - استمارة تسجيل للمواليد والرضَّع حتى سن أقل من ستة أشهر.
  - استمارة تسجيل للأطفال من سن ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات.

وهما من الأدوات التي تُجمَّع البيانات على أساسها للمساعدة في تقييم الوضع قبل تقديم المشورة، والتمكُّن من تقديم المعلومات ذات الصلة؛

- الكتاب القلاب: أداة تُستخدَم كمرجع للعاملين الصحيين المجتمعيين أثناء الدورة التدريبية والزيارات المنزلية لتقديم المشورة للأسر، وتقديم المعلومات ذات الصلة حسب وَضع الطفل؛ ويتضمن رسومات توضيحية ونصائح.
- مجموعات من بطاقات اللعب (في المرفقين)، ومنها:
  - ألعاب بطاقات "صواب وخطأ".
  - ألعاب بطاقات "مطابقة المعلومات".
- أربعة عشر تدريبًا تمثيليًا، وتتضمن هذه التدريبات سيناريوهات للتدريب على تقديم المشورة؛
- مقاطع فيديوهات توضيحية وتدريبات.

دليل المُيسِّر

يتكون دليل المُيسِّر من مقدمة عامة يليها تسع وحدات.

الوحدة الأولى. مقدمة عن الدورة التدريبية.

الوحدة الثانية. مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟

الوحدة الثالثة. مهارات التواصُل الجيد.

الوحدة الرابعة. العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

الوحدة الخامسة. العناية بصحة ونماء صغار الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

الوحدة السادسة. العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد.

الوحدة السابعة. العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين.

الوحدة الثامنة. العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات.

الوحدة التاسعة. رعاية صحة الأمهات.

وفي كل وحدة، تُخَصَّص بعض الجلسات لتعليم العاملين الصحيين المجتمعيين كيفية تقديم المشورة حول مختلف مكونات الرعاية المنزلية حسب السن. وبالنسبة لجميع الفئات العمرية، تتكون الرعاية المنزلية من 7 مكونات.

المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية (الخاصة بالفئة العمرية ذات الصلة):

- ممارسات طلب الرعاية الصحية
- ممارسات وقائية

المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية.

المكون 3: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية.

المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية.

المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل).

المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات.

المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف.

تشتمل رعاية المواليد وصغار الرضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين على ثلاثة مكونات إضافية للرعاية، ألا وهي:

- تقديم المشورة حول الحفاظ على دِفء الطفل.
- تقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة.
- تقديم المشورة حول العناية بالحبل السُّري.

ويغطي الفصل الأخير حول عناصر صحة الأمهات النقطتين التاليتين:

- تقديم المشورة حول العناية بالأمهات أو صحتهن أثناء الحمل.
- تقديم المشورة حول العناية بصحة الأمهات بعد الوَضع.

الدورة التدريبية

تشتمل الدورة التدريبية على جلسات نظرية وعملية وسريرية، ومن المقرَّر أن تكون في صورة سلسلة من الجلسات داخل قاعة الدرس، وجلسات في عنابر المستشفى وجلسات في العيادة الخارجية، وزيارات منزلية.

والمكان المثالي لعقد هذه الدورة التدريبية هو المستشفى الذي يوجد به عددٌ مناسب من الغرف للجلسات النظرية، وجناح للمرضى الداخليين مع عدد مناسب من المواليد والرضَّع والأطفال المرضى، وقسم للعيادات الخارجية به تدفُّق جيد للأطفال المرضى، ومساحة كافية لاستيعاب المشاركين في الدورة. وعلى منظِّمي الدورة التدريبية أن يزوروا الموقع المُقترَح لعقد التدريب لمناقشة متطلبات الدورة والتجهيزات اللازمة مع مدير المستشفى وفريقه. (للإعداد للجلسات السريرية والزيارات المنزلية، انظر المرفقَين 1 و2.)

ويجب أن يكون هناك مسؤول تنسيق بالمستشفى لتنسيق متطلَّبات الدورة التدريبية مع المدير القائم عليها.

ويمكن تدريب ما يتراوح بين 16 و24 مشاركًا في هذه الدورة التدريبية، وتقسيمهم إلى مجموعات لا يتجاوز عدد المشاركين في كلٍّ منها ثمانية أفراد. ويقود كل فريق مُيسِّران اثنان.

فريق تنظيم الدورة التدريبية

يكون مدير الدورة التدريبية والميسِّرون مسؤولين عن تنظيم الدورة التدريبية وتنفيذها.

ويكون **مدير الدورة التدريبية** مسؤولاً عما يلي:

- الإعداد للدورة التدريبية
- زيارة مواقع التدريب قبل عَقد الدورة التدريبية لشرح الأهداف والمتطلَّبات؛
- شرح المساحات المطلوبة ومتطلبات الجلسات السريرية لمسؤولي التنسيق؛
- اختيار الأماكن المناسبة لجميع مكوِّنات التدريب؛
- اتخاذ الترتيبات اللوجستية، ومنها استراحات تناول المشروبات والغداء، ووسائل النقل، وغيرها.
- رصد تقدم الدورة التدريبية: عقد اجتماع يومي للميسِّرين، وحل المشكلات، ورصد أداء المشاركين.

المُيسِّرون: يكون لكل فريق مُيسِّران اثنان، يضطلعان بالمسؤوليات التالية:

- توجيه المشاركين خلال الدورة التدريبية. لا يُعطي المُيسِّران محاضرات، ولكن يوجهان المشاركين من خلال المناقشات الجماعية، والعروض العملية، والفيديوهات التوضيحية، وتمرينات الفيديو، والتدريبات التمثيلية. ولكي يتمكنا من مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات المُستهدَفة، يجب أن يتمتعا بمهارات التواصل الجيد.
- التأكد من أن المشاركين يفهمون محتوى الدورة التدريبية، وكيفية استخدام مواد الدورة وأدواتها، وكيفية إتمام مختلف أنواع التمرينات المكلَّفين بأدائها.
- رصد التقدم الذي يحرزه كل مشارك، واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب لتعزيز اكتساب المهارات.
- الإجابة عن الأسئلة، وتوضيح النقاط الصعبة التي تُسبب لبسًا.
- مساعدة كل مشارك في تطبيق المهارات التي تعلَّمها أثناء الجلسات العملية والسريرية والزيارات المنزلية.
- إبداء الملاحظات حول عمل المشاركين. وسيعمل المُيسِّرون في مجموعات من اثنين للتمكُّن بشكل وثيق من رصد أداء المشاركين واكتسابهم للمهارات. وسيوجه المُيسِّران المشاركين أثناء تعلُّمهم مهارات جديدة في الجلسات النظرية، ويساعدانهم على تطبيق المهارات المكتسبة أثناء الجلسات العملية، والجلسات المنعقدة في المستشفي وجلسات العيادة الخارجية، والزيارات المنزلية.

يجب أن يتبع المُيسّران دليل المُيسّر بدقة لضمان تناسق المعايير بين جميع مُيسّري الدورة التدريبية

قد تضم مجموعة المُيسِّرين مزيجًا من الأطباء ومدربي التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة، واختصاصيي التغذية، ومسؤولي الصحة العامة (أو غيرهم وَفقًا لوضع كل بلد واحتياجاته). وقد ترى بعض البلدان ضرورة وجود طبيب في الفريق لضمان تحقُّق عناصر معينة مثل، تحديد علامات الخطورة بطريقة سليمة، وتقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، وبعض عناصر التغذية. وبغض النظر عن كيفية تشكيل المجموعات، يجب أن يكون المُيسِّرون حاصلين على تدريب جيد، ويتمتعون بالخبرة ومهارات التواصل الجيد.

المشاركون

سيَجري اختيار المشاركين وَفقًا للمعايير التي يضعها كلُّ بلد. وتتمثل المتطلَّبات الوحيدة التي يجب أن يستوفيها جميع المشاركين فيما يلي:

- أن يكونوا مقيمين في المجتمع الذي سيخدمونه،
- أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة.

ويجب أن تضم كل دورة تدريبية ما يتراوح بين 16 و24 مشاركًا، على أن يُقسَّموا إلى مجموعتي عمل أو ثلاثة، وعلى ألا يزيد عدد المشاركين في كل مجموعة عن ثمانية أفراد بحد أقصى.

مدة الدورة التدريبية، وخيارات التدريب

دورة تدريبية متواصلة. يمكن تقديم الدورة التدريبية على مدار 10 أيام، مع استراحة لمدة يوم واحد في منتصف المدة، وقد ثبت نجاح خيار الدورة التدريبية المتواصلة في التدريب حول التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة. ويجب أن تأتي في أعقاب الدورة التدريبية فترة إشرافية مدتها 5 أيام يتولى القيام بها المُيسِّرون للتأكُّد من أن العاملين الصحيين المجتمعيين قادرون على نقل المعلومات والمعارف التي تعلَّموها أثناء الدورة التدريبية.

وعلى الرغم من أن لهذا الخيار ميزة تتمثل في ضمان التكامل واستمرارية الرعاية، فإن بعض البلدان قد ترى أن له متطلبات كثيرة ويشكل عبئًا إضافيًا نظرًا لطول مدته.

الدورة التدريبية المكوَّنة من مرحلتين منفصلتين: يمكن أن تُنفَّذ الدورة التدريبية على مرحلتين، تستمر كل منهما لمدة خمسة أيام، ويكون بينهما فاصل لمدة خمسة أيام يستطيع خلاله المشاركون العودة إلى مجتمعاتهم المحلية لممارسة ما تعلموه. وسيُشرف المُيسِّرون على فترة استراحة الدورة التدريبية، التي ستتيح لهم فرصة تصحيح عمل المشاركين، إذا لزم الأمر، وحل المشكلات التي قد تظهر أثناء تطبيق ما تعلموه خلال الأيام الخمسة الأولى من الدورة التدريبية. وتأتي بعد المرحلة الثانية من التدريب فترة إشرافية مماثلة مدتها خمسة أيام.

وستغطي المرحلة الأولى من التدريب المواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن شهرين من العُمر، ورعاية الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، وصحة الأمهات بعد الوضع. أما المرحلة الثانية، فتغطي الفئات العمرية المتبقية ورعاية صحة النساء الحوامل.

ويُحبَّذ أن يدير الدورة التدريبية المكوَّنة من مرحلتين نفس فريق المُيسِّرين. ولكن نظرًا إلى طول المدة الزمنية التي يتطلبها تحقيق ذلك، فقد يبدو ذلك أمرًا غير عملي. وفي هذه الحالة، يمكن تقسيم مرحلتي التدريب التي تستمر كل منهما لمدة خمسة أيام وفترتي الإشراف بين فريقين من المُيسِّرين، على أن يكون كل فريق مسؤولاً عن مرحلة واحدة من

التدريب الذي يستمر لمدة خمسة أيام والفترة الإشرافية التي تليه.

ولكن قد تنشأ بعض المشكلات بسبب تفاوت مهارات المُيسِّرين. ولتجنُّب حدوث ذلك، يجب أن يكون كل فريق من المُيسِّرين على درجة عالية من الكفاءة، وعلى المُيسِّرين أن يتبعوا دليل المُيسِّر بدقة لضمان ثبات جودة التدريب.

وبعد مرور شهر على إتمام الدورة التدريبية، سواءً كانت متواصلة أو مكوَّنة من مرحلتين، يجب إجراء زيارة متابعة لتقييم التنفيذ وتعزيزه، وحل أي مشكلات قائمة.

وعلى البلدان أن تحدد خيار التدريب الأنسب للوضع المحلي.

تصميم الدورة التدريبية

يعتمد تصميم الدورة التدريبية على منهجية تعلُّم تفاعلية، ويشمل الجلسات النظرية، والعملية، والسريرية والزيارات المنزلية. ويعتمد التصميم على نطاق واسع من طرق التدريب لضمان اكتساب المعارف والمهارات الجيدة:

الجلسات النظرية والعملية ستُعقَد في قاعات الدرس، التي بها طاولات ومقاعد. ويجب أن تكون كل قاعة من قاعات الدرس مُجهَّزة لاستيعاب ثمانية مشاركين واثنين من المُيسّرين. وسيحتاج كل فريق مكوَّن من ثمانية مشاركين إلى قاعة درس منفصلة. ويجب أن تكون قاعات الدرس جيدة التهوية والإضاءة.

كما يجب أن تتوافر في كل قاعة درس طاولة للحاسوب (الكمبيوتر) المحمول وجهاز العرض.

ويتمثل الهدف من هذه الجلسات في المساعدة على إعداد المشاركين للجلسات السريرية والزيارات المنزلية اللاحقة، باستخدام مجموعة متنوعة من طرق التدريب لتعزيز التعلُّم واكتساب المهارات:

- مقدمة حول الجلسة
- مناقشات جماعية
- عروض توضيحية
- فيديوهات توضيحية
- تمرينات الفيديو
- صور توضيحية
- تمرينات الصور
- عروض توضيحية عملية
- ممارسة المهارات
- التدريبات التمثيلية
- تمارين كتابية وتقديم تعقيبات فردية
- الألعاب:
  - ألعاب الكرة
  - ألعاب التحرك خُطوة إلى الأمام
  - ألعاب البطاقات:
    - ألعاب بطاقات "صواب وخطأ"
    - ألعاب بطاقات "مطابقة المعلومات"
- تدريبات الأسئلة السريعة
- القراءة

تسمح العروض التوضيحية، والتدريبات التمثيلية، وتمرينات الفيديو للمشاركين بممارسة المهارات التي يكتسبونها، وتساعدهم على الاستعداد للتعامل مع مقدمي الرعاية والأطفال على أرض الواقع أثناء الجلسات السريرية والزيارات المنزلية.

الجلسات السريرية تنقسم إلى:

أ. جلسات المستشفى

تشمل الدورة التدريبية جلستين في المستشفى للأطفال المرضى تُعقدان في أجنحة المستشفى أو وحدات العناية المركَّزة، حيث يُعالج ما لا يقل عن تسعة من المواليد/ الرضّع. وستساعد كل جلسة المشاركين على تحديد مجموعات من علامات الخطورة، وفهم أهمية الإحالة العاجلة. وستشتمل على:

- عروض توضيحية سريرية
- التمرين العملي على تحديد علامات الخطورة
- تقديم تعقيبات فردية
- مناقشات جماعية
- إشراف مُوجَّه
- ملء استمارة التسجيل

ب. جلسات العيادة الخارجية

تشمل الدورة التدريبية أربع جلسات في العيادة الخارجية تُعقد في المرافق الصحية (العيادة الخارجية للمستشفى أو أحد مرافق الرعاية الصحية الأولية) التي تفحص يوميًا ما لا يقل عن 30 طفلاً دون سن الخامسة، وحيث توجد غرفة أو مساحة منفصلة تحتوي على طاولات ومقاعد. ونظرًا لأن التركيز الأساسي لهذه المواد التدريبية ينصب على رعاية طفل سليم صحيًا، يُفضَّل أن تُعقَد جلسات العيادة الخارجية في ركن أو عيادة تقديم خدمات الرعاية للأطفال الأصحاء، إن وُجد، مما يسمح بممارسة تقديم المشورة لأطفال أصحاء في موقف واقعي.

ويتمثل الهدف من هذه الجلسات في إتاحة الفرصة للمشاركين من أجل:

- التمرين العملي على التحقُّق من وجود علامات الخطورة؛
- التمرين العملي على تقديم المشورة للأمهات حول مكونات العناية المختلفة في جميع الفئات العمرية؛
- التمرين العملي على استخدام استمارة التسجيل باعتبارها أداة لتقييم الوضع؛
- التمرين العملي على استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة.

ويجب أن يحتوي برنامج الدورة على الجلسات الأربع للعيادة الخارجية، مما يمكّن المشاركين من ممارسة مهارات تقديم المشورة.

ويعرض المرفق 1 في نهاية دليل المُيسِّر وصفًا مفصَّلاً لكيفية إعداد كلا النوعين من الجلسات السريرية وتنظيمها وتنفيذها.

الزيارات المنزلية

تشمل الدورة التدريبية زيارتين منزليتين تهدفان إلى ممارسة المعارف والمهارات التي اكتُسبت أثناء الدورة التدريبية على أرض الواقع. ويُوصَى بأن تُجرَى الزيارة الأولى عقب إتمام الفصل الخامس من الدورة التدريبية حول رعاية الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، على أن تُقرَّر الزيارة الثانية قرب نهاية الدورة التدريبية، مما يسمح للمشاركين بممارسة تقديم المشورة إلى جميع الفئات العمرية. ويمكن تغيير توقيت الزيارات حسب الوضع.

وأثناء الزيارات المنزلية، سيقوم المشاركون بما يلي:

- تعلُّم كيفية إجراء هذه الزيارات؛

- التمرين العملي على استخدام استمارة التسجيل لتحديد ممارسات الأسرة فيما يتعلق بالعناية بالمواليد والأطفال في المنزل؛
- التمرين العملي على تقديم المشورة من خلال تقديم المعلومات ذات الصلة باستخدام الكتاب القلاب.
- وفيما يلي نموذج لجدول أعمال الدورة التدريبية. ويمكن تكييف جدول الأعمال وَفقًا للظروف المحلية، وخيار التدريب، وعدد المشاركين، وتوافر الأماكن لعقد جلسات المرضى الداخليين والعيادة الخارجية والزيارات المنزلية.

جدول الأعمال المقترَح لدورة تدريبية مدتها 10 أيام

اليوم	الوقت	الموضوع
	09:00-08:30	التسجيل
اليوم الأول	10:15-09:00	الجلسة الافتتاحية، ومقدمة عن الدورة التدريبية (30 دقيقة) **الوحدة الثانية: مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟** (15 دقيقة) **الوحدة الثالثة: مهارات التواصل: الخطوة الأولى** (30 دقيقة)
	10:45-10:15	استراحة
	14:15-10:45	**الوحدة الثالثة: مهارات التواصل: الخطوتان الثانية والثالثة** (90 دقيقة) **الوحدة الرابعة: العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل:** مقدمة، تشمل غسل اليدين للعاملين الصحيين المجتمعيين (60 دقيقة) * المكون 1: الحفاظ على دِفء الطفل (60 دقيقة)
	15:15-14:15	استراحة الغداء
	17:15-15:15	**الوحدة الرابعة. العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل:** * المكون 2: البدء المبكر في الرضاعة (90 دقيقة) * المكون 3: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين : علامات الخطورة (30 دقيقة)
اليوم الثاني	11:10–09:00	**الوحدة الرابعة: العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل** * المكون 3: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين: ● (تابع) علامات الخطورة (60 دقيقة) ● مَن الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟ (10 دقائق) ● الممارسات الوقائية (60 دقيقة)
	11:25–11:10	استراحة لتناول المشروبات
	14:25–11:25	**الوحدة الرابعة. العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل** * المكون 3: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين: (تابع) الممارسات الوقائية (20 دقيقة) * المكون 4: العناية بالحبل السُّري (60 دقيقة) * المكون 5: النظافة الشخصية (60 دقيقة) * المكون 6: الرضاعة (40 دقيقة)

اليوم	الوقت	الموضوع
	15:25–14:25	استراحة الغداء
	17:15–15:15	**الوحدة الرابعة: العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل** * المكون 6: (تابع) الرضاعة (80 دقيقة) * المكون 7: معالم النَّماء الرئيسية (40 دقيقة)
اليوم الثالث	10:30–09:00	جلسة سريرية بالمستشفى (1) علامات الخطورة في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين
	11:00–10:30	استراحة لتناول المشروبات
	13:50–11:00	**الوحدة الرابعة: العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل** * المكون 7: (تابع) تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية (50 دقيقة) * المكون 8: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (45 دقيقة) تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات (45 دقيقة) تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف (30 دقيقة)
	14:50–13:50	استراحة الغداء
	16:20–14:50	**الوحدة التاسعة: العناية بصحة الأمهات بعد الوضع** (90 دقيقة)
اليوم الرابع	12:00–09:00	**جلسة العيادة الخارجية (1)** تقديم المشورة حول العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل
	14:00–12:00	**العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر في المنزل** * المكون 1: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (120 دقيقة)
	15:00–14:00	استراحة الغداء
	16:30–15:00	**العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر** * المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية (90 دقيقة)
اليوم الخامس	12:00–09:00	**الزيارة المنزلية (1)** تقديم المشورة حول العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل، والعناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية والتغذية لهذه الفئة العمرية (تشمل استراحة لتناول المشروبات)
	14:15–12:00	**الوحدة الخامسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر** *** المكون 2: (تابع) تقديم المشورة حول التغذية (90 دقيقة)** *** المكون 3: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية (45 دقيقة)**
	15:15–14:15	استراحة الغداء
	16:30–15:15	**الوحدة الخامسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر** المكون 4: (تابع) تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية (45 دقيقة) * المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (30 دقيقة)

اليوم	الوقت	الموضوع
اليوم السادس	11:00–09:00	**الجلسة السريرية في المستشفى (2)** علامات الخطورة لدى الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر
	13:40–11:00	**الوحدة الخامسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر في المنزل** * المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات (30 دقيقة) * المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف (30 دقيقة) كيفية إجراء زيارات منزلية للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (10 دقائق) **الوحدة السادسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد في المنزل** * المكون 1: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية (90 دقيقة)
	14:40–13:40	استراحة الغداء
	16:40–14:40	**الوحدة السادسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد في المنزل** * المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية (120 دقيقة)
اليوم السابع	11:00–09:00	**جلسة العيادة الخارجية (2)** **العناية بصحة ونماء المواليد والرضّع حتى سن عام واحد، والعناية بصحة الأمهات**
	11:15–11:00	استراحة لتناول المشروبات
	14:15–11:15	**الوحدة السادسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من سن ستة أشهر حتى أقل من عام واحد في المنزل** المكون 3: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية (45 دقيقة) * المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية (60 دقيقة) * المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (45 دقيقة) * المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/الإصابات (30 دقيقة)
	15:15–14:15	استراحة الغداء
	16:30–15:15	**الوحدة السادسة: العناية بصحة ونماء الرُّضَّع من سن ستة أشهر حتى أقل من عام واحد** المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف (30 دقيقة) الوحدة السابعة: العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين * المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية (45 دقيقة) * المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية (30 دقيقة)
اليوم الثامن	12:00–09:00	**جلسة العيادة الخارجية (3)** تقديم المشورة حول رعاية المواليد، والرضّع، والأطفال حتى سن عامين، وصحة الأمهات في المنزل (تشمل استراحة لتناول المشروبات)
	14:00–12:00	**الوحدة السابعة: العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين في المنزل** المكون 3: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية (30 دقيقة) المكون 4: معالم النَّماء (45 دقيقة) المكون 5: العناية من أجل النماء (45 دقيقة)
	15:00–14:00	استراحة الغداء

اليوم	الوقت	الموضوع
	16:45–15:00	**الوحدة السابعة: العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين في المنزل** * المكون 6: الوقاية من الحوادث/ الإصابات (30 دقيقة) * المكون 7: الوقاية من سوء المعاملة (30 دقيقة) **الوحدة الثامنة: العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات** * المكون 1: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية (45 دقيقة)
اليوم التاسع	12:00–09:00	**جلسة العيادة الخارجية (4)** تقديم المشورة حول العناية بصحة ونماء المواليد والرضّع حتى أقل من ستة أشهر، وصحة الأمهات
	14:30–12:00	**الوحدة الثامنة: رعاية الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات في المنزل** * المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية (60 دقيقة) * المكون 3: تقديم المشورة حول النظافة الشخصية (60 دقيقة) * المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية (30 دقيقة)
	15:30–14:30	استراحة الغداء
	17:00–15:30	**الوحدة الثامنة: رعاية الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات في المنزل** * المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (30 دقيقة) * المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات (60 دقيقة)
اليوم العاشر	12:00–09:00	**الزيارة المنزلية (2)**
	14:00–12:00	**الوحدة الثامنة: رعاية الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات في المنزل** المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف (30 دقيقة) **الوحدة التاسعة: العناية بصحة الأمهات أثناء الحمل (120 دقيقة)**
	14:30–14:00	الجلسة الختامية

الإمدادات والمُعدَّات اللازمة للدورة التدريبية

البند	العدد
1. دليل المُيسِّر	واحد لكل ميسِّر + 2
2. دليل المشاركين	واحد لكل ميسِّر واحد لكل مشارك + 5
3. الكتاب القلاب	واحد لكل ميسِّر واحد لكل مشارك + 5
4. وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) لمقاطع الفيديو	واحد لكل ميسِّر + 2
5. حاسوب (كمبيوتر) محمول، وجهاز عرض البيانات، وشاشة	مجموعة واحدة لكل فريق
6. دُمية للعروض التوضيحية	واحدة لكل فريق
7. علبة طباشير لألعاب "التحرك خُطوة إلى الأمام"	واحدة لكل فريق
8. منشفة للعروض التوضيحية	واحدة لكل فريق

البند	العدد
9. مجموعات بطاقات لألعاب البطاقات: - ألعاب بطاقات "صواب وخطأ": • علامات الخطورة في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين • تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين • تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمس سنوات - ألعاب بطاقات مطابقة المعلومات • مراجعة الرضاعة في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين • معالم النَّماء الرئيسية في الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر • مراجعة التنفُّس السريع	مجموعتان من البطاقات لكل فريق
10. مقاييس الحرارة الرقمية	واحد لكل مشارك واحد لكل ميسِّر + 5
11. مؤقتات	واحد لكل مشارك واحد لكل ميسِّر + 5
12. مقياس وزن محمول	واحد لكل مشارك واحد لكل ميسِّر + 2
13. مذكرة إحالة	اثنتان لكل مشارك واحدة لكل ميسِّر + 5
14. الموقف 3 والموقف 4 للتحقُّق من فهم الأمهات، في إطار مهارات التواصل الجيد	نسختان لكل فريق
15. استمارة التسجيل للمواليد والرضّع حتى أقل من ستة أشهر	10 لكل مشارك + 10
16. استمارات التسجيل للرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات	20 لكل مشارك + 15
17. مُستلزَمات غسل اليدين: صابون، وإبريق ماء، ومنشفة نظيفة، وإناء كبير	مجموعة واحدة لكل فريق
18. لوح ورقي قلاب وأقلام	مجموعة واحدة لكل فريق
19. كرة من أجل ألعاب الكرة	مجموعة واحدة لكل فريق
20. أسلاك التمديد، بالإضافة إلى محولات تناسب نوع المقابس الخاصة بالبلد	مجموعة واحدة لكل فريق

البند	العدد
21. سيناريوهات الحالات من أجل: – تمثيل الأدوار (1)، المساعدة في الإحالة – تمثيل الأدوار (2)، تقديم المشورة حول الرضاعة للمواليد – مثيل الأدوار (3)، تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين – تمثيل الأدوار (4)، تقديم المشورة حول علامات الخطورة في الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر – تمثيل الأدوار (5)، تقديم المشورة حول الرضاعة للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر – تمثيل الأدوار (6)، تقديم المشورة حول النظافة الشخصية للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر – تمثيل الأدوار (7)، تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر – تمثيل الأدوار (8)، تقديم المشورة حول علامات الخطورة للرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد – تمثيل الأدوار (9)، تقديم المشورة حول تغذية الرُّضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد – تمثيل الأدوار (10)، تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد – تمثيل الأدوار (11)، تقديم المشورة حول الرعاية من أجل نماء الرُّضَّع من سن ستة أشهر حتى أقل من عام واحد – تمثيل الأدوار (12)، تقديم المشورة حول الرعاية من أجل نَماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين – تمثيل الأدوار (13)، تقديم المشورة حول التغذية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام – تمثيل الأدوار (14)، تقديم المشورة حول النظافة الشخصية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام – تمثيل الأدوار (15)، تقديم المشورة حول العناية بصحة الأمهات بعد الوضع	نسختان من سيناريوهات الحالات لكل فريق
22. لإمدادات الخاصة بالعرض التوضيحي "اللعب والتواصل" مع الطفل: – مجموعات من الأكواب البلاستيكية أو المعدنية بمقابض (ذات أحجام وأشكال مختلفة، على أن تضم كل مجموعة ثلاثة أكواب على الأقل) – حاويات بلاستيكية ذات أغطية صغيرة الحجم بما يسمح للطفل بفتحها وغلقها – أدوات منزلية ليَقْرع عليها الطفل ويُسقطها (أوانٍ معدنية، أغطية، وأوانٍ عميقة (سلطانيات)، وأطباق، وأكواب، وملاعق خشبية) – أقمشة للعبة المداعبة بإخفاء الأشياء ثم إظهارها فجأة ("بِخّ") (أقمشة قطنية نظيفة لإخفاء الأشياء خلفها) – كرة صغيرة ناعمة الملمس	مجموعة واحدة لكل فريق
23. أقلام رصاص وبَرّايَات	واحد/ واحدة لكل مُيسِّر وواحد/ واحدة لكل مشارك + 5
24. دباسة، وثقابة ورق	مجموعة واحدة
25. مقاعد وطاولات	بما يكفي لعدد المشاركين والمُيسِّرين في كل غرفة

على مدار الدورة التدريبية، ستتبع دليل المُيسِّر بدقة. وتدل الرموز المُستخدمة في الدليل على نوع النشاط الذي يتعين القيام به، وهي:


مقدمة حول الجلسة


مناقشة جماعية


لعبة الكرة


قراءة


ممارسة المهارات


عرض توضيحي


تمرين كتابي


فيديو توضيحي


لعبة


لعبة بطاقات مطابقة المعلومات


تدريب الأسئلة السريعة


تمرين الصور


لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام


لعب الأدوار



الوحدة الأولى: مقدمة حول الدورة التدريبية

الجلسة 1

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- مجموعة واحدة كاملة من مواد الدورة التدريبية
- دليل المشاركين لكل مشارك ومُيسِّر
- لوحًا ورقيًا قلابًا
- أقلامًا بألوان مختلفة

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- إدراك أهمية العناية بالمواليد والرضّع والأطفال في المنزل؛
- إدراك أسباب إدراج عناصر العناية بصحة الأمهات في البرنامج؛
- إدراك أهمية الدور المنوط بهم بوصفهم عاملين صحيين مجتمعيين.

1.1 مناقشة جماعية: أهداف الدورة التدريبية

وزِّع أدلة المشاركين. واحتفظ بنسختين، واحدة لك وأخرى للميسِّر المشارك. ووضح أن: الكتاب يُعتبر دليلاً مرجعيًا. وهو يُلخص المعلومات التي سيتعلَّمونها أثناء الدورة التدريبية، وسيُستخدم بصفة دائمة أثناء الدورة التدريبية، ويمكن الرجوع إليه لاحقًا عند عودتهم إلى عملهم.

اطلب من المشاركين النظر إلى الرسم التوضيحي (1) في صفحة 4 من الدليل.

اسأل المشاركين عما يرونه في الرسم.

انتظر إجاباتهم، ثم اختتم المناقشة قائلاً: "نرى حالة فوضوية في الحمَّام. فالأطفال متروكون وحدهم دون أي إشراف أو رعاية".

اسأل عن العواقب التي قد تترتب على ذلك. واستمع إلى إجابات المشاركين قبل أن تختتم المناقشة بأن الأطفال قد يتعرَّضون للإصابة، أو المرض، أو الغرق في الماء. وأكد على أن الأطفال يحتاجون إلى التدريب على الانضباط ليتعرفوا على السلوكيات والممارسات الجيدة. ويجب ألا يُترك الأطفال مطلقًا دون رقابة لتجنب الحوادث.

اسأل المشاركين عما إذا كان من المهم أن يتلقى الأطفال رعاية من آبائهم أو أجدادهم أم لا، وأسباب ذلك.

لخص المناقشة بأنه من الضروري أن تعتني الأسر بأطفالهم منذ الولادة. ووضِّح أن الرعاية لا تقتصر فقط على إطعام الأطفال أو الاعتناء بهم عندما يمرضون، ولكنها تشمل أيضًا تعزيز صحتهم البدنية ونمائهم، ومهاراتهم الحياتية وانضباطهم، وتحفيز نَمائهم النفسي والاجتماعي. واكتب على اللوح الورقي القلاب: العناية بصحة ونماء الأطفال في المنزل.

اطلب من المشاركين النظر إلى الرسم التوضيحي (2) في صفحة 4. ثم اسأل المشاركين عما يرونه في الرسم. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن تخبرهم أن هذا الرسم يصور طفلاً مريضًا.

أكد على أنه قد يسهل التعامل مع اعتلال صحة الطفل، ثم اسألهم عما قد يحدث إذا لم يطلب الآباء الرعاية الصحية لأطفالهم في الوقت المناسب من أحد مقدمي الرعاية الصحية الأكْفاء.

امنحهم وقتًا لتقديم بضع إجابات، ثم اختم المناقشة بأنه:

> إذا لم تُطلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب، فقد يشتد اعتلال صحة الطفل سريعًا، وقد يهدد ذلك حياته. اكتب على اللوح الورقي القلاب: طلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب يُنقذ حياة الأطفال.

اطلب من المشاركين النظر إلى الرسم التوضيحي (3) في صفحة 4. ماذا يرون؟ انتظر للاستماع إلى بضع إجابات، ثم اشرح لهم أن هذه الرسومات التوضيحية توضح كيف يمكن أن يسوء وضع الأسرة عندما تمرض الأم.

اسألهم عن أسباب أهمية العناية بصحة الأمهات، واستمع إلى إجاباتهم.

> **لخص المناقشة** بأن الأمهات يُقدّمن الدعم إلى أسرهن، وعادةً ما يتحملن مسؤولية إدارة المنزل بالكامل، بالإضافة إلى العديد من المسؤوليات الأخرى خارجه (في العديد من المواقف). فإذا مرضت الأم، تتعرض حياة الأسرة كلها للخطر. اكتب على اللوح الورقي القلاب: تشكل العناية بصحة الأمهات جزءًا بالغ الأهمية من رعاية صحة الأطفال.

وأضف أن صحة الأم مرتبطة بصحة المولود: على سبيل المثال، إذا لم تكن المرأة الحامل تتغذى جيدًا و/أو كانت حالتها التغذوية سيئة، سيعاني الوليد من نقص الوزن الحاد، وقد يواجه مضاعفات خطيرة.



2.1 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 1، لماذا نحتاج إلى العناية بصحة ونماء المواليد والأطفال والأمهات في المنزل؟ في صفحة 5، من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.1 مناقشة جماعية: مَن هو مقدِّم الرعاية؟

اسأل المشاركين عن تعريف مقدم الرعاية. انتظر للاستماع إلى بضع إجابات، ثم أكد على أن مقدم الرعاية هو أهم شخص بالنسبة للطفل. فمقدم الرعاية هو مَن يقوم بتغذية الطفل والاعتناء به، وهو مصدر العاطفة له، وهو من يتواصل مع الطفل ويستجيب لاحتياجاته. وإذا مرض الطفل، يكون مقدم الرعاية عادةً هو من يأخذه إلى مقدم الرعاية الصحية.

اسأل المشاركين عن تعريف مقدم الرعاية في مجتمعاتهم. انتظر للاستماع إلى بضع إجابات، ثم أخبرهم أنه في معظم المواقف تكون الأم هي مقدِّم الرعاية. وفي بعض الأحيان، تكون الجدة، أو الشقيقة الكبرى، أو الأب، أو الخالة/ العمة، أو غيرهم.



4.1 مناقشة جماعية: مَن الذي تطلب منه الأسرة النصيحة عندما يمرض أحد أطفالها؟ ولماذا أنتم هنا؟

اسأل المشاركين عن المصدر الذي يأخذ منه مقدمو الرعاية معلوماتهم عن كيفية رعاية الأطفال في المنزل. اكتب إجاباتهم على اللوح الورقي القلاب، ثم لخِّصها قائلاً إن مصدر المعلومات يمكن أن يتمثل في الجدة، أو أحد الجيران، أو أحد الأصدقاء، أو أحد العاملين الصحيين المجتمعيين، أو أحد المرافق الصحية، إلى ما إلى ذلك.

ويأتي عادة المصدر الأول للمعلومات من داخل المجتمع. ونظرًا لأن العاملين في مجال الرعاية الصحية يكونون من داخل المجتمعات، فهم يمثلون مصدرًا مهمًا للمعلومات بالنسبة للأسر. وعندما يُدربون بشكل جيد، يمكنهم تقديم قدر كبير من المساعدة.

ستساعد هذه الدورة التدريبية العاملين الصحيين المجتمعيين على اكتساب المهارات اللازمة لمساعدة الأسر على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواليد والأطفال في مجتمعاتهم. وسينصب تركيز هذه الدورة التدريبية على العناية بالمواليد، والرضّع، والأطفال حتى أقل من سن الخامسة، بالإضافة إلى بعض العناصر الخاصة بصحة الأمهات.



5.1 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 2، في صفحة 5، من دليل المشاركين، لماذا أنتم هنا؟ وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



6.1 عرض توضيحي. الدورة التدريبية، وموادها، ومحتواها

أخبر المشاركين عن مدة الدورة التدريبية، ووضح لهم أنها ستشتمل على جلسات نظرية وعملية وسريرية وزيارات منزلية.

واعرض الأشياء التي سيستخدمها المشاركون:

- دليل المشاركين (الموجود لديهم بالفعل)
- الكتاب القلاب
- استمارات التسجيل
- مذكرة الإحالة

أخبر المشاركين أن هذه الدورة التدريبية مُصمَّمة لتغطي خمس فئات عُمرية، ألا وهي:

- المواليد (من الميلاد - ثمانية أيام)، وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- الرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛
- الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام.

وسيُدرَّب المشاركون على تقديم المشورة بالنسبة لكل فئة عمرية بشأن سبعة مكونات للرعاية، ألا وهي:

- ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لكل فئة عمرية؛
- التغذية؛
- النظافة الشخصية؛
- معالم النَّماء الرئيسية؛
- العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)؛
- الوقاية من الحوادث/ الإصابات؛
- الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف.

وبالنسبة للمواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، توجد ثلاثة مكونات إضافية:

- تقديم المشورة حول الحفاظ على دِفء المواليد؛
- تقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة؛
- تقديم المشورة حول العناية بالحبل السُّري.

كما سيتعلم المشاركون كيفية تقديم المشورة حول العناية بصحة الأمهات أثناء الحمل وبعد الوضع.2

بالنسبة للأطفال من عمر شهرين حتى أقل من خمسة أعوام، هناك سبعة مكونات لتقديم المشورة حول الرعاية في المنزل. وبالنسبة للمواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، هناك 10 مكونات.



الوحدة الثانية: العاملون الصحيون المجتمعيون
الجلسة 2: مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟

مدة الجلسة
15 دقيقة

جهِّز
مجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين (الخاصة بالبلد)

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- إدراك النقاط التالية:
  - مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟
  - دور العاملين الصحيين المجتمعيين.
  - أهمية الزيارات المنزلية.
- التعرف على مكونات مجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين.

1.2 مقدمة

اشرح للمشاركين أن العاملين الصحيين المجتمعيين يكونون عادةً من بين أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه. ويُفضَّل أن يختارهم المجتمع ويكونوا مستجيبين له، ويدعمهم النظام الصحي، على الرغم من أنهم ليسوا بالضرورة جزءًا من مؤسسته. وهم يتلقون تدريبًا لمدة أقل من المهنيين الصحيين الآخرين.

وفي بلدان إقليم شرق المتوسط، هناك العديد من أنواع العاملين الصحيين المجتمعيين الذين قد يكونون جزءاً من مؤسسات متعددة: فقد يكونون جزءًا من النظام الصحي، مثل رائدات ريفيات، أو قابلات مجتمعيات، أو عاملات صحيات، أو غيرهن، أو يمكنهم العمل خارج النظام الصحي، كأن يعملوا مثلاً مع منظمات غير حكومية، أو أفراد المجتمع، أو المسؤولين عن تعزيز الصحة، أو المتطوعين، وغيرهم.

وبشكل عام، يقوم العاملون الصحيون المجتمعيون بوظيفة واحدة أو أكثر ترتبط بتقديم الرعاية الصحية. وهم يتلقون تدريبًا مركَّزًا على التدخلات المتوقَّع أن ينفذوها (مثل المباعدة بين الولادات والتغذية).

وقد يقدم بعض العاملين الصحيين المجتمعيين خدمات علاجية ونَمائية/ تعزيزية أو مزيجًا من كليهما.

أخبر المشاركين بما يلي:

- يكون العاملون الصحيون المجتمعيون مرتبطين بالنظام الصحي من خلال المرفق الصحي الذي يرفعون تقارير إليه؛
- سيُكلَّف واحدٌ أو أكثر من العاملين في المرفق الصحي لمساعدة العامل الصحي المجتمعي والإشراف عليه، ومساعدته في حل المشكلات، وتقديم تدريب أثناء العمل، وإبداء ملاحظات، وما إلى ذلك؛
- سيتلقى العاملون الصحيون المجتمعيون تدريبًا من خلال هذه الدورة التدريبية على تقديم حُزمة متكاملة من خدمات الرعاية التعزيزية والوقائية من أجل صحة ونَماء المواليد والرضّع والأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى عناصر العناية بصحة الأمهات أثناء الحمل وبعد الوضع؛

- الهدف من مشاركتهم في هذه الدورة التدريبية يتمثل في أن يتدربوا على العمل كمسؤولين عن تعزيز صحة المجتمع، ولتقديم المشورة للآباء بشأن الجوانب التعزيزية والوقائية للصحة حتى يقدموا الرعاية المثلى للمواليد والأطفال الأصحاء في المنزل.

ستكون الزيارات المنزلية هي آلية عمل العاملين الصحيين المجتمعيين أثناء مساعدتهم للأسر في رعاية المواليد والأطفال في المنزل. وسيُكلَّف كل عامل من العاملين الصحيين المجتمعيين بمنطقة مُستهدَفة بالخدمات الطبية أو عدد من الأسر داخل القرية، بناءً على المعلومات التالية:

- عدد المنازل في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية؛
- عدد النساء الحوامل في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية؛
- عدد الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية.

وعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يضعوا خطة بشأن:

1. إجراء زيارتين للمرأة الحامل:
   - الأولى أثناء الثلاثة أشهر الأولى من الحمل؛
   - الثانية أثناء الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل.
2. إجراء زيارتين للمولود والأم بعد الوضع:
   - الأولى أثناء الوضع أو بعده مباشرة (إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن زيارتهما خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى بعد الوضع)؛
   - الثانية في اليوم الثالث بعد الوضع.
3. إجراء زيارة واحدة للرضيع الصغير في عُمر ستة أسابيع.
4. إجراء زيارة واحدة للفئات العمرية الأخرى كل شهرين.

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية إجراء زيارتين للنساء الحوامل، من وجهة نظرهم. واستمع إلى إجاباتهم، ثم أكِّد على أن صحة المولود تبدأ بصحة الأم. كما يعتمد بقاء المواليد على قيد الحياة ورفاهتهم على صحة الأم من عدة جوانب مهمة للغاية.

- عندما تعاني الأمهات من سوء التغذية، يؤثر ذلك على نَماء الجنين، وصحته بعد الولادة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف نمو الجنين في الرحم، ويزيد من احتمال انخفاض وزنه عند الميلاد. ويكون الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الميلاد أكثر عُرضة لخطر ضعف الإدراك، ومشاكل النَّماء مثل ضعف مدى الانتباه، والتعرُّض للأمراض والوَفَيَات المبكرة.
- إذا كانت الأمهات مريضات، أو تتلقى قدرًا غير كافٍ من الرعاية قبل الولادة وعند الوضع، يصبح أطفالهن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض والوفاة المبكرة.
- من شأن تقديم القدر الكافي من الرعاية أثناء الحمل أن يساعد في الوقاية من المضاعفات وتثقيف النساء بشأن الخطوات التي يستطعن اتخاذها لحماية أطفالهن، وضمان حمل صحي. ومن المهم أيضًا السيطرة على الأمراض الموجودة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السُّكَّري لمنع حدوث مضاعفات خطيرة قد تؤثر على الطفل.
- ومن الضروري معرفة أماكن النساء الحوامل في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية، وخطط الأسرة بالنسبة لعملية الوضع. وإذا كان من المقرَّر أن يتم الوضع في المنزل، فعلى العامل الصحي المجتمعي أن:
- يحصل على أرقام هواتف الأسرة، كما يحصل على إذن منهم لحضور عملية الوضع برفقة قابلة ماهرة، بحيث يساعدان الأسرة على الاعتناء بالطفل بمجرد ولادته، ويقدمان الرعاية لصحة الأم بعد الوضع؛
- يتواصل مع القابلة للاتفاق على حضور عملية الوضع بهدف مساعدة الطفل بمجرد ولادته.

ووضح أنه في حالة حدوث عملية الوضع في أحد المرافق الصحية، فإن المرفق الصحي سيقدم الرعاية للأم والطفل، ولكن عند عودة الأسرة إلى المنزل من المستشفى، من المُفترَض أن يزورها العامل الصحي المجتمعي كما هو مقررًا.

وأكِّد للمشاركين على أنه يُفضل أن تكون زيارتهم الأولى للمواليد أثناء عملية الوضع أو بعدها مباشرةً نظرًا لأن هناك بعض التدخلات الضرورية الواجب تنفيذها في ذلك الوقت من أجل رعاية المولود.

ووضح أنه أثناء الزيارات المنزلية، يجب أن يقوم العاملون الصحيون المجتمعيون بتقييم وضع الأم والطفل بشكل شامل فيما يتعلق بمكونات الرعاية وبيئتهما المعيشية. وبعد ذلك، يقومون بتقديم المشورة والمعلومات حسب تقديرهم للوضع.

وأكِّد على أن تقديم المشورة لا يعني مجرد ترديد/ قراءة المعلومات التي سيتعلمونها، إذ يجب تصميم النصيحة بما يتناسب مع الوضع بما أن الغرض منها هو مساعدة الأسر على رعاية أطفالها وتحسين ممارساتها.



2.2 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 3: مَن هم العاملون الصحيون المجتمعيون؟ والإطار 4: الزيارات المنزلية، والإطار 5: الارتباط المهم بين صحة الوليد وصحة الأم في صفحة 6 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.2 مقدمة: مجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين

وضِّح مجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين التي سيستعملونها في عملهم. وفيما يلي القائمة التي اقترحها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط لمجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين (رهنًا بمواءمة كل بلد):

1. الكتاب القلاب للعاملين الصحيين المجتمعيين.
2. استمارات التسجيل للمواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.
3. استمارات التسجيل للأطفال من سن ستة أشهر حتى خمسة أعوام.
4. مذكرة الإحالة.
5. مقياس حرارة رقمي.
6. مقياس وزن محمول.
7. مؤقت.
8. سجل.



الوحدة الثالثة: مهارات التواصل

الجلسة 3: استخدام مهارات التواصل الجيد

مدة الجلسة
90 دقيقة

جهِّز

- ورقة من اللوح الورقي القلاب لتحديد الخطوات الأربع للتواصل وما يقابلها من مجموعة مهارات التواصل الجيد تحت كل منها.
- نسختين من الموقف 3 والموقف 4 بشأن التحقُّق من استيعاب الأم.
- دمية.
- أصبعين من الطباشير.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أساسيات مهارات التواصل الجيد؛
- ممارسة الخطوات الأربع للتواصل الجيد.

1.3 مقدمة: استخدام مهارات التواصُل الجيد

وضِّح للمشاركين أنهم بوصفهم مسؤولين عن تعزيز الصحة، سيقدمون المشورة إلى الأسر حول كيفية العناية بصحة أطفالها ونمائهم في المنزل. ويُقصَد بتقديم المشورة رفع درجة الوعي ونصح الآباء بشأن مختلف مكونات الرعاية لتحسين ممارساتهم في رعاية أطفالهم.

واسأل المشاركين هل سيشعرون بالرضا إذا تحدثوا مع شخص يُملي عليهم ما يجب أن يفعلوه دون سؤالهم عن رأيهم أو الاستماع لما يرغبون في قوله؟ ووضح أنه عندما لا يُظهر الأشخاص احترامًا لآراء الآخرين أو اهتمامًا بها، فهذا معناه أنهم لا يستخدمون مهارات التواصل الجيد.

وأضف أن المقصود باستخدام مهارات التواصل الجيد هو التحدث بطريقة تساعد على اكتساب ثقة الأفراد في المجتمع. ويعني ذلك ضمان أن المعلومات التي تُقدَّم إلى الأسر:

- تكون ذات صلة بوضع الأسرة؛
- تُقدَّم بطريقة يسهل فهمها واتباعها.

كما أن استخدام مهارات التواصل الجيد يضمن استماع الناس إليك وتقبل نصيحتك.

> يعتمد نجاح عملك على كيفية تواصلك بفعالية مع الأسر

اعرض الورقة التي أعددتها لتبين الخطوات الأربع للتواصل الجيد. واشرح للمشاركين أنه يجب عليهم أن يتبعوا أربع خطوات من أجل التواصل الجيد أثناء الزيارات المنزلية:

- إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة؛

- طرح الأسئلة والإنصات للإجابات؛ وفهم الوضع؛
- تقديم المعلومات ذات الصلة، وتقديم المساعدة العملية، عند الحاجة؛
- التحقُّق من الاستيعاب وحل المشكلات.

ووضح أن كل خطوة تتطلب مهارات مختلفة.

اذكر الخطوة الأولى، ووضح أنها تتمثل في إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة، وتتطلب من العاملين الصحيين المجتمعيين:

- التحلي بالود والاحترام؛
- شرح أسباب الزيارة؛
- التحدث بلطف ووضوح؛
- ستخدام اسم الطفل والأم، متى كان ذلك مناسبًا؛
- التحدث إلى جميع أفراد الأسرة المتواجدين، وليست الأم فقط.

وأكد للمشاركين أن الخطوة الأولى ضرورية، حتى ترحب الأسرة بالزيارة، وتوافق على وجود العامل الصحي المجتمعي، وتجيب عن الأسئلة وتفهم النصيحة المُقدَّمة.



2.3 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 6: لماذا تُعتبر مهارات التواصل الجيد ضرورية؟ والإطار 7: الخطوات الأربع للتواصل مع الأسر أثناء الزيارات المنزلية، في صفحة 7 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.3 عرض لعب الأدوار: استخدام مهارات التواصل الجيد؛ الخطوة الأولى: إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة

أخبر المشاركين أنهم سيشاهدون تدريبًا تمثيليًا بشأن الخطوة الأولى: إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة. اشرح أنك ستقوم مع الميسِّر المشارك بتقديم مشهد يزور فيه العامل الصحي المجتمعي أحد مقدمي الرعاية. وسيُمثل المشهد بطريقتين مختلفتين. ضع مقعدين أمام بعضهما البعض،

- أخبر المشاركين أنه سيُطلَب منهم التعليق على المشهدين، وتحديد الطريقة الجيدة لإلقاء التحية وبناء العلاقات الجيدة.
- ستمثل أنت دور العاملة الصحية المجتمعية، بينما يمثل الميسِّر المشارك دور مقدمة الرعاية.

الموقف 1

تطرق **العاملة الصحية المجتمعية** الباب، وتفتح لها سمرة.

العاملة الصحية المجتمعية: مرحبًا، هل أنتِ سمرة؟

الأم: أجل، مَن أنتِ؟

العاملة الصحية المجتمعية: أنا زكية، وقد أتيتُ لأرى ما هي مشاكل طفلكِ الجديد؟

زكية تقلب أوراقها وبطاقاتها

الأم: لا سمح الله! من أخبركِ أن طفلي لديه أي مشاكل؟

العاملة الصحية المجتمعية: أنا العاملة الصحية المجتمعية.

الأم: لا، شكرًا، لا حاجة لنا بكِ اليوم.

سمرة تغلق الباب.

الموقف 2

تطرق **العاملة الصحية المجتمعية** الباب، وتفتح لها سمرة. تنظر العاملة الصحية المجتمعية إلى سمرة، وتبتسم.

العاملة الصحية المجتمعية: أسعد الله صباحك يا سمرة. أنا زكية، العاملة الصحية المجتمعية بقريتنا. وأنا أعيش في المنزل الموجود في الشارع المجاور.

الأم: نعم، بالطبع أنا أعرفك وأعرف أسرتك. تفضلي بالدخول واجلسي.

تدخل **العاملة الصحية المجتمعية** وتجلس بجوار سمرة.

العاملة الصحية المجتمعية: شكرًا لكِ. كيف حالك؟ لقد سمعت أنكِ أنجبتِ طفلاً منذ ثلاثة أيام.

الأم: أجل، طفل ذكر.

العاملة الصحية المجتمعية: تهانينا! ما اسمه؟

الأم: أحمد

العاملة الصحية المجتمعية: عظيم! يتمثل جزء من مسؤوليتي في مساعدتك على رعاية أحمد، والتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.

الأم: عظيم! هذا توقيت جيد، فهو لا يرضع بشكل جيد.

العاملة الصحية المجتمعية: فعلاً! دعيني أرى إذا كان بإمكاني أن أساعد أحمد كي يرضع بصورة أفضل.

الأم: بالطبع، شكرًا لك.

اسأل المشاركين إذا كانوا يرون الموقف قد سار على ما يرام أم لا، ولماذا. وامنحهم بعض الوقت للتعليق، وتأكد من إدراكهم لمهارات التواصل المُستخدمة.

والفت انتباه المشاركين إلى أن العاملة الصحية المجتمعية في الموقف الثاني قد قدّمت نفسها بشكل جيد، وتحدثت بلطف مع مُقدمة الرعاية، وشرحت طبيعة عملها وسبب زيارتها للأسرة، كما أنها أبدت عنايةً واهتمامًا، واستخدمت اسمي الأم والطفل. أما في الموقف الأول، فهي لم تقدم نفسها بشكل جيد، ولم تتحدث بلطف مع الأم، ولم تُبدِ أي عناية أو اهتمام، بل إنها أخافت الأم عندما أخبرتها أنها قد جاءت للتعامل مع المشاكل دون وجود أي بيّنة على أن هناك مشاكل للتعامل معها في الأساس.

واختتم حديثك بالإشارة إلى أن العاملة الصحية المجتمعية في الموقف الأول لم تنجح في بناء علاقة جيدة مع الشخص القائم على رعاية الطفل.

4.3 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 8، الخطوة الأولى: إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة؛ في الصفحة 7 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

5.3 مناقشة جماعية: الخطوة الثانية: طرح الأسئلة والإنصات للإجابات. (فهم الوضع)

أشر إلى الخطوة الثانية الموضَّحة على اللوح الورقي القلاب، واشرح للمشاركين أن طرح الأسئلة والإنصات للإجابات لفهم الوضع يمثل الخطوة الثانية في التواصل الجيد.

اذكر للمشاركين مجموعة المهارات التي تشتمل عليها هذه الخطوة:

- طرح أسئلة مفتوحة؛

- الجلوس بجوار الشخص الذي تتحدث إليه أو أمامه؛
- النظر إلى الشخص، دون تشتت ودون الانشغال بشيء آخر؛
- عدم الاستعجال، وعدم التصرف وكأن الشخص على عَجَلة من أمره؛
- استخدام بعض الإشارات، مثل الإيماء بالرأس، أو الابتسام، أو قول "إممم" أو "نعم" لإظهار المتابعة لما تقوله الأم.

ووضح للمشاركين أن الأسئلة المفتوحة هي أسئلة لا تكون الإجابة عنها بمجرد (نعم) أو (لا)، ولكنها أسئلة تشجع مقدم الرعاية على تقديم تفاصيل عن الموقف. وستسمح الأسئلة المفتوحة لك بتقييم الموقف وتحديد المعلومات التي يجب تقديمها، بحيث تتأكد من تقديم المعلومات ذات الصلة. فلا يمكن أن تقدم المشورة دون فهم الوضع.

ومن خلال فهم الوضع، ستحدد الممارسات الجيدة، وستمدح الأم وتشجعها على تطبيقها، كما ستحدد الممارسات غير الجيدة التي يجب تغييرها بإعطاء المعلومات ذات الصلة.

وأكد للمشاركين على أن استمارات التسجيل التي سيتعلمون كيفية استخدامها تُعتبر أداةً ضرورية لتقييم الوضع في كل أسرة يزورونها.



6.3 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 9، الخطوة الثانية: طرح الأسئلة والإنصات للإجابات؛ وفهم الوضع؛ في صفحة 8 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



7.3 تمرين تحريري 1 وإبداء ملاحظات جماعية: الأسئلة المفتوحة

أخبر المشاركين أنك ستشرح الفرق بين الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. واطلب منهم أن يخبروك ما إذا كانت الأسئلة التالية مفتوحة أم مغلقة: اقرأ السؤال الأول:

- هل طفلكِ بخير؟

استمع إلى إجاباتهم، ثم قل إن هذا السؤال مُغلق نظرًا لأن الإجابة عنه ستكون بمجرد نعم أو لا.

ثم، اقرأ السؤال الثاني:

- كيف تنظفين الجزء المتبقي من الحبل السري للطفل؟

ستتضمن الإجابة عن السؤال الثاني شرح الأم لكيفية قيامها بتنظيف الجزء المتبقي من الحبل السري لطفلها. وبالتالي، يُعتبر هذا السؤال مفتوحًا. فهي تعطيك بعض المعلومات التي تساعدك على فهم الوضع.

اطلب من المشاركين فتح الصفحة 8 من دليل المشاركين، ووضح أنهم سيقومون بتمرين تحريري. وسيجد المشاركون قائمةً بأسئلة، وعليهم أن يضعوا علامة في المربع المجاور لكل سؤال ليوضحوا إذا كان السؤال مفتوحًا أم مغلقًا.

وعندما ينتهون من هذا التمرين، ناقش إجاباتهم عن كل سؤال.

اقرأ السؤال الأول - هل تُرضعين طفلك؟ - واسأل هل هذا سؤال مفتوح. اسأل كل مشارك، ثم وضح أنه ليس سؤالًا مفتوحًا لأن الإجابة عنه تكون بنعم أو لا.

اقرأ السؤال الثاني - كيف تُرضعين طفلك؟ - واطلب من كل مشارك أن يقول إذا كان هذا السؤال مفتوحًا أم مغلقًا ولماذا. ووضح أن هذا السؤال مفتوح لأنه يتضمن تقديم الأم تفاصيل عن كيفية قيامها بالرضاعة، بدلاً من مجرد الإجابة بنعم أو لا.

ثم، اقرأ السؤال الثالث: هل يرضع طفلك جيدًا؟ واطلب من كل مشارك أن يقول إذا كان هذا السؤال مفتوحًا أم مغلقًا ولماذا. ووضح أنه ليس سؤالًا مفتوحًا لأن الإجابة عنه تكون بنعم أو لا.

ثـم اقـرأ السـؤال الرابـع: كـم عـدد مـرات قيامـك بإرضـاع طفلـك؟ واطلـب مـن كل مشـارك أن يقـول إذا كان هـذا السـؤال مفتوحًـا أم مغلقًـا ولماذا. ووضـح أن هـذا السـؤال مفتـوح لأنـه يتضمـن تقديـم الأم تفاصيـل عـن عـدد مـرات قيامهـا بالرضاعـة، بـدلًا مـن مجـرد الإجابـة بنعـم أو لا.

ثـم اقـرأ السـؤال الخامـس: هـل تغسـلين يديـك قبـل إعـداد الطعـام؟ واطلـب مـن كل مشـارك أن يقـول إذا كان هـذا السـؤال مفتوحًـا أم مغلقًـا ولماذا. ووضـح أن هـذا السـؤال ليـس مفتوحًـا لأن الإجابـة عنـه تكـون بمجـرد نعـم أو لا.

ثـم، اقـرأ السـؤال السـادس: كيـف تُعدِّيـن الطعـام لطفلـك؟ واطلـب مـن كل مشـارك أن يقـول إذا كان هـذا السـؤال مفتوحًـا أم مغلقًـا ولماذا. ووضـح أن هـذا السـؤال مفتـوح لأنـه يتضمـن تقديـم الأم تفاصيـل عـن كيفيـة إعدادهـا الطعـام لطفلهـا، بـدلاً مـن مجـرد الإجابـة بنعـم أو لا.

ثـم اقـرأ السـؤال السـابع: هـل تـأكلين جيـدًا؟ واطلـب مـن كل مشـارك أن يقـول إذا كان هـذا السـؤال مفتوحًـا أم مغلقًـا ولماذا. ووضـح أنـه ليـس سـؤالًا مفتوحًـا لأن الإجابـة عنـه تكـون بنعـم أو لا.

وأخيرًا اقـرأ السـؤال الثامـن: كيـف تحمـمين طفلـك؟ واطلـب مـن كل مشـارك أن يقـول إذا كان هـذا السـؤال مفتوحًـا أم مغلقًـا ولماذا. ووضـح أن هـذا السـؤال مفتـوح لأنـه يتضمـن تقديـم الأم تفاصيـل عـن كيفيـة قيامهـا بتحميـم طفلهـا، بـدلاً مـن مجـرد الإجابـة بنعـم أو لا.

8.3 مناقشة جماعية: الخطوة الثالثة: تقديم المعلومات ذات الصلة.

يُعـتبر تقديـم المعلومـات ذات الصلـة هـو الخطـوة الثالثـة في التواصـل الجيـد. ضـع للمشـاركين قائمـة بمجموعـة المهـارات التـي تشـتمل عليهـا هـذه الخطـوة:

- تقبُّل ما تقوله الأم، وعدم انتقاده؛
- الثناء على الأم بشأن ما تقوم به بشكل صحيح لأطفالها؛
- تقديم القليل من المعلومات كل مرة، بما يتناسب مع وضع الأسرة. فتقديم قدر كبير من المعلومات مرةً واحدةً قد يتسبب في إرباك الأم.

ووضـح أن تقبـل مـا تعتقـده الأم وتقولـه لا يعنـي أنـك تتفـق معهـا: فأحيانًـا يكـون لـدى الأم/ مقـدم الرعايـة معلومـات خاطئـة أو ربمـا تكـون منزعجـة مـن شيء مـا ليـس خـطيرًا. وبالتـالي، مـن المهـم ألا تنتقدهـا أو تختلـف معهـا صراحـةً، كما أنـه مـن المهـم ألا توافـق على فكـرة أو ممارسـة خاطئـة. ويُقصَـد بالتقبُّـل هنـا الـرد بطريقـة حياديـة، دون إبـداء الموافقـة أو المعارضـة.

ناقش مع المشاركين المثال التالي:

يـزور أحـد العامـلين الصحـيين المجتمعـيين أمًـا تبـدو منزعجـة، وتقـول: "يـا إلهـي، أحمـد يعـاني مـن مشـكلة في الرضاعـة، فهـو لا يفعـل شـيئًا سـوى البـكاء فقـط، ولا أعـرف مـاذا أفعـل".

اسأل المشاركين أي من الإجابات التالية هي الأنسب:

1. "لا داعي للقلق، فطفلكِ بخير" (معارضة)

اسأل المشاركين عن رأيهم في هذه الإجابة. استمع لما يقولونه، ثم وضح أنه في حين يبدو أن العامل الصحي المجتمعي يحاول طمأنة الأم بأن طفلها بخير، إلا أنه في الواقع ليس لديه أدنى فكرة عن حالة الطفل. فالإجابة (1) تُعتبر مثالاً على الإجابة المعارضة. فالعامل الصحي المجتمعي في هذا الموقف يعارض مخاوف الأم، ولا يتقبل ما تقوله.

2. "أنتِ قلقة على أحمد، ألستِ كذلك؟" (تقبل)

اسأل المشاركين عن رأيهم في الإجابة (2). استمع لما يقولونه ثم وضح أن الإجابة (2) تُعتبر مثالاً على إجابة التقبل. فالعامل الصحي المجتمعي يتسم بالحيادية، ولا يوافق الأم أو يخالفها في الرأي، إنما يتقبل ما تعتقده الأم وتقوله.

3. "نعم، قد يكون الأمر خطيراً، لِمَ لم تذهبي إلى العيادة؟" (موافقة)

اسأل المشاركين عن رأيهم في الإجابة (3). استمع لما يقولونه ثم وضح أن الإجابة (3) تُعتبر مثالاً على إجابة الموافقة. فالعامل الصحي المجتمعي في هذا الموقف يتفق مع الأم، على الرغم من أنه لم يُقيِّم الموقف بعد. وستضاعف هذه الإجابة من مخاوف الأم، وسيكون ذلك دون داعٍ في أغلب الأحوال.

واشرح للمشاركين أن امتداحهم لما تقوم به الأم من شأنه أن يعزز من ثقتها بنفسها، ويعزز السلوك المرغوب، ويجعلها مستعدة لتقبل سلوك جديد. وأكد على أنه يمكن دائمًا إيجاد أمرٍ يستحق الثناء والمدح.

وأخبر المشاركين أنهم يستطيعون تحديد المعلومات التي سيقدمونها إلى الأسرة فقط بعد تقييم الموقف. فإذا كانت الأسرة:

- غير مدركة للممارسة الجيدة، قدِّم معلومات عن منافعها وكيفية تنفيذها؛
- مدركة للممارسة الجيدة ولكن لا تنفذها، شجعها على المحاولة وعلى تحديد أي مشكلة قد تحول دون قيامها بذلك؛
- تنفذ الممارسة الجيدة بالفعل، امدحها وشجعها على الحفاظ على هذه الممارسة.

وذكّر المشاركين أنه لا يجب عليهم تقديم معلومات أكثر من اللازم. وإذا كانت هناك مشكلات عديدة، رتبها حسب الأولوية، وأرجئ الأقل خطورة إلى الزيارة التالية.



9.3 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 10، الخطوة الثالثة: تقديم المعلومات ذات الصلة في صفحة 9 من دليل المشاركين.

وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



10.3 التمرين الكتابي 2 وتقديم تعقيبات فردية

اطلب من المشاركين فتح الصفحة 9 من دليل المشاركين. ووضح أن هذا التمرين يدور حول مهارة "تقبل ما تقوله/ تعتقده الأم، وعدم النقد"، واطلب من المشاركين وضع علامة في المربع المجاور للعبارة التي تتوافق مع مهارة "تقبل ما تقوله/ تعتقده الأم، وعدم النقد". وعندما ينتهون من التمرين، قم بتقديم تعقيبات فردية بالتعاون مع الميسِّر المشارك. وناقش الإجابات التي تتفق مع ما تقوله الأم في عبارتها الأولى، أو تعارضه، أو تتقبله.

وفيما يلي إجابات عن هذا التمرين.

1. "اللبن لديّ خفيف، فيجب أن أعطي طفلي لبنًا اصطناعيًا".

- لا، لبنك ليس خفيفًا مطلقًا. **معارضة**
- اللبن الخفيف مشكلة. **موافقة**
- إممم، أنتِ قلقة بشأن اللبن لديكِ! **تقبل**

2. "طفلي مريض، لقد أُصيب بالبرد. فأنفه مسدود ولا يستطيع الرضاعة. وهو يبكي طوال الوقت، ولا أعرف ما الذي يتعين علي فعله".

- أنتِ محقة، فالأنف المسدود يجعل الطفل يبكي. **موافقة**
- أنتِ قلقة بشأن طفلك، أليس كذلك! **تقبل**
- لا تبكي، فطفلك في صحة جيدة، وسيتحسن قريبًا. **معارضة**

3. "الطفل مصاب بالإسهال، وستضره الرضاعة".

- هل ترغبين في إيقاف الرضاعة فقط في الوقت الذي يعاني فيه الطفل من الإسهال؟ **موافقة**
- الرضاعة لن تزيد الإسهال. **معارضة**
- إممم...! **تقبل**

4. "لم أستطع أن أرضع طفلي لمدة يومين، والآن قد أصبح لبني فاسدًا".

- بعد يومين من التوقف عن الرضاعة، يتغير مذاق لبن الأم. **موافقة**
- لبن الأم لا يفسد مطلقًا. **معارضة**
- أنتِ قلقة بشأن مذاق اللبن الخاص بكِ، ألستِ كذلك! **تقبل**



11.3 مناقشة جماعية: الخطوة الرابعة: التحقق من استيعاب الأم وحل المشكلات

يُعتبر التحقق من استيعاب الأم وحل المشكلات هو الخطوة الرابعة في التواصل الجيد. ضع قائمة للمشاركين بالمهارات التي تشتمل عليها هذه الخطوة:

- اطرح أسئلة مفتوحة للتحقق من درجة الاستيعاب؛
- ناقش ما تعتزم الأسرة القيام به؛
- امدح الأسرة متى كان ذلك مناسبًا.

وضح أن استخدام الأسئلة المفتوحة للتحقق من الاستيعاب يسمح للأم بإعادة قول ما يجب عمله بأسلوبها الخاص، مما يسمح للعامل الصحي المجتمعي بتحديد مقدار النصائح التي تم استيعابها مما قيل. أما الأسئلة المغلقة، التي يمكن الإجابة عنها بمجرد نعم أو لا، فهي لا تسمح للعامل الصحي المجتمعي بتقييم مدى الاستيعاب الفعلي للأم.

وناقش ما تعتزم الأم والأسرة عمله. ويُعتبر هذا هو أهم جزء في عملية تقديم الإرشادات. فشجِّع الأسرة على الإفصاح عن مخاوفها أو مشاكلها، وحاول إيجاد حلول لها.

امدح الأسرة على استيعابها وخططها متى كان ذلك ملائمًا. وهذا من شأنه أن يعزز من ثقة الأسرة في قدرتها على تبني الممارسات الصحيحة والحفاظ عليها.

وأكِّد للمشاركين على أن المدح لا يجب أن يقتصر على خطوات مُحدَّدة من عملية التواصل. فيمكن، بل ويجب، التعبير عن المدح طوال عملية تقديم المشورة، متى كان ذلك مناسبًا.



12.3 عرض لعب الأدوار: استخدام مهارات التواصل الجيد

أخبر المشاركين أنه يتعين عليهم الآن مشاهدة موقفين بتركيز. ويجب أن يلاحظوا مهارات التواصل الجيد والسيئ التي استُخدمت في كل موقف. وعند انتهاء العرض، ناقش المهارات المُستخدَمة في كل موقف.

أخبر المشاركين أنك ستمثل دور العاملة الصحية المجتمعية، بينما سيمثل الميسِّر المشارك دور الحماة، وسيقع الاختيار على أحد المشاركين لتمثيل دور الأم.

بعد اختيار المشارك، أعطه نسخة من الموقف (3). أخبر المشارك بأنه سيقرأ دور الأم من النص. وأعطه دُمية لتكون بمثابة الطفلة.

الموقف 3

تزور العاملة الصحية المجتمعية ندى التي وضعت طفلتها منذ أسبوعين.

العاملة الصحية المجتمعية: صباح الخير ندى، كيف حالك اليوم؟

الأم: صباح الخير زكية. تفضلي بالجلوس.

العاملة الصحية المجتمعية: لقد أتيت لأرى إذا كنتِ تواجهين أي مشاكل.

الأم: لدي مشاكل مع حماتي. تقول إن لبني خفيف، وهذا سيضر بالطفلة. لذا يجب أن أتوقف عن الرضاعة. ولقد طلبت من زوجي رضا بالفعل أن يُحضر لبنًا اصطناعيًا. وأنا حزينة للغاية لأني لن أرضعها. ولكن في الوقت نفسه، لا أريد أن أضر طفلتي.

العاملة الصحية المجتمعية: ماذا! إنها مخطئة تمامًا. استدعيها، وسأخبرها أنها تعرِّض كل شيء للخطر.

ندى تستدعي حماتها التي تدخل.

العاملة الصحية المجتمعية: صباح الخير يا حاجّة، لماذا تختلقين مشاكل مع زوجة ابنك؟

الحماة: ماذا تقولين؟ هل اشتكتني؟ هي من يريد إيذاء حفيدتي. أنا قلقة حيال الطفلة. لبنها خفيف للغاية. ستتسبب في مقتل الطفلة.

العاملة الصحية المجتمعية: عم تتحدثين؟ لا يوجد ما يُسمى بلبن خفيف. أنتِ مخطئة. سأخبرك المعلومة الصحيحة.

الحماة: كيف تعرفين؟ أنتِ لم تري أي شيء. أنا أبلغ من العمر 60 عامًا، ولدي خبرة أكثر منكِ بكثير.

العاملة الصحية المجتمعية: المسألة لا علاقة لها بالعمر. دعيني أراها إذًا.

الحماة: بالطبع لا. لن أسمح لكِ. فهذا سيجلب الحظ السيئ للفتاة.

العاملة الصحية المجتمعية: أنا العاملة الصحية المجتمعية.

الحماة: حسنًا، ولكني أعرف أكثر بشأن هذه المسائل. وأنا أدرى بما تحتاجه حفيدتي. شكرًا جزيلًا لكِ، ولكن لدينا كثير من الأشياء يتعين علينا القيام بها. لسنا بحاجة إليكِ اليوم.

على اللوح الورقي القلاب، اكتب مهارات التواصل الجيد على اليسار، ومهارات التواصل السيئ على اليمين. ناقش مع المشاركين:

- مهارات التواصل الجيد؛
- مهارات التواصل السيئ؛
- نتيجة الزيارة.

اكتب على اللوح الورقي القلاب ما يقوله المشاركون تحت كل عنوان.

أعط المشارك المُختار نسخة من الموقف 4. ستقوم أنت والميسِّر والمشارك بتمثيل نفس الأدوار.

الموقف 4

تزور العاملة الصحية المجتمعية ندى التي وضعت طفلتها منذ أسبوعين.

العاملة الصحية المجتمعية: صباح الخير ندى، كيف حالك اليوم؟

الأم: صباح الخير زكية. تفضلي بالجلوس.

العاملة الصحية المجتمعية: لقد أتيت لرؤية ليلى. فكما تعرفين، أنا العاملة الصحية المجتمعية، وأنا هنا لأساعدك على الاعتناء بطفلتك.

الأم: نعم، عزيزتي. لقد أتيتِ في الوقت المناسب. لقد حاولت إرضاع ليلى، ولكن حماتي قالت إن لبني خفيف، وهذا سيضر الطفلة. ولقد طلبت من زوجي رضا بالفعل أن يُحضر لبنًا اصطناعيًا. وأنا حزينة للغاية لأني لن أرضعها. ولكن في الوقت نفسه، لا أريد أن أضر طفلتي.

العاملة الصحية المجتمعية: إذًا، حماتك قلقة بشأن الطفلة. فلنستدعها ونناقش الأمر معها.

ندى تستدعي حماتها التي تدخل.

العاملة الصحية المجتمعية: صباح الخير حاجّة أم رضا. كيف حالك اليوم؟ أنا زكية، العاملة الصحية المجتمعية بالقرية، وأنا أساعد الأسر على الاعتناء بأطفالها. ولقد أتيت لأتفقد حال ليلى.

الحماة: جيد! لست راضية عن صحة ليلى. فلبن أمها خفيف جدًا.

العاملة الصحية المجتمعية: لماذا تعتقدين أن اللبن خفيف؟

الحماة: لأن لونه ليس أبيض، ولكنه شفاف.

العاملة الصحية المجتمعية: ممم!. هل أستطيع أن أغسل يدي، من فضلك؟

العاملة الصحية المجتمعية تغسل يديها.

العاملة الصحية المجتمعية: هل تسمحين لي أن ألاحظ لبن ندى بينما تُرضع ليلى؟

ندى تأخذ الطفلة وتبدأ في إرضاعها. وتستأذنها العاملة الصحية المجتمعية بأن تعتصر ثديها قبل أن تبدأ الرضاعة، وترى أن اللبن شفاف.

الحماة: أرايتِ!

العاملة الصحية المجتمعية: نعم. ولكن من فضلكِ، هل يمكن أن نسمح لها بالاستمرار في الرضاعة؟

وبعد مرور بعض الوقت، تستأذن العاملة الصحية المجتمعية باعتصار الثدي مرة أخرى، ويكون اللبن ثخينًا وأبيض.

الحماة وندى: ياه!

العاملة الصحية المجتمعية: من الجيد ندى أنك واصلتي محاولة إرضاع طفلتك. فلقد ساعد ذلك على إدرار مزيدٍ من اللبن. كما تعرفين، فإن اللبن في بداية الرضاعة يكون شفافًا لأنه يحتوي على الماء وبعض العناصر المغذية. أما في نهاية الرضاعة، يصبح لونه أبيض لأنه يحتوي على دهون. ويجب منح الطفلة الوقت الكافي للرضاعة من كل ثدي. فانتظري حتى تتركه الطفلة من تلقاء نفسها. وبهذه الطريقة، تستفيد الطفلة من كلٍ من اللبن الشفاف واللبن الأبيض وتحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

الحماة: الآن فهمت لم كان اللبن شفافًا في البداية. شكرًا ابنتي.

العاملة الصحية المجتمعية: عظيم، حاجّة أم رضا. هل يمكن أن تخبريني الآن كيف ستدعمين ندى؟

الحماة: سأخبر ابني ألا يحضر لبنًا اصطناعيًا، وسأساعد ندى كي يكون لديها الوقت الكافي لإرضاع ليلى. كما سنهتم بتغذية ندى.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا عظيم. وأنت يا ندى، ماذا ستفعلين؟

الأم: سأدع ليلى ترضع حتى تترك الثدي من تلقاء نفسها. وبهذه الطريقة ستأخذ اللبن الشفاف والأبيض لأن كليهما مهم ومفيد.

العاملة الصحية المجتمعية: كلاكما يقوم بعمل جيد. فأنتما تعتنيان بليلى بشكل ممتاز.

على اللوح الورقي القلاب، اكتب مهارات التواصل الجيد على اليسار، ومهارات التواصل السيئ على اليمين. ناقش مع المشاركين:

- مهارات التواصل الجيد؛
- مهارات التواصل السيئ؛
- نتيجة الزيارة.

اكتب على اللوح الورقي القلاب ما يقوله المشاركون تحت كل عنوان.

في نهاية التدريبين التمثيليين، اسأل المشاركين أي من الموقفين يعكس مهارات التواصل الجيد ولماذا. استمع إلى تعليقاتهم.

ثم، لخص الجلسة بأن العاملة الصحية المجتمعية في الموقف الأول:

- لم تقدم نفسها في البداية، وعندما قدَّمت نفسها أخيرًا لم تتقبل الحماة ذلك الأمر؛
- بدأت الزيارة بطريقة سيئة، إذ أشارت أنها قد أتت لحل المشاكل في حين أنه لم يكن هناك أي دليل على وجود مشكلة ما.
- لم تتحدث بلطف؛
- لم تتقبل ما قالته الحماة، ولم تنجح في اكتساب ثقة الأسرة أو تقبُّلها لها، ولم تقدم أي معلومات ذات صلة. وقد أدى ذلك كله في النهاية إلى جدل بين العاملة الصحية المجتمعية والحماة، ولم تستطع العاملة أن تصل إلى أي شيء.

أما في الموقف الثاني، فإن **العاملة الصحية المجتمعية:**

- استخدمت جميع خطوات ومهارات التواصل الجيد؛
- ألقت التحية على الأم، وقدَّمت نفسها، وتقبلت طريقة تفكير الحماة، وتحدَّثت بلطف وأدب، واستمعت إلى المشكلة، وطرحت أسئلة مفتوحة لفهم الوضع بصورة أفضل؛
- أشركت الحماة في عملية اتخاذ القرار؛
- قدَّمت المعلومات ذات الصلة ودليلاً عليها، عندما طلبت من الأم اعتصار ثديها في بداية الرضاعة ونهايتها؛
- تحققت من فهم الأم؛
- أثنت على الأم والحماة في كل فرصة ممكنة.



13.3 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 11، "الخطوة الرابعة: التحقُّق من فهم الأم وحل المشكلات" في صفحة 10 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



14.3 لعبة.

لعبة التحرك خطوة إلى الأمام (1)

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون الآن لعبة التحرك خطوة إلى الأمام، وهي لعبة ستساعدهم على تذكُّر خطوات ومهارات التواصل الجيد.

استخدم أصبعًا من الطباشير لرسم خط البداية وخط النهاية. ويجب أن تكون المسافة بين الخطين أربع خطوات أو أكثر. قسّم المشاركين إلى فريقين، وأعط كل فرد رقمًا بين 1 و4. اطلب منهم أن يتذكروا أرقامهم. ثم، نادِ على أحد الأرقام، وليكن رقم 2 على سبيل المثال. فيبدأ الشخص الذي يحمل رقم 2 من كل فريق في التحرك تجاه خط البداية. وأخبرهما أنك ستسأل كل واحد منهما سؤالاً. وعلى المشارك الذي يجيب إجابة صحيحة أن يتحرك خطوة إلى الأمام. أما المشارك الذي يجيب إجابة خاطئة، فيرجع إلى الخلف، ويحاول باقي أفراد الفريق الإجابة عن السؤال حتى يصلوا إلى الإجابة

الصحيحة. واستمر في اللعبة حتى يصل أحد المشاركين إلى خط النهاية. وأعلن عن الفريق الفائز، واطلب من الفريق الآخر التصفيق له.

وفيما يلي الأسئلة والإجابات الخاصة بهذا التمرين:

السؤال 1: ما أهمية مهارات التواصل الجيد؟

الإجابة 1: مهارات التواصل الجيد:

- تزيد من احتمال إنصات الأسر لنا وقبول نصائحنا؛
- تساعد على كسب ثقة أفراد المجتمع؛
- تضمن أن تكون المعلومات المُقدَّمة إلى الأسر ذات صلة بوضع الأسرة ويسهل استيعابها، وأن تكون النصائح سهلة الاتباع.

السؤال 2: كم عدد الخطوات التي ستتبعها للتواصل مع الأسر؟

الإجابة 2: أربع خطوات

السؤال 3: ما هي الخطوة الأولى؟

الإجابة 3: إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة.

السؤال 4: ما هي المهارات اللازمة من أجل إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة؟

الإجابة 4:

- التحلي بالود والاحترام؛
- توضيح سبب الزيارة؛
- التحدث بلطف ووضوح؛
- استخدام اسمي الطفل والأم، متى كان ذلك ملائمًا؛
- التحدث إلى جميع أفراد الأسرة المتواجدين.

السؤال 5: ما أهمية إلقاء التحية وبناء علاقات جيدة؟

الإجابة 5: حتى ترحب الأسرة بالزيارة، وتجيب عن الأسئلة، وتتقبل النصائح.

السؤال 6: ما هي الخطوة الثانية؟

الإجابة 6: طرح الأسئلة والإنصات للإجابات؛ وفهم الوضع.

السؤال 7: ما هي المهارات اللازمة عند طرح الأسئلة والإنصات؟

الإجابة 7:

- طرح أسئلة مفتوحة؛
- الجلوس إلى جوار الشخص الذي تنصت إليه؛
- النظر إلى الشخص، وتجنب أن يبدو عليك التشتت؛
- عدم التسرع، أو الظهور بمظهر الشخص الذي يكون على عَجَلة من أمره؛
- استخدام بعض الإشارات، مثل الإيماء بالرأس، أو الابتسام، أو قول "إممم" أو "نعم" للدلالة على
- متابعة ما يُقال.

السؤال 8: ما المقصود بالسؤال المفتوح؟

الإجابة 8: هو السؤال الذي لا تكون الإجابة عنه بمجرد نعم أو لا.

السؤال 9: ما أهمية الأسئلة المفتوحة؟

الإجابة 9: تساعد العامل الصحي المجتمعي في تقييم الوضع. وتسمح للأم بإعطاء تفاصيل يمكن أن يستخدمها العامل الصحي المجتمعي لتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها.

السؤال 10: ما هي الخطوة الثالثة؟

الإجابة 10: تقديم المعلومات ذات الصلة.

السؤال 11: ما هي مهارات التواصل اللازمة لتقديم المعلومات ذات الصلة؟

الإجابة 11:

- تقبُّل ما تعتقده الأم أو تقوله وعدم نقده؛
- الثناء على الأم بشأن ما تقوم به بشكل صحيح لأطفالها؛
- تقديم القليل من المعلومات كل مرة، بما يتناسب مع وضع الأسرة والمرحلة التي وصلت إليها في تبني سلوك جديد.

السؤال 12: ما المقصود بتقبل ما تعتقده الأم أو تقوله؟

الإجابة 12: الالتزام بالحيادية. عدم الموافقة على ما يقال أو معارضته.

السؤال 13: ما أهمية الثناء؟

الإجابة 13: يساعد الثناء الأم أو أي شخص آخر يعتني بالطفل على اكتساب الثقة.

السؤال 14: ما هي الخطوة الرابعة؟

الإجابة 14: التحقق من فهم الأم وحل المشكلات.

السؤال 15: ما هي مهارات التواصل الجيد اللازمة للتحقق من فهم الأم؟

الإجابة 15:

- استخدام أسئلة مفتوحة للتحقق من الفهم؛
- مناقشة ما تعتزم الأسرة القيام به؛
- الثناء على الأسرة متى كان ذلك مناسبًا.

السؤال 16: ما أهمية التحقق من مدى فهم الأم؟

الإجابة 16: هذا أمر ضروري للتأكد أن الأم قد فهمت وأنك قد عالجت مخاوفها وقلقها.

الخلاصة:

تُعتبر الطريقة التي نتحدث بها وما نقوله ونفعله أمرًا مهمًا عند التعامل مع الأسر في المجتمع واكتساب ثقتها. وتذكر أن عملاءك هم أسرتك، وجيرانك، وأصدقاؤك.

الوحدة الرابعة

العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل





الجلسة 4
مقدمة

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- مقطع فيديو 1، غسل اليدين للعاملين الصحيين المجتمعيين
- مستلزمات غسل اليدين:
  - صابون
  - إبريق ماء
  - إناء كبير

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهموا ما المقصود بالمولود؛
- عرفوا أهمية العناية بالمواليد؛
- عرفوا أسباب الجمع بين العناية بصغار الرُّضَّع الذي تقل أعمارهم عن شهرين والعناية بالمواليد؛
- عرفوا مكونات العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل؛
- أدركوا أسباب وكيفية قيام العاملين الصحيين المجتمعيين بغسل أيديهم قبل لمس المولود؛
- تدربوا على غسل اليدين.

---

1. مناقشة جماعية: ما المقصود بالمولود؟

أخبر المشاركين أنهم سيكونون مسؤولين عن تقديم المشورة حول رعاية المواليد والأطفال حتى أقل من سن الخامسة في المنزل.

واسألهم ما المقصود بالمولود. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضِّح أن مصطلح المولود ينطبق على أول أربعة أسابيع من عُمر الطفل (أي 28 يومًا منذ الوضع).

2. مناقشة جماعية: ما هي أسباب الجمع بين العناية بصغار الرُّضَّع الذي تقل أعمارهم عن شهرين والعناية بالمواليد؟

وضح أن هذه الفئة العمرية تضم المواليد (0 - 28 يومًا) وصغار الرُّضَّع (شهر واحد وحتى شهرين؛ أي الذين لم يبلغوا شهرين من العمر بعد). ويتقاسم المواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين عددًا من الخصائص، أهمها ما يلي:
- يتسم كلاهما بالهشاشة، ويتقاسمان نفس علامات الخطورة التي تدل على المرض الشديد؛
- الطعام الأمثل بالنسبة لهما هو لبن الأم، ويُوصَى بالاقتصار على الرضاعة المطلقة في تغذيتهما.

وهناك تدخلات مُحدَّدة لرعاية الرُّضَّع في الأسبوع الأول من عمرهم:

- ملامسة جلد المولود لجلد الأم تساعد على الحفاظ على دِفء المواليد خلال الساعات الأولى من عمرهم؛
- البدء المبكر في الرضاعة؛
- العناية بالحبل السُّري (التي قد تمتد إلى الأسبوع الثاني من العمر)؛
- تحميم المولود باستخدام إسفنجة فاترة.

وبخلاف ذلك، تكون مكونات الرعاية هي تلك الخاصة بالأعمار المتبقية في هذه الفئة العمرية.

وأخبر المشاركين أن العاملين الصحيين المجتمعيين يجب أن يزوروا هذه الفئة العمرية ثلاث زيارات:

- الأولى، أثناء الوضع أو بعده مباشرة، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من العمر؛
- الثانية، بعد الوضع بثلاثة أيام؛
- الثالثة، عندما يبلغ الرضيع من العمر ستة أسابيع.

وأخبر المشاركين أن العناية بصحة ونماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين تشتمل على 10 مكونات:

1. تقديم المشورة حول الحفاظ على دِفء الطفل.
2. تقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة (في غضون ساعة واحدة من الولادة).
3. تقديم المشورة حول العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري.
4. تقديم المشورة حول ممارسات رعاية الأسرة المرتبطة بالمواليد والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.
5. تقديم المشورة حول الرضاعة.
6. تقديم المشورة حول النظافة الشخصية.
7. تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية.
8. تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء.
9. تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث.
10. تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والعنف، والإهمال.

وأضف إلى ذلك أنه أثناء الزيارة الأولى، سيقوم العاملون الصحيون المجتمعيون بتقييم الوضع باستخدام استمارة التسجيل (التي سيتعلم المشاركون لاحقًا كيفية استخدامها) وتقديم المشورة وَفقًا لذلك. كما يجب ترتيب تقديم المشورة حسب الأولوية. فأخبر المشاركين أنهم غير مضطرين لتقديم المشورة حول جميع مكونات الرعاية، لتجنب إرباك الأم. ولكن عليهم ترتيب الأولويات حسب الوضع. ويشمل ذلك التحقق من علامات الخطورة، والحفاظ على دِفء الطفل، والبدء المبكر في الرضاعة، والعناية بالحبل السُّري، وتقديم المشورة حول تحميم المولود أثناء الزيارة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم العاملون الصحيون المجتمعيون مشورة بشأن رعاية صحة الأم بعد الوضع (انظر الفصل 9). ويجب أيضًا إعطاء الأولوية لهذا الأمر.

فأثناء الزيارة الثانية، سيتحقق العاملون الصحيون المجتمعيون من اتباع الأسرة للنصائح التي قُدمت أثناء الزيارة الأولى بشكل صحيح. ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين تقديم معلومات إضافية، حسب تقييمهم للوضع.

وأثناء الزيارة الثالثة، سيتحقق العاملون الصحيون المجتمعيون من اتباع الأسرة للنصائح التي قُدمت أثناء الزيارة الثانية بشكل صحيح قبل تقييم الوضع الحالي، وتقديم المشورة وَفقًا لذلك.

اسأل المشاركين عن أسباب ضرورة زيارة المواليد أثناء الوضع أو بعده مباشرةً. استمع إلى إجاباتهم، ثم لخص كما يلي:

- يتسم المواليد بالهشاشة، ويمكن أن يلقوا حتفهم بسهولة.

- من بين كل 100 وفاة للأطفال دون سن الخامسة، يكون 40 طفلاً منهم من المواليد (يمكن تعديل الرقم وفقًا للإحصاءات الوطنية).
- تحدث معظم وَفَيَات المواليد خلال السبعة أيام الأولى من عمرهم.
- طريقة معاملة هؤلاء الأطفال –سواءً بالعناية بهم أو إهمالهم– تضع الأساس لصحتهم البدنية، والنفسية ورفاهتهم أثناء مرحلة الطفولة ووصولاً إلى مرحلة البلوغ.

يجب أن يقوم العاملون الصحيون المجتمعيون بزيارتين للمواليد: ويُفضل أن تكونا أثناء الوضع (أو بعده مباشرةً) وفي اليوم الثالث بعد الوضع، وزيارة واحدة للرضيع الصغير الذي يقل عمره عن شهرين، في عُمر الستة أسابيع.



3. قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 12، "لماذا يحتاج المواليد إلى عناية خاصة؟" في صفحة 12، والإطار 13 "مكونات العناية بصحة ونماء المواليد والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين في المنزل"، في صفحة 12 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



4. مناقشة جماعية: التخطيط لإجراء زيارة أثناء الوضع أو بعده مباشرةً

أكّد للمشاركين على أن الأيام القليلة الأولى من عُمر المواليد تُعتبر ذات أهمية بالغة. وبوصفهم عاملين صحيين مجتمعيين، فيجب عليهم جمع معلومات عن النساء الحوامل في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية والتاريخ المتوقع للوضع. كما يجب أن يخططوا لزيارة المولود أثناء الوضع، أو بعده مباشرةً. ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين التنسيق مع القابلة لحضور الوضع والتواجد للمساعدة في تقديم الرعاية بمجرد ولادة الطفل. وأثناء الزيارات للنساء الحوامل، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن يشرحوا للأسر أهمية زيارة المولود والأم، بحيث يمكن البدء فورًا في تقديم مكونات الرعاية.

حدد النساء الحوامل في المنطقة المستهدفة بالخدمات الطبية، وخطط لإجراء زيارة أثناء الوضع، أو بعده مباشرةً.



5. مناقشات جماعية: غسل اليدين

أخبر المشاركين بأنه يجب عليهم دائمًا غسل أيديهم جيدًا قبل لمس الطفل. واسألهم عن سبب أهمية هذه الخطوة، واستمع إلى إجاباتهم، ثم أكد على ما يلي:

- يسهل إصابة المواليد بالعدوى مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا والبالغين؛
- قد تكون العدوى خطيرة في المواليد؛
- ُعتبر غسل اليدين جيدًا بصورة متكررة أحد أهم الطرق الفعالة للوقاية من العدوى.

تذكر في كل مرة أن تغسل يديك بالماء والصابون قبل لمس الطفل.

مـن الضروري دائمًـا أن يغسـل العاملـون الصحيـون المجتمعيـون أيديهـم قبـل لمـس الطفـل لتجنـب إصابتـه بالجراثيـم والعـدوى. اطلـب مـن المشـاركين الرجـوع إلى الإطـار 14، غسـل اليديـن للعامـلين الصحـيين المجتمعـيين قبـل لمـس المولـود، في صفحـة 13 مـن دليـل المشـاركين.

وسـلِّط الضـوء على أن العامـلين الصحـيين المجتمعـيين لديهـم طريقـة خاصـة لغسـل اليديـن تختلـف عـن طريقـة غسـل اليديـن التـي تُعلَّـم للأسرة لتجنُّـب جلـب الجراثيـم مـن خـارج المنـزل.

اقـرأ على المشـاركين الخطـوات التـي يجـب على العامـلين الصحـيين المجتمعـيين اتباعهـا عنـد غسـل اليديـن، واشرح كل خُطـوة بالاسـتعانة بالرسـومات التوضيحيـة.

وأكـد على الملحوظـة المكتوبـة في نهايـة الإطـار 14؛ والتـي تُـشير إلى أن هـذه الطريقـة خاصـة بالعامـلين الصحـيين المجتمعـيين فقـط.



6. عرض توضيحي عملي: غسل اليدين للعاملين الصحيين المحتمعيين قبل لمس الطفل

ستحتاج لتنفيذ هذا العرض التوضيحي إلى ما يلي:

- إبريق ماء
- صابون
- إناء كبير

اطلـب مـن المشـاركين صـب الماء عندمـا تطلـب منهـم ذلـك. واعـرض بصـورة عمليـة كيفيـة غسـل اليديـن أثنـاء الحديـث مـع المشـاركين في كل خطـوة.



7. فيديو توضيحي

جهز مقطع الفيديو 1: غسل اليدين للعاملين الصحيين المجتمعيين (01:52 دقيقة)

أخبر المشـاركين بـأن يسـتعدوا لمشـاهدة مقطـع فيديـو حـول غسـل اليديـن للعامـلين الصحـيين المجتمعـيين. اعـرض مقطـع الفيديـو 1، غسـل اليديـن للعامـلين الصحـيين المجتمعـيين.

بعـد مشـاهدة المشـاركين لمقطـع الفيديـو، أجـب عـن الأسـئلة التـي قـد تكـون لديهـم، وكـرر عـرض الفيديـو إذا كان ذلـك ضروريًـا.



8. ممارسة غسل اليدين

جهِّز مستلزمات غسل اليدين.

اطلـب مـن كل فـرد مـن المشـاركين غسـل يديـه، مـع الرجـوع إلى دليـل المشـاركين عنـد الاقتضـاء. لاحـظ أداءهـم، واطلـب مـن باقـي المشـاركين التعليـق على الخطـوات التـي يتبعونهـا.



الجلسة 5:
المكون 1: تقديم المشورة حول الحفاظ على دفء المواليد

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز

- 15 نسخة لكل مشارك من استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.
- كتابًا قلابًا لكل مشارك
- استمارة تسجيل مُكبّرة
- أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 2، الحفاظ على دِفء الطفل، ومقطع الفيديو 3، ملامسة جلد الأم لجلد الطفل
- جهاز عرض البيانات (DATA SHOW)
- حاسوبًا محمولاً
- شاشة
- دمية
- فستانًا للدمية
- غطاء للرأس وجوارب للدمية
- منشفة
- صابونًا لغسل اليدين
- إبريقَ ماء
- إناءً كبيرًا

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على أدوات تسجيل المعلومات ذات الصلة وتقديمها: استمارة التسجيل والكتاب القلاب؛
- إدراك أهمية الحفاظ على دِفء الطفل؛
- فهم المقصود بالحفاظ على دِفء الطفل.

1.1.4 عرض توضيحي. استمارة التسجيل والكتاب القلاب

استمارة التسجيل:

وزع استمارات التسجيل الخاصة بالمواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن أقل من ستة أشهر.

أخبر المشاركين أن استمارة التسجيل هي الأداة التي ستساعدهم على تسجيل المعلومات وفهم الوضع.

ضع النسخة المُكبرة لاستمارة التسجيل حيث يمكن رؤيتها. واشرح للمشاركين أن هذه الاستمارة واحدة من اثنتين سيستخدمونهما - والثانية ستكون للأطفال الأكبر سنًا - لمساعدتهم على تسجيل المعلومات التي سيحتاجونها لتقييم وضع الأسرة بدقة.

- الاستمارة على ورقة من وجهين.
- يُخصَّص الجزء العلوي على الوجه الأمامي للورقة للمعلومات العامة، مثل: اسم الطفل، وسنه، واسم الأم، وتاريخ الميلاد، واسم العامل الصحي المجتمعي، واسم القرية، إلى ما غير ذلك.
- أما الصف الذي يليه، فهو للتذكرة بإلقاء التحية، وتقديم نفسك، وتوضيح الغرض من الزيارة. كما يُذكرك أيضًا بإشراك جميع أفراد الأسرة المتواجدين. ثم يوجهك للسؤال عن أحوال الطفل. وتحتوي الاستمارة على مساحة لكتابة إجابات الأم عند سؤالها عن أحوال الطفل.
- تحت هذا الصف، تنقسم الاستمارة إلى عمودين. ويُخصص العمود الموجود على اليسار من أجل "فهم الوضع"، كما يسرد الأسئلة التي يجب على العامل الصحي المجتمعي أن يطرحها، وتوجد مساحة لتسجيل الإجابات والملاحظات. أما العمود الموجود على اليمين، فهو عن "ملاحظة الممارسات"، حيث يمكن تسجيل ملاحظات أكثر تفصيلاً عن الرضاعة، ووضعية الطفل، والتقام الطفل لثدي أمه.
- يُعنى كل صف بفهم الوضع، فيما يتعلق بمكون مُحدد من مكونات رعاية المواليد والرضّع حتى سن أقل من ستة أشهر. وتحدَّث مع المشاركين أثناء الاطلاع على الاستمارة لتوضح لهم الصفوف الخاصة بالمكونات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يُعنى الصف الأول بالمخاوف المتعلقة بالحفاظ على دِفء المواليد وصغار الرضّع، بينما يُعنى الصف الذي يليه بتحري علامات الخطورة، وما إلى ذلك.
- املأ استمارة التسجيل بوضع علامة في المربع المجاور للسؤال، أو إدراج المعلومات المطلوبة على السطر المُنقط.
- سيتعلم المشاركون كيفية ملء استمارة التسجيل خطوةً بخطوة.

الكتاب القلاب:

وزع الكتاب القلاب وأخبر المشاركين أنهم سيستخدمونه على مدار التدريب ولأغراض الزيارات المنزلية. ووضح لهم أن هذا الكتاب هو إحدى أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين، ويقدم معلومات حول مجموعة متنوعة من المواقف.

- يُقسَّم الكتاب القلاب إلى ستة فصول، بحيث يوجد فصل لكل فئة عمرية، وواحد عن صحة الأمهات. وتوجد علامات في جانب الكتاب لتمييز الفصول. (اعرض على المشاركين العلامة أثناء حديثك).
- تُقسَّم كل فئة عمرية إلى أقسام فرعية حول مكونات الرعاية. وتوجد علامات في جانب الكتاب لتمييز الأقسام الفرعية (اعرض العلامات أثناء شرحك).

أرهم العلامات الخاصة بالمكونات العشرة للرعاية لهذه الفئة العمرية.

ووضح لهم أن الكتاب القلاب يضم صفحات تشتمل على رسومات توضيحية ، وأخرى تتضمن نصائح مكتوبة. وعند استخدام الكتاب أثناء الزيارات المنزلية، يجب أن تكون الرسومات التوضيحية مواجهة للأم (أو أي مقدم رعاية آخر)، بينما يجب أن يكون النص المكتوب مواجهًا للعامل الصحي المحتمعي. ويتضمن النص المكتوب النصائح المتوافقة مع الرسومات التوضيحية الموجودة في الصفحة السابقة.

وتتضمن بعض الصفحات إطارًا أحمر به تعليمات للعامل الصحي المحتمعي ليضعها في الاعتبار أثناء تقديم المشورة حول مكون مُحدَّد (أرهم الإطار في صفحة 7 من الكتاب القلاب، واشرح ما ورد به).

اطلب من المشاركين فتح القسم الخاص بالمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، باستخدام العلامة الموجودة في جانب الكتاب القلاب.

ثم اطلب من المشاركين الرجوع إلى القسم الخاص بالحفاظ على دِفء المواليد في الفصل الذي يدور حول رعاية المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، وأخبرهم أنهم سيناقشون هذا المحتوى خلال هذه الجلسة.

2.1.4 مناقشة جماعية: الحفاظ على دِفء الطفل

أخبر المشاركين أن المكون الأول من رعاية المواليد في المنزل هو الحفاظ على دِفء المواليد.

ووضح لهم أن الأم، أثناء الحمل، تحافظ على درجة حرارة طفلها. وبعد الولادة مباشرةً، يشعر المواليد بالبرد بسهولة عند التعرض لدرجات حرارة أبرد من درجة الحرارة داخل الرحم. ولا يستطيع المواليد ضبط درجة حرارة أجسامهم مثل البالغين والأطفال الأكبر سنًا، لأنهم لم يكتسبوا هذه القدرة بعد. وإذا لم يتم الحفاظ على دِفء المواليد –خاصة في الأسابيع الأولى من العمر– فقد يُصابون بالبرد، ولن يتمكنوا من الرَّضاعة بشكل جيد، وسيُصبحون أكثر عُرضة للإصابة بالمرض. وقد يؤدي عدم الحفاظ على دِفء المواليد إلى وفاتهم

لخص بأن الحفاظ على دفء المواليد، خاصة خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى يُعتبر من التدابير المُنقذة للحياة.

كيف يمكن أن يساعد العاملون الصحيون المجتمعيون الأم على الحفاظ على دِفء الطفل عندما تكون الزيارة الأولى أثناء الوضع أو بعده مباشرةً؟

- جففي الطفل بعد الولادة مباشرةً، وأبعدي المناشف المبللة عنه، ودَفِّئي الغرفة التي جرت بها عملية الوضع. وضعي الطفل على بطن الأم مباشرةً.
- تكون أفضل طريقة للحفاظ على دِفء الطفل في الأربع والعشرين ساعة الأولى من خلال ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. ويُعتبر جسم الأم أفضل من أي جهاز تدفئة صناعية.
- ألبسي الطفل غطاءً للرأس وجوارب.
- ضعي الطفل على ثدي أمه بمجرد أن يكون كلاهما مستعدًا لبدء الرضاعة. ويكون ذلك عادةً خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

وإذا كانت الزيارة بعد ساعات قليلة من الولادة، تحققي مما إذا كان الطفل في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل أم لا. وإذا لم يكن كذلك، انصحي الأم وساعديها.

ويجب عدم الفصل بين الأم والطفل، إذ يجب أن يظلا في نفس الغرفة 24 ساعةً في اليوم. وتجنب تحميم الطفل خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى بعد الوضع، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى إصابته بالبرد والمرض.

وبعد مرور الأربع والعشرين ساعة الأولى، يُوصى بإلباس الطفل ملابس مناسبة لدرجة حرارة الغرفة. ويشمل ذلك ارتداء طبقة واحدة أو طبقتين أكثر مما يرتديه البالغون، وغطاء للرأس. ويجب تجنب إضافة طبقات من الملابس أكثر من اللازم، والإفراط في لف الطفل بهذه الطبقات.

علّمي الأم أن تتحقق من درجة حرارة طفلها من خلال لمس قدمه.

3.1.4 فيديو توضيحي: مقطع الفيديو 2: الحفاظ على دِفء المواليد

جهز مقطع الفيديو 2. الحفاظ على دِفء المواليد (04:36 دقيقة)

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول الحفاظ على دِفء المواليد. اعرض مقطع الفيديو، وفي نهايته أجب عن أي أسئلة.

ملاحظة للميسِّر: يجب أن يرتدي العامل الصحي المجتمعي قفازات معقمة أثناء مساعدة الأم في الحفاظ على دِفء الطفل.

4.1.4 عرض لعب الأدوار: قدِّم مشورة للأم حول أهمية الحفاظ على دِفء المولود

ستحتاج إلى ما يلي:

- الكتاب القلاب
- دُمية دون ملابس
- استمارة تسجيل للمواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر
- استمارة تسجيل مُكبّرة

عَلِّق استمارة التسجيل المُكبّرة.

أخبر المشاركين أنهم سيشاهدون تدريبًا تمثيليًا حول كيفية استخدام استمارة التسجيل من أجل "فهم الوضع" الخاص بكيفية "الحفاظ على دِفء المواليد"، واستخدام الكتاب القلاب لتقديم مشورة للأمهات بشأن أهمية الحفاظ على دِفء المواليد.

وأكد على ضرورة أن يتذكروا دائمًا أهمية مهارات التواصل الجيد عند تقديم مشورة للأمهات.

واطلب من المشاركين الاطلاع على استمارة التسجيل الخاصة بالمواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر في الصفحتين 14 و15 من دليل المشاركين، وإيجاد الصف المعْني بالحفاظ على دِفء المواليد.

استعرِض الصف الأول، ووضح للمشاركين أنه يجب عليهم أولاً أن يطرحوا الأسئلة الواردة في العمود الموجود على اليسار، ثم انتقل إلى استعراض العمود الخاص بالجانب العملي الموجود على اليمين، وضع علامة على الإجابة المُقدَّمة أو الممارسة المُتبعة. وإذا كانت الأم تحافظ على دِفء الطفل بطريقة صحيحة، امدحها وانتقل إلى الصف التالي. أما إذا كان أداؤها سيئًا، أو اكتشفت أن الأم لا تعرف أسباب أو كيفية الحفاظ على دِفء الطفل، استعن بالكتاب القلاب لتقديم المشورة لها ولباقي أفراد الأسرة.

ارفع الكتاب القلاب عاليًا، وذكِّر المشاركين بما يلي:

- الكتاب مُقسَّم إلى أقسام تتناسب كل منها مع فئة عمرية معينة؛
- يُقسَّم كل قسم في الكتاب إلى أقسام فرعية حول مكونات مُحددة للرعاية؛
- يجب أن تكون الصفحة التي تحتوي على النص المكتوب مواجهةً للعامل الصحي المجتمعي، بحيث يستطيع التحقق من الرسائل، بينما يجب أن تكون الصفحة التي تحتوي على رسومات توضيحية مواجهة للأم.

اطلب من المشاركين فتح صفحة 6 من الكتاب القلاب، قسم الحفاظ على دِفء المواليد. ووضح لهم أن الصفحة 6 تشتمل على رسومات توضيحية للحفاظ على دِفء المواليد، بينما تشتمل الصفحة 7 على النصائح المتوافقة معها.

وأكد على وجود الإطار الأحمر في أعلى يمين الصفحة 7. ووضح لهم أن هذا الإطار يُذكّر العاملين الصحيين المجتمعيين بما يجب عليهم القيام به للحفاظ على دِفء المولود.

ضع الكتاب القلاب على الطاولة أمامك، بحيث تكون الصفحة 7 التي تشتمل على النصائح المكتوبة مواجهة لك، بينما الصفحة 6 التي تشتمل على الرسومات التوضيحية مواجهة للمشاركين.

أحضر مقعدين، واطلب من أحد المشاركين الجلوس أمامك وتمثيل دور الأم.

واطلب من المشارك الذي يمثل دور الأم حمل الدمية التي لا ترتدي ملابس، وأخبر المشاركين أنك ستستخدم استمارة التسجيل لفهم/ تقييم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة. وبعد ذلك، ستقدم مساعدة عملية.

صف المشهد: أنت تزور الأم بعد الولادة مباشرة. وأخبر المشاركين أنك ستتبع استمارة التسجيل صفًا صفًا، بدءًا من الحفاظ على دِفء المواليد.

أولًا، اقرأ البنود الواردة في عمود الملاحظة. الطفل دون ملابس. واسألهم عن المربع الذي ستضع فيه علامة. استمع إلى ما سيقوله المشاركون، ثم أخبرهم أنك ستضع علامة في المربع المجاور لعبارة "دون ملابس".

ثم انتقل إلى عمود "فهم الوضع"، واسألهم عن المربع الذي ستضع فيه علامة. استمع إلى ما سيقوله المشاركون، ثم أخبرهم أنك ستضع علامة في المربع المجاور لكلمة "لا".

واذكر في النهاية أن هذه الأم بحاجة إلى مشورة بشأن الحفاظ على دِفء المولود.

وباستخدام الكتاب القلاب، اشرح للأم كيفية الحفاظ على دِفء الطفل. وأشر إلى الرسم التوضيحي الأول على اليسار، واسأل الأم عما فهمته من الرسم. استمع إلى الأم واشرح الرسم التوضيحي، حسب النصيحة المكتوبة أمامك. واشرح أولاً أسباب أهمية الحفاظ على دِفء الطفل، إلى أن تصل إلى النقطة المتعلقة بملامسة جلد الأم لجلد الطفل. واعرض الرسومات التوضيحية، وأشر إلى أنها توضح كيف يجب أن تحمل الأم طفلها للحفاظ على دفئه. وتابع النصائح المكتوبة في الكتاب القلاب.

وتحقق من فهم الأم من خلال طرح الأسئلة التالية.

- ما أهمية الحفاظ على دِفء المولود؟
- ما هي أفضل طريقة للحفاظ على دِفء المولود؟
- متي يجب أن تقوم بتحميم الطفل؟ ولماذا؟

وأكد في النهاية على ضرورة استخدام مهارات التواصل الجيد عند تقديم المشورة، والمعلومات، والدعم والتحقُّق من الفهم.

وعند الانتهاء من تمثيل الأدوار، توجه إلى استمارة التسجيل المُكبرة، ووضح كيفية ملئها في إطار هذا التدريب.



5.1.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 6 و7 من الكتاب القلاب. ناقش الإطار الأحمر في الصفحة 7الذي يشتمل على تعليمات للعاملين الصحيين المجتمعيين أثناء الزيارات المنزلية. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



6.1.4 التمرين الكتابي 3، تقديم تعقيبات فردية: استخدام استمارة التسجيل لفهم الوضع الخاص بالحفاظ على دِفء الطفل

أخبر المشاركين أنهم سيتدربون على ملء الجزء المتعلق بالحفاظ على دِفء المواليد في استمارة التسجيل. واطلب منهم الإشارة إلى القسم ذي الصلة في استمارة التسجيل في الصفحة 16 من دليل المشاركين.

ووضح أن الصفحة 16 تشتمل على الجزء العلوي من استمارة التسجيل والصف المقابل للحفاظ على دِفء الطفل.

وعلى المشاركين أن يقرؤوا العبارة الموجودة أعلى استمارة التسجيل، ويملؤوا استمارة التسجيل وَفقًا لذلك. وعندما ينتهون، قدم تعقيبات فردية.

وفيما يلي إجابة هذا التمرين:

استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن ستة أشهر		
تاريخ الزيارة: **(تاريخ اليوم)** اسم العامل الصحي المجتمعي: **(اسمك)** القرية: **السلام** اسم الطفل: **أحمد** السن: **وُلد للتو** تاريخ الميلاد: **تاريخ اليوم** اسم الأم: **حسناء** وزن المولود عند الميلاد: .... درجة حرارة المولود:		
ألقِ التحية على مُقدم/ مُقدمة الرعاية وقدِّم نفسك ووضح الغرض من الزيارة. اسأل: كيف حال الطفل؟ ... بخير..... (دوّن ما تقوله الأم) **وقدّم المشورة في وجود أفراد الأسرة الآخرين**		
فهم الوضع		**لاحظ الممارسة**
1. بالنسبة للمواليد: اسأل عما إذا كان الطفل دافئًا أم لا وانظر لتتحقق بنفسك: نعم ☐ لا ☑ قدِّم المشورة والمساعدة **إذا كانت الإجابة بنعم**، على نحو صحيح ☐، امدح الأم إذا لم تكن صحيحة (مثل: الإفراط في لف الطفل)☑، قدّم المشورة والمساعدة		☐ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل ☐ ارتداء الملابس بشكل سليم ☐ الإفراط في لف الطفل ☑ يرتدي ملابس خفيفة ☐ لا يرتدي ملابسه

7.1.4 مناقشة جماعية: الرعاية عن طريق ملامسة جلد الأم لجلد الطفل

اطلب من المشاركين الرجوع مرةً أخرى إلى الصفحة 6 من الكتاب القلاب للاطلاع على الرسومات التوضيحية الخاصة بملامسة جلد الأم لجلد الطفل. ووضح أن لوضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل فوائد عديدة، فهي:

- تُخفف من صعوبة المرحلة الانتقالية للطفل من الرحم.
- تساعد المواليد على الارتباط بأمهم.
- تحافظ على استقرار درجة حرارتهم.
- تساعد في الحد من بكاء الأطفال لشعورهم بالحماية والأمن اللذين توفرهما الأم.
- تساعد على بدء الرضاعة عندما يوضع الطفل على بطن الأم بعد الولادة مباشرةً. ويستطيع المولود أن يجد ثدي أمه بنفسه، وأن يقرر متى يبدأ الرَّضعة الأولى. ويمكن أن تساعد الغرائز الطبيعية المنتبهة للطفل على أن يقوم بتحديد مكان ثدي الأم، والتعلق به وبدء الرضاعة، شريطةً أن يكون ملامسًا بشكل وثيق لأمه.

معلومات إضافية للميسِّرين

وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل

- تُحسّن وظائف القلب والرئة. فعندما يولد الأطفال، يمرون بمرحلة انتقالية هائلة، إذ يستعدون لالتقاط أنفاسهم الأولى من الهواء خارج الرحم. وتساعدهم ملامسة جلد الأم لجلد الطفل على التكيف مع الوضع الجديد، ربما لأن نمط صوت ضربات قلب الأم وتنفسها يكون مألوفًا للطفل بعد الفترة التي أمضاها في الرحم.
- تحافظ أيضًا على استقرار معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستوى السكر في الدم. ويستخدم الأطفال سكر الدم للحصول على الطاقة. فقبل الولادة، يحصل الأطفال على الجلوكوز من خلال المشيمة. وبعد الولادة، يحصلون عليه من الأم. وإذا زادت احتياجات الطفل عما يحصل عليه من لبن الأم، فإن الرعاية عن طريق ملامسة جلد الأم لجلد الطفل في الساعات التالية للوضع من شأنها أن تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم لدى الطفل.

وبعد تقديم المشورة حول أهمية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، أشِر إلى الرسومات الموجود في الكتاب القلاب لمساعدة الأم على جعل طفلها في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل.

- انزع ملابس الطفل عنه، باستثناء الحفاض وغطاء الرأس والجَوْرَبين.

- ضع الطفل في وضع مستقيم بين ثدي الأم، على أن يلامس صدر الطفل الأم.
- ضع الطفل على ضلوع الأم، وأدر رأسه إلى أحد الجانبين.
- ثبّت الطفل بقميص أو قطعة قماش مربوطة حول الأم والطفل.
- ثم، يمكن للأم أن ترتدي قميصًا، أو سترة، أو شالاً إذا أرادت ذلك.

وأكد على أنه لا يجب لف الطفل بطبقات كثيرة من الملابس.



8.1.4 فيديو توضيحي: مقطع الفيديو 3، ملامسة جلد الأم لجلد الطفل

جهز ما يلي: أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 3 (5:42 دقيقة). ملامسة جلد الأم لجلد الطفل وطرق لف الطفل المختلفة.

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول كيفية مساعدة الأمهات على جعل الطفل في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، والطرق المختلفة للف الطفل.

اعرض مقطع الفيديو 3، والفت الانتباه إلى أهم النقاط. وكرر عرض الفيديو، إذا كان ذلك ضروريًا.



9.1.4 عرض توضيحي عملي؛ كيفية مساعدة الأم على تنفيذ وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل

ستحتاج إلى ما يلي:

- دمية
- غطاء للرأس
- جَوْرَبين
- حفاض
- قطعة كبيرة من القماش لربطها حول الأم
- سترة أو قميص
- لكتاب القلاب

اطلب من أحد المشاركين تمثيل دور الأم، ووضح للمجموعة أنك ستعرض كيفية مساعدة الأم فيما يتعلق بالرعاية عن طريق ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. ويجب عليهم أن يشاهدوا العرض وينصتوا إليه جيدًا، إذ سيُطلَب منهم مناقشة أداء زميلهم في النهاية. واستخدم الكتاب القلاب لشرح طريقة ملامسة جلد الأم لجلد الطفل للمشارك الذي يمثل دور الأم. وأره الرسومات التوضيحية، ثم ابدأ في تقديم المساعدة للأم. ووضح أنه في الواقع، ستكون الأم دون ملابس.

احمل الدمية. ضع عليها غطاء الرأس، والجوربين والحفاض، ثم ضعها على صدر الأم في الوضعية الصحيحة. واتبع الخطوات اللازمة لوضع قطعة القماش وربطها حول الأم والدمية، وضع القميص/ السترة على ظهر الأم.

تحقق من فهم الأم بأن تطلب منها وصف ما عرضته، ثم ابدأ مناقشة جماعية حول العرض مع المجموعة.

10.1.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 15، بشأن الرعاية عن طريق ملامسة الجلد للجلد، في الصفحة 17 من دليل المشاركين. واطلب منهم الرجوع مرةً أخرى إلى الرسومات التوضيحية والوصف الوارد خُطوةً بخطوة للرعاية عن طريق ملامسة الجلد للجلد في الصفحة 6 من الكتاب القلاب. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



11.1.4 تدريب لعب الأدوار ولعبة الفريق. الحفاظ على دِفء المواليد

قسِّم المجموعة إلى فريق (أ) وفريق (ب).

اطلب من المشاركين الوقوف في نصف دائرة حول اللوح الورقي القلاب. ارسم عمودين على اللوح الورقي القلاب، واحد للفريق (أ) وآخر للفريق (ب)، لتسجيل درجات الفريقين.

ووضح أن الفريقين سيشاهدان تدريبًا تمثيليًا. وعلى الفريق (أ) أن يذكر الأشياء التي يقوم بها العامل الصحي المجتمعي بشكل جيد، ومنها استخدام مهارات التواصل الجيد، واستمارة التسجيل، والكتاب القلاب. وسيكون الفريق (ب) مسؤولاً عن تحديد الأشياء التي قام بها العامل الصحي المجتمعي بشكل غير صحيح.

وعند الانتهاء من لعب الأدوار، اطلب من كل فرد من أفراد الفريق (أ) ذكر شيء واحد فقط جيد قام به العامل الصحي المجتمعي. وسيأخذ الفريق درجةً عن كل إجابة صحيحة. أما إذا كانت الإجابة غير صحيحة، فإن الفريق لا يحصل على درجة. ثم انتقل إلى الفريق (ب)، الذي يجب أن يذكر الأشياء التي قام بها العامل الصحي المجتمعي بشكل غير صحيح.

واطلب من الميسِّر المشارك أن يمثل دور الأم، بينما تمثل أنت دور العامل الصحي المجتمعي.

وفي النهاية، هنئ الفريق الفائز. والمطلوب لتدريب لعب الأدوار ما يلي:

- دمية
- غطاء للرأس
- جوربان
- منشفة نظيفة لتجفيف الطفل
- قطعة قماش لربط الطفل والأم
- صابون
- إبريق ماء
- إناء كبير

سيناريو الحالة

تزور العاملة الصحية المجتمعية أمينة أثناء الوضع. تغسل يديها، وتجفف الطفل مباشرة، ثم تضعه على بطن أمينة للحفاظ على دفء الطفل من خلال ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. وتستخدم العاملة الصحية المجتمعية الكتاب القلاب لتشرح لأمينة كيفية الرعاية عن طريق ملامسة جلد الأم لجلد الطفل التي يجب أن تقوم بها خلال الساعات الأولى من عُمر الطفل (الأهمية والخطوات). لا تقوم العاملة الصحية المجتمعية بإلباس الطفل غطاء الرأس أو جوربين، ولا تتحقق من فهم أمينة للنصائح التي قُدّمت إليها. وتقوم العاملة بتحميم الطفل بعد مرور 30 دقيقة باستخدام مياه الصنبور (لم تكن هناك مياه دافئة)، ثم تُعيد الطفل إلى أمينة لإرضاعه. وعلى استمارة التسجيل، تضع العاملة علامة على "نعم" بالنسبة لملامسة جلد الأم لجلد الطفل في عمود ملاحظة الممارسة المُتبعة، وعلامة على "نعم" في عمود تفهم الوضع.

وبعد تدريب لعب الأدوار، ابدأ اللعبة المذكورة أعلاه.

الممارسات الصحيحة

قدمت العاملة الصحية المجتمعية مساعدة عملية من حيث خطوات تنفيذ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. فلقد غسلت يديها، وجففت الطفل على الفور، وتأكدت من ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، مما يسهل البدء المبكر في الرضاعة. كما استخدمت أيضًا استمارة التسجيل والكتاب القلاب بشكل صحيح.

الممارسات غير الصحيحة

مهارات التواصل: لم تتحقق العاملة الصحية المجتمعية من فهم الأم.

طريقة ملامسة جلد الأم لجلد الطفل: لم تقم العاملة بإلباس الطفل غطاء الرأس أو الجوربين. وقامت بتحميم الطفل خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى باستخدام الماء البارد.

واختتم الجلسة بالتأكيد على ما يلي:

> تُعتبر ملامسة جلد الأم لجلد الطفل أفضل طريقة للحفاظ على دفء المواليد. وهي لها فوائد أخرى عديدة، مثل تيسير البدء المبكر في الرضاعة، وتيسير المرحلة الانتقالية للطفل من الرحم إلى العالم الخارجي. وبوصفك أحد العاملين الصحيين المجتمعيين، يجب أولاً أن تشرح أهمية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، ثم تساعد الأم في ضبط وضعية الطفل.



الجلسة 6:
المكون 2: تقديم المشـورة بشأن البدء المبكر في الرضاعة

مدة الجلسة
90 دقيقة

جهِّز
- لوحًا ورقيًا قلابًا
- أقلامًا
- أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 4، البدء المبكر في الرضاعة، ومقطع الفيديو 5، تقييم الرضاعة ووضعية الطفل وتعلقه بثدي أمه.
- حاسوبًا محمولاً
- شاشة
- جهاز عرض البيانات

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم المقصود بالرضاعة المبكرة، والرضاعة المطلقة، واللِّبَأ (لبن السرسوب)، ولبن أول الرضعة، ولبن آخر الرضعة، ووضعية الطفل وتعلقه بثدي الأم؛
- فهم أهمية البدء المبكر في الرضاعة؛
- إدراك أهمية اللِّبَأ (لبن السرسوب)؛
- التمكُّن من تقديم المشورة للأمهات بشأن أهمية البدء المبكر في الرضاعة؛
- التمكن من دعم الأمهات في البدء المبكر في الرضاعة؛
- التعرف على كيفية استخدام أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين: استمارة التسجيل والكتاب القلاب لتقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة.

1.2.4 مناقشة جماعية: البدء المبكر في الرضاعة

اسأل المشاركين عن أفضل غذاء للمواليد، امنحهم وقتًا للإجابة، ثم وضِّح أن لبن الأم هو أفضل وأنظف غذاء للمواليد.

اسأل المشاركين عن أسباب اعتبار الرضاعة أفضل طريقة لتغذية المواليد. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية:

- تخلق الرضاعة رابطةً قوية، وعلاقة حب بين الرضيع والأم. وتساعد وضعية الطفل على أن ينظر إلى عيني أمه.
  - تتعلم الأمهات المرضعات كيفية الانتباه للمولود والاستجابة لاحتياجاته.
  - توفر الرضاعة للأطفال شعورًا بالأمن والحماية، مما يساعدهم على النماء.
  - يُعتبر لبن الأم أرخص غذاء للأطفال. وهو مجاني وجاهز للطفل متى شعر بالجوع.
  - يحتوي لبن الأم على جميع العناصر الغذائية –البروتينات والسكر والفيتامينات والدهون والحديد وفيتامين ج– التي يحتاج إليها الطفل للنمو بشكل صحي حتى يكمل سن ستة أشهر، كما أنها توجد في صورة سهلة الهضم والامتصاص.
  - يحتوي لبن الأم على جميع أنواع الدهون التي تساعد المخ والعينين والأوعية الدموية على النمو والنَّماء. ولا يوجد هذا النوع من الدهون ومادته الهضمية في أي بديل للبن الأم أو حليب الحيوانات.

- توفر الرضاعة للطفل القدر الكامل من الماء الذي يحتاج إليه الرضّع، حتى في الطقس الحار.
- يوفر لبن الأم الوقاية من العدوى. ومن المرجَّح أن يقل احتمال العدوى بالالتهاب الرئوي والإسهال والتهاب السَّحَايا والتهابات الأذن للرضّع الذين يشاركون أمهاتهم القدرة على مكافحة العدوى.
- قد تساعد الرضاعة الطفل على النمو عقليًا.
- تقلل الرضاعة من خطر الإصابة بالحساسية والسرطان والسكري والسمنة مع نمو الطفل.

كما تفيد الرضاعة الأم أيضًا، فهي:

- تساعد على تأخير حدوث حمل جديد.
- تحمي الأم من مخاطر النزف، إذ تساعد الرحم على العودة إلى حجمه الطبيعي السابق، وتساعد على طرد المشيمة.
- تساعد في الوقاية من الإصابة بالأنيميا عن طريق تقليل النزيف، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرحم.

اسأل المشاركين عن مخاطر اللبن الاصطناعي. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية:

- تعوق التغذية باللبن الاصطناعي الترابط بين الأم والطفل؛
- مكلف، ويمكن أن يشكل عبئًا اقتصاديًا على الأسرة؛
- يزيد من خطر الإصابة بالإسهال وعدوى الجهاز التنفسي؛
- يزيد من خطر سوء التغذية ونقص فيتامين أ،
- يؤثر على النمو المعرفي، فقد تنخفض درجات الطفل في اختبارات الذكاء، كما قد يكون أداؤه ضعيفًا في المدرسة؛
- يكون الطفل أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري والسرطان عندما يصبح أكبر سنًا؛
- يكون الطفل أكثر عُرضة لخطر الإصابة بحساسية الألبان وعدم تحملها.

كما قد يشكل اللبن الاصطناعي خطرًا على صحة الأم، على النحو التالي:

- قد يحدث حملٌ آخر مبكرًا؛
- يزيد من مخاطر الإصابة بالنزيف وفقر الدم وسرطان الرحم والثدي.

اسأل المجموعة عن توقيت بدء الرضاعة. واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح أن الرضاعة يجب أن تبدأ خلال الساعة الأولى من الوضع.

ويُقصد بالبدء المبكر في الرضاعة إرضاع الطفل خلال الساعة الأولى من الوضع، بمجرد أن يكون الطفل مستعدًا. وللمساعدة في البدء المبكر في الرضاعة، يمكن القيام بما يلي:

- وضع الطفل بعد الولادة مباشرة على بطن الأم لتحقيق وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. وخلال الساعة الأولى من الولادة، سيتحرك الطفل بشكل غريزي نحو ثدي الأم ويتعلق به من تلقاء نفسه. ويساعد قيام الطفل بالتعلق بالثدي مبكرًا في البدء المبكر في الرضاعة.
  - إذا تُركت الأم والطفل دون إزعاج بعد الولادة مباشرةً، فمن المرجَّح أن تنجح هذه العملية الطبيعية. ويتفاوت الوقت الذي يستغرقه الطفل للتعلق بالثدي من طفل إلى آخر. فبعض الأطفال قد يستغرقون وقتًا أطول من غيرهم.
  - لا تجفف يدي الطفل لمساعدته على إيجاد حلمة ثدي الأم. فهما تحملان السائل الأمنيوسي الذي سيساعد الطفل على إيجاد حلمة ثدي الأم التي تحمل نفس الرائحة. ولهذا، لا يُنصح بقيام الأمهات بغسل حلماتهن قبل الرضاعة.

كما يكون الطفل مستعدًا للرضاعة عندما يفتح فمه، ويدير رأسه بحثًا عن الحلمة أو يمص أصابع يده. ولا يُعتبر البكاء علامةً على أن الطفل مستعدٌ للرضاعة.

2.2.4 فيديو توضيحي: البدء المبكر في الرضاعة

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 4، البدء المبكر في الرضاعة (07:28 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول البدء المبكر في الرضاعة. اعرض مقطع الفيديو 4، البدء المبكر في الرضاعة (07:28 دقيقة).

والفت الانتباه إلى الحقائق التالية:

- تساعد ملامسة جلد الأم لجلد الطفل بعد الولادة مباشرة على البدء المبكر في الرضاعة؛
- من الطبيعي بالنسبة للطفل أن يحدد مكان ثدي أمه، ويلتقمه من تلقاء نفسه، ويبدأ الرضاعة.

كرّر العلامات التي تدل على أن الطفل أصبح مستعدًا للرضاعة، وعندما ينتهي مقطع الفيديو، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

3.2.4 مناقشة جماعية: فوائد البدء المبكر في الرضاعة وفوائد اللِّبَأ (لبن السرسوب)

قبل هذه الجلسة، جهّز اللوح الورقي القلاب بكتابة الأسئلة التالية عليه.

- متى تبدأ الأم الرضاعة بعد الوضع، في مجتمعك؟
- ما هي المعتقدات الشائعة حول اللِّبَأ (لبن السرسوب)، أو اللبن الأول الذي يخرج من الثدي؟ (استخدم المصطلح المعروف به اللِّبَأ في المجتمع).
- ما الذي يُقدم عادةً للأطفال بعد الولادة في المجتمع؟

اكتب إجابة المجموعة تحت كل سؤال. وإذا ذكر المشاركون أن الرضاعة في مجتمعهم تبدأ بعد الساعة الأولى من الوضع، اسألهم عن السبب، وصاحب القرار في هذا الشأن. اكتب إجاباتهم.

ثم، اسألهم إذا كانوا يعرفون ما هو اللِّبَأ (لبن السرسوب) (استخدم المصطلح المحلي المقابل له)، وكرّر أنه اللبن الأول الذي يخرج من الثدي.

وعند كتابة جميع الإجابات، لخص وضع الرضاعة في مجتمعاتهم وَفقًا لإجاباتهم.

راجع مع المشاركين معنى البدء المبكر في الرضاعة واستعداد الطفل، ووضح لهم أن جسم الأم يبدأ في إنتاج اللِّبَأ قبل الولادة بفترة طويلة. ويُعرف اللبن الأول الأصفر الثخين الذي يخرج من الثدي بعد الوضع باسم اللِّبَأ (استخدم المصطلح المحلي). وفي بعض المجتمعات، يعود السبب الرئيسي لتأخير البدء المبكر في الرضاعة إلى الاعتقاد بأن لبن السرسوب الثخين الذي يخرج أولاً من الثدي بعد الوضع (اللِّبَأ، لكن استخدم المصطلح المحلي) يكون غير نظيف ومضر ويجب اعتصاره (وربما يعود ذلك إلى لونه وثخانته).

وأكد للمشاركين على أن اللبن الأول الأصفر الثخين أو اللِّبَأ مفيدٌ للغاية، وله منافع عديدة للطفل.

- يكون بمثابة أول تطعيم للطفل، إذ يحميه من العدوى.
- يمنع إصابته باليَرَقان من خلال السماح بإخراج مزيدٍ من البراز (له تأثير المُلين.)
- يساعد على نمو الدماغ والعينين.
- يساعد على نمو الأمعاء.

ويُنتج اللِّبَأ بكمية ضئيلة تتناسب مع حجم المعدة الصغيرة للطفل. وهذه الكمية الصغيرة هي كل ما يحتاج إليه

أغلب الأطفال قبل خروج اللبن الناضج. وعندما يرضع الطفل بشكل متكرر، بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنتاج اللِّبَأ، سيبدأ ثدي الأم في أن يصبح أكثر صلابة. وتُعتبر هذه علامة على زيادة إدرار اللبن وتغيره من لِبَأ إلى لبن الثدي العادي. وأكد للمجموعة على أن الرَّضاعة المنتظمة للطفل تُحفز عملية إدرار اللبن بالكامل.

وحتى بعد خروج اللبن، قد تعتقد بعض الأمهات أنه ليس لديها لبن كافٍ، وتنتظر فترة أطول قبل أن تبدأ إرضاع طفلها.

وأكد للمشاركين أنه إذا كان الطفل يرضع بشكل جيد ومتكرر، فإن اللبن الذي تدره الأم سيكون كافيًا لتلبية احتياجاته. واطلب من المشاركين ذكر منافع الرضاعة المبكرة. استمع إلى الإجابات، ثم اذكر في النهاية أن الرضاعة المبكرة مهمة للأسباب التالية:

- يحصل الطفل على جميع منافع اللبن الأول (اللِّبَأ أو لبن السرسوب)؛
- يحافظ على دِفء الطفل؛
- يعزز الارتباط بالأم؛
- يساعد على طرد المشيمة، ويقلل من نزيف المشيمة، ونزيف ما بعد الولادة؛
- يمكن أن يساعد في منع احتقان الثدي؛
- تُحفز الرَّضاعة المبكرة إدرار مزيدٍ من اللبن.

أكد على أن ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عاملٌ مهمٌ في البدء المبكر في الرضاعة. وأكد للمشاركين على أهمية أن يقوموا في زيارتهم الأولى بتشجيع الأم على وضع طفلها في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل لمساعدة الطفل على التعلق بثديها من تلقاء نفسه. ويجب مساعدتها في القيام بذلك، ولكن دون دفع الطفل تجاه الثدي. فمن الأفضل أن يُترك الطفل ليتعلق بثدي أمه من تلقاء نفسه مدفوعًا بغريزته الطبيعية.

4.2.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى قسم البدء المبكر في الرضاعة في الصفحتين 8 و9 من الكتاب القلاب. ووضح أن الرسم التوضيحي الأول الموجود على اليسار يبين ضرورة أن يكون البدء المبكر في الرضاعة خلال ساعة واحدة من الوضع. أما الرسم التوضيحي الثاني، فهو يصور امرأة تُرضع طفلها. ويجب إعطاء عناية خاصة للرسم الموجود في المنتصف الذي يصور العلامات التي تدل على استعداد الطفل لبدء الرضاعة (كأن يفتح فمه أو يمص يده).

5.2.4 مناقشة جماعية: منافع الرضاعة ومضار اللبن الاصطناعي

جهِّز: لوحًا ورقيًا قلابًا

أقلام اللوح الرقمي القلاب

اسأل المشاركين عن أسباب اعتبار الرضاعة أفضل طريقة لتغذية المواليد. اكتب إجاباتهم على اللوح الورقي القلاب، ثم اذكر مزايا الرضاعة للرضّع.

- تساعد على الارتباط بالأم، مما يُحفز نَماء الطفل.
- يُعتبر لبن الأم هو أفضل وأنظف غذاء للمواليد، إذ إنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل للنمو والنَّماء بشكل صحي وتوجد في صورة سهلة الهضم.
- يساعد على الوقاية من اليَرَقان وله تأثير مليّن.
- يحمي الأطفال من الإصابة بالعدوى والحساسية.

- يحمي الأطفال من الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل داء السُّكَّري والسمنة.
- قد يساعد الطفل أيضًا على النَّماء فكريًا، (درجات أعلى في اختبارات الذكاء).

كما تُعتبر الرضاعة مهمة لصحة الأمهات، إذ إنها:

- تقلل من النزيف عقب الوضع؛
- تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض والرحم؛

كما تؤخر حدوث حمل. ثم، اسأل المشاركين عن مضار اللبن الاصطناعي. واكتب إجاباتهم على اللوح الورقي القلاب، ثم عدِّد مضار اللبن الاصطناعي.

- يعوق الارتباط بالأم، مما يؤثر سلبًا على نَماء الطفل.
- يزيد من مخاطر الإصابة بالإسهال وعدوى الجهاز التنفسي؛
- يكون الطفل أكثر عُرضة للإصابة بالإسهال المستمر، وسوء التغذية، ونقص فيتامين أ.
- يزيد من خطر الإصابة بحساسية الألبان وعدم تحملها.
- يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل داء السُّكَّري والسمنة والسرطان.
- يحرز الأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعي درجات أقل في اختبارات الذكاء.

كما قد يكون ذلك مضرًا أيضًا لصحة الأم:

- تكون الأم أكثر عُرضة لخطر النزيف وفقر الدم؛
- تكون الأم أكثر عُرضة لخطر سرطان المبيض والثدي؛
- تكون الأم عُرضة لحدوث حمل مبكر.

6.2.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 10 و11 من الكتاب القلاب. ووضح الرسمتين الموجودتين في الصفحة 10. يوجد رسمتان: الأولى موجودة على اليسار لأم تُرضِع طفلها؛ والثانية على اليمين لأم تُعطي طفلها لبنًا اصطناعيًا.

اسألهم عن الفروق التي يرونها في كلتا الصورتين. استمع إلى إجاباتهم، ثم أشر إلى أنه يمكن رؤية ترابط وثيق بين الأم وطفلها في الصورة التي تظهر فيها أم تُرضع طفلها. فالأم تنظر بحب إلى طفلها، بينما الصورة التي تظهر فيها أم تُعطي طفلها لبنًا اصطناعيًا لا تعكس هذه الرابطة بوضوح.

واطلب منهم قراءة النصائح المرتبطة بهاتين الصورتين في الصفحة 11.

وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

7.2.4 مناقشة جماعية: دعم الأمهات في البدء المبكر في الرضاعة

سيحتاج المشاركون إلى الإلمام بنقاط مهمة متعلقة بالرضاعة: مفهوم الرضاعة المطلقة ومزاياها، والتعرف على كيفية ملاحظة الرضاعة، وتحديد علامات الوضعية الجيدة، وتعلق الطفل بثدي أمه بطريقة صحيحة.

نقاط مهمة حول الرضاعة

يجب إرضاع الأطفال عند الطلب في أي وقت نهارًا وليلاً، ثماني مرات في اليوم على الأقل.

ولا يجب إعطاؤهم أي شيء بخلاف لبن الأم، بما في ذلك الماء، حتى في الطقس الحار. وهذا ما يُسمى بالرضاعة المطلقة،

والتي يجب أن تستمر حتى يكمل الطفل ستة أشهر من العُمر. فلبن الأم يحتوي على كل ما يحتاجه الأطفال، حتى في الطقس الحار. وإذا أُعطي الطفل أي شيء آخر بخلاف لبن الأم، فإنه سيملأ معدة الطفل الصغيرة. ولن يكون هناك مساحة للبن الأم، مما يعني أن الطفل لن يحصل على العناصر الغذائية اللازمة، وسيؤثر ذلك سلبًا على نموه ونمائه بشكل صحي.

وفي الطقس الحار، يمكن أن تزيد الأم من معدل الرضاعة، وأن تشرب هي كميات أكبر من الماء.

ويُعتبر إعطاء الطفل ماء في الطقس الحار أحد أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه الرضاعة المطلقة.

لبن أول الرضعة: في بداية الرضاعة، يرضع الطفل لبن أول الرضعة. ويكون لونه شفافًا، ويُنتج بكميات كبيرة. ويحتوي على كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة. وبسبب لونه، تعتقد بعض الأمهات على سبيل الخطأ أن لبن أول الرضعة لبن خفيف.

لبن آخر الرضعة: في نهاية الرضعة، يرضع الطفل لبن آخر الرضعة. ويكون لونه أبيض وغنيًا بالدهون. ويزود لبن آخر الرضعة الطفل بالطاقة والإحساس بالشبع (أي يشعر الطفل بالشبع فلا يكون جائعًا).

ويجب أن يستمر الطفل في الرَّضاعة حتى يترك الثدي من تلقاء نفسه. وبهذا، يمكن للطفل أن يأخذ كلاً من لبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة. أما إذا كانت الأم تنقل الطفل من ثدي إلى آخر، قبل أن يتركه من تلقاء نفسه، فلن يأخذ الطفل سوى لبن أول الرضعة. وذلك معناه أنه سيُحرَم من الدهون والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاج إليها من لبن آخر الرضعة، وسيشعر بالجوع.

ويعتمد إنتاج الأم من اللبن على ما يلي:

- رضاعة الطفل بفعالية؛
- إفراغ الثدي؛ يُرسل الثدي إشارات إلى المخ لإنتاج اللبن. فإذا ظل الثدي ممتلئاً ولم يُفرغه الطفل، سيتوقف الثدي عن إنتاج اللبن. ويحدث عدم إفراغ الثدي نتيجة عدم الرضاعة بصفة متكررة، أو عدم تعلق الطفل بثدي أمه بصورة جيدة، أو عدم رضاعته بفعالية. وقد تظن بعض الأمهات في هذا الموقف أنها ليس لديها لبن كافٍ.

أخبر المشاركين أن هذه معلومات سيحتاجون إليها للمساعدة في حل أي مشكلات قد تواجه الأم أثناء الرضاعة. وذكّرهم أنهم سيحتاجون إلى استخدام مهارات التواصل الجيد التي تعلموها بالفعل في الجلسات السابقة لدعم الأم وبناء ثقتها بنفسها أثناء قيامها بالرضاعة.

8.2.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 16، معلومات مهمة حول الرضاعة، في الصفحة 18 من دليل المشاركين.

واطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 12 و13 من الكتاب القلاب. اشرح الصورتين، واسأل المشاركين عن كيفية استخدامهما أثناء تقديم المشورة، مع الرجوع دائمًا إلى النصائح المكتوبة. وذكّر المشاركين أنه يجب عليهم أن يتحققوا من فهم الأم. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

9.2.4 مناقشة جماعية: ملاحظة الرضاعة

وضح للمشاركين أهمية ملاحظة الرضاعة لتقييم تعلق الطفل بثدي أمه ووضعيته.

ووضح أن بعض الأمهات قد يشتكين من عدم إدرار كمية كافية من اللبن، أو من الألم أثناء الرضاعة، أو من احتقان

الثـدي. وتعتمـد الرضاعـة الناجحـة أساسًـا على تعلـق الطفـل بثـدي أمـه بصـورة جيـدة وعلى وضعيتـه. وللتحقـق مـن هذيـن الأمريـن، مـن الضروري الحصـول على إذن لملاحظـة عمليـة الرضاعـة.

ووضح كيفية تقييم تعلق الطفل بثدي أمه ووضعيته، على النحو التالي:

لفهـم كيفيـة تقييـم تعلـق الطفـل بثـدي أمـه ووضعيتـه، اطلـب مـن المشـاركين الرجـوع إلى الصفحـتين 14 و15 مـن الكتـاب الـقلاب. وأشر إلى الصـورة الموجـودة على اليسـار، ووضـح أنهـا تُـبين تعلـق الطفـل بثـدي أمـه بصـورة جيـدة. ويمكـن أن تقـول إن ذلـك يرجـع إلى الأسـباب التاليـة:

- رؤية منطقة أكبر من هالة الثدي فوق فم الطفل مقارنةً بالمنطقة الظاهرة أسفله؛
- فم الطفل مفتوح تمامًا؛
- اتجاه الشَّفَة السفلى للطفل إلى الخارج؛
- ملامسة ذقن الطفل للثدي.

واذكر في النهاية أن ذلك يدل على تعلق الطفل بثدي أمه بشكل جيد.

وأشر إلى الصـورة الموجـودة على اليـمين، واطـرح الأسـئلة التاليـة: "مـا رأيـك بالنسـبة للجـزء الظاهـر مـن الهالـة المحيطـة بالثـدي؟" اسـتمع إلى إجاباتهـم، ثـم اذكـر مـا يلي: "منطقـة هالـة الثـدي فـوق فـم الطفـل مسـاوية للمنطقـة الظاهـرة أسـفله".

ثم اسأل: "ما رأيكم بالنسبة لفم الطفل؟" استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي: "فم الطفل ليس مفتوحًا تمامًا".

اسـألهم: "مـا رأيكـم بالنسـبة للشَّـفة السـفلى؟" اسـتمع إلى إجاباتهـم، ثـم اذكـر مـا يلي: "الشـفة السـفلى للطفـل متجهـة إلى الداخـل".

وأخيرًا، اسـأل المشـاركين: "مـا رأيكـم بالنسـبة لذقـن الطفـل؟" اسـتمع إلى إجاباتهـم، ثـم اذكـر مـا يلي: "ذقـن الطفـل غير ملامسـة لثدي الأم".

واذكر في النهاية أن تعلق الطفل بثدي الأم في هذه الحالة ليس جيدًا.

وأكـد للمشـاركين على أنهـم عندمـا يلاحظـون عمليـة الرضاعـة، فيجـب أن يـروا جميـع العلامـات الأربـع التـي تـدل على تعلـق الطفـل بثـدي أمـه بصـورة جيـدة. وفي حالـة غيـاب علامـة واحـدة، فـإن هـذا لا يُعـتبر تعلقًـا جيـدًا.

ويـؤدي عـدم تعلـق الطفـل بالثـدي بصـورة جيـدة إلى عـدم فعاليـة الرضاعـة. وحتـى في حالـة غيـاب علامـة واحـدة مـن العلامـات الأربـع، فإنـه يجـب على العامـلين الصحـيين المجتمعـيين مسـاعدة الأم لتحـسين تعلـق الطفـل بثديهـا. وحتـى يمكـن القيـام بذلـك، يجـب التأكـد مـن استرخـاء الأم وشـعورها بالراحـة في أي وضعيـة تتخذهـا للرضاعـة. أمـا إذا كانـت الأم تشـعر بالقلـق أو الألم، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يعـوق تدفـق الـلبن.

1. تأكد من أن وضعية الطفل جيدة.
   واطلب من المشاركين أن ينظروا مرةً أخرى إلى الرسم الذي يوضح تعلق الطفل بثدي أمه بصورة جيدة في الكتاب القلاب. وأشر إلى أن الرسم الموجود على اليسار يصور طفلاً في وضعية جيدة. واقرأ عليهم علامات الوضعية الجيدة، ثم اطلب من المجموعة النظر إلى مثال الوضعية السيئة (الرسم الموجود على اليمين)، واقرأ هذه العلامات عليهم أيضًا. وأكد على أن الوضعية السيئة تؤدي إلى تعلق الطفل بثدي أمه بطريقة غير سليمة. ولتيسير الرضاعة، من الضروري أولاً تصحيح وضعية الطفل.
2. ساعد الأم على تحسين تعلق الطفل بثديها.
   واطلب منها أن تلمس شفتي الطفل بحلمتها، وتنتظر حتى يفتح الطفل فمه تمامًا، ثم تحرك الطفل سريعًا بحيث تكون شفته السفلى أسفل الحلمة.
3. اسأل الأم إذا كان الطفل يرضع جيدًا أم لا.
4. إذا لم يكن تعلقه بالثدي جيدًا، تُعاد المحاولة مرة أخرى.

وقد تأخذ الأمهات وضعيات مختلفة أثناء الرضاعة. والمهم أن تشعر الأم بالراحة والاسترخاء، وبأن طفلها في وضعية جيدة ومتعلقا بثديها بطريقة سليمة ويرضع بفعالية.

واطلب من المشاركين النظر في الصفحة 16 من الكتاب القلاب والاطلاع على وضعيات الرضاعة المختلفة.



10.2.4 قراءة

اطلب من المشاركين النظر في الصفحات 14، و15، و16، و17 من الكتاب القلاب.

ناقش الرسومات التوضيحية مع المشاركين: ما الذي يرونه، وكيف سيستخدمون الرسومات أثناء تقديم المشورة؟ واطلب منهم قراءة النصائح المقترنة بالرسومات التوضيحية، وذكِّرهم أن يتحققوا دائمًا من فهم الأم. وناقش أيضًا معهم التعليمات الموجَّهة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين في الإطار الأحمر في الصفحة 15. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



11.2.4 تمرين الصور 1 ومناقشة جماعية: وضعية الطفل وكيفية تعلقه بثدي الأم

اطلب من المشاركين النظر في الصفحة 19 من دليل المشاركين، تمرين الصور 1: وضعية الطفل وكيفية تعلقه بثدي الأم. ووضح أن هذه الصفحة تشتمل على 7 صور، لكل منها رقم. وتحت كل صورة من الصور السبع، يوجد مربعان، واحد للتعلق الجيد، والآخر للتعلق السيئ. اطلب منهم النظر إلى كل صورة، وتحديد ما إذا كانت تعبر عن وضعية وتعلق جيدين أم سيئين، وَفقًا للعلامات التي تعلموها، ووضع علامة في المربع المناسب. امنحهم 10 دقائق، ثم اسألهم بالترتيب عن كل صورة. واسألهم عن سبب القرارات التي اتخذوها.

الإجابات:

الصورة 1: تعلق جيد (جميع العلامات جيدة وظاهرة)

الصورة 2: تعلق جيد (جميع العلامات جيدة وظاهرة)

الصورة 3: تعلق سيئ (جميع العلامات الأربعة غير موجودة)

الصورة 4: تعلق سيئ (جميع العلامات الأربعة غير موجودة)

الصورة 5: تعلق جيد (يمكن ملاحظة علامتين جيدتين فقط)، ووضعية جيدة

الصورة 6: تعلق سيئ، ووضعية سيئة (جميع العلامات غير موجودة)

الصورة 7: تعلق جيد (يمكن ملاحظة علامة واحدة)، ووضعية جيدة



12.2.4 فيديو توضيحي: تقييم الرضاعة ومساعدة الأم على ضبط وضعية الطفل والتقامه لثديها

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 5 (04:06 دقيقة)، تقييم الرضاعة ومساعدة الأم على ضبط وضعية الطفل وتعلقه بثديها.

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول وضعية الطفل وتعلقه بثدي الأم وكيفية مساعدة الأم على ضبط وضعية طفلها. اعرض مقطع الفيديو 5. وبعد العرض، ناقش علامات التعلق الجيد والوضعية الجيدة.



الجلسة 7:
المكون 3: تقديم المشـورة حول ممارسات الأسرة المتعلقـة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع حتى أقل من شهرين من العمر

مدة الجلسة
4 ساعات

جهِّز

- مقطع الفيديو 6، المولود ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة والتشنجات. ومقطع الفيديو 7، الحركة واليَرَقان. ومقطع الفيديو 8، التنفس السريع. ومقطع الفيديو 9، الانسحاب الشديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل. ومقطع الفيديو 10، قياس درجة حرارة الجسم. ومقطع الفيديو 11، علامات العدوى الموضعية. ومقطع الفيديو 12، وزن المواليد.
- جهاز عرض البيانات
- حاسوب محمول
- شاشة
- مؤقت لكل مشارك ومُيسِّر
- نسخة من مذكرة الإحالة، واحدة لكل مشارك وميسِّر + 5
- مقياس حرارة رقمي، واحد لكل مشارك وميسِّر
- ماء دافئ وصابون
- مقياس وزن محمول برموز لونية ومعلاق، واحد لكل مشارك وميسِّر
- دُمى بأوزان مختلفة (يُفضل أن تتراوح بين 1.2 كغم إلى 3.0 كغم)
- نسختان من كل سيناريو من سيناريوهات الحالة الأربعة للعب الأدوار (1) حول المساعدة في الإحالة
  - مجموعة مستلزمات غسل اليدين:
  - صابون
  - إبريق ماء
  - إناء كبير
  - منشفة نظيفة
- مجموعتان من البطاقات الخاصة بلعبة بطاقات "صواب وخطأ" حول علامات الخطورة في المواليد لكل فئة عمرية
- طاولة لاستخدامها في لعبة البطاقات

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على كيفية قياس درجة حرارة جسم المولود؛
- التدريب على قياس درجة حرارة جسم المولود بطريقة صحيحة؛
- إدراك أهمية وزن المولود يوم ولادته؛
- تعلُّم كيفية استخدام الميزان المحمول لوزن المولود بشكل صحيح وبأمان؛
- ترجمة قراءات الألوان التي تظهر على الميزان؛

- تعلم كيفية تقديم المشورة إلى الأسر حول علامات الخطورة في المواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- تعلم كيفية دعم الإحالة؛
- استخدام الأدوات اللازمة لتقديم مشورة حول ممارسات طلب الرعاية الصحية؛
- تعلم خطوات غسل اليدين، وتعليمها للأم؛
- التعرف على كيفية تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية؛
- استخدام الأدوات اللازمة لتقديم المشورة حول ممارسات الوقاية.



1.3.4 مناقشة جماعية: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع حتى أقل من شهرين

أخبر المشاركين أن ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية تؤثر تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على صحة الطفل: فيمكن أن تفيد الطفل أو تضره حسب طبيعتها.

اسأل المجموعة عن المقصود بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، وقدم بعض الأمثلة. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضح لهم أن ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية تنقسم إلى ممارسات طلب الرعاية الصحية، وممارسات الوقاية.

1. ممارسات طلب الرعاية الصحية:

أ. متى يجب طلب الرعاية الصحية اعتمادًا على التحقق من وجود علامات الخطورة؟

ب. مَن الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟

2. ممارسات الوقاية:

- التطعيم.
- غسل اليدين.
- النوم تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات حشرية (في المناطق التي تشكل الملاريا فيها خطرًا).
- استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد.



2.3.4 مناقشة جماعية. ممارسات طلب الرعاية الصحية

وضح أنه في حالة مرض الأطفال، فإنه يجب طلب الرعاية الصحية من أحد مقدمي الرعاية المؤهَّلين الحاصلين على تدريب جيد.

وهناك مجموعة من العلامات التي يُطلق عليها اسم "علامات الخطورة"، وتدل على وجود مرض خطير. وإذا لوحظت أي من علامات الخطورة، فإنه تجب إحالة الطفل سريعًا إلى أحد المرافق الصحية.

وأخبر المشاركين أن المواليد، لا سيما في الأيام الأولى من حياتهم، وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، يمرضون بسهولة، ويمكن أن تسوء حالاتهم سريعًا وتصبح خطيرة. ويمكن أن يصبح أي تأخر في الحصول على العلاج مهددًا للحياة. وبالتالي، يجب أن تعرف الأسر توقيت ومكان طلب الرعاية الصحية. ووضح للمجموعة أنهم سيتعلمون خلال التدريب علامات الخطورة، وكيفية التعرف عليها.

وأضف: "قد لا تعرف الأسر علامات الخطورة، وقد لا تكون قادرة على التعرف عليها". وباعتبارهم عاملين صحيين مجتمعيين، لن يكونوا قادرين فقط على تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، بل سيستطيعون أيضًا نقل

هـذه المعرفـة إلى الأسر التـي سـتتمكن لاحقًـا مـن التعـرف على علامـات الخطـورة عندمـا لا يوجـد أحـد العامـلين الصحـيين المجتمعـيين، واتخـاذ الإجـراء الملائـم.

وتتمثـل المهمـة الأولى في تقديـم المشـورة حـول ممارسـات طلـب الرعايـة الصحيـة في تحديـد الوقـت الـذي يتـعين فيـه طلـب الرعايـة الصحيـة. ويتطلـب ذلـك ملاحظـة دقيقـة للتحقُّـق مـن وجـود علامـات الخطـورة مـن عدمـه.

فـخلال زيـارات المواليـد، يجـب دائمًـا التحقـق أولاً مـن وجـود علامـات الخطـورة. وإذا لم يكـن هنـاك أي علامـات خطـورة، يجـب تعليـم الأم وباقـي أفـراد الأسرة كيفيـة التعـرف عليهـا. وهـذا أمـر ضروري حتـى يمكـن طلـب الرعايـة الصحيـة في الوقـت المناسـب.

وتوجـد تسـع علامـات خطـورة للمواليـد وصغـار الرُّضَّـع الذيـن تقـل أعمارهـم عـن شـهرين. وإذا لوحظـت أي مـن هـذه العلامـات، يصبـح مـن المحتـم طلـب الـعلاج العاجـل.

ويجب أن يستأذن العاملون الصحيون المجتمعيون من الأسرة لتقييم علامات الخطورة الخاصة بالطفل.

وتتمثل علامات الخطورة فيما يلي:

العلامة الأولى: الطفل ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة أو توقف عن الرضاعة بشكل جيد

إذا حاولـت الأم وضـع طفلهـا على ثديهـا عـدة مـرات على مـدار سـاعتين أو ثلاث سـاعات، إلا أن الطفـل كان أضعـف مـن أن يتمكـن مـن الرَّضاعـة، ولا يسـتطيع الرَّضاعـة على الإطلاق، فهـذه علامـة خطـورة، وتـدل على مـرض الطفـل مرضًـا شـديدًا.

كما أنـه لـو قالـت الأم إن الطفـل كان يرضـع بصـورة جيـدة بعـد الـولادة، إلا أنـه الآن لا يتغـذى جيـدًا، فهـذه أيضًـا علامـة خطـورة.

اطلـب مـن الأم أن تضـع الطفـل على ثديهـا، حتـى يمكـن أن تلاحـظ كيفيـة رضاعـة الطفـل. فـإذا تـبين أن الطفـل ضعيـف جـدا ولا يقـدر على الرضاعـة، أو لم يَعُـد يتغـذى بشـكل جيـد، فتجـب إحالتـه فـورًا إلى أحـد المرافـق الصحيـة.

العلامة الثانية: التشنجات

وضـح أنـه أثنـاء حـدوث تشـنجات، قـد يصبـح ذراعـا الطفـل وسـاقاه في حالـة تيبـس. وقـد يتوقـف الطفـل عـن التنفـس ويتحـول لونـه إلى الأزرق. وقـد يمكـن عـادةً ملاحظـة حركـة متكـررة لجـزء واحـد مـن الجسـم، مثـل ارتعـاش الفـم أو رمـش العيـنين.

اسـأل الأم إذا كان الطفـل مصابًـا بالتشـنجات (يجـب أن تسـتخدم المصطلـح المحلي المقابـل لهـا). فـإذا أجابـت الأم بالإيجـاب، أو إذا لاحظـت بنفسـك تشـنج الطفـل، فهـذه علامـة خطـورة، ويجـب فـورًا إحالـة الطفـل إلى أحـد المرافـق الصحيـة.

واشرح للمشـاركين أن استفسـاراتهم عـن علامـات الخطـورة يجـب أن تكـون قائمـة على اسـتمارة التسـجيل والملاحظـة وَفقًـا لما تعلمـوه أثنـاء التدريـب، ومـن خلال الرجـوع إلى دليـل المشـاركين. وإذا كانـت توجـد علامـة خطـورة، سـتقدم مشـورة بشـأن الإحالـة. أمـا إذا لم تكـن هنـاك علامـات خطـورة، فاسـتعن بالكتـاب الـقلاب لتعليـم الأم علامـات الخطـورة.

واطلـب مـن المشـاركين النظـر إلى البنـد 3 مـن اسـتمارة التسـجيل، التحقـق مـن وجـود علامـات الخطـورة، ووضـح لهـم أنهـم يجـب أولاً أن ينظـروا في عمـود الملاحظـة، حيـث توجـد التعليـمات الخاصـة بملاحظـة علامـات الخطـورة. ثـم، يجـب عليهـم الرجـوع إلى عمـود "فهـم الوضـع". ويجـب أن يضعـوا علامـة في المربـع المجـاور لأي علامـة خطـر يلاحظونهـا. وأكـد على أنـه في حالـة عـدم وجـود علامـة، يجـب أن يُترك المربـع فارغًـا. والفـت انتباههـم إلى الجـزء السـفلي مـن البنـد 3، حيـث كُتـب **إذا كانـت هنـاك أي علامـة مـن علامـات الخطـورة، تخطـي جميـع المهـام الأخـرى، واكتبـي مذكـرة إحالـة، وسـاعدي في تنفيـذ الإحالـة،** وأكـد على أن هـذا مـا يجـب عليهـم القيـام بـه.

واطلـب منهـم الرجـوع إلى الصفحـتين 18 و19 مـن الكتـاب الـقلاب. وتُعـتبر المعلومـات الخاصـة بعلامـات الخطـورة هـي المعلومـات التـي يجـب اطلاع الأم عليهـا في حالـة عـدم وجـود علامـة ظاهـرة.

والفت انتباههم إلى الإطار الأحمر الموجود في الصفحة 19، ووضح أنه يشتمل على تعليمات يجب أن يتبعها العاملون الصحيون المجتمعيون أثناء تقديم المشورة حول علامات الخطورة.

وناقش مع المجموعة الرسومات التوضيحية والنصائح الواردة في هاتين الصفحتين.

3.3.4 فيديو توضيحي: طفل ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة أو توقف عن التغذية بشكل جيد والتشنجات

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 6: طفل ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة أو توقف عن التغذية بشكل جيد والتشنجات (01:17 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول علامتين من علامات الخطورة، ألا وهما: الطفل ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة أو توقف عن التغذية بشكل جيد والتشنجات.

اعرض مقطع الفيديو 6، وبعد مشاهدته، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

4.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 17: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية والإطار 18: ممارسات طلب الرعاية الصحية. متى يجب طلب الرعاية؟ التحقق من وجود علامات الخطورة، الصفحة 20 من دليل المشاركين، ثم اطلب منهم الرجوع إلى الصفحتين 18 و19 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وأكد على أهمية اتباع التعليمات والنصائح الواردة في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

5.3.4 مناقشة جماعية: قلة الحركة، أو عدم الحركة إلا عند التحفيز أثناء الاستيقاظ، أو عدم الحركة على الإطلاق

علامة الخطورة الثالثة: عندما يتحرك الطفل بصورة أقل، فلا يتحرك إلا عند التحفيز أثناء الاستيقاظ، أو لا يتحرك على الإطلاق.

وللتعرف على هذه العلامة، يجب أن يُدرك العاملون الصحيون المجتمعيون الأمور التي يجب عليهم التحقق منها. فالأطفال ينامون أغلب الوقت، ولا يُعتبر ذلك علامة على المرض. وعندما يستيقظ الطفل، من الطبيعي أن يبدأ في تحريك ذراعيه وساقيه أو لف رأسه عدة مرات في الدقيقة.

وأخبر المشاركين أنه يجب عليهم ملاحظة حركة الطفل أثناء استيقاظه.

وإذا كان الطفل نائمًا أثناء التقييم، يُطلب من الأم إيقاظه. وإذا لاحظت أن الطفل يحرك أطرافه بصورة طبيعية دون تحفيز، فذلك معناه عدم وجود علامة خطورة.

وإذا كان الطفل متيقظًا ولا يتحرك، يمكن تحفيزه بلطف عن طريق الضرب أو النقر الخفيف على باطن القدم. وإذا كان الطفل يتحرك فقط استجابةً لهذا التحفيز، ثم يتوقف عن الحركة، أو إذا كان الطفل لا يتحرك على الإطلاق حتى بعد تحفيزه على الحركة، فهذه علامة خطورة، وتجب إحالة الطفل فورًا إلى أحد المرافق الصحية.

علامة الخطورة الرابعة هي اليَرَقان خلال أول 24 ساعة، أو اصفرار راحة اليدين وباطن القدمين.

اسأل المشاركين: ما المقصود باليَرَقان؟

وضح أن اليَرَقان هو تلون العينين و/أو الجلد باللون الأصفر. وقد يُصاب العديد من الأطفال باليرقان خلال الأسبوع الأول من حياتهم. ولا يُعتبر ذلك أمرًا خطيرًا، ويختفي خلال أيام قليلة. ولكن إذا ظهر اليَرَقان خلال أول 24 ساعة من عُمر الطفل، أو في حال اصفرار راحة يديه وباطن قدميه، فإن ذلك يدل على إصابة الطفل باليرقان الشديد. ويُعتبر ظهور اليَرَقان خلال أول 24 ساعة من عُمر الطفل، و/أو اصفرار راحة يديه وباطن قدميه علامة خطورة، ويجب إحالة الطفل إلى أحد المرافق الصحية على الفور.

أخبر المشاركين أنه يجب عليهم اتباع الخطوات التالية لتقييم اليَرَقان:

- ملاحظة الطفل في الضوء الطبيعي. أكد للمشاركين على أنه ليس من الدقة إجراء تقييم اليَرَقان في ضوء اصطناعي لأنه قد يلقي بظل أصفر مما يجعل الطفل يبدو وكأنه مصاب باليرقان بينما هو غير مصاب.
- اضغط بإبهامك برفق على أنف الطفل وراحة يديه وباطن قدميه حتى يتحول لون الجلد إلى الأبيض. وعندما ترفع إبهامك، إذا تحول لون الجلد إلى الأصفر، فهذه علامة خطورة، وتجب إحالة الطفل فورًا إلى أحد المرافق الصحية.

والفتْ الانتباه إلى الصفحتين 20 و21 من الكتاب القلاب اللتين تتضمنان إطارًا أحمر اللون لتوضيح التعليمات التي يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن يتبعوها، والمعلومات التي تحدد علامات الخطورة والتي يحتاجون إلى نقلها للأم.

6.3.4 فيديو توضيحي: قلة الحركة، أو عدم الحركة إلا عند التحفيز أثناء الاستيقاظ، أو عدم الحركة على الإطلاق

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 7 حول قلة الحركة واليرقان (06:48 دقيقة).

وأخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول علامتي الخطورة المتمثلتين في قلة الحركة واليرقان.

اعرض مقطع الفيديو 7 على المشاركين. وكرر عرض الفيديو، إذا كان ذلك ضروريًا. وعندما تنتهي المجموعة من مشاهدة الفيديو، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

7.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 20 و21 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، والتعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

8.3.4 مناقشة جماعية: التنفس السريع

راجع مع المشاركين علامات الخطورة التي تعلموها بالفعل، ثم أخبرهم أنهم سيتعلمون الآن علامة الخطورة الخامسة، وهي التنفس السريع.

العلامة الخامسة: التنفس السريع (صعوبة التنفس)

اشرح أن عملية التنفس هي استنشاق الهواء إلى داخل الجسم ثم إخراجه منه عن طريق الفم أو الأنف.

وحتى يمكن التعرف على هذه العلامة، يجب أن تعدّ الأنفاس التي يأخذها الطفل في الدقيقة الواحدة. ويُسمَّى هذا

معدل سرعة التنفس، ويمكن عد أنفاس الطفل عن طريق النظر إلى حركة جسمه عند التنفس.

واشرح أثناء العرض النقاط التالية: يتحرك الصدر والبطن إلى الخارج عندما نأخذ نَفَسًا إلى الداخل (الشهيق)، ويتحرك إلى الداخل عندما نُخرج النفس إلى الخارج (الزفير). وتُعتبر حركة الصدر والبطن إلى الخارج وإلى الداخل معًا نفسًا واحدًا.

ووضح أن المواليد يتنفسون عادةً أسرع من الرُّضَّع والأطفال الصغار الأكبر سنًا. ويُعتبر 60 نَفَسًا في الدقيقة هو حد التعرف على التنفس السريع في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

وإذا كنت تحسب معدل تنفس المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، واكتشفت أنه 60 نفسًا أو أكثر، كرِّر العد. فإذا ظل معدل التنفس 60 نفسًا أو أكثر، فذلك معناه تنفس سريع. وهذه علامة خطورة تدل على مرض شديد. ويجب أن يُحال الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.



9.3.4 فيديو توضيحي: حساب معدل سرعة التنفس

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 8 حول التنفس السريع في المواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين (03:23 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول التنفس السريع في المواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين. وأخبرهم أنه سيكون لديهم فرصة لحساب معدل سرعة التنفس، وتحديد ما إذا كان هناك تنفس سريع أم لا.

اعرض على المجموعة مقطع الفيديو 8، وتأكد من أن الجميع يتمرن مع الفيديو.

وأكد على أهمية قيام العاملين الصحيين المجتمعيين بغسل اليدين قبل لمس الطفل.

وعندما ينتهي عرض الفيديو، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



10.3.4 العرض التوضيحي: كيفية حساب معدل التنفس

ستحتاج إلى ما يلي:

- مؤقت لكل مشارك
- دُمية مرتدية ملابس

أخبر المشاركين أن استخدام مؤقت هو أسهل طريقة لعدّ الأنفاس التي يأخذها الطفل في الدقيقة. وأرهم المؤقت، واشرح لهم كيف يعمل.

ووزع المؤقتات على المشاركين، واطلب منهم تشغيلها وإيقافها، والاستماع إلى الصافرة القصيرة كل 30 ثانية والصافرة الطويلة كل دقيقة.

واطلب منهم التمرُّن على استخدام المؤقت لحساب معدل سرعة تنفس زملائهم. وامنحهم خمس دقائق للتمرن، ثم أخبرهم بضرورة مراعاة النقاط التالية عند عدّ أنفاس الطفل:

- يجب أن يكون الطفل هادئًا؛ لأنه إذا كان يبكي، فسيكون عدد الأنفاس غير صحيح؛
- يجب ألا يكون ذلك أثناء الرضاعة؛ لأن الطفل إذا كان يرضع، فسيكون عدد الأنفاس غير صحيح؛
- من الضروري عدّ الأنفاس لمدة دقيقة كاملة.

واذكر في النهاية أن هذه هي الطريقة الصحيحة لحساب معدل سرعة التنفس.

ثم، استخدم دُمية لعرض الخطوات التي يجب أن يتبعها المشاركون عند حساب معدل سرعة التنفس.

- انتظر حتى يهدأ المولود/ الرضيع الصغير أو ينام. لا تبدأ العدّ إذا كان الطفل يرضع.
- تأكد من توافر إضاءة كافية لرؤية حركات الجسم بوضوح عند التنفس.
- ارفع قميص الطفل برفق حتى تتمكن من رؤية حركات الجسم عند التنفس. ويجب أن يرتفع الصدر والبطن وينخفضان لاحتسابهما نَفَسًا واحدًا.
- لاحظ عدة أنفاس دون عدّ حتى تألف حركات الجسم عند التنفس (الشهيق والزفير).
- شَغِّل المؤقت وعدّ الأنفاس لمدة دقيقة كاملة (حتى سماع صوت الصافرة الطويلة التي تشير إلى نهاية دقيقة واحدة).
- إذا قمت بعدّ 60 نفَسًا أو أكثر، كرر العد وسجِّل عدد الأنفاس مرة أخرى.

ووضح أن العدّ الثاني مهمٌ لأن معدل تنفس المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين يكون غير منتظم في كثيرٍ من الأحيان. وقد يتوقفون أحيانًا عن التنفس لثوانٍ معدودة، ثم يتبعون ذلك بفترة قصيرة من التنفس السريع. وإذا كانت نتيجة العدّ الثاني 60 نفسًا أو أكثر، فذلك يعني أن المولود/ الرضيع الصغير لديه تنفس سريع.

وأكد على أنه لا يجب أبدًا أن يقرروا إذا كان الطفل يتنفس بسرعة أم لا، إلا إذا كان معدل التنفس في العدّ الثاني 60 نفسًا أو أكثر في الدقيقة.



11.3.4 تمرين الأسئلة السريعة 1: التنفس السريع

أخبر المشاركين أنك ستُجري تمرينًا لمراجعة الجزء الخاص بالتنفس السريع. ووضح أنك ستخبرهم ببعض الأرقام الخاصة بمعدل سرعة التنفس، وعليهم أن يحددوا إذا كان ذلك يُعتبر تنفسًا سريعًا بالنسبة للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين أم لا. وإذا لم يتمكن أحد المشاركين من الإجابة، ينتقل السؤال إلى الفرد الثاني من أفراد الفريق.

هل هذا الطفل لديه سرعة تنفس؟	الإجابة
معدل التنفس 65 نفسًا/ الدقيقة	يكرر العدّ. إذا كان معدل التنفس 60 نفسًا/ الدقيقة أو أكثر، يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا، وإذا كان معدل سرعة التنفس في العدّ الثاني أقل من 60 نفسًا/ الدقيقة، فلا يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا.
معدل التنفس: 55 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 59 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 69 نفسًا/ الدقيقة معدل التنفس في العدّ الثاني 63 نفسًا/ الدقيقة	نعم، معدل التنفس في العدّ الثاني أكثر من 60 نفسًا/ الدقيقة.
معدل التنفس: 48 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 70 نفسًا/ الدقيقة معدل التنفس في العدّ الثاني: 68 نفسًا/ الدقيقة	نعم، معدل التنفس في العدّ الثاني أكثر من 60 نفسًا/ الدقيقة.
معدل التنفس: 37 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 79 نفسًا/ الدقيقة	يكرر العدّ. إذا كان معدل التنفس 60 نفسًا/ الدقيقة أو أكثر، يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا، وإذا كان معدل سرعة التنفس في العدّ الثاني أقل من 60 نفسًا/ الدقيقة، فلا يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا.
معدل التنفس: 43 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 74 نفسًا/ الدقيقة معدل التنفس في العدّ الثاني: 70 نفسًا/ الدقيقة	نعم، معدل التنفس في العدّ الثاني أكثر من 60 نفسًا/ الدقيقة.

معدل التنفس: 62 نفسًا/ الدقيقة معدل التنفس في العدّ الثاني: 59 نفسًا/ الدقيقة	لا، معدل التنفس في العدّ الثاني أقل من 60 نفسًا/ الدقيقة.
معدل التنفس: 56 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 42 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 53 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 67 نفسًا/ الدقيقة	يكرر العدّ. إذا كان معدل التنفس 60 نفسًا/ الدقيقة أو أكثر، يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا، وإذا كان معدل التنفس في العدّ الثاني أقل من 60 نفسًا/ الدقيقة، فلا يُعتبر ذلك تنفسًا سريعًا.
معدل التنفس: 55 نفسًا/ الدقيقة	لا
معدل التنفس: 62 نفسًا/ الدقيقة معدل التنفس في العدّ الثاني: 57 نفسًا/ الدقيقة	لا، معدل التنفس في العدّ الثاني أقل من 60 نفسًا/ الدقيقة.

12.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 22 و23 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية، وكيف يمكن استخدامها في تقديم المشورة، وراجع الإطار الأحمر للتعليمات الخاصة بحساب معدلات سرعة التنفس في الدقيقة. وعندما ينتهون، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

13.3.4 مناقشة جماعية: انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل

أخبر المشاركين أنك ستشرح علامة الخطورة السادسة: **انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.**

اشرح للمشاركين أن انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل هو الخط الذي يتشكل بين الصدر والبطن بسبب تحرُّك جدار الصدر السفلي إلى الداخل عندما يأخذ الطفل شهيقًا، وتحرُّك جدار الصدر العلوي والبطن إلى الخارج. وفي الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، يكون من الطبيعي وجود انسحاب خفيف للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل لأن جدار الصدر لديهم ليِّن. لكن عندما يكون الخط عميقًا، فهذا يدل على انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل ومرض رئوي خطير. وتُعتبر هذه علامة خطورة.اشرح للمشاركين النقاط التالية: كيفية الكشف عن انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل:

- يجب أن يكون الطفل هادئًا (لا يبكي)، وليس أثناء الرضاعة.
- لا يجب أن يكون خصر الطفل مثنيًا؛
- اطلب من مقدم الرعاية رفع ملابس الطفل فوق الصدر؛
- احظ جدار الصدر السفلي عندما يأخذ الطفل شهيقًا.
- حتى يمكن تحديد وجود انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، فإنه يجب أن يكون ظاهرًا بوضوح وفي كل نَفَس يأخذه الطفل.

فإذا لاحظت انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل عندما يبكي الطفل أو يرضع، فإن هذه ليست علامة خطورة. وإذا لم تكن متأكدًا من وجود انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، فليكن قرارك أنه لا يوجد انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.

14.3.4 فيديو توضيحي: انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 9 حول انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين (03:37 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل في هذه الفئة العمرية، وستتاح لهم فرصة التمرُّن على حساب معدل سرعة التنفس، والتحقُّق من وجود انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل من عدمه.

اعرض مقطع الفيديو، وتأكد أن كل مشارك يعرف الموضع الذي يجب فحصه للتحقق من وجود انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل من عدمه. وأكد على أنه قد يكون من الطبيعي وجود انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل الطفيف في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

وعندما ينتهي عرض الفيديو، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

15.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 19، ممارسات طلب الرعاية الصحية، متى يجب طلب الرعاية الصحية؟ التحقق من وجود علامة الخطورة 2، في الصفحة 21 من دليل المشاركين. ثم اطلب منهم الرجوع إلى الصفحتين 24 و25 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. ناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

16.3.4 تمرين الصور(2) وتقديم تعقيبات فردية: انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل

اطلب من المشاركين فتح الصفحة 22 من دليل المشاركين. سيجدون فيها ثلاث صور، وعليهم أن يقرروا أي من هذه الصور تدل أو لا تدل على وجود انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، عن طريق وضع علامة في المربع الصحيح. صحح إجاباتهم، كل على حدة. فإذا وجدت خطأ شائعًا، ناقشه في النهاية مع المجموعة.

17.3.4 مناقشة جماعية: علامات الخطورة: ارتفاع/ انخفاض درجة حرارة الجسم

أخبر المشاركين أنهم سيتعلمون علامة الخطورة السابعة، ألا وهي: ارتفاع/ انخفاض درجة حرارة الجسم.

واشرح للمشاركين أن الطفل السليم لا تكون درجة حرارة جسمه منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية. ولكن يمكن أن يصاب الطفل المصاب بعدوى شديدة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، وكلاهما يمثل علامة خطورة.

ذكِّر المشاركين أنهم قد تعلموا أهمية الحفاظ على دِفء الطفل. ويساعد هذا التدخل المهم على تجنب انخفاض درجة حرارة جسم الطفل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة. فانخفاض درجة حرارة الجسم تُعتبر علامة خطورة.

وقد يصعُب تحديد ما إذا كانت درجة حرارة المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية بمجرد لمسهم. وتُعتبر أفضل طريقة هي قياس درجة حرارة أجسامهم بمقياس الحرارة. وتتراوح درجة الحرارة

الطبيعية للمواليد وصغار الرُّضَّع بين 35.5 و37.5 درجة مئوية. ويمكن أن تدل أي درجة حرارة خارج هذا النطاق على المرض.

وتكون درجة الحرارة الإبطية مرتفعة عندما تكون 37.5 درجة مئوية أو أكثر؛

وتكون درجة الحرارة الإبطية منخفضة، عندما تكون 35.5 درجة مئوية أو أقل.

درجة الحرارة الإبطية المرتفعة: *37.5* درجة مئوية أو أكثر:

أثناء الزيارة المنزلية، إذا لمست الطفل، ووجدت أن درجة حرارته مرتفعة، فقد يكون ذلك نتيجة الإفراط في لفه بطبقات عديدة من الملابس أو ارتفاع درجة حرارة الغرفة. فتأكد من ذلك بقياس درجة حرارة جسمه باستخدام مقياس الحرارة.

درجة الحرارة الإبطية المنخفضة: *35.5* درجة مئوية أو أقل:

أثناء الزيارات المنزلية، إذا وجدت درجة الحرارة الإبطية للمولود منخفضة، دَفِّئ الغرفة، واجعل المولود في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، وغطِّ الطفل والأم ببطانية.

وإذا كان رضيعًا صغيرًا، دَفِّئ الغرفة، وألبسه الملابس الملائمة، وغطِّه ببطانية دافئة. وبعد فترة وجيزة، قس درجة الحرارة مرةً أخرى. فإذا كانت درجة حرارة الطفل لا تزال منخفضة، تجب إحالته فورًا إلى أحد المرافق الصحية.

إذا كانت مجموعة أدواتك تتضمن مقياس الحرارة، فيجب أن تستخدمه لقياس درجة الحرارة الإبطية للطفل للتحقق من علامة الخطورة هذه. وإذا لم يكن لديك مقياس حرارة، يمكنك تحسس المعدة أو الإبط لتحديد ما إذا كان الطفل يشعر بالحرارة أو البرودة على غير العادة.

ملاحظة إلى الميسِّرين: مجموعة أدوات العاملين الصحيين المجتمعيين التي اقترحها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط تشتمل على مقياس حرارة رقمي.

18.3.4 فيديو توضيحي: ارتفاع وانخفاض درجة حرارة الجسم

جهّز وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) لمقطع الفيديو 10، قياس درجة الحرارة الإبطية، ارتفاع وانخفاض درجة حرارة الجسم (04:53 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول قياس درجة الحرارة الإبطية، درجة حرارة الجسم المرتفعة والمنخفضة.

اعرض مقطع الفيديو، وتأكد من فهم المشاركين لجميع النقاط الواردة فيه.

19.3.4 عرض توضيحي عملي (خاص فقط بالعاملين الصحيين المجتمعيين الذين تتضمن مجموعة أدواتهم الوطنية مقياس حرارة)

ستحتاج إلى ما يلي:

- دمية
- مقياس حرارة رقمي
- صابون وماء دافئ

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 20 في الصفحة 23 من دليل المشاركين. واشرح الخطوات اللازمة لقياس درجة الحرارة الإبطية (اقرأ عليهم الخطوات) مع استعمال مقياس الحرارة الرقمي، بينما توضح الخطوات على الدمية. وتذكر أن تغسل يديك أولاً.

وأكّـد على أنـه عنـد قيـاس درجـة حـرارة الطفـل، يجـب على ا لعامـلين الصحـيين المجتمعـيين أن يغتنمـوا هـذه الفرصـة ليوضحـوا للأسرة كيفيـة القيـام بذلـك.



20.3.4 ممارسة عملية

ستحتاج إلى ما يلي:

- دمية
- مقياس حرارة رقمي
- صابون وماء دافئ

اطلـب مـن كل مشـارك أن يعـرض في دوره كيفيـة قيـاس درجـة حـرارة الطفـل، واطلـب مـن باقـي أفـراد المجموعـة التعليـق على الأداء.



21.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 20: ممارسات طلب الرعاية الصحية. متى يجب طلب الرعاية الصحية؟

التحقـق مـن وجـود علامـة الخطـورة 3، في الصفحـة 23 مـن دليـل المشـاركين. واطلـب مـن المشـاركين الاطلاع على الصفحـتين 26 و27 مـن الكتـاب الـقلاب. ناقـش الرسـومات التوضيحيـة والنصائـح المقدَّمـة وكيفيـة توظيفهـا عنـد تقديـم المشـورة. وناقـش أيضًـا التعليـمات المُقدَّمـة للعامـلين الصحـيين المجتمعـيين في الإطـار الأحمـر. وعندمـا ينتهـون، أجـب عـن أي أسـئلة قـد تكـون لديهـم.



22.3.4 مناقشة جماعية: علامات العدوى الموضعية

أخبر المشـاركين أنـك سـتشرح علامـة الخطـورة الثامنـة، ألا وهـي علامـات العـدوى الموضعيـة: احمـرار السُّرَّة، أو سـيلان القيـح مـن العيـنين، أو الدمامـل الجلديـة.

واسـأل المشـاركين عـن علامـات العـدوى الموضعيـة. اسـتمع إلى إجاباتهـم، ثـم أخبرهـم أن أكثر أنـواع العـدوى شـيوعًا هـي التـي تصيـب الجلـد والسُّرَّة والعيـنين. ويُعـتبر القيـح والاحمـرار مـن علامـات العـدوى الموضعيـة.

ولتحديد العدوى الموضعية، انظر لتعرف ما إذا كان هناك:

- سيلان للقيح من الجزء المتبقي من الحبل السري؛
- احمرار للجلد حول السُّرَّة؛
- توضح هاتان العلامتان أهمية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري، وهي نقطة ستُناقش لاحقًا.
- وجود دمامل جلدية ممتلئة بالقيح على جلد الطفل. ثم انظر إلى جسم الطفل بأكمله، ويشمل ذلك الظهر، والإبطين والأُرْبِية؛
- سيلان القيح من العينين.

وأكـد على أنـه في حالـة وجـود أي مـن علامـات العـدوى الموضعيـة، فإنـه يجـب إحالـة الطفـل فـورًا إلى أحـد المرافـق الصحيـة، لأن حالتـه قـد تتطـور إلى عـدوى شـديدة، إذا لم تُعالَـج.

23.3.4 فيديو توضيحي: مقطع الفيديو 11. علامات العدوى الموضعية

جهز مقطع الفيديو 11، علامات العدوى الموضعية (02:46 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول علامات العدوى الموضعية.

اعرض مقطع الفيديو، وكرر عرضه إذا كان ذلك ضروريًا.

وعندما ينتهي عرض الفيديو، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

24.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 28 و29 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

25.3.4 مناقشة جماعية: صِغَر حجم الأطفال

أخبر المشاركين أن آخر علامة خطورة هي: قلة وزن الأطفال.

اسأل المشاركين عن سبب ضرورة قياس وزن المواليد. استمع إلى إجاباتهم، ثم اشرح لهم أنه من الصعب تقدير ما إذا كان وزن المولود قليلا أم عاديًا بمجرد النظر إليه. وبالتالي، فإن أفضل طريقة هي قياس وزن الطفل. ويوزن الأطفال الذين يُولَدون في المرافق الصحية بصورة روتينية بعد الولادة مباشرةً. أما بالنسبة للأطفال الذين يُولدون في المنزل، فيجب قياس أوزانهم في نفس يوم الوضع، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

ويكون الأطفال قليلو الوزن الذين يعانون من نقص الوزن هم الأكثر تعرضًا للمخاطر والأشد تأثرًا بها خلال الأيام الأولى، ويحتاجون إلى الحصول على رعاية خاصة في أقرب وقت ممكن. وأكد على أنه في حالة ظهور أي علامة خطورة أخرى لدى الطفل، فإن العامل الصحي المجتمعي يجب ألا يضيع الوقت في وزن الطفل. ولكن، يجب أن يركز على إحالة الطفل إلى أحد المرافق الصحية على الفور.

ويكون الأطفال ذوو الوزن القليل مولودين مبكرًا، أو ربما لم ينموا بقدرٍ كافٍ في الرحم. ومن ثَمّ، لا يكون الأطفال قليلو الوزن مستعدين استعدادًا تامًا للعيش خارج الرحم، ويكونون أكثر عُرضة للإصابة بمرض خطير أو الوفاة أكثر من الأطفال ذوي الوزن المتوسط. وقد يواجه الأطفال قليلو الوزن عدة مشاكل، مثل:

- انخفاض درجة حرارة الجسم: نظرًا لوجود قدرٍ ضئيلٍ من الدهون في أجسام الأطفال قليلي الوزن، فقد لا يستطيعون الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم. وهذا يعني سهولة إصابتهم بالزكام والمرض. ويجب العمل على زيادة تدفئتهم.
- مشاكل التغذية: قد يحتاج الأطفال قليلو الوزن إلى لبن الأم للبقاء على قيد الحياة والنمو، ولكن معدتهم تكون صغيرة، وقد لا يمتلكون الطاقة اللازمة للرضاعة، كما أنهم يشعرون بالتعب بسهولة، ويمكن أن يواجهوا صعوبة في التعلق بالثدي بطريقة صحيحة. وهذا يعني أن الأطفال قليلي الوزن مُعرَّضون لخطر عدم الحصول على قدرٍ كافٍ من لبن الأم. وبالتالي، يجب إرضاعهم بشكل متكرر لضمان حصولهم على العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها.
- لعدوى: يكون الأطفال قليلو الوزن أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى، وقد لا تكون لديهم القوة الكافية لمكافحة الأمراض، مما يعني أن مقدمي الرعاية عليهم أن يكونوا أكثر تنبهًا بشأن النظافة الشخصية، ويشمل ذلك التدابير الأساسية مثل غسل اليدين.
- التنفس: قد لا تكون رئة الأطفال ذوي الوزن القليل مكتملة النمو، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

26.3.4 فيديو توضيحي: قياس وزن المواليد بعد الولادة

جهِّز مقطع الفيديو 12، قياس وزن المواليد (02:12 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول قياس وزن المواليد بعد الولادة.

اعرض مقطع الفيديو. وعند الانتهاء من عرض الفيديو، تأكد من اتباع أفراد المجموعة للنقاط التي وردت فيه. كرر عرض الفيديو إذا كان ذلك ضروريًا، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

27.3.4 عرض توضيحي: كيف يمكن قياس وزن الطفل باستخدام مقياس وزن محمول؟

اعرض على المشاركين مختلف أجزاء مقياس الوزن المحمول: القضيب العلوي، ومقبض الضبط، والخطاف والرافعة، والفت انتباههم إلى مقياس الوزن ذي الرموز اللونية. واطلب منهم تحديد الأجزاء المختلفة.

والفت انتباههم إلى التدرج الموجود على مقياس الوزن ذي الرموز اللونية. ووضح لهم أن مقياس الوزن يبدأ من 0 كغم، ويتدرج حتى 5 كغم. ارسم مقياس الوزن على اللوح الورقي القلاب. وضع علامة بين 1 كغم و2 كغم - على سبيل المثال 1.4 أو 1.7 أو 1.8 كغم - واطلب من المشاركين قراءة الوزن. كرر الخطوة مرةً أخرى، من خلال وضع علامة على مقياس الوزن بين 2 كغم و3 كغم.

خطوات وزن الطفل

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الإطار الأحمر في الصفحة 31 من الكتاب القلاب، واختر أحد المشاركين لقراءة التعليمات الخاصة بوزن الطفل، بينما تقوم أنت بتوضيح ذلك باستخدام مقياس الوزن. وأكد على أن هذه التعليمات موجَّهة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين، بينما يجب تقديم النصائح إلى الأمهات.

ومن الضروري الانتباه لعدم سقوط الطفل. ارفع القضيب العلوي بحرص باستخدام ذراعيك إذا كان ذلك ضروريًا، وزِن الطفل فوق فراش ناعم أو بالقرب من الأرض. ولا تقلق إذا بكى الطفل. فهذا أمرٌ طبيعي. ولا يجب أن تحمل الطفل أو تلمسه من الأسفل (سواء أنت أو مقدم الرعاية) لأن الوزن لن يكون دقيقًا في هذه الحالة. وأضف أنه من الضروري غسل الرافعة بانتظام عندما يلوثها الطفل.

ووضح النقاط التالية، إذا كان وزن الطفل:

- في المنطقة الحمراء (أقل من 2.0 كغم)، يُعتبر الطفل قليل الوزن للغاية، ويمكن أن يعاني من مشاكل شديدة فيما يتعلق بالشعور بالدفء، والتغذية، والتنفس. وفي هذه الحالة، يجب إحالة الطفل إلى أحد المرافق الصحية على الفور.
- في المنطقة الصفراء (2.0 - 2.4 كغم)، يُعتبر الطفل قليل الوزن، ويحتاج إلى رعاية خاصة لأنه قد يمرض بسهولة. ويجب أن يُحال هذا الطفل إلى أحد المرافق الصحية على وجه السرعة.
- في المنطقة الخضراء، (2.5 كغم أو أكثر)، يكون وزن الطفل طبيعيًا، ويحتاج إلى الرعاية المعتادة.

تذكر ألا تضيِّع الوقت في وزن الطفل حال وجود أيٍّ من علامات الخطورة الأخرى. وأحِلْ الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

زِن الطفل فقط إذا لم يكن هناك أي علامات خطورة أخرى

28.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 30 إلى 33 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. ويجب إعطاء عناية خاصة للتعليمات الخاصة باستخدام مقياس الوزن المحمول في الإطار الأحمر. وكرر أن هذه التعليمات موجهة فقط إلى العاملين الصحيين المجتمعيين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

29.3.4 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول علامات الخطورة

ذكِّر المشاركين أنه يجب عليهم ملاحظة علامات الخطورة في كل زيارة للمولود في المنزل، وملء استمارة التسجيل وَفقًا لذلك. وأخبرهم أن عليهم دائمًا أن يتذكروا غسل أيديهم قبل لمس الطفل.

وإذا لم يلاحظوا وجود أي علامات خطورة، فيجب عليهم الاستعانة بالكتاب القلاب لتعليم الأسرة كيفية تحديد العلامات، كما يجب أن يتحققوا دائمًا من فهم الأسرة لما يقولونه.

وأكِّد على أنه في حالة وجود أي من علامات الخطورة لدى الطفل، فيجب إحالته إلى أحد المرافق الصحية على وجه السرعة.

وفي بعض الأحيان، قد ترفض الأسرة التوجه مع طفلها إلى مرفق صحي. وبالتالي، يجب استعمال مهارات التواصل الجيد لإقناع الأسرة.

وفي حالة وجود أي من علامات الخطورة، يجب ألا يضيِّعوا الوقت في وزن الطفل، ولكن يجب وقف جميع المهام الأخرى والمساعدة في الإحالة.

30.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 21: ممارسات طلب الرعاية الصحية: تقديم المشورة حول علامات الخطورة، وإحالة الطفل الذي تظهر عليه إحدى علامات الخطورة، في الصفحة 24 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

31.3.4 مناقشة جماعية: المساعدة في الإحالة. مذكرة الإحالة

أخبر المشاركين أن الإحالة العاجلة للمواليد من شأنها أن تنقذ الأرواح.

وأخبرهم أنه بمجرد أن يكتشفوا إحدى علامات الخطورة، فعليهم أن يتخطوا جميع المهام الأخرى، ويحرروا مذكرة الإحالة إلى المرفق الصحي، ويساعدوا الأسرة في مواجهة أي صعوبات قد تواجهها أثناء التوجه بطفلها إلى هناك.

وزع مذكرة الإحالة على كل متدرب، ووضح لهم أن هذه هي الاستمارة التي سيملؤونها عند إحالة الطفل الذين توجد لديه علامة خطورة إلى أحد المرافق الصحية.

وهذه الاستمارة على ورقة من وجهين. فعلى الوجه الأول من الاستمارة، يسجل العاملون بعض البيانات.

ثم، يجب أن يسجلوا المعلومات المتعلقة بأسباب إحالتهم للطفل.

اقرأ الجزء العلوي من الاستمارة، ووضح كيفية ملئها، مع إيلاء عناية خاصة بالقسم المعْني بعلامات الخطورة، والمربعات التي يتعين على المشاركين وضع علامة فيها في حالة ملاحظة أي علامة من علامات الخطورة. كرِّر نفس الخطوات بالنسبة للقسم المعني بتحديد علامات الخطورة بالنسبة للأم.

أخْبِر المشاركين أن الجزء السفلي من استمارة التسجيل مُخصص للمرفق الصحي: وسيُستخدم لكتابة تعليقات المهنيين الصحيين، واسم الشخص الذي يفحص المولود و/ أو الأم هناك.

ويشتمل الوجه الآخر من الاستمارة على النصائح المُقدَّمة إلى الأم في الطريق إلى المستشفى:

- إذا كان الطفل قادرًا على الرَّضاعة، يجب أن تقوم الأم بإرضاعه كل ساعتين. وانصح الأم بأن ترضعه فقط من ثدييها. فقد تسوء حالة الطفل المريض إذا لم يرضع.
- يجب أن تحافظ الأم على دِفء الطفل. وبالنسبة للمواليد، يتحقق ذلك على أفضل نحو من خلال ملامسة جلد الأم لجلد الطفل. ويمكن لف الأطفال الأكبر سنًا في بطانية دافئة، إلا إذا كانوا يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، إذ يجب في هذه الحالة أن يكون الغطاء خفيفًا.
- إذا كان من الصعب تحقيق وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، فعلى الأم أن تلف الطفل بطبقات متعددة من الملابس، مع الحرص على إلباسه غطاء للرأس وجوربين.
- إذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة، فيجب لفه ببطانية خفيفة أو بطبقات قليلة.

32.3.4 التمرين الكتابي 4، وتقديم تعقيبات فردية

اطلب من المشاركين فتح الصفحتين 25 و26 من دليل المشاركين، وأخبرهم أنهم بصدد القيام بتمرين مكتوب.

وأخبرهم بأنك ستقرأ عليهم بعض المعلومات عن طفل مولود. ويتعين عليهم وَفقًا لهذه المعلومات، أن يقرروا إذا كان الطفل بحاجة إلى إحالة عاجلة أم لا. وإذا قرروا أن الطفل يحتاج إلى الذهاب إلى مرفق صحي، فيجب عليهم ملء كلا الوجهين من استمارة التسجيل.

اقرأ المعلومات التالية:

رُزقت منيرة بطفلة، اسمها سعادة. وهما يعيشان في قرية "المحبة".وقد وُلدت الطفلة منذ ثلاثة أيام.
وتستطيع الطفلة أن ترضع
ولا تعاني من تشنجات.
وكان معدل سرعة التنفس في العدّ الأول 60 نفسًا/ الدقيقة؛ بينما كان معدل التنفس في العدّ الثاني 64 نفسًا/ الدقيقة.
ولم يُلاحظ انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.
درجة الحرارة هي 34 درجة مئوية.
لا تتحرك إلا عند تحفيزها.
لا يوجد اصفرار للون راحة اليدين أو باطن القدمين.
لا يوجد قيح من السُّرَّة.
لا يوجد احمرار للجلد حول السُّرَّة.
لا يوجد قيح من العينين.
لم تزن الطفلة نظرًا لوجود علامات خطورة.
ولا تظهر على الأم أي علامات خطورة.

اسأل المشاركين عن مذكرة الإحالة. وعندما ينتهون من ملء مذكرة الإحالة، راجع ما كتبه كل مشارك على حدة. وناقش أي أخطاء مشتركة على مستوى المجموعة.

إذا لاحظت إحدى علامات الخطورة في المولود، فلا داعي لوزنه. تخطى جميع المهام الأخرى، وقدِّم مشورة حول الإحالة العاجلة. املأ مذكرة الإحالة وساعد الأسر في إحالة الطفل.

مذكرة الإحالة

اسم العامل الصحي المحتمعي: **(اسم المشارك)**

اسم الأم/ الطفل: **منيرة/ سعادة**

تاريخ الإحالة: **(تاريخ اليوم)**

القرية: **المحبة**

عمر الطفل عند الإحالة: ***3* أيام**

الوزن عند الولادة:

أسباب الإحالة

يعاني الطفل من: (ضع علامة في المربع الصحيح)

- ☐ ضعيف جدًا لا يقدر على الرضاعة أو الشرب
- ☐ تشنجات
- ☑ الحركة فقط عند التحفيز، أو عدم الحركة حتى بعد التحفيز
- ☐ تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله
- ☐ اصفرار راحة اليدين وباطن القدمين
- ☑ التنفس السريع
- ☐ انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل
- ☐ انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل
- ☐ درجة الحرارة الإبطية 37.5 درجة مئوية أو أقل
- ☑ درجة الحرارة الإبطية 35.5 درجة مئوية أو أقل
- ☐ علامات العدوى الموضعية
- ☐ الطفل صغير الحجم

تعاني الأم من (ضع علامة في المربع المناسب)

- ☐ نزيف شديد
- ☐ صُداع
- ☐ صعوبة التنفس
- ☐ حُمّى

يُملأ هذا الجزء في المرفق الصحي

تعليقات:

_____

_____

_____

فُحص في المرفق الصحي بواسطة: _____

في الطريق إلى المستشفى



☑ درجة الحرارة الإبطية 35.5 درجة مئوية أو أقل
على ألا يُعطَى أي شيء بخلاف لبن الأم.
وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين لا يرضعون، يُنصح بإعطائهم ماء مُحلى بالسكر في الطريق.



☑ حافظ على دِفء الطفل
حافظ على وجود الطفل في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل.

☐ إذا كان من غير الممكن ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، يُلف الطفل جيدًا مع إبقائه على مقربة من أمه

33.3.4 مناقشة جماعية: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين. من الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟

اسأل المشاركين عن المكان الذي يتوجه إليه الناس في مجتمعاتهم عندما يطلبون الرعاية الصحية لأطفالهم. استمع إلى إجاباتهم، ثم أكّد على أنه يجب طلب الرعاية الطبية من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية. وأكّد على أنهم يجب أن ينصحوا الأسر بأن طلب الرعاية الصحية من مصادر غير مُدرّبة قد يضر الطفل ولا ينفعه، لدرجة أنه قد يتسبب في موته.

34.3.4 مناقشة جماعية: صعوبات نقل طفل إلى المستشفى

اسأل المشاركين إذا كان من المرجح أن يواجه الناس في مجتمعاتهم صعوبات في نقل طفل إلى المستشفى. استمع إلى إجاباتهم، ثم اقرأ على المشاركين الصعوبات التي من المرجح أن تواجهها الأسر، كما وردت في الصفحة 37 من الكتاب القلاب. وكلما تذكر واحدة من الصعوبات، اسأل المشاركين عن نصيحتهم بشأنها. استمع إلى اقتراحاتهم، ثم اقرأ النصائح الواردة في الكتاب القلاب. وإذا ذكر المشاركون مشاكل و/ أو نصائح غير واردة في الكتاب القلاب، أعد جدولاً موسعًا بها، ثم اطبعه ووزعه عليهم في جلسة لاحقة.

وأكّد على أن إحدى أهم مهامهم باعتبارهم عاملين صحيين مجتمعيين تتمثل في القيام بشكل واضح ودقيق بشرح أسباب ضرورة أخذ الطفل إلى أحد المرافق الصحية إذا ظهرت عليه إحدى علامات الخطورة.

35.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات 34-37 من الكتاب القلاب. ناقش التعليمات الموجهة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

36.3.4 التمرين الكتابي 5، تقديم تعقيبات فردية: ملء استمارة التسجيل الخاصة بعلامات الخطورة

أخبر المشاركين أنهم سيقومون بعمل تمرين كتابي حول ملء استمارة التسجيل الخاصة بعلامات الخطورة.

واطلب منهم ملء استمارة التسجيل الواردة في الصفحة 27 من دليل المشاركين. وراجع استمارة كل مشارك على حدة، واذكر ملاحظاتك لكل مشارك.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحة 27 من دليل المشاركين، تمرين كتابي 5. ويجب أن يملؤوا استمارة التسجيل فيما يتعلق بالسيناريو الوارد أدناه. (الاستمارة المكتملة واردة تحت السيناريو).

أنت أحد العاملين الصحيين المجتمعيين في قرية النصر، وحاليًا في زيارة لأسرة، إذ وضعت الأم (فريدة) لتوها طفلًا ذكرًا اسمه حسن. وعندما سألت عن أحوال الأم وطفلها، قالت الأم إن الطفل يرفض الرضاعة. وتجد أن الطفل في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، وعندما تسأل إذا كنت تستطيع إلقاء نظرة على حسن، ترحب الأسرة بذلك.

اغسل يديك، ثم اطلب من الأم إرضاع الطفل. يبدو أن الطفل أضعف من أن يرضع. ولا يعاني حسن من تشنجات. وعندما تسأل الأم عن ذلك، تجيب بأنه لم تصبه أي تشنجات. ولا يعاني حسن من التنفس السريع أو انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل. كما أنه ليس مصابًا باليَرَقان. ودرجة حرارته *34* درجة مئوية. ولا تزنه بسبب وجود علامتي خطر، ألا وهما: ضعيف جدا ولا يقدر على الرَّضاعة، وانخفاض درجة حرارة الجسم. املأ استمارة التسجيل الخاصة بحسن.

وعندما ينتهي المشاركون من ملء الاستمارات، قدم تعقيبات فردية لكل منهم. وناقشهم بشأن ما سيفعلونه لحسن، وأسباب ذلك.

استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر	
تاريخ الزيارة: **(تاريخ اليوم)** اسم العامل الصحي المجتمعي: **(اسمك)** القرية: **النصر** اسم الطفل: **حسن** السن: **5 ساعات** تاريخ الميلاد: **تاريخ اليوم** اسم الأم: **فريدة** وزن المولود عند الميلاد: .... درجة حرارة المولود: ***34*** **درجة مئوية**	
ألقِ التحية على مُقدم/ مُقدمة الرعاية وقدِّم نفسك ووضح الغرض من الزيارة. اسأل عن أحوال الطفل: ... **يرفض الطفل الرضاعة** ... (دوّن ما تقوله الأم) **وقدّم المشورة في وجود أفراد الأسرة الآخرين**	
فهم الوضع	**لاحظ الممارسة**
2. بالنسبة للمواليد **اسأل إذا كان الطفل يشعر بالدفء، وانظر لتتحقق بنفسك** نعم ☑ لا ☐ قدِّم المشورة والمساعدة **إذا كانت الإجابة بنعم**، على نحو صحيح ☑، امدح الأم إذا لم تكن صحيحة (مثل: الإفراط في لف الطفل)☐، قدّم المشورة والمساعدة	☑ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل ☐ ارتداء الملابس بشكل سليم ☐ الإفراط في لف الطفل ☐ يرتدي ملابس خفيفة

3. تحقق من وجود علامات الخطورة لدى الطفل ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة☑ التشنجات☐ انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل☐ اصفرار راحة اليدين وباطن القدمين☐ العدوى الموضعية☐ ارتفاع/ انخفاض درجة الحرارة☑ التنفس السريع☐ انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل☐ تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله☐ انخفاض الوزن بدرجة كبيرة☐ **إذا رأيت أي علامة من علامات الخطورة، فتخطى جميع المهام الأخرى، واكتب مذكرة إحالة، وساعد في الإحالة العاجلة**	**لاحظ علامات الخطورة**
3. التحقق من وجود علامات الخطورة من عدمها بالنسبة للأم نزيف شديد☐ نوبات☐ صداع شديد/ رؤية مشوشة☐ ألم في البطن☐ صعوبة في التنفس☐ وَذَمة في اليدين/ القدمين☐ ألم في رَبْلة الساق☐ **إذا رأيت أي علامة من علامات الخطورة، فتخطى جميع المهام الأخرى، واكتب مذكرة إحالة، وساعد في الإحالة العاجلة**	
4. اسأل الأسرة عمن يطلبون منه الرعاية الصحية إذا مرض الطفل الطبيب☐، قدم المدح والثناء المرفق الصحي☐، قدم المدح والثناء عامل صحي مجتمعي☐، قدم المدح والثناء آخرين☐، قدّم المشورة	



37.3.4 لعب الأدوار 1. المساعدة في الإحالة

أخبر المشاركين أنهم سيؤدون تمري لعب الأدوار للتدريب على إسداء النصائح حول الإحالة العاجلة إلى المرفق الصحي باستخدام مهارات التواصل الجيد والكتاب القلاب. جهِّز نُسخًا من السيناريوهات الأربعة الواردة أدناه، التي تدور حولها التدريبات التمثيلية حول المساعدة في الإحالة. وسيمثل الميسِّر دور الأم، بينما سيمثل الميسِّر المشارك دور أحد أفراد الأسرة الآخرين. وسيتناوب المشاركون الأدوار لتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي.

جهِّز أوراقًا مطوية للمواقف الأربعة. واطلب من المشارك الذي سيمثل دور العامل الصحي المجتمعي أن يأخذ ورقة، ويمثل الدور وَفقًا لما هو مكتوب فيها.

امنح كل مشارك الفرصة لتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي . ويمكن إعادة استخدام نفس سيناريوهات الحالات إذا كان هناك أكثر من أربعة مشاركين.

وبعد كل تمرين من تمارين لعب الأدوار، ناقشه مع المشاركين باستخدام الأسئلة التالية:

- هل استخدم العامل مهارات التواصل الجيد؟
- هل شرح العامل أهمية الإحالة العاجلة؟
- هل نجح العامل في إقناع الأسرة بالتوجه إلى المرفق الصحي؟

الموقف 1

وُلدت سميرة منذ خمس ساعات. وهي تعاني من التنفس السريع. ولا يرغب والداها في التوجه إلى المرفق الصحي لأن طفل أحد جيرانهم قد توفي بالمستشفى الشهر الماضي.

الموقف 2

وُلد هاني منذ سبع ساعات. وتبلغ درجة حرارته الإبطية 37 درجة مئوية، ولديه قيحٌ يخرج من سُرَّته. ولا يستطيع والداه أن يصطحباه إلى المستشفى لأن لديهما أطفالاً آخرين في المنزل ولا يوجد من يرعاهم.

الموقف 3

وُلدت سارة منذ سبعة أيام. وتبلغ درجة حرارتها الإبطية 34 درجة مئوية، ولا تتحرك إلا عند تحفيزها على ذلك. والأم وحدها بالمنزل، ولا تستطيع أن تذهب إلى المرفق الصحي دون إذن من زوجها.

الموقف 4

محسن يبلغ من العمر يومًا واحدًا. ولديه احمرار في منطقة الجلد حول السُّرَّة. ولا تستطيع الأسرة التوجه إلى المستشفى لأنها ليس لديها المال الكافي لدفع مصاريف المواصلات.



38.3.4 مناقشة جماعية: 2. ممارسات الوقاية

أخبر المشاركين أنك ستبدأ مناقشة الفئة الثانية من ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للمواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين، ألا وهي ممارسات الوقاية.

اطلب من المشاركين تقديم أمثلة لممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية التي يمكن أن تساعد على الوقاية من الأمراض. ثم، وضِّح أن هناك أربع ممارسات أساسية للوقاية:

- التطعيم
- غسل اليدين
- النوم تحت ناموسيات (في المناطق التي تشكل الملاريا فيها خطرًا)
- استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد

التطعيم

اسأل المشاركين عن أهمية التطعيم. واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية:

يحمي التطعيم الأطفال من المرض الشديد ومضاعفات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطراف، وفقدان حاسة السمع، والتشنجات، وتلف المخ، والعَمَى، والوفاة. وإذا لم يتلق الأطفال تطعيماتهم، فقد ينشرون المرض إلى أطفال آخرين أيضًا.

ويجب أن يحصل الأطفال في هذا العُمر على التطعيمات التالية (يجب اتباع الجدول الوطني للتطعيمات):

- الجَرْعة الأولى من لقاح التهاب الكبد B، ويُفضل أن يكون ذلك خلال 24 ساعةً من الولادة؛
- جرعة الولادة (الجرعة الصفرية) من لقاح شلل الأطفال الفموي؛
- لقاح بي سي جي.



39.3.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 38 و39 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المُقدَّمة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



40.3.4 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية: غسل اليدين

أخبر الممارسين أنهم قد اطلعوا على ممارسات طلب الرعاية الصحية. وفي هذه الجلسة، ستناقش معهم الفئة الثانية من ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، ألا وهي: ممارسات الوقاية.

وتتمثل الممارسة الأولى في إطار هذه الفئة في غسل اليدين.

أكِّد على أن غسل اليدين بالماء والصابون هو أهم إجراء يمكن أن تقوم به الأمهات لحماية صحة الأسرة.

واسأل المشاركين عن سبب أهمية قيام الأمهات بغسل أيديهن. واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية:

- يعمل غسل اليدين على الوقاية من الأمراض وانتشار العدوى، كما يوفر الوقاية من أمراض فترة الطفولة، مثل الالتهاب الرئوي والإسهال، وهما أكثر الأمراض التي تتسبب في وفاة الأطفال دون سن الخامسة؛
- لا يُعتبر غسل اليدين مجرد شطف اليدين سريعًا، ولكنه يستغرق 20 ثانيةً، ويستلزم ماءً دافئًا وصابونًا؛
- يساعد غسل اليدين بالصابون على إزالة المكروبات من اليدين، مما يساعد على الوقاية من العدوى، نظرًا لأن الناس كثيرًا ما يلمسون أعينهم، وأنوفهم، وأفواههم دون حتى أن يدركوا أنهم يقومون بذلك.

إذا لم يكن في المنازل مراحيض مزوَّدة بمصدر للماء وحوض، فيجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن ينصحوا الأسر بإنشاء مكان داخل المنزل مخصَّص لغسل اليدين. ويجب أن يتوفر في هذا المكان حوض لغسل اليدين، وحاوية للماء وصابون أو أحد البدائل المحلية.

اسأل المشاركين: متى يجب غسل اليدين؟ استمع إلى إجاباتهم، ثم أكد على ضرورة غسل اليدين في الأوقات التالية:

- قبل لمس الطفل؛
- قبل إرضاع الطفل؛
- بعد تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل الذي تبول/ تبرز؛
- بعد استخدام المرحاض؛
- قبل إعداد الطعام؛
- قبل تناول الطعام؛
- قبل تقديم الرعاية لشخص مريض أو بعدها؛
- بعد التمخُّط، أو السُّعال، أو العطس؛
- بعد ملامسة الحيوانات أو علفها أو فضلاتها؛
- بعد ملامسة النفايات.

يتعين على جميع أفراد الأسرة غسل أيديهم للحيلولة دون انتشار المرض على مستوى الأسرة.

وأكِّد على أن خطوات غسل اليدين الروتيني للأسرة تختلف عن تلك التي تعلَّم العاملون الصحيون المجتمعيون اتباعها لغسل أيديهم.

اطلب من المشاركين الاطلاع على خطوات غسل اليدين الروتيني التي تعلَّم العاملون الصحيون المجتمعيون اتباعها لغسل أيديهم، والتي تُعتبر أمرًا ضروريًا قبل لمس الطفل.

راجع معهم خطوات غسل اليدين للعاملين الصحيين المجتمعيين، وأخبرهم أنه يجب عليهم أن يغسلوا أيديهم عند دخول أي منزل.

ووضح أنهم عندما يسألون عن المكان الذي يستطيعون فيه القيام بغسل اليدين بمجرد دخول المنزل في أول زيارة ستتاح لهم فرصة تقييم المرافق المتاحة لدى الأسرة لغسل اليدين سريعًا. وأكِّد على أنهم يستطيعون استخدام ملاحظاتهم لتقديم النُّصح للأسرة ومساعدتها في تجهيز مكان لغسل اليدين، إذا لزم الأمر.

وأخبر المشاركين أن يفتحوا الصفحتين 40 و41 من الكتاب القلاب، ويتبعوا التعليمات الواردة فيهما بينما تقوم أنت بعرض خطوات غسل اليدين.

1. بلل اليدين بالماء
2. افرك اليدين المبللتين بالصابون، بحيث يغطي الصابون اليدين بالكامل
3. افرك راحة اليدين معًا

4. افرك ظهر كل يد براحة اليد الأخرى مع تشبيك الأصابع
5. افرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع
6. افرك ظهر الأصابع مع تشبيكها
7. نظف الإبهام من خلال تشبيكه باليد المقابلة في حركة دائرية
8. افرك أطراف الأصابع في راحة اليد المقابلة في حركة دائرية
9. افرك كل معصم باستخدام اليد المقابلة
10. اشطف اليدين بالماء
11. جفف اليدين بِمِنْشَفة نظيفة أو مجفف الهواء

وتذكر ألا تغلق مطلقًا صنبور الماء بيديك، ولكن استخدم مرفقك أو منشفة. وإذا لم يتوافر في المنزل صنبور وحوض، اطلب من أحد أفراد الأسرة صب ماء نظيف من إبريق ماء، واغسل يديك فوق إناء غسل اليدين.



41.3.4 عرض عملي: غسل اليدين

ستحتاج إلى ما يلي:

- صابون
- إبريق ماء
- إناء كبير
- منشفة نظيفة

أخبر المشاركين أنك ستريهم كيفية تقديم المشورة للأم بشأن غسل اليدين. وستقوم بتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي، بينما يقوم الميسِّر المشارك بتمثيل دور الأم.

اعرض خطوات غسل اليدين، ثم أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



42.3.4 ممارسة عملية: غسل اليدين

جهِّز مستلزمات غسل اليدين.

قسِّم المشاركين إلى مجموعات من اثنين. سيقوم أحد المشاركين بتمثيل دور الأم، بينما يقوم الآخر بتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي الذي يعلِّم الأم كيفية غسل يديها. وعلى باقي أفراد المجموعة ملاحظة كل زوج من الزملاء أثناء تقديم العرض. وتأكد من مشاركة كل مشارك في غسل اليدين. وعندما تنتهي العروض التوضيحية، يمكن مناقشة النقاط التالية:

- ما هي الأمور الجيدة التي قام بها العامل الصحي المجتمعي؟
- هل تعلمت الأم مهارات غسل اليدين بطريقة صحيحة؟
- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات التواصل الجيد؟
- ما هي الأمور التي يستطيع العامل الصحي المجتمعي القيام بها على نحو أفضل؟



43.3.4 قراءة:

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 40 و41 من الكتاب القلاب. وعندما ينتهون من القراءة، ناقش النقاط التي أثيرت، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم. والفت انتباههم إلى التعليمات الواردة في الإطار الأحمر.



44.3.4 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية. النوم تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات حشرية للوقاية من الملاريا (في المناطق التي تنتشر فيها الملاريا) واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد

النوم تحت ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية

اسأل المشاركين عما يعرفونه عن الملاريا، وأكِّد على أنه مرض خطير يحمله البعوض، وقد يكون مُميتًا.

وأخبرهم أن البعوض الذي يحمل طفيليات الملاريا يلدغ ليلاً. ودون الحماية التي توفرها الناموسيات، تكون الأمهات والأطفال عُرضة للدغ البعوض أثناء نومهم، وقد يُصابون بالملاريا. وتُعتبر الملاريا سببًا رئيسيًا لوَفَيَات الأطفال دون الخامسة. وأضف أنه يتعين عليهم أن ينصحوا الأسر بالأماكن التي يستطيعون الحصول منها على ناموسيات مُعالَجة بمبيدات حشرية. وتستطيع الأسر أن تتعلم كيفية استعمال هذه الناموسيات في المرافق الصحية.

استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد

اسأل المشاركين عما إذا كانت الأسر في مجتمعاتهم تميل إلى وصف المضادات الحيوية لنفسها، أو تشتريها مباشرةً من الصيدلية. استمع إلى إجاباتهم، ثم أخبرهم أنه بينما تُعتبر المضادات الحيوية مفيدة لقتل المكروبات، إلا أن الأمراض المختلفة تتطلب مضادات حيوية مختلفة، ولا يستطيع أن يصف المضادات الحيوية وتوقيت تناولها وكيفيته إلا المهنيون الصحيون المدرَّبون تدريبًا رسميًا.

ولسوء الحظ، فإن العديد من الأسر تتوجه مباشرةً إلى الصيدليات لشراء المضادات الحيوية، أو قد تُعطي أطفالها مضادات حيوية قديمة موجودة في المنزل، أو تأخذ زجاجة مضاد حيوي مفتوحة من أحد الجيران أو الأخوات، وما إلى ذلك.

وأكِّد على ضرورة التخلص من زجاجات المضادات الحيوية المفتوحة. ولا يحتاج الطفل عادةً إلى مضاد حيوي، أو قد يحتاج إلى نوعٍ مختلف. ويمكن أن يؤدي الإفراط في استعمال المضادات الحيوية إلى تطور مقاومة المكروبات، وقد يعوق نَماء الأطفال.

> تُعتبر الملاريا مرضًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. وتكون الأمهات والأطفال عُرضة بصفة خاصة لخطر الإصابة بالملاريا. وللحيلولة دون وقوع ذلك، يجب أن تنام الأمهات والأطفال تحت ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية. ويمكن أن يسبب استعمال المضادات الحيوية على نحو غير رشيد إلى الإضرار بالأطفال، إذ ستقاوم المكروبات المضادات الحيوية، وقد يُعوق ذلك نَماء الطفل أيضًا.



45.3.4 قراءة

يقرأ المشاركون الإطار 22: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، 2: ممارسات الوقاية، في الصفحة 27 من دليل المشاركين، والصفحتين 42 و43 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المُقدّمة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



46.3.4 لعبة: بطاقات "صواب وخطأ" 1 (علامات الخطورة في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين)

ستحتاج إلى: مجموعتين من البطاقات حول علامات الخطورة في المواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن شهرين وطاولة للعب عليها.

وأخبر المشاركين أنهم سيراجعون علامات الخطورة في المواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن شهرين من خلال لعبة بطاقات "صواب وخطأ".

قسِّم المشاركين إلى فريقين. وعلى جانبٍ واحدٍ من الطاولة، ضع البطاقتين المكتوب على أحدهما "صواب" ولونها أخضر، ومكتوب على الأخرى "خطأ" ولونها أحمر بجوار بعضهما البعض. ووزِّع مجموعة من البطاقات على كل فريق. وقل إن البطاقات تشتمل على عبارات عن علامات الخطورة التي تعلَّموها. واشرح لهم أنه يجب عليهم أن يقَرَؤوا العبارة المكتوبة على البطاقة، ويضعوا البطاقة ذات العبارة الصحيحة تحت البطاقة الخضراء، بينما يضعوا البطاقة ذات العبارة الخاطئة تحت البطاقة الحمراء.

وأخبرهم أنك ستمنحهم 10 دقائق للانتهاء من هذه اللعبة. وعندما تمر الدقائق العشر، اطلب منهم أن يتوقفوا وناقش معهم أين وضع كل فريق بطاقاته، واشرح العبارة الواردة في كل بطاقة، وما إذا كانت صحيحة أم خطأ، مع ذكر السبب. عِد البطاقات التي وُضعت في المكان الصحيح، وأعلن عن الفريق الفائز. ويُصفَّق للفريق الفائز.

صواب	خطأ
تُعتبر درجة الحرارة المنخفضة علامة خطورة في المواليد	يُعتبر العدُّ الأول الذي يبلغ 65 نفسًا في الدقيقة تنفسًا سريعًا في المواليد.
يجب ألا تحسب معدل سرعة تنفس المواليد أثناء الرضاعة.	تُعتبر التشنجات أمرًا طبيعيًا في المواليد.
لا يُعتبر العدُّ الأول الذي يبلغ 57 نفسًا في الدقيقة تنفسًا سريعًا في المواليد.	يمكن الحكم على ما إذا كان المولود يتحرك بقدر أقل أو لا يتحرك على الإطلاق أثناء نومه.
إذا لم تكن متأكدًا من انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، فلا يوجد إذًا انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.	إذا رأيت انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل مرةً واحدةً فقط في المولود، فإن ذلك يُعتبر انسحاباً شديداً للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.
تدل الحرارة المنخفضة والمرتفعة على الإصابة بعدوى خطيرة.	يمكن الحكم على انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل دون رفع قميص الطفل عنه.
يُعتبر اصفرار راحة اليدين وباطن القدمين من علامات الخطورة.	في حالة الإصابة بعدوى خطيرة، تكون درجة حرارة المواليد مرتفعة فقط، وليست منخفضة مطلقًا.
قبل التحقق من علامات الخطورة، اغسل يديك.	تُعتبر حركة الجسم الواحدة للخارج نفسًا واحدًا.



47.3.4 عرض توضيحي. ملء استمارة التسجيل الخاصة بعلامات الخطورة وممارسات الوقاية

أخبر المشاركين أنهم سيتعلمون كيفية ملء استمارة التسجيل الخاصة بممارسات طلب الرعاية الصحية والوقاية.

\واشرح للمشاركين أن القسم المتعلق بعلامات الخطورة موجود في أعلى استمارة التسجيل لسبب معين، وهو أن علامات الخطورة هي أول ما يجب أن يتحقق منه العامل الصحي المجتمعي، وإذا لوحظت إحدى علامات الخطورة، فيجب وقف جميع المهام الأخرى من أجل المساعدة في الإحالة العاجلة إلى أحد المرافق الصحية.

وأخبرهـم أن ممارسـات الوقايـة موجـودة في موضـع أدنى في اسـتمارة التسـجيل لأن بعـض المهـام الأخـرى، مثـل العنايـة بالجـزء المتبقـي مـن الحبـل السري، قـد تكـون أهـم. وإذا لم تتـم العنايـة بالجـزء المتبقـي مـن الحبـل السري بشـكل سـليم، فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلى عـدوى خـطيرة.

راجـع مـع المشـاركين المربعـات التـي يجـب أن يضعـوا علامـة عليهـا إذا لاحظـوا واحـدةً مـن علامـات الخطـورة. وإذا لم يكـن هنـاك أي علامـات خطـر ظاهـرة، فيجـب أن تُترك المربعـات فارغـة. ويجـب على العامـل الصحـي المجتمعـي أن يشرح للأسر كيفيـة تحديـد علامـات الخطـورة باسـتخدام الكتـاب الـقلاب. فـإذا ظهـرتْ لاحقًـا أيٌّ مـن علامـات الخطـورة، يجـب طلـب الرعايـة الصحيـة مـن أحـد مقدمـي الرعايـة الموثـوقين في الوقـت المناسـب.



الجلسة 8:
المكون 4: تقديم المشورة حول العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 13، العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري
- أنبوب جل الكلورهيكسيدين 4%، أو زجاجة من محلول الكلورهيكسيدين 7.5% (حسب السياسات الوطنية)

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، يكون المشاركون قد اكتسبوا المهارات اللازمة من أجل:
- العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري؛
- تقديم مشورة بشأن أهمية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري؛
- تعليم الأم كيفية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري؛
- استخدام الأدوات اللازمة لتقديم المشورة حول العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري.

1.4.4 مناقشة جماعية: المكون 4: العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري

أخبر المشاركين أنك ستناقش معهم المكون الرابع من مكونات الرعاية لهذه الفئة العمرية، ألا وهو العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري.

يُعتبر الحبل السري نقطة دخول محتملة لأنواع خطيرة من العدوى، ويجب العناية به بوضع الكلورهيكسيدين عليه.

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري. واستمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر في النهاية ما يلي: **ويجب تحذير الأمهات من أن الكلورهيكسيدين يُوضع فقط على الجزء المتبقي من الحبل السري، ولا يُوضع مطلقًا على العينين. فقد يسبب العَمَى.**

وتُطبَّق العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري فقط في إطار الرعاية المُقدمة إلى المواليد أثناء الأسبوع الأول إلى الثاني من الولادة.

وتتمثل خطوات العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري فيما يلي:

اطلب من المشاركين فتح الصفحة 44 من الكتاب القلاب. واشرح لهم الرسومات التوضيحية، مع التأكيد على أنهم يجب أن يبدؤوا بما يلي:
- تقديم المشورة للأم بشأن أهمية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري. واطلب منهم أن يخبروك بأسباب أهمية العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري،
- ثم، ابدأ في ذكر خطوات العناية:
- اغسل يديك بالماء والصابون. (اطلب من المشاركين أن يُذكِّروك بالخطوات التي تعلَّموها لغسل اليدين (بالنسبة للأسر). وصحح ما يقولون، إذا لزم الأمر)؛

- اكشف الجزء المتبقي من الحبل السري، مع الإبقاء على الطفل دافئًا؛
- نظِّف الجزء المتبقي من الحبل السري من أي تلوث قد يكون أصابها من البول أو البراز.

ابدأ في وضع جل الكلورهيكسيدين 4% أو محلول الكلورهيكسيدين بمجرد أن ينقطع الحبل من أعلى الجَدَعَة (أيْ الجزء الذي يتبقى من الحبل السري) - أرِ المشاركين أنبوب الكلورهيكسيدين - ووزعه على جميع منطقة الجلد المحيطة بالجزء المتبقي من الحبل السري. وثبت الكلورهيكسيدين جيدًا على الجلد.

- اسمح للحبل السري بأن يجف تمامًا في الهواء قبل أن تُلبس الطفل.
- ألبس الطفل ملابس فضفاضة.
- تجنب سحب الجزء المتبقي من الحبل السري أو شدها.
- لا تُغطِ الجزء المتبقي من الحبل السري.

ويمكن استعمال جل أو محلول الكلورهيكسيدين مرةً واحدةً كل يوم لمدة سبعة أيام (وقد يختلف ذلك حسب المبادئ التوجيهية الوطنية).

2.4.4 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأم بشأن العناية بالحبل السُّري

ناقش مع المشاركين كيفية تقديم المشورة للأم بشأن العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري.

وكرر أنه يجب عليهم أولاً أن يستخدموا استمارة التسجيل لتدوين ملاحظاتهم، واطرح عليهم أسئلة لفهم الوضع.

واشرح للمشاركين القسم المعني بالعناية بالحبل السُّري في استمارة التسجيل. وأخبرهم أنه يتعين عليهم سؤال الأم عن كيفية عنايتها بالحبل السُّري، ووضع علامة على المربع الذي يُعبر عن إجابة الأم. ثم، يجب أن يلاحظوا الجزء المتبقي من الحبل السري بأنفسهم ليروا إذا كانت نظيفة أم لا. وبعد ذلك، يجب أن يضعوا علامة في المربع ذي الصلة أسفل عمود الملاحظة. ووضح أين وكيف يجب عليهم وضع العلامة في المربع بينما تشرح لهم ذلك.

إذا كانت الأم تعتني بالحبل السُّري عنايةً جيدةً، فامدحها. أما إذا لم تكن تعتني به جيدًا، فيجب أن تقدم لها المعلومات ذات الصلة ودعمًا عمليًا.

3.4.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 23: العناية بالجزء المتبقي من الحبل السري، في الصفحة 29 من دليل المشاركين والصفحتين 44 و45 من الكتاب القلاب. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

4.4.4 فيديو توضيحي

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 13، العناية بالحبل السُّري (02:44 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول العناية بالحبل السُّري.

اعرض مقطع الفيديو. وعند الانتهاء من العرض، سلِّط الضوء على أهم النقاط، وكرر عرضه إذا كان ذلك ضروريًا. ثم، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



5.4.4 التمرين الكتابي 6: ملء استمارة التسجيل

اطلب من المشاركين أداء التمرين الكتابي 6 في الصفحة 30 من دليل المشاركين. واطلب منهم قراءة السيناريو الوارد في دليل المشاركين وملء الاستمارة وَفقًا لما جاء به. وعندما ينتهون من ذلك، قدِّم ملاحظاتك على كل استمارة.

استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرُّضَّع حتى سن ستة أشهر	
تاريخ الزيارة: **(تاريخ اليوم)** اسم العامل الصحي المجتمعي: **(اسمك)** القرية: **السلام** اسم الطفل: **سماح** السن: **5 أيام** تاريخ الميلاد:..... اسم الأم: **سامية** وزن المولود عند الميلاد: **2.95 كغم** درجة حرارة المولود: **36.5 درجة مئوية**	
ألقِ التحية على مُقدم/ مُقدمة الرعاية وقدِّم نفسك ووضح الغرض من الزيارة. اسأل: كيف حال الطفل؟ ... **بخير**..... (دوّن ما تقوله الأم) **قدّم المشورة في وجود أفراد الأسرة**	
فهم الوضع	**لاحظ الممارسة**
1. بالنسبة للمواليد اسأل عما إذا كان الطفل دافئًا أم لا وانظر لتتحقق بنفسك: نعم ☐ لا ☑ قدِّم المشورة والمساعدة **إذا كانت الإجابة بنعم**، على نحو صحيح ☐، امدح الأم إذا لم تكن صحيحة (مثل: الإفراط في لف الطفل)☐، قدّم المشورة والمساعدة	☐ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل ☐ ارتداء الملابس بشكل سليم ☐ الإفراط في لف الطفل ☑ ارتداء ملابس خفيفة ☐ غير مرتدٍ لملابسه
2. تحقق من وجود علامات الخطورة لدى الطفل: لاحظ وعلِّم الأسرة: ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة☐ التشنجات☐ انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل☐ اصفرار راحة اليدين وباطن القدمين☐ العدوى الموضعية☐ ارتفاع/ انخفاض درجة الحرارة☐ التنفس السريع☐ انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل☐ تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله☐ انخفاض الوزن بدرجة كبيرة☐ **إذا رأيت أي علامة من علامات الخطورة، فتخطى جميع المهام الأخرى، واكتب مذكرة إحالة، وساعد في الإحالة العاجلة**	**لاحظ علامات الخطورة**
3. التحقق من وجود علامات الخطورة من عدمها بالنسبة للأم نزيف شديد☐ نوبات☐ صداع شديد/ رؤية مشوشة☐ ألم في البطن☐ صعوبة في التنفس☐ وَذَمة في القدمين☐ **(إذا رأيت أي علامة من علامات الخطورة، فأوقف جميع المهام الأخرى وانصح بالإحالة، حرر مذكرة إحالة، وقدِّم المساعدة اللازمة)**	
4. اسأل الأسرة عمن يطلبون منه الرعاية الصحية إذا مرض الطفل الطبيب☐، قدم المدح والثناء المرفق الصحي☐، قدم المدح والثناء عامل صحي مجتمعي☐، قدم المدح والثناء صيدلية، استشارة الآخرين، قدّم المشورة	
5. هل تعتني الأم بالحبل السُّري (خلال الأسبوع الأول بعد الوضع): نعم☑ لا☐، قدم المشورة والمساعدة إذا كانت الإجابة نعم، فكيف يتم ذلك؟ إذا كانت الخطوات صحيحة☑، امدح إذا كانت غير صحيحة☐، قدم المشورة والمساعدة	☑ الجزء المتبقي من الحبل السري نظيف ☐ الجزء المتبقي من الحبل السري مصاب بعدوى

أنـت عامـل صحـي مجتمعـي في قريـة الـسلام. وأنـت حاليًـا تـزور سـامية التـي وضعـت طفلتهـا سماح منـذ خمسـة أيـام. وعندمـا تسـأل عـن أحوالهـا وأحـوال ابنتهـا، تـرد بـأن كل شيء على مـا يـرام. اغسـل يديـك واطلـب الإذن برؤيـة الطفلـة. وعندما تـرى الفتـاة، تجـد أنهـا ترتـدي طبقـةً واحـدةً مـن الملابـس. وتفحصهـا للتحقـق مـن علامـات الخطـورة، ولكـن لا تـرى أيًّـا منهـا. ويبلـغ وزن سماح 2.95 كغـم. وتقيـس درجـة حرارتهـا، فتجدهـا 36.5 درجـة مئويـة. وعندمـا تسـأل عـن المـكان الـذي تطلـب فيـه الأسرة الرعايـة الصحيـة عنـد المـرض، تُجيـب الأم بأنهـم يتوجهـون إلى الصيدليـة للحصـول على الـدواء. وعندمـا تسـأل الأم عما إذا كانـت تعتنـي بالحبـل السُّري، يـأتي ردهـا بالإيجـاب. وتطلـب مـن الأم أن تريـك كيفيـة قيامهـا بتنظيـف الجـزء المتبقـي مـن الحبـل السري. وتـرى أنهـا تتبـع الخطـوات الصحيحـة. وعندمـا تفحـص الحبـل السُّري، تجـده نظيفًـا. املأ اسـتمارة التسـجيل وَفقًـا لما سـبق.

وفي النهايـة، وضـح للمشـاركين أن هنـاك صفًـا متعلقًـا بعلامـات الخطـورة بالنسـبة للأم لم يملـؤوه بعـد. ووضـح لهـم أن هـذا الصـف يوجـد بعـد الجـزء الخـاص بعلامـات الخطـورة في المواليـد وصغـار الرُّضَّـع لأنـه يجـب التحقـق مـن علامـات الخطـورة في كلٍّ مـن المواليـد والأمهـات أثنـاء الزيـارة التـي تلي الـولادة مبـاشرة (وسـيتعلمون ذلـك لاحقًـا). وفي حالـة اكتشـاف أي علامـات خطـورة في المولـود أو الأم، فيجـب وقـف جميـع المهـام الأخـرى، وتقديـم النصيحـة بضرورة الإحالـة العاجلـة. وسـيتعلمون علامـات الخطـورة في الأمهـات لاحقًـا.



الجلسة 9:
المكون 5: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- دُمية
- مِنْشَفة لعرض تحميم الطفل بالإسفنجة
- طباشير

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- إدراك أهمية العناية بالنظافة الشخصية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- تقديم المشورة للأمهات بشأن كيفية العناية بالنظافة الشخصية لأطفالهن؛
- مساعدة الأمهات أثناء قيامهن بذلك؛
- تقديم المشورة للأم حول العناية بالنظافة الشخصية للطفل.

1.5.4 مناقشة جماعية: العناية بالنظافة الشخصية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين

ستحتاج إلى ما يلي:

دُمية

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية للمواليد والأطفال. واستمع إلى إجاباتهم قبل توضيح أن تدابير النظافة الشخصية السليمة تحمي الأطفال من عدوى الجلد وأمراض أخرى، كما تساعد على جعلهم سعداء. وأكِّد على أن العناية بالنظافة الشخصية للمواليد يجب أن تتم بعناية ورفق.

ووضح أنه لا توجد حاجة إلى تحميم المواليد كل يوم. وبشكلٍ عام، يكفي تحميم الطفل ثلاث مرات في الأسبوع حتى يصبح أكثر قُدرة على الحركة، طالما يُنظَّف الوجه، واليدان، والعنق، ومنطقة الحفاض جيدًا (المناطق التي تحتاج إلى عناية أكبر)، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد يؤدي تحميم الطفل كثيرًا إلى جفاف جلده.

أخبر المشاركين أنهم سيتعلمون ثمانية عناصر أساسية للنظافة الشخصية للمواليد.

العنصر 1: تحميم الطفل

أكِّد على أنهم قد تعلموا ضرورة تجنب تحميم الطفل خلال الأربع والعشرين ساعةً الأولى التي تلي الولادة لتجنب إحساس الطفل بالبرودة. فقد تتسبب درجات الحرارة الباردة في وفاة الطفل.

ويمكن تحميم الطفل في اليوم الثاني، ثم تحميمه بشكل روتيني كل يومين أو ثلاثة أيام. ووضح أن طريقة تحميم الطفل قبل سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري تختلف عنها بعد سقوطها.

فقبل سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري: يُحمَّى المولود باستخدام الإسفنجة

استخدم الدُمية لتُري المشاركين كيفية تحميم المولود باستخدام إسفنجة.

ووضح أن استعمال الإسفنجة في تحميم الطفل معناه أنه لا يُغمَر بالماء. ويُوصَى بتحميم الطفل بالإسفنجة إلى أن يقع الجزء المتبقي من الحبل السري. وقد يستغرق ذلك الأمر أسبوعًا أو اثنين.

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحة 46 من الكتاب القلاب، وتحدث معهم أثناء الاطلاع على الرسومات. وأكِّد على أن الأم يجب عليها أن تُجهِّز كل شيء ليكون في متناول يديها قبل أن تبدأ في تحميم الطفل. وتتمثل أهم مستلزمات تحميم الطفل فيما يلي:

- مكان دافئ بسطح مُسطّح: طاولة الحمام أو المطبخ (على أن توضع بطانية أو مِنشفة على الأسطح الصلبة)، أو طاولة لتغيير ملابس الطفل، أو سرير ثابت، أو حتى بطانية أو مِنْشفة على الأرض؛
- بطانية ناعمة، أو منشفة، أو مفرش لتغيير الحفاض، بحيث تُفرَد ليستلقي الطفل عليه؛
- حوض أو وعاء بلاستيكي عميق للماء الدافئ؛
- ماء دافئ، وقطعة قماش لتحميم الطفل، ومِنشفة، يُفضل تلك التي يوجد بها غطاء للرأس، وصابون مرطِّب خفيف، وحفاض نظيف، وملابس نظيفة.

وبعدما تقوم الأم بخلع الملابس عن طفلها، يجب أن تلفه بالمنشفة. وللإبقاء على الطفل دافئًا، يجب الكشف فقط عن أجزاء جسمه التي تُغسَل فقط.

وتبلل الأم قطعة القماش، وتعصر الماء الزائد منها، ثم تمسح بها وجه الطفل. ويجب مسح الجفنين من الداخل إلى الخارج. ويجب إعطاء اهتمام خاص بالثنيات الموجودة أسفل الذراعين، ومنطقة خلف الأذنين، وحول العنق، ومنطقة الحفاض. كما يجب على الأم أن تغسل ما بين أصابع اليدين والقدمين.

ملاحظة: يجب دائمًا على الأم أن تسند طفلها بيدها التي لا تستعملها.

وعقب سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري (تقريبًا في الأسبوعين الثاني والثالث):

- بمجرد أن يسقط الجزء المتبقي من الحبل السري عن الطفل، يمكن تحميمه في حوض استحمام صغير. ويُفضل أن يُحمَّم الطفل قبل الرَّضاعة وليس بعدها لتجنب قيام الطفل بالبصق في حوض الاستحمام.
- عليها أن تصب كمية صغيرة من الماء في حوض الاستحمام بما يكفي لضمان عدم وجود أي فرصة لغرق الطفل. وفي المناطق التي يكون الماء فيها غير مأمون، يجب غلي الماء أولاً مع الانتظار قليلاً حتى يصبح دافئًا. ويجب الانتباه إلى أنه أثناء الاستحمام، قد يبلع الطفل كميةً صغيرةً من الماء، مما قد يتسبب في مرضه إذا كان الماء غير مأمون. ويجب أن يكون الماء دافئًا (38 درجة مئوية) وليس ساخنًا. وتستطيع الأم أن تختبر درجة حرارة الماء بوضع مرفقها فيه تجنبًا لإصابة الطفل بالحروق.
- للحفاظ على دِفء الطفل، تستمر الأم في صب الماء الدافئ على جسده طوال وقت الاستحمام. ويجب أن تظل الغرفة دافئة. فالأطفال المبللون قد يصابون بالبرد بسهولة (قد يكون استخدام مزيدٍ من الماء بما يكفي ليغطي كتفي الطفل من العوامل المهدِّئة للطفل، ويساعد على تقليل فقدان الحرارة).
- مهما كانت كمية الماء المُستخدَم، لا يجب مطلقًا أن يُترك الطفل وحده في حوض الاستحمام، ويجب أن تحمله الأم دائمًا بإحكام تجنبًا لتعرضه للغرق.
- يجب أن تستعمل الأم ذراعها التي لا تستعملها كثيراً لسند رأس الطفل وعنقه، بينما تستعمل الذراع الأخرى في حمل جسم الطفل، بينما تضع قدميه أولاً في الماء.
- ثم تبدأ في غسل وجه الطفل، وتنتقل تدريجيًا إلى الأسفل نحو الأجزاء التي تكون أكثر اتساخًا. وتساعد هذه الطريقة على الإبقاء على الأجزاء التي شُطفت بعيدةً عن الصابون.
- عندما تنتهي الأم، يجب إخراج الطفل من حوض الاستحمام، وتجفيفه، وإلباسه ملابسه سريعًا.

2.5.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 46 و47 من الكتاب القلاب. وعندما ينتهون، ناقش معهم الرسومات، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

3.5.4 مناقشة جماعية: العنصر 2: تنظيف منطقة الحفاض، والوجه، والعنق، والأيدي

العنصر 2. تنظيف منطقة الحفاض

وضِّح أن تغيير الحفاض بانتظام أمرٌ ضروري. واطلب من المشاركين فتح الصفحة 48 من الكتاب القلاب، ووضح لهم الخطوات المتبعة في تنظيف منطقة الحفاض. ارجع مرةً أخرى إلى الرسومات التوضيحية التي تُبين كيفية تنظيف عيني الطفل وأنفه وتقليم أظافره، ووضح كيفية القيام بذلك.

العنصر 3: تقليم أظافر الطفل

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية تقليم أظافر الطفل. واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية: وضح أن الأظافر المتسخة تكون مصدرًا للمكروبات التي يمكن أن تجد طريقها إلى داخل جسم الطفل عندما يمص يديه، مما قد يسبب له المرض.

ويجب أن تحافظ الأمهات على تقليم أظافر أطفالهن ونظافتها.

- أما إذا كانت الأظافر طويلة وحادة، فإن الطفل قد يخدش نفسه بها، ويؤذي نفسه.
- تأكد من استعمال المقص الملائم لأظافر الطفل دون أن تتسبب في جرحه.
- يُعتبر أفضل وقت لتقليم أظافر الطفل أثناء نومه.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الرسم الذي يوضح كيفية تقليم أظافر اليدين في الكتاب القلاب.

العنصر 4: عدم انسداد أنف الطفل:

يجب أن تنظف الأم أي مخاط جاف من أنف الطفل برفق، باستعمال قطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة. وإذا كان لدى الطفل سيلان في الأنف أو قشرة حول أنفه، فيجب على الأم أن تزيل المخاط والقشرة برفق. وعلى الأم أن تبلل كرة قطنية بماء دافئ. وتقوم بمسح المخاط بعناية. وإذا تحول المخاط إلى قشرة، فيمكن ترطيبها بكُرة قطنية رطبة قبل إزالتها حتى لا يشعر الطفل بعدم الراحة. ويجب أن تحرص الأم على مسح الأنف نحو الخارج وليس إلى الداخل. ويجب تجنب وضع أي شيء داخل أنف الطفل. فعلى الأم ألا تضع مطلقًا أي شيء داخل أنف الطفل لتنظيفه.

العنصر 5: تنظيف العينين

يساعد تنظيف عيني الطفل على الوقاية من العدوى. وعلى الأم أن تزيل المخاط الجاف باستخدام قطعة قماش قطنية ورطبة، على أن تُنظِّف العينين من الداخل إلى الخارج. ويجب عدم استخدام نفس قطعة القطن مرة أخرى. فعلى الأم أن تتخلص من قطعة القماش بعد استعمالها.

العنصر 6: تنظيف الأذنين

يجب تنظيف الأذن برفق شديد. ويجب عدم إدخال أعواد التنظيف القطنية في أذني الطفل الصغيرتين. ولكن يكون التنظيف حول الأذن. وإذا خرج شيءٌ ما من الأذن، فيجب إزالته برفق من الخارج.

العنصر 7: الحفاظ على نظافة ملابس الطفل

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية الحفاظ على نظافة ملابس الطفل. استمع إلى إجاباتهم، وأكِّد على أنه من الضروري إزالة أي مواد أو أتربة من شأنها أن تؤدي إلى تهيج بشرة الطفل الرقيقة. وأخبر المشاركين أن عليهم أن ينصحوا الأمهات بتعليق ملابس أطفالهم في الشمس. فهي تساعد على قتل المكروبات.

العنصر 8: تنظيف المنزل

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية الحفاظ على نظافة المنازل التي يوجد فيها مواليد ورضّع صغار. واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح النقاط التالية:

- يجب الحفاظ على نظافة المنازل للحد من التعرض للجراثيم والمكروبات الضارة؛
- يجب الحفاظ على خلو المنازل من الذباب والبعوض لأنها تُسبب الأمراض، ويجب أن ينام الأطفال تحت ناموسية.
- اسأل المشاركين عن الأمراض التي يمكن أن ينقلها الذباب والبعوض. استمع إلى إجاباتهم، ثم قل إن البعوض ينشر الملاريا، والذباب يحمل أمراضًا قد تؤدي إلى الإسهال.
- يجب أن تظل المنازل خالية من الأتربة والأدخنة التي قد يمكن أن تُسبب الحساسية.
- أكِّد على أنه عند تنظيف المنزل من الغبار، يجب أن تتجنب الأم القيام بذلك بالقرب من الطفل، إذ يمكن أن يتسبب الغبار في تهيج استنشاق الطفل، لأنه قد يسبب الحساسية، كما يُحتمل أن يحمل أيضًا الكثير من المكروبات.



4.5.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 24: العناية بالنظافة الشخصية، في الصفحة 31، من دليل المشاركين، والصفحات من 48 إلى 51 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



5.5.4 لعبة: التحرك خطوة إلى الأمام 2

ستحتاج إلى أصبع من الطباشير لرسم الخطوط.

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون الآن لعبة "التحرك خُطوة إلى الأمام" التي تدور حول تقديم المشورة بشأن النظافة الشخصية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

استخدم أصبعًا من الطباشير لرسم خط البداية وخط النهاية. ويجب ألا تقل المسافة بين الخطين عن أربع خُطوات أو أكثر.

قسّم المشاركين إلى فريقين، وأعطِ كل فرد رقمًا بين 1و4. اطلب منهم أن يتذكروا أرقامهم. ثم، نادِ على أحد الأرقام، وليكن رقم 2 على سبيل المثال. فيبدأ الشخص الذي يحمل رقم 2 من كل فريق في التحرك تجاه خط البداية.

وأخبرهما أنك ستسأل كلَّ واحد منهما سؤالاً.

وذكِّر المشاركين بقواعد اللعبة: على المشارك الذي يجيب إجابة صحيحة أن يتحرك خُطوة إلى الأمام. أما المشارك الذي يجيب إجابة خاطئة، فيرجع إلى الخلف، ويحاول باقي أفراد الفريق الإجابة عن السؤال حتى يصلوا إلى الإجابة الصحيحة. واستمر في اللعبة حتى يصل أحد المشاركين إلى خط النهاية.

وأعلن عن الفريق الفائز، واطلب من الفريق الآخر التصفيق له.

وفيما يلي الأسئلة والإجابات التي ستُستخدم في هذه اللعبة:

السؤال 1: ما أهمية العناية بالنظافة الشخصية للمواليد؟

الإجابة 1: تساعد النظافة الشخصية على حماية الأطفال من الإصابة بعدوى الجلد والأمراض الأخرى، وتساعد على جعلهم سعداء.

السؤال 2: ما هي عناصر النظافة الشخصية الثمانية للمواليد؟

الإجابة 2:

1. الاستحمام
2. تنظيف الوجه والعنق واليدين
3. تقليم الأظافر
4. تنظيف الأذنين
5. الحفاظ على عدم انسداد الأنف
6. تنظيف العينين
7. الحفاظ على نظافة ملابس الطفل
8. تنظيف المنزل

السؤال 3: متي يجب البدء في تحميم المواليد؟

الإجابة 3: بعد يوم واحد من الولادة.

السؤال 4: كيف تُحمِّم الأم المولود؟

الإجابة 4: قبل سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري، على الأم أن تُحمم طفلها باستخدام إسفنجة مبللة بماء فاتر. بعد سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري، على الأم أن تُحمم طفلها في ماء دافئ في حوض استحمام صغير.

السؤال 5: ما أهمية تغيير الحفاض بانتظام؟

الإجابة 5: للوقاية من حدوث طفح جلدي ناتج عن الحفاضات والعدوى الجلدية.

السؤال 6: ما أهمية تنظيف أظافر الأطفال؟

الإجابة 6: تحمل الأظافر المتسخة المكروبات التي يمكن أن تجد طريقها إلى داخل جسم الطفل عندما يمص يديه، مما قد يسبب له المرض.

السؤال 7: ما أهمية تقليم أظافر الأطفال؟

الإجابة 7: للحفاظ على نظافة الأظافر، وتجنب خدش الطفل لنفسه إذا كانت أظافره حادة وطويلة.

السؤال 8: ما أهمية الحفاظ على نظافة المنزل؟

الإجابة 8: للحد من التعرُّض للجراثيم والمكروبات الضارة، والغبار الذي يسبب الحساسية، ومن التعرض للذباب والبعوض الذي ينقل الأمراض.

السؤال 9: ما أهمية الحفاظ على نظافة ملابس الأطفال؟

الإجابة 9: للتخلص من الأتربة والمواد التي قد تُهيج بشرة الأطفال الحساسة.

6.5.4 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية للمواليد والرضّع الصغار

ذكِّر المشاركين بأن النجاح في تقديم المشورة يعتمد على التواصل الجيد. فيجب أن يستخدموا مهارات التواصل الجيد التي تعلموها لتقديم المشورة للأمهات.

راجع خطوات ومهارات التواصل الجيد مع المشاركين.

ثم، راجع معهم كيفية ملء استمارة التسجيل فيما يتعلق بالتدخلات السابقة.

وتأكد من أنهم يتذكرون ما يتعين عليهم القيام به لتقييم الحفاظ على دِفء الطفل، والبدء المبكر في الرضاعة، وتحديد علامات الخطورة.

وذكِّر المشاركين أنه بعد قيامهم بتقييم الوضع، عليهم أن يستعينوا بالكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الأسرة. وفي حالة وجود أي علامة من علامات الخطورة، عليهم أن يتخطوا المهام الأخرى، ويحيلوا الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

وأخبرهم أنهم سيقومون بالشيء نفسه عند تقديم المشورة حول النظافة الشخصية.

واطلب من المشاركين أن يخبروك بالخطوات التي سيتبعونها لتقديم المشورة إلى الأم حول العناية بالنظافة الشخصية. استمع إلى إجاباتهم، ثم أخبرهم أنه يجب عليهم أن يستخدموا استمارة التسجيل لتقييم عدد مرات القيام بالعناصر الثمانية، وطرق تطبيقها.

واطلب منهم أن ينظروا في استمارة التسجيل، وتحدث معهم أثناء المرور على الأجزاء المتعلقة بالعناية بالنظافة الشخصية:

- تحميم الطفل؛
- تنظيف الوجه والعينين والأنف والأذنين؛
- تغيير الحفاض؛
- تنظيف ملابس الطفل وألعابه؛
- تنظيف المنزل.

وأخبرهم أنه يجب عليهم أيضًا أن يلاحظوا النقاط التالية (اطلب منهم النظر في عمود الملاحظة):

- نظافة وجه الطفل وعينيه وأنفه وأذنيه؛
- نظافة الأظافر وتقليمها؛
- انبعاث رائحة من الحفاض؛
- نظافة ملابس الطفل وألعابه؛
- نظافة المنزل وترتيبه؛
- وجود شخص مُدخن ضمن أفراد الأسرة.

واسأل المشاركين عن الطريقة التي سيستخدمونها لتقييم نظافة المنزل. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضح لهم أنه يجب عليهم التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك غبار أو تراب أو ذباب أو بعوض أم لا، وما إذا كان كل شيء مرتَّب، وما إذا كان أحد الأشخاص يُدخن في المنزل.

ويجب أن يثنوا على كل ما تقوم به الأم بشكل جيد، ويقدموا المشورة لها حول الأشياء التي لا تفعلها.

وذكِّر المشاركين أن تقديم المشورة لا يتضمن ترديد/ قراءة محتويات الكتاب القلاب، ولكن يجب أن تُصمَّم بما يتناسب

مـع الوضـع الخـاص بـكل أسرة. وإذا لاحظـوا أن الأم لا تعتنـي بالنظافـة الشـخصية لطفلهـا، يجـب أن يقدمـوا لهـا المشـورة حـول العنـاصر الثمانيـة للعنايـة بالنظافـة الشـخصية.



7.5.4 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الإطـار 25: كيفيـة تقديـم المشـورة للأم حـول العنايـة بالنظافـة الشـخصية، في الصفحـة 31 مـن دليـل المشـاركين.

وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



الجلسة 10:
المكون 6: تقديم المشورة حول التغذية (الرضاعة)

مدة الجلسة
ساعتان

المُعدَّات
- مجموعتين من بطاقات اللعب، على أن تتكون كل مجموعة من 20 بطاقة للعبة بطاقات مطابقة المعلومات الخاصة بالرضاعة.
- طاولة
- نسختين من السيناريوهات السبعة الخاصة بتمثيل الأدوار 2

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون:
- قد تعرفوا على المشكلات الشائعة للرضاعة؛
- قد تمرنوا على تقديم المشورة حول الرضاعة وحل مشاكل الرضاعة.

مقدمة حول الجلسة:

أخبر المشاركين أنهم قد تعلموا بالفعل أمورًا عن الرضاعة، لا سيما البدء المبكر في الرضاعة وبعض المعلومات المهمة بشأنها.

وخلال هذه الجلسة، سيوظفون هذه المعلومات في حل المشاكل المتعلقة بالرضاعة.

وأخبر المشاركين أنهم سيجدون بعض الرسومات التوضيحية والنصائح المتكررة في الكتاب القلاب. وهذا أمرٌ مقصودٌ لتيسير عملهم أثناء تقديم المشورة، بدلاً من أن يضطروا إلى البحث في الكتاب عن الرسومات التوضيحية والنصائح ذات الصلة.

1.6.4 لعبة بطاقات مطابقة المعلومات 1: مراجعة المعلومات الخاصة بالرضاعة

جهِّز طاولة ومجموعتين من البطاقات الخاصة باللعبة.

استعرض ما يعرفه المشاركون عن الرضاعة –مزايا الرضاعة، والبدء المبكر في الرضاعة ومنافعه، واللِّبَأ ومنافعه، والرضاعة المطلقة، والأنواع المختلفة للبن الأم، ونظافة الثدي – ومهارات تقديم المشورة.

وعند مناقشة الرضاعة المطلقة، أضف أنها يجب أن تستمر حتى يكمل الطفل ستة أشهر من العمر.

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون الآن لعبة بطاقات مطابقة المعلومات. وقسِّم المشاركين إلى فريقين، ووضح لهم أن كل فريق سيحصل على 20 بطاقة تشتمل على معلومات عن الرضاعة. وعليهم أن يجدوا البطاقتين اللتين تتوافقان مع بعضهما البعض.

وأخبرهم أنك ستمنحهم 15 دقيقةً لمطابقة البطاقات. وفيما يلي المطابقة السليمة للبطاقات:

البدء المبكر في الرضاعة	خلال الساعة الأولى بعد الولادة
اللِّبَأ (لبن السرسوب) ليس	اللبن الأول الرديء
الرضاعة المطلقة	يُعطى الرضيع لبن الأم فقط، ويجب ألا يُعطى أي أطعمة أو سوائل أخرى، ولا حتى الماء، قبل أن يبلغ ستة أشهر من العمر
لبن أول الرضعة	يحتوي على كل الماء الذي يحتاج إليه الطفل
يشعر الطفل بالجوع	لأنه يأخذ لبن أول الرضعة فقط
الرضاعة الفعالة	تزيد إدرار لبن الأم
اللِّبَأ (لبن السرسوب) هو	أول تطعيم يأخذه الطفل
التعلق بالثدي بطريقة خاطئة	يُسبب ألمًا في الثدي ولن يشعر الطفل بالشبع
نظافة الثدي	يُشطف بالماء وتُوضَع قطرة من لبن الثدي على الحلمة، ثم تُترك لتجف في الهواء
لبن الأم	يحمي الطفل من العدوى

2.6.4 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول مشاكل الرضاعة

أخبر المشاركين أنهم بحاجة إلى التعرف على المشاكل الشائعة للرضاعة ومعلومات مهمة عن الرضاعة حتى يستطيعوا أن يقدموا إلى الأمهات مشورةً بهذا الشأن.

واطلب من المشاركين أن يخبروك عن أكثر المشاكل الشائعة للرضاعة. وعندما ينتهون، أخبرهم أنك ستناقش معهم المشاكل واحدةً تلو الأخرى.

المشكلة الأولى: عدم كفاية اللبن

اطلب من المشاركين أن يخبروك عن أسباب اعتقاد بعض الأمهات بأن لبنهن غير كافٍ، وأكِّد على المبدأ الأساسي: كلما فُرّغ الثديان، زاد إدرار اللبن. وأكِّد على أن تقديم المشورة يجب أن يكون وَفقًا للوضع.

- بعد الوضع مباشرة، تشعر الأم عادةً بأن ثدييها ليسا ممتلئين بما يكفي لإدرار كميات كافية من اللبن لمعدة الطفل الصغيرة.
  المشورة: كلما رضع الطفل، زاد إدرار اللبن.
- يؤدي التعلق بالثدي بطريقة خاطئة إلى رضاعة غير فعالة لا تؤدي إلى إفراغ الثدي. ونتيجة لذلك، سيكون إنتاج اللبن بكميات صغيرة فقط.

تقديم المشورة: في هذه الحالة، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين ملاحظة عملية الرضاعة، وتصحيح وضعية الطفل وكيفية تعلقه بالثدي. ثُم، تُقدم المشورة للأم بشأن أهمية وضعية الطفل السليمة وطريقة تعلقه بالثدي .

- عند تغذية الطفل تغذيةً مختلطةً، لن تستوعب معدته الصغيرة سوى كمية صغيرة من لبن الأم، ولن يُفرّغ الثديان نظرًا لأن الطفل لا يرضع منهما بصورة كافية.

المشورة: لبن الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل. ولا يحتاج الأطفال إلى أي أغذية أو سوائل أخرى، ومنها الماء. وأخبر الأم أن تقلل تدريجيًا من كمية السوائل الأخرى، وأن تزيد من معدل الرضاعة، إلى أن يتناول الطفل لبن الثدي فقط. ووضح أيضًا أن عدم إفراغ الثدي سيؤدي إلى تقليل إنتاج اللبن.

- تعني قلة الرضاعة عدم قيام الطفل بالرَّضاعة من ثدي الأم بانتظام وقلة إنتاج اللبن.

المشورة: يجب إرضاع الأطفال عند الطلب، بما لا يقل عن ثماني مرات في اليوم لأن الرَّضاعة المتكررة تساعد على إدرار مزيدٍ من اللبن.

المشكلة الثانية: اللبن الخفيف

عندما ترى الأم لبن أول الرضعة الشفاف، تعتقد أحيانًا أن لبنها خفيف.

المبدأ: ليس هناك ما يُسمى بلبن خفيف، إذ يحتوي لبن الأم لدى جميع الأمهات على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل، وَفقًا لعمره.

المشورة: توضيح الفرق بين لبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة.

- لبن أول الرضعة هو اللبن الشفاف الذي يكون في بداية الرضاعة. وهو يحتوي على جميع احتياجات الطفل من الماء والعناصر الغذائية المهمة.
- أما لبن آخر الرضعة، فهو اللبن الأبيض الثخين الذي يكون في نهاية الرضاعة. وهو يحتوي على دهون وعناصر غذائية أخرى. كما أنه السبب في شعور الطفل بالامتلاء والشبع.

المشكلة الثالثة: يبكي الطفل بعد الرضاعة لأنه جائع

المشورة: يحتاج الأطفال إلى تناول لبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة حتى يشعروا بالامتلاء والشبع.

وتميل بعض الأمهات إلى وضع أطفالهن على ثدي واحد، ثم نقله إلى الثدي الآخر بعد فترة وجيزة، اعتقادًا منهن بأنه يجب أن يأخذ الطفل لبنًا من الثديين. ويعني ذلك أن الطفل يأخذ لبن أول الرضعة فقط، وليس لبن آخر الرضعة، مما يجعله يشعر بالجوع.

المشورة: لبن آخر الرضعة هو اللبن الذي يتناوله الطفل في نهاية الرضاعة، وهو يحتوي على الدهون، ويمنح الطفل شعورًا بالشبع. وعلى الأم أن تضع طفلها على ثدي واحد، ولا تنقله إلى الثدي الآخر حتى يتركه من تلقاء نفسه. وبهذه الطريقة، يتناول الطفل لبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة، ولن يشعر بالجوع.

المشكلة الرابعة: عدم الاقتصار على الرضاعة المطلقة

المبدأ: تكون معدة الطفل صغيرة، ومُصمَّمة لتناول كمية اللبن اللازمة بالضبط.

المشورة: يحتوي لبن الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل. وإذا امتلأت معدة الطفل بأغذية أو سوائل أخرى مثل الماء، ستقل كمية لبن الأم التي يتناولها، ولن يأخذ جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها كي ينمو بصورة صحية.

المشكلة الخامسة: إعطاء الطفل الماء في الطقس الحار

تعتقد بعض الأمهات أن لبنها غذاء فقط، ويحتاج الطفل إلى شرب الماء أيضًا، خاصةً في الطقس الحار لأنه يشعر بالعطش.

المشورة: يحتوي لبن الأم على كل الماء الذي يحتاج إليه الطفل في لبن أول الرضعة، حتى في الطقس الحار. وفي الطقس الحار، يجب إرضاع الطفل كثيرًا لإشباع حاجته من الماء، ويجب أن تشرب الأمهات أنفسهن الماء.

المشكلة السادسة: عدم إرضاع الطفل عند الطلب/ الطفل لا يبدو عليه أنه جائع

تعتقد بعض الأمهات أن الطفل نائم، ولا يرغب في الرضاعة، ولا يُدركن العلامات التي تدل على أن الطفل جائع. وهناك أمهات أخريات لا يُرضعن الطفل عند الطلب.

المشورة: تُنصَح الأم بضرورة إرضاع الطفل عند الطلب لضمان حصول الطفل على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ولضمان إدرار لبن الأم.

ويجب مساعدة الأم في تحديد علامات الجوع قبل أن يبكي الطفل. كما تُشجَّع على إرضاع طفلها عندما يكون جائعًا.

المشكلة السابعة: الشعور بالألم عند الرضاعة

تشعر بعض الأمهات بالألم عندما يُرضعن أطفالهن، بينما تعاني أمهات أخريات من احتقان الثدي أو تشقق الحلمة.

المشورة: ملاحظة الرضاعة وتصحيح وضعية الطفل وتعلقه بثدي أمه. ويمكن أن يسبب التعلق السيئ بالثدي في الشعور بألم في الحلمة والثدي. وإذا حدث احتقان في الثدي، فيجب على الأم أن تُرضع طفلَها رضاعةً مطلقة وعند الطلب. وتُعلّم الأم كيفية اعتصار لبن الثدي أو استخدام مضخة لذلك. وإذا لم يفلح ذلك، تُحال إلى مرفق صحي. وإذا كانت الأم تعاني من تشقق الحلمة، يجب أيضًا أن تُحال إلى مرفق صحي.

المشكلة الثامنة: إعطاء الطفل لبن اصطناعي/ عدم قيام الأم بالرضاعة

بعض الأمهات لا يُرضعن أطفالهن لأنهن يعتقدن أن أطفالهن سينمون على نحو أسرع وأكثر صحة إذا تناولوا لبنًا اصطناعيًا. وقد لا تمتلك أمهات أخريات الوقت للرضاعة، ويعتقدن أن التغذية الاصطناعية أسهل وأسرع.

المشورة: تُنصح الأمهات بمزايا الرضاعة وعيوب/ مخاطر اللبن الاصطناعي.



3.6.4 قراءة:

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 52 إلى 55 - من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات والنصائح، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعند انتهائهم من القراءة، أجب عن أية أسئلة قد تكون لديهم.



4.6.4 عرض توضيحي: استمارة التسجيل

اطلب من المشاركين الرجوع إلى استمارة التسجيل في الصفحة 14 من دليل المشاركين.

وذكِّرهم أن هذه الاستمارة للمواليد وصغار الرُّضَّع حتى أقل من ستة أشهر، وأنهم سيستخدمونها لتسجيل معلومات عن المولود والأم، كما أنها ستساعدهم على فهم الوضع أثناء الزيارات المنزلية.

- راجع أجزاء الاستمارة، وذكِّر المشاركين بالغرض منها.
- ذكِّرهم بأنه يجب عليهم ملء الاستمارة عن طريق وضع علامة في المربع حسب إجابات الأم، أو بناءً على ملاحظاتهم.
- اقرأ كل سؤال وارد في الصف الخاص بالرضاعة، وتحقق من فهم المشاركين لكل بند، وكيفية قيامهم بتقديم المشورة.
- الفت انتباه المشاركين إلى أن الأسئلة الواردة في استمارة التسجيل على سبيل الاسترشاد. فإذا رَأَوْا الأم على سبيل المثال وهي تُرضع طفلها، فلا داعي لسؤالها إذا كانت تقوم بالرضاعة أم لا، على الرغم من أن هذا السؤال مُدرَج في الاستمارة.
- أخبر المشاركين أنه يجب عليهم الحصول على إذن الأم لملاحظة عملية الرضاعة –إذا لم تكن الأم قد أرضعت طفلها في الساعة الأخيرة– من أجل تقييم الوضع.

وإذا كان الطفل لا يتعلق بثدي أمه بطريقة سليمة، عليهم أن يسألوا الأم إذا كانوا يستطيعون المساعدة في تحسين وضعية الطفل. فإذا وافقت، تُساعد الأم في ضبط وضعية الطفل وتعلقه بالثدي.

- إذا كانت الأم تعاني من أي مشاكل، بسبب افتقارها إلى المعلومات أو لأنها تقوم بالأشياء بطريقة غير صحيحة، فعليهم أن يقدموا إليها المعلومات ذات الصلة، ويشجعوها على الرضاعة بطريقة سليمة.
- عليهم أن يتحققوا من فهم الأم، وحل أي مشاكل قبل شكرها على تعاونها. وتُشجَّع الأم على مواصلة رعاية طفلها رعاية جيدة.

5.6.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 26: كيفية تقديم المشورة للأم بشأن التغذية (الرضاعة) في الصفحة 32، من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

6.6.4 تدريب تمثيلي 2: تقديم المشورة للأمهات حول الرضاعة

راجع مع المشاركين الخطوات الأربع للتواصل الجيد، وأكِّد على أنه يجب أن يستخدموا استمارة التسجيل لفهم الوضع.

أخبر المشاركين أنهم سيُؤَدُّونَ تدريبًا تمثيليًا حول تقديم المشورة للأمهات بشأن الرضاعة.

وقبل البدء في تمثيل الأدوار، اطلب من المشاركين قراءة الإطار 26 في الصفحة 32 من دليل المشاركين.

ووضح كيف سيؤدَّى تمثيل الأدوار، أنت ستؤدي دور الأم، بينما سيؤدي المشاركون دور العامل الصحي المجتمعي، كلٌّ في دوره. وسيقومون بسحب أحد السيناريوهات السبعة أدناه ويسلمونك إياه، دون أن يروا ما به. ويجب عليك طي الأوراق المكتوب فيها السيناريوهات قبل أن يختار المشاركون منها. ثم سيبدأ المشارك في طرح أسئلة على الأم عن وضعها، وستكون إجاباتك حسب السيناريو المُختار، وسيُقدم المشارك المشورة وَفقًا لذلك. وأكِّد على أنه عند تمثيل دور العامل الصحي المجتمعي، يجب على المشاركين اتباع الخطوات الأربع للتواصل الجيد والأدوات - استمارة التسجيل لفهم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المشورة والمعلومات ذات الصلة، والمساعدة العملية عند الضرورة.

اطلب من المشاركين الملاحظة، وتدوين تعليقاتهم حول النقاط التالية:

- مهارات تقديم المشورة التي استخدمها العامل الصحي المجتمعي؛
- طريقة استخدام العامل الصحي المجتمعي لاستمارة التسجيل وملئها؛
- المعلومات المُقدَّمة إلى الأم؛
- ما إذا كانت الأم مقتنعة بما قيل بدرجة كافية لاتباع نصيحة العامل الصحي المجتمعي.

الموقف 1

- لقد بدأتِ الرضاعة بعد الوضع مباشرةً.
- تعتقدين أن لبنك ليس ثخينًا وخفيفٌ.
- ستوقفين الرضاعة لأنها ستضر طفلك.
- ستَبْدَئينَ في تغذيته اللبن الاصطناعي بزجاجة التغذية .

الموقف 2

- لقد وضعتِ طفلك منذ ساعتين.
- جعلتِ طفلك في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل.
- تعتقدين أنكِ ليس لديكِ لبن كافٍ وأن ثدييك فارغان.
- ستعطين الطفل لبنًا اصطناعيًا.

الموقف 3

- لقد وضعت طفلك للتو.
- جعلتِ طفلك في وضعية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل .
- لا تستطيعين إرضاع طفلك مباشرةً لأن عليكِ أولاً اعتصار اللبن الرديء.

الموقف 4

- لقد وضعت طفلك للتو.
- وضعتِ طفلكِ مباشرةً على ثديك لتبدئي الرضاعة.
- بعد الانتهاء من الرضاعة، بدأ طفلكِ في البكاء. ووضعته على ثدي واحد لمدة دقيقتين، ثم نقلتِه إلى الثدي الآخر حتى يتمكن من الرضاعة من كلا الثديين.

الموقف 5

- لقد وضعتِ طفلتك منذ ساعتين.
- تعرفين أنه يجب عليكِ إرضاع طفلتك، ولكنك
- لم تضعي طفلتك على ثديك بعد لأنها لم تبكِ طلبًا للغذاء، وبالتالي لا يمكن أن تكون جائعة.

الموقف 6

- لقد وضعتِ طفلك منذ ساعةٍ واحدةٍ.
- بدأتِ في إرضاعه فورًا.
- شعرتِ بألم في الحلمة أثناء الرضاعة.

الموقف 7

- لقد وضعتِ طفلك منذ ساعتين.
- لم تبدئي إرضاع طفلك بعد.
- تستخدمين لبنًا اصطناعيًا لأنه يجعل الأطفال ينمون بشكل أسرع وأكثر صحة.



الجلسة 11:
المكون 7: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية

مدة الجلسة
90 دقيقة

المُعدَّات
- مقطع الفيديو 14، حركات الطفل
- مستلزمات لتوضيح كيفية تخفيف المغص وتجشئة الطفل؛
- دُمية؛
- قطعة قماش؛
- زجاجة.
- نسختين من خمسة سيناريوهات للتدريب التمثيلي 3 حول تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- حالة نَماء المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- أهمية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- كيفية تقديم المشورة للأسر حول معالم النَّماء الرئيسية.

1.7.4 مناقشة جماعية: معالم النَّماء الرئيسية

اسأل المشاركين عن أسباب أهمية تقديم المشورة للآباء والأمهات حول نَماء أطفالهم.

انتظر للاستماع إلى بضع إجابات، ثم وضِّح لهم أن النَّماء يشير إلى نمو المخ وأجهزة الجسم الأخرى، وعلى الأهل أن يفهموا كيفية نَماء الأطفال في الأحوال العادية، بحيث يستطيعون اكتشاف أي مشاكل محتملة في النماء. وأكِّد أيضًا على أن الآباء والأمهات يستطيعون تحفيز نَماء أطفالهم بالمتابعة.

واسأل عن المخاوف الشائعة بين الأمهات في الأسابيع الأولى من عُمر الطفل. استمع إلى إجابات المشاركين، ووضح أن نوم الأطفال لساعات طويلة وبكاءهم يُعتبران من المخاوف الشائعة.

اشرح بعض الحقائق عن نَماء المواليد في الأسبوع الأول من أعمارهم.

- **النوم**

في هذا العمر، ينام الأطفال عادةً ما يتراوح من 14 إلى 17 ساعةً في اليوم، ومنها فترات القيلولة. ولا داعي لقلق الأم طالما أن الطفل يرضع جيدًا، ويحرك ساقيه وذراعيه بشكل طبيعي (وفيما يلي أدناه، توضيح للحركة الطبيعية). وإذا كان الطفل ينام بشكل جيد، سيكون لديه الطاقة ليظل نشطًا. ويكون الطفل الذي ينال قسطًا جيدًا من الراحة طفلاً نشطًا. ومع تقدُّم الطفل في العمر، تقل ساعات النوم.

• **الوضعية**

خلال الأسابيع الأولى، يميل الطفل إلى ضم قبضتيه، وثني مِرفقيه، وفخذيه وركبتيه، وجعل ذراعيه وساقيه قريبة من الجزء الأمامي من جسمه. وتُعتبر هذه الوضعية مشابهة لوضعية الطفل عندما كان جنينًا خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.

• **الحركة**

في الأسابيع الأولى من عُمر الطفل، يقوم الطفل بحركات متشنجة وغير متسقة ومتفرقة وخارجة عن سيطرته. وقد يبدو أحيانًا أن المولود يدفع ثدي أمه بعيدًا عندما تحاول أن ترضعه. ولكن هذه الحركة غير متعمَّدة. ففي الأسابيع الأولى من عمر الطفل، تكون الحركات غير مقصودة.

ومن المهم تقديم المشورة للأمهات بعدم الإفراط في لف المولود لأنه يجب أن يكون لديه مساحة لتحريك ذراعيه وساقيه. وتساعد هذه الحركات على تقوية العضلات واتساقها.

ولا يجب مطلقًا ترك الأطفال دون رقابة، خاصة إذا كانوا على سطح مرتفع. فمن الممكن أن يتحركوا حركة مفاجئة، ويتدحرجوا ليقعوا من الحافة.

• **عضلات العنق**

تكون عضلات العنق ضعيفة لدى الأطفال، ولا يستطيعون سند رؤوسهم. فعلى الأم أن تسند رأس طفلها لتجنب مخاطر إصابة المخ أو الرأس.

• **البكاء**

لا يستطيع الأطفال التحدُّث، والبكاء هو طريقة تواصلهم مع الآخرين. وهو الطريقة التي يعبرون بها عن شعورهم بالجوع، والألم، والخوف، والحاجة إلى النوم، وطريقة رد فعلهم للحفَّاض المبتل، والضوضاء، وما إلى ذلك. وقد يبكي بعض الأطفال لفترات طويلة. وغالبًا ما يكون ذلك بسبب المغص. وعلى الأم أن تعرف سبب بكاء الطفل.

فعلى الأم أن تستجيب عند بكاء طفلها ولا تُهمل ذلك. فقد يكون الطفل في حاجةٍ إلى الشعور بالحب والأمن. ويجب على الآباء والأمهات أن يحملوا أطفالهم بالقرب من صدورهم ويحتضنوهم. وإذا كان الطفل جائعًا، فيجب إرضاعه. وإذا كان الحفاض مبتلاً، فيجب تغييره.

• **السمع**

عند الميلاد، يستطيع الأطفال أن يسمعوا جيدًا، لأن حاسة السمع لديهم تكون قد تطورت بصورة جيدة، وستفجعهم الأصوات العالية.

• **الرؤية**

عند الميلاد، تكون الرؤية مشوَّشة، إذ يستطيع الأطفال رؤية الوجوه بوضوح على مسافة 25 سم (الوجوه القريبة) ويحدِّقون بها. ويهتمون أكثر بالأشياء ذات اللونين الأسود والأبيض، وبالوجوه أكثر من الأشياء.

ملاحظة: يشعر بعض الآباء بالقلق إزاء إصابة أطفالهم بحَوَل العينين. وهذا جانب طبيعي لنَماء عيني المواليد. فلا يزال الطفل يتعلم التحكم في حركات عينيه. ومع تقدم الأطفال في العمر، يصبح لديهم تحكم أفضل في حركات العين.

وعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يقدموا المشورة للآباء بشأن أي مسائل قد تظهر فيما يتعلق بالنماء. وإذا كان هناك أي ابتعاد عن أنماط النَّماء المعتادة، فيجب على الأسرة أن تستشير طبيبًا.

لخص بأن المواليد:

- ينامون لمدة تتراوح ما بين 14 و17 ساعةً يوميًا؛
- يقومون بحركات متشنجة غير متعمَّدة (فلا يجب الإفراط في لف الأطفال، ولكن يجب إعطاؤهم مساحة للحركة)؛
- لديهم عضلات ضعيفة في منطقتي العنق والرأس؛
- يسمعون جيدًا، وقد تفزعهم الأصوات العالية؛
- يرون الوجوه على مسافة 25 سم ويحدقون بها؛
- يجب ألا يُتركوا وحدهم دون رقابة على أسطح عالية، فقد يتدحرجون بحركة مفاجئة ويقعون من فوق الحافة.
- يبكون عندما يرغبون في إخبار آبائهم بشيء ما، مثل: أنا جائع، أنا خائف، أشعر بالوحدة، أنا مُبتل، أشعر بالألم، إلى ما غير ذلك.



2.7.4 فيديو توضيحي

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 14، حركة الطفل والأيدي المضمومة (01:13 دقيقة).

وأخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول حركة الطفل والأيدي المضمومة.

اعرض مقطع الفيديو 14. وعند الانتهاء من عرض الفيديو، أكِّد على أهم النقاط التي وردت فيه، وكرر عرضه إذا كان ذلك ضروريًا، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.7.4 قراءة:

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 56 و57 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



4.7.4 عرض توضيحي: كيف يمكن تخفيف المغص لدى الطفل؟

ستحتاج إلى ما يلي لتوضيح كيفية تخفيف المغص:

دُمية

قطعة قماش

زجاجة

اشرح للمشاركين أن بكاء الطفل لفترة طويلة دون توقف ودون التمكُّن من تهدئته يكون في كثير من الأحيان بسبب المغص. ويجب أن ينصح العاملون الصحيون المجتمعيون الآباء والأمهات بأنه لا يُوصَى باستعمال الأدوية لعلاج المغص.

ووضح أن المغص بشكل عام يكون بسبب الغازات المزعجة للطفل، وأن هناك عددًا من الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها لتخفيف المغص لدى الأطفال. وأضف إلى ذلك أن الانزعاج الذي يشعر به الطفل مع المغص يمكن أن يتفاقم بسبب عوامل خارجية. وعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن ينصحوا الأم بإبقاء الطفل في مكان هادئ، وتخفيف الإضاءة، وتقليل مستوى الضوضاء في المنزل بشكل عام. ويمكن أن تتحدث الأم مع طفلها أو تغني له أغنية هادئة.

وأخبر المشاركين أن أفضل طريقة لتهدئة الطفل الذي يبكي هي حمله وضمه، مع تحريكه والضغط على بطنه برفق.

وأخبر المشاركين أنك ستعرض عليهم طرقًا مختلفة لتخفيف المغص:

استخدم دُمية لتوضيح طرق تخفيف المغص:

- حمل الطفل بطريقة الكنغر والتجول به. ويمكن للآباء أن يحملوا الطفل سواءً كان مواجهًا لهم أم لا، ويتجولون به في أنحاء المنزل، أو خارجه إذا كان ذلك ممكنًا.
- حمل الطفل في وضعية "المغص"، وضبط وضعية الطفل، بحيث تكون معدته على ساعد أحد الوالدين، مع سند رأسه براحة اليد أو ثنية الذراع.
- يجب وضع الطفل على حِجْر أحد الوالدين ودعك ظهره برفق للتخلص من الغازات.
- تغطية الطفل بصورة محكمة. فقد يستجيب بعض الأطفال بصورة جيدة عند لَفهم بإحكام، خاصة عند هدهدتهم.
- هدهدة الطفل ولفه بإحكام، إذ يمكن أن يقوم الآباء بهدهدة الطفل أثناء حمله بين ذراعيهم. ويبعث استخدام إيقاع ثابت للحركة على التهدئة.
- تحريك ساقي الطفل كما لو كان يُبدِّل بهما، إذ يوضع الطفل على ظهره برفق، وتُحرَّك ساقاه كما لو كان يبدل بهما لمساعدته على إطلاق الغازات.
- وضع زجاجة ماء دافئ على بطن الطفل.

كما يجب أن يُنصح العاملون الصحيون المجتمعيون بأن تغيير النظام الغذائي للأم بوقف استعمال منتجات الألبان، والكافيين، والبصل، والكرنب، والبروكلي، والثوم، والأطعمة الغنية بالتوابل قد يساعد في تخفيف المغص من خلال تقليل خصائص إنتاج الغازات في لبن الأم.



5.7.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 58 و59 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



6.7.4 مناقشة جماعية: تجشئة الطفل

اسأل المشاركين عن سبب تجشئة الأطفال. استمع إلى إجاباتهم قبل أن تشرح لهم أن فقاعات الهواء قد تدخل إلى معدة الأطفال أثناء الرضاعة.

وقد تُسبب هذه الفقاعات إزعاجًا واضطرابًا للأطفال. وعندما تقوم الأم بتجشئة الطفل، فإنها تساعده على إفراغ مساحة في بطنه حتى يهدأ الطفل ويتغذى لفترة أطول. كما قد يكون التجشؤ مفيدًا في الحالات التالية:

- إذا كان يحدث للطفل ارتجاع في أغلب الأحيان للقليل من لبن الرَّضاعة (القشط)؛
- إذا كان الطفل يميل بطبيعته إلى الشعور بالمغص.

ولا توجد قاعدة تنص على ضرورة تجشئة الأطفال بعد كل رضعة. فقد يحتاج بعض الأطفال إلى تجشئتهم أكثر من غيرهم.

متى يجب تجشئة الطفل؟

لا يُجَشَّأ الطفل إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك. فلا داعي لتجشئة الطفل إذا كان هادئًا أو إذا نام أثناء الرَّضاعة أو بعدها. وإذا نام الطفل بعد الرَّضاعة ليلاً، ولكنه كان يستيقظ كثيرًا بسبب الغازات، فعلى الأم أن تحمل طفلها في وضع الجلوس، ثم تربت على ظهره برفق.

وقد يحتاج الطفل إلى التجشؤ إذا بدا عليه الشعور بعدم الراحة أثناء الرضاعة، كأن يتلوى الطفل مثلاً أو يسحب نفسه بعيدًا أو يبكي.

ومع تقدم الطفل في العمر، سيتعلم الأطفال الرَّضاعة بشكل أفضل دون ابتلاع الكثير من الهواء، وقد لا تحتاج الأم إلى تجشئته في كثيرٍ من الأحيان. وبحلول ذلك الوقت، ستكون الأم قد أصبحت لديها فكرة جيدة عما إذا كان طفلها يحتاج إلى التجشؤ بعد الرَّضاعة أم لا.



7.7.4 عرض توضيحي: كيفية تجشئة الطفل

ستحتاج إلى ما يلي:

دمية

منشفة

أخبر المشاركين أنه يجب على الأم قبل تجشئة الطفل أن تضع قطعة مربعة من القماش أو منشفة قديمة على كتفها لأن بعض الأطفال قد يحدث لهم ارتجاع لكمية صغيرة من لبن الرَّضاعة مع خروج الهواء، وهو أمر طبيعي تمامًا.

وهناك ثلاث طرق لتجشئة الطفل. وأخبر المشاركين أنهم بوصفهم عاملين صحيين مجتمعيين، عليهم تشجيع الأمهات على تجربة الطرق الثلاث لمعرفة الأنسب لهن ولأطفالهن.

واعرض الطرق الثلاث لتجشئة الأطفال باستخدام دُمية، أثناء الشرح.

1. على الكتف: يجب على الأم أن:
   - تحمل الطفل بحيث تكون ذقنه على كتفها.
   - تسند مؤخرة الطفل بيدٍ واحدة.
   - تفرك ظهره وتربت عليه برفق باليد الأخرى.

2. الجلوس في حِجْر الأم: يجب على الأم أن:
   - تُجلِس الطفل في حجرها، بحيث لا يكون مواجهًا لها.
   - تستعمل ذراعًا واحدةً لتسند جسم الطفل، بحيث تسند صدره براحة يدها، وتسند ذقنه وفكه بأصابعها.
   - تجعل الطفل يميل قليلاً إلى الأمام، وتُربت برفق على ظهره أو تفركه باستعمال يدها الأخرى.

3. الوجه لأسفل بين حجر ي الأم. يجب على الأم أن:
   - تضبط وضعية الطفل بحيث يكون نائما على بطنه على حجر الأم ووجهه إلى أسفل، بزاوية مستقيمة لها.
   - تسند ذقن الطفل وفكه بيدٍ واحدة.
   - تكون رأس الطفل أعلى قليلاً من باقي جسمه، حتى لا يندفع الدم إلى الرأس.
   - تفرك ظهر الطفل أو تربت عليه برفق بيدها الأخرى.

وأضف أنه يجب على الأم أن تتحدث مع طفلها حديثًا خافتًا، أو تغني له أغنية هادئة بينما تفرك ظهره أو تربت عليه برفق. وسيساعد سماع الطفل لصوت أمه على الاسترخاء.

وإذا لم يتجشأ الطفل خلال دقيقتين، فهذا معناه أنه لا يحتاج إلى ذلك في الغالب. ولكن إذا بدا على الطفل أنه غير مرتاح، فعلى الأم أن تستمر في المحاولة أو تغير وضعية الطفل.

8.7.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 60 و61 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

9.7.4 مناقشة جماعية: تأثير النشاط البدني والنوم الجيد والحد من أوقات الخمول على نمو المولود ونمائه

أخبر المشاركين أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على النمو والنَّماء على نحو صحي، ولكن قد يعتقد البعض أنها غير مهمة. وتشمل هذه العوامل حجم النشاط البدني للطفل، وعدد الساعات التي يقضيها في النوم والخمول.

النشاط البدني

يُعتبر اللعب النشط المأمون لمدة 30 دقيقة على مدار اليوم أمرًا ضروريًا لهذه الفئة العمرية من أجل نَمائهم العاطفي والمعرفي. ويمكن أن يكون اللعب مع المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين عن طريق ثني الأطراف وتمديدها. ولا يجب الإفراط في لف الطفل للسماح له بتحريك ذراعيه وساقيه.

النوم الجيد

يحتاج الأطفال في هذا العمر إلى ما يتراوح بين 14 و17 ساعةً من النوم الجيد في اليوم. ويُعتبر النوم ضروريًا كي يحصل الطفل على الطاقة اللازمة ليبقى نشطًا. فالطفل النشط هو الطفل الذي ينال قسطًا جيدًا من الراحة.

تقليل أوقات الخمول إلى أدنى حد

يجب عدم تقييد حركة الأطفال بوضعهم في عربات الأطفال أو بربطهم على ظهر أحد الوالدين أو الإفراط في لفِّهم لأكثر من ساعة واحدة في كل مرة. وعندما تُقيَّد حركة الأطفال لمدة طويلة، يتواصلون مع أفراد أسرهم بمعدل أقل ويُحرَمون من النشاط البدني الضروري بالنسبة لهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التأخر اللغوي وضعف الانتباه. ويمكن توظيف أوقات الخمول في الحديث مع الطفل والغناء له ولمسه.

10.7.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 27: تأثير النشاط البدني والنوم الجيد والحد من أوقات الخمول على نمو المواليد وصغار الرُّضَّع ونمائهم على نحو صحي في الصفحة 33 من دليل المشاركين، والصفحتين 62 و63 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

11.7.4 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للمواليد

أخبر المشاركين أنه يتعين عليهم استخدام مهارات التواصل الجيد في تقديم المشورة.

وعليهم القيام بما يلي:

- السؤال عن حال الطفل؛

- استخدام استمارة التسجيل لفهم الوضع؛
- تقديم المعلومات ذات الصلة باستخدام الكتاب القلاب؛
- تقديم الدعم المناسب حسب وضع الأسرة.

وعليهم أن يلاحظوا ما يلي:

- حركات الطفل؛
- وضعية الطفل؛
- ما إذا كان الطفل مستيقظًا، عليهم أن يلاحظوا إذا كان يحدِّق في وجه والدته أم لا؛
- ما إذا كان الطفل يبكي بصورة مستمرة دون أن يهدأ؛
- ما إذا كانت حركة الطفل مقيَّدة لفترات طويلة.

وعلى العامل الصحي المجتمعي أن يُحدِث ضوضاء مفاجئة ليرى إذا كان ذلك سيفزع الطفل أم لا.



12.7.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 28: كيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، في الصفحة 34 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



13.7.4 تدريب تمثيلي 3. تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين

جهِّز أوراقًا مطوية بخمسة سيناريوهات للتدريب التمثيلي 3.

أخبر المشاركين بأنهم سيؤدون تدريبًا تمثيليًا للتدرب على تقديم النصائح للأمهات بشأن نَماء المواليد وصغار الرضّع.

راجع مع المشاركين الخطوات الأربع للتواصل الجيد. وراجع أيضًا الجزء الخاص بمعالم النَّماء الرئيسية في استمارة التسجيل.

واطلب من كل مشارك اختيار ورقة مطوية، ثم أعطها له.

ووضح أنك ستؤدي دور الأم، بينما سيقوم المشاركون بدور العامل الصحي المجتمعي، كلٌّ في دوره. وسيبدأ المشارك في سؤال الأم عن وضعها، وستجيب أنت حسب السيناريو المُختار، ويقدم المتدرب المشورة وَفقًا لذلك. وأكِّد على أنه عند تمثيل دور العامل الصحي المجتمعي، يجب على المشاركين اتباع الخطوات الأربع للتواصل الجيد، واستمارة التسجيل للمساعدة في تقييم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات، والمساعدة العملية عند الضرورة. اطلب من المشاركين الملاحظة وتدوين تعليقاتهم بشأن النقاط التالية:

- مهارات تقديم المشورة التي استخدمها العامل صحي المجتمعي؛
- طريقة استخدام العامل الصحي المجتمعي لاستمارة التسجيل وملئها؛
- طريقة استخدام العامل الصحي المجتمعي للكتاب القلاب لتقديم المعلومات إلى الأم؛
- ما إذا كانت المعلومات المُقدَّمة للأم ذات صلة أم لا؛
- ما إذا كانوا يعتقدون أن الأم قد اقتنعت وستتبع نصيحة العامل الصحي المجتمعي أم لا.

الموقف 1

- طفلي ينام كثيرًا.
- أشعر أنه لا يرضع بما فيه الكفاية لأنه ينام كثيرًا.
- أخشى أنه ليس طبيعيًا.

الموقف 2

- طفلتي تبكي كثيرًا.
- لا أستطيع النوم بسبب بكائها.
- لا أعرف لماذا تبكي كثيرًا.

الموقف 3

- طفلي يبكي كثيرًا.
- لا نستطيع تهدئته.
- إنه يبكي لفترات طويلة.

الموقف 4

- لا تقوم طفلتي بتمديد ذراعيها وتجعل يديها مضمومتين طوال الوقت.
- ألفها بحيث أجعل راحة يديها وذراعيها ممدودة.
- أخشى أنها ليست طبيعية.

الموقف 5

- لدي الكثير من الأعمال المنزلية.
- أترك طفلي في عربته أغلب اليوم للحفاظ على سلامته.
- أشعر بالقلق حيال سلامته.



الجلسة 12:
المكون 8: تقديم المشورة حول "العناية من أجل النماء" (اللعب والتواصل مع الطفل)

مدة الجلسة
45 دقيقة

المُعدَّات
- أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو
- 15، مقدمة حول (اللعب والتواصل؛ مقدمة)
- ومقطع الفيديو 16، (اللعب والتواصل، 0 - شهرين)

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- إدراك المقصود بالعناية من أجل النماء؛
- تقييم كيفية قيام الآباء باللعب والتواصل مع المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- تقديم النصائح للآباء بشأن اللعب والتواصل مع الأطفال؛
- مساعدة الآباء في تعزيز المهارات الأساسية لمقدمي الرعاية، وتحسين قدرتهم على مراعاة مصالح الطفل واحتياجاته والاستجابة لها.

1.8.4 مناقشة جماعية: دور الآباء في تشجيع نَماء الطفل من خلال اللعب والتواصل (العناية من أجل النماء)

أخبر المشاركين أنه مع تقدُّم الأطفال في العمر، يتعلمون كيفية التحدث والمشي والجري والتفكير وحل المشكلات. وتُعتبر هذه التغيرات أمثلةً على نَماء الطفل. ويجب أن يُساهم جميع أفراد الأسرة في نَماء الطفل، ويمكنهم القيام بذلك عن طريق اللعب والتواصل مع الطفل.

أخبر المشاركين أن بعض الآباء يعتقدون أنهم لا يستطيعون اللعب أو التواصل مع المواليد وصغار الرضّع. واسألهم عن رأيهم في هذا الشأن. استمع إليهم، ثم اشرح أن الأطفال قادرون على السمع والرؤية منذ الولادة، ومن الطبيعي أن يرغبوا في التواصل مع شخص آخر. ويصبحوا قريبين بشكل خاص من مقدمي الرعاية الذين يقومون بتغذيتهم، ويمضون وقتًا في التواصل معهم، ويمنحونهم الحب والود.

ويجب أن تتاح للمواليد فرص استخدام أعينهم وآذانهم والحصول على تغذية جيدة. ويُعتبر وجه الأم هو الشيء المفضل الذي يرغب الطفل في رؤيته، ويحب أن يستجيب لابتساماتها والأصوات التي تصدر منها. وعلى الأم أن تبدأ في التحدث والغناء لطفلها، ولمسه منذ الولادة، بل وقبل الولادة.

وهناك العديد من الفرص للعب مع المواليد والتواصل معهم، وذلك أثناء الرضاعة وإلباسهم وغيرهما من المهام اليومية. وأثناء الرضاعة، تكون الأم وطفلها قريبين جدًا من بعضهما البعض. وهما يتواصلان من خلال الاستجابة إلى ما يصدر من أحدهما من أقل حركة، وصوت، وحتى الرائحة. ويرتبط الأطفال بالشخص الذي يستجيب لهم باستمرار، ويحملهم ويحبهم ويشعرهم بالأمان. وتدوم هذه العلاقة مدى الحياة.

وتعتبر الاستجابة لبكاء الطفل ولمسه وإظهار الحب والمودة له ورعايته من الأمور الأساسية التي يحتاج إليها الطفل حتى يشعر بالأمن والحماية.

وأكّـد على أن كل طفـل يكـون فريـدًا عنـد الـولادة، وهـذا التبايـن بين الأطفـال هـو مـا يؤثـر على طريقـة تعلُّمهـم. وتؤثـر الرعايـة المبكـرة لاحقًـا على التعلـم والـخبرات المكتسـبة خلال السـنوات الأولى مـن عُمـر الأطفـال مـع أسرهـم ومقدمـي الرعايـة الآخريـن، مما يُحـدد بـدوره ملامـح شـخصية الطفـل عندمـا يصبـح بالغًـا.

أخبر المشاركين: "يستطيع الآباء اللعب والتواصل مع أطفالهم منذ ولادتهم".

اللعـب مـع الطفـل: يمنـح الطفـل فرصـة رؤيـة الوالديـن وسماعـهما ولمسـهما، بالإضافـة إلى تحريـك ذراعيـه وسـاقيه بحريـة. وعليـهما أن يهدئـا الطفـل ويربتـا عليـه ويحـملاه برفـق.

التواصـل مـع الطفـل: يجـب على الوالديـن النظـر إلى طفلـهما في عينيـه، والتحـدث معـه، والغنـاء لـه. وتُعـتبر الرضاعـة فرصـة مثاليـة للقيـام بذلـك. وعلى الوالديـن أن يسـتجيبا بمـودة إلى بـكاء طفلـهما.

العناية من أجل النماء هي مشاركة الآباء وبقية أفراد الأسرة في تشجيع النَّماء النفسي والاجتماعي للأطفال



2.8.4 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين الرجـوع إلى الصفحـتين 64 و65 في الكتـاب الـقلاب. ناقـش الرسـومات التوضيحيـة والنصائـح المقدمـة وكيفيـة توظيفهـا عنـد تقديـم المشـورة. وعندمـا ينتهـون مـن القـراءة، أجـب عـن أي أسـئلة قـد تكـون لديهـم.



3.8.4 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء

في بعـض الأحيـان، تجـد الأمهـات والأطفـال صعوبـةً في تكويـن رابطـة خاصـة بينهـم. ويسـتطيع العاملـون الصحيـون المجتمعيون مسـاعدة الأمهـات ومقدمـي الرعايـة الآخريـن في مراعـاة وفهـم مـا يحـاول أطفالهـم القيـام بـه عندمـا يبـدؤون في التواصـل معهـم، والاسـتجابة لهـم على نحـو مناسـب.

ويمكـن أن يسـاعد العاملـون الصحيـون المجتمعيـون مقدمـي الرعايـة في تشـجيع جهـود أطفالهـم على التعلـم. ويمكـن أن يشـجع البالغـون أطفالهـم مـن خلال الاسـتجابة لكلماتهـم وأفعالهـم واهتماماتهـم بالأصـوات والإيمـاءات واللمسـات الرقيقـة والكلمات.

وسـيقدم العاملـون الصحيـون المجتمعيـون المشـورة حـول العنايـة مـن أجـل الـنماء باسـتخدام اسـتمارة التسـجيل لفهـم الوضـع (السـؤال والملاحظـة) والكتـاب الـقلاب لتقديـم المعلومـات ذات الصلـة. وسـيلاحظون طريقـة تعامـل أفـراد الأسرة مـع الطفـل، ويشـمل ذلـك طريقـة حمـل الأم لطفلهـا ونظراتهـا إليـه.



4.8.4 فيديو توضيحي: اللعب والتواصل مع المواليد وصغار الرضّع

جهـز أسـطوانة مدمجـة (CD)/ وحـدة تخزيـن محمولـة (USB) لمقطـع الفيديـو 15، مقدمـة حـول العناية مـن أجل الـنماء (09:14 دقيقـة) ومقطـع الفيديـو 16، اللعـب والتواصـل مـع المواليـد وصغـار الرُّضَّـع الذين تقـل أعمارهم عـن شـهرين (07:16 دقيقة).

أخبر المشـاركين بأنهـم سيشـاهدون مقطعـي فيديـو، الأول عـن مقدمـة حـول العنايـة مـن أجـل الـنماء، والثـاني عـن كيفيـة اللعـب والتواصـل مـع المواليـد وصغـار الرُّضَّـع الذيـن تقـل أعمارهـم عـن شـهرين.

اعرض مقطعي الفيديو، ثم افتح باب المناقشة بشأنهما، وأجب عن أسئلة المشاركين.

5.8.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 29: كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء، في الصفحة 35، من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

6.8.4 عرض تمثيل الأدوار والتمرين الكتابي 7

أخبر المشاركين أنهم سيشاهدون تدريبين لتمثيل الأدوار . وستؤدي أنت دور العامل الصحي المجتمعي ، بينما سيؤدي الميسِّر المشارك دور الأم. اطلب منهم فتح الصفحة 36 من دليل المشاركين حيث توجد نسختان من القسم الخاص بالعناية من أجل النماء في استمارة التسجيل، واحدة لكل تدريب تمثيلي (ووضح لهم مكان هذا القسم في استمارة التسجيل الكاملة. واقرأ هذا القسم معهم واشرحه). يجب على المشاركين الاستماع إلى تدريبي تمثيل الأدوار ، وملء استمارتي التسجيل وَفقًا لهما، ومتابعة ما ورد في الكتاب القلاب أثناء تقديمك المشورة للأم.

جهِّز مقعدين مواجهين لبعضهما البعض. واستخدم استمارة التسجيل لفهم الوضع والكتاب القلاب لتقديم المشورة إلى الأم. وفي نهاية كل تدريب لتمثيل الأدوار، ناقش مع المشاركين ما سجلوه في استمارة التسجيل. وفي نهاية كل تدريب لتمثيل الأدوار، ناقش آراءهم حول ما سجله العامل الصحي المجتمعي في استمارة التسجيل، وأساليب تقديم المشورة التي استخدمها، وما إذا كانت الأم قد اقتنعت أم لا.

ملاحظة إلى الميسِّر: ستجد القسم المذكور من استمارة التسجيل بالإجابات الصحيحة تحت كل تدريب من تدريبات تمثيل الأدوار.

تمثيل الأدوار 1

العاملة الصحية المجتمعية: أرى أنكِ تعتنين بآية عنايةً جيدةً. فهل تلعبين معها؟
الأم: ماذا؟ ألعب معها؟ بالطبع لا؟
العاملة الصحية المجتمعية: هل لي أن أسألك لماذا؟
الأم: آية لا تزال طفلة. ولا تعرف كيف تلعب.
العاملة الصحية المجتمعية: هل تتحدثين إليها؟
الأم (تضحك): إنها لا تتكلم

العناية من أجل النماء: هل يلعب أي فرد من أفراد الأسرة مع الطفل؟ نعم ☐ لا ☑
إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للمواليد: كيف؟ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل ☐ التربيت برفق ☐ تحريك الذراعين والساقين ☐ أمور أخرى ☐ .....
إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: كيف؟ إعطاؤهم أشياء ليحاولوا الوصول إليها ☐ تحريك أشياء ملونة أمام الرضيع ☐
إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للمواليد: لماذا؟ المواليد لا يلعبون ☑ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك ☐ ليس لدي وقت ☐ أمور أخرى ☐ .....
إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: ليس لدي وقت ☐ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك ☐ لا أعرف كيف أقوم بذلك ☐ أمور أخرى ☐.....
هل تتواصل مع الطفل؟ نعم ☐ لا ☑

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للمواليد: كيف؟ الغناء للطفل ☐ الحديث مع الطفل ☐ لمس الطفل ☐ أمور أخرى☐
إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: كيف؟ اللعب، والحديث والضحك ☐ مواصلة المحادثة بتقليد إيماءات الرضيع ☐

إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للمواليد: لماذا؟ الأطفال لا يتكلمون ☑ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك☐ ليس لدي وقت ☐ أمور أخرى☐ .....
إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: لماذا؟ ليس لدي وقت ☐ هذا أمر غير ضروري ☐ لا أعرف كيف أقوم بذلك ☐ لم أكن أعرف أنه يجب أن أقوم بذلك ☐

تمثيل الأدوار 2

العاملة الصحية المجتمعية: أرى أنكِ تعتنين بآية عنايةً جيدةً. فهل تلعبين معها؟
الأم: لا
العاملة الصحية المجتمعية: هل لي أن أسألك لماذا؟
الأم: لا أعرف كيف ألعب معها. فهي صغيرة جدًا.
العاملة الصحية المجتمعية: إمم! هل تتواصلين معها؟
الأم: نعم.
العاملة الصحية المجتمعية: عظيمٌ أنتِ تقومين بأشياء جيدة لابنتك. كيف تتواصلين معها؟
الأم: أغني لها وألمسها.
العاملة الصحية المجتمعية: هل يتواصل أي فرد آخر من أفراد الأسرة مع آية؟
الأم: نعم، والدها يحبها كثيرًا، ويغني لها ويمزح معها.
العاملة الصحية المجتمعية: أحسنت، إنك تعتنين بآية عنايةً جيدةً.

العناية من أجل النماء: هل يلعب أي فرد من أفراد الأسرة مع الطفل؟ نعم ☑ لا ☐

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للمواليد: كيف؟ ملامسة جلد الأم لجلد الطفل ☐ التربيت برفق ☐ تحريك الذراعين والساقين ☐ أمور أخرى ☐ .....
إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: كيف؟ إعطاؤهم أشياء ليحاولوا الوصول إليها ☐ تحريك أشياء ملونة أمام الرضيع ☐

إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للمواليد: لماذا؟ المواليد لا يلعبون ☑ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك ☐ ليس لدي وقت ☐ أمور أخرى ☐ .....
إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: ليس لدي وقت ☐ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك ☐ لا أعرف كيف أقوم بذلك ☐ أمور أخرى ☐.....

هل تتواصل مع الطفل؟ نعم ☑ لا ☐

إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للمواليد: كيف؟ الغناء للطفل ☑ الحديث مع الطفل ☐ لمس الطفل ☑ أمور أخرى☐
إذا كانت الإجابة بنعم بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: كيف؟ اللعب، والحديث والضحك ☐ مواصلة المحادثة بتقليد إيماءات الرضيع ☐

إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للمواليد: لماذا؟ الأطفال لا يتكلمون ☐ لم أكن أعرف أنني يجب أن أقوم بذلك☐ ليس لدي وقت ☐ أمور أخرى☐ .....
إذا كانت الإجابة بلا بالنسبة للأطفال من عمر شهر واحد حتى أقل من 6 أشهر: لماذا؟ ليس لدي وقت ☐ هذا أمر غير ضروري ☐ لا أعرف كيف أقوم بذلك ☐ لم أكن أعرف أنه يجب أن أقوم بذلك ☐



الجلسة 13:
المكون 9: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات

مدة الجلسة
45 دقيقة

المُعدَّات
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قد تعرفوا على:

- أنواع الحوادث المنزلية التي تشكل خطرًا على المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.
- كيفية تقديم المشورة إلى الآباء حول الوقاية من الحوادث المنزلية.

1.9.4 مناقشة جماعية الوقاية من الحوادث: 1. الاختناق والشَرَق

أخبر المشاركين أن الحوادث المنزلية تعتبر من ضمن الأسباب الشائعة للوفاة بين الأطفال. كما يكون المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين عُرضة للحوادث والإصابات على الرغم من أنهم لا يتحركون في أنحاء المنزل.

اسأل المشاركين عن الحوادث والإصابات التي يمكن أن تؤثر على المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح أن أكثر الحوادث شيوعًا هي:

- الشَرَق والاختناق
- الجروح والسقوط
- الحروق
- الغرق

الشَّرَق والاختناق

وضِّح أن الشَّرَق يحدث عند انسداد مجرى الهواء، مما يجعل الشخص غير قادر على التنفس. ويكون الأطفال أكثر عُرضة على وجه الخصوص للإصابة بالشَّرَق لأن مجرى الهواء لديهم صغيرٌ للغاية.

اسأل المشاركين: "ما الذي يمكن أن يُسبب الشَّرَق والاختناق في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟ استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر الأسباب.

الوضعية الخاطئة على الثدي يمكن أن تُسبب الشَّرَق، ويُعتبر ذلك أحد الأسباب التي تجعل من الضروري أن يلاحظ العاملون الصحيون المجتمعيون عملية الرضاعة، وتصحيح وضعية الطفل وتعلقه بالثدي عند الضرورة. وفي حالة حدوث الشَّرَق، انصح الأم بالجلوس ووضع وجه الطفل إلى الأسفل على فخذيها، مع سند الرأس بيدٍ واحدة، وعليها أن تستخدم اليد الأخرى في التربيت بشدة على المنطقة بين لوحي الكتف خمس مرات براحة اليد.

الدخان الناجم عن الفحم أو الحطب داخل المنزل يؤدي إلى تهيج رئتي الطفل، وقد يُسبب الاختناق في بعض الحالات.

وفي المجتمعات التي يُستخدم فيها الفحم والحطب في التدفئة أو الطهي، يجب تقديم نصائح بشأن الضرر الذي يمكن أن يسببه. وإذا كان لا يمكن تجنب استخدام الفحم والحطب، تُنصح الأسرة بإبقاء الطفل بعيدًا عن مصدر الدخان.

دخان التبغ يمكن أن يُسبب الاختناق، وتهيج الرئتين. ويُعتبر دخان التبغ ضارًا جدًا للمُدخنين، كما يضر المُدخنين السلبيين (الذين يستنشقون دخان التبغ دون تدخين). انصح أي مدخنين في الأسرة بالإقلاع عن التدخين، من أجل مصلحة الطفل وباقي أفراد الأسرة. وحافظ على بقاء الطفل بعيدًا عن المُدخنين والأماكن التي يوجد فيها مُدخنون، وتأكد من خلو السيارة والمنزل من الدخان. ويجب عدم التدخين في أي مكان بالقرب من الطفل، حتى لو في الخارج. فرائحة التبغ تظل عالقة في الملابس والجسم. ويجب على المدخنين أن يستحموا ويغيروا ملابسهم فور دخولهم المنزل.

الاختناق بسبب الوسائد والألعاب المحشوَّة والبطانيات يشكل خطرًا على الأطفال، خاصة عندما ينامون على بطونهم ووجوههم إلى أسفل. ويحتاج المواليد إلى حماية خاصة من الاختناق لأنهم لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم.

تُنصح الأم بضرورة وضع الطفل على جنبه أثناء النوم في فترات القيلولة أو ليلاً. ويجب ألا يوضع وجه الطفل إلى الأسفل على الأسطح الناعمة، ويجب أن يظل سرير الطفل خاليًا من الألعاب المحشوة والوسائد الناعمة.

الاختناق من شرائط المرايل التي تُربَط حول العنق، أو المثبَّتة باللهَّايات يمكن أيضًا أن تُشكل خطرًا.

وتُنصَح الأم بعدم استعمال اللهايات (لا يُوصَى باستعمالها)، وإزالة المرايل قبل النوم.

الأطفال الذين ينامون في نفس السرير الذي ينام فيه آباؤهم، مُعرَّضون لخطر الاختناق. يمكن أن يتقلب الوالدان على الطفل أثناء النوم، أو أن يعلق الطفل في الملاءات والبطانيات.

تُنصح الأم بتخصيص مكان منفصل لنوم الطفل، بعيدًا عن الأخوات والآباء.



2.9.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 66 إلى 69 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. واشرح التعليمات الواردة في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.9.4 مناقشة جماعية: الوقاية من الحوادث: الجروح والسقوط والغرق

الجروح والسقوط

- قد يتسبب ترك أشياء على الأرض، أو ترك الأرض زلقة في وقوع أحد أفراد الأسرة أثناء حمل الطفل. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث رَضْح أو كسر للطفل.
  المشورة: يُنصَح بالحفاظ على المنزل مُنظمًا ومُرتبًا، بحيث يكون كل شيء في مكانه.
- ترك الأطفال دون رقابة على أسطح عالية قد يُعرضهم إلى خطر السقوط على الأرض والكسر.
  المشورة: لا يُترك الطفل مطلقًا دون رقابة على سطح مُرتفع.
- قد تتسبب الدبابيس المُثبّتة في ملابس الطفل في إصابته بجروح.
  المشورة: لا يجب ُترك دبابيس مُثبتة في ملابس الطفل. وفي حالة الضرورة القصوى، تُستخدم دبابيس الأمان.
- قد تتسبب الأظافر الحادة الطويلة في إحداث جروح وخدوش.
  المشورة: تُنصح الأم بتقليم أظافر طفلها بانتظام، باستخدام مقص مناسب.

- يمكن أن يؤدي اللعب المحفوف بالمخاطر، مثل رمي الطفل إلى أعلى والتقاطه، إلى إصابة خطيرة إذا اصطدم رأس الطفل بمروحة، أو غير ذلك من الأمور.
المشورة: يُنصح بتجنب هذا النوع من اللعب.

الحروق

- قد يؤدي استعمال ماء ساخن في تحميم الطفل إلى إصابته بحرق.
المشورة: يُنصح بأن تختبر الأم درجة حرارة الماء بمرفقها قبل تحميم الطفل.
- قد يؤدي حمل الطفل أثناء الطهي، حيث توجد أشياء ساخنة، أو أثناء حمل مشروب ساخن إلى إصابة الطفل بحرق.
المشورة: تُنصح الأم بإبقاء الطفل في مكان آمن على مرأى منها، بدلاً من حمله أثناء القيام بأعمال تتضمن استخدام أشياء أو سوائل ساخنة.
- يكون الأطفال عُرضة للإصابة بحروق الشمس.
المشورة: يجب تجنب التعرض لضوء الشمس عندما تكون شديدة الحرارة. الغرق
- قد يتعرض الأطفال الذين يُترَكون وحدهم أثناء الاستحمام إلى الغرق في الماء بغض النظر عن عُمقه.
المشورة: لا يُترك الطفل مطلقًا دون رقابة في حوض الاستحمام.

المشورة: تُنصح الأم بتجهيز كل ما تحتاج إليه قبل البدء في تحميم الطفل، وبتجنب احتمال تعرضها لأي شيء يشتت انتباهها أثناء تحميم الطفل.

4.9.4 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 70 و71 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

5.9.4 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث

أخبر المشاركين أنه يتعين عليهم القيام بما يلي عند تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث:

- استخدام مهارات التواصل الجيد؛
- استخدام استمارة التسجيل لفهم الوضع (اقرأ القسم الخاص بالوقاية من الحوادث في استمارة التسجيل، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحها المشاركون)؛
- أثناء الزيارات المنزلية، يجب تحري أي مصدر من مصادر الضرر بعناية، مثل الشرائط المثبَّتة في المرايل، أو الدبابيس المثبَّتة في الملابس، أو وجود دخان داخل المنزل، إلى ما غير ذلك.
- استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة، مع تذكُّر تقديم المشورة فقط حول مشكلات مُحددة، واستخدام الرسومات دائمًا لتوضيح الرسائل.

6.9.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 30: كيفية تقديم المشورة إلى الأم حول الوقاية من الحوادث والإصابات، في الصفحة 37 من دليل المشاركين. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



الجلسة 14:

المكون 10: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

مدة الجلسة
30 دقيقة

المُعدَّات
- طباشير

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- إدراك المقصود بسوء المعاملة، والإهمال، والعنف تجاه المواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- الإلمام بمختلف نواحي سوء المعاملة والإهمال والعنف التي تنطبق على هذه الفئة العمرية؛
- الإلمام بكيفية الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف تجاه المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؛
- الإلمام بكيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن سوء المعاملة والإهمال والعنف.

1.10.4 مناقشة جماعية: سوء المعاملة والإهمال

اطلب من المشاركين تعريف الإهمال وسوء المعاملة بالنسبة للمواليد/ صغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

استمع إلى إجاباتهم، ثم اشرح أن الإهمال هو إخفاق الوالدين في تقديم الرعاية الملائمة لرفاة الطفل في أي من النواحي التالية (اكتبهم على اللوح الورقي القلاب):
- النَّماء العاطفي
- الصحة
- التغذية
- التنشئة
- المسكن والأحوال المعيشية الآمنة

وأضف أن سوء المعاملة والإهمال يترتب عليهما آثار سلبية على نَماء المخ أثناء مرحلتي الرَّضاعة والطفولة المبكرة. وهناك مؤشرات على أنه قد يحدث تغيرات فسيولوجية في المخ بسبب سوء المعاملة لفترة طويلة، مما يؤثر بدوره على النمو البدني، والمعرفي، والعاطفي، والاجتماعي للطفل. وعند بلوغ الطفل الثالثة من العمر، يكون حجم المخ قد وصل إلى 90% من حجمه لدى البالغين. وفي غياب التحفيز والتنشئة (مثل عدم اهتمام الوالدين بالطفل)، قد يتأخر نَماء المخ. فالمخ يتكيف مع بيئته، وسيتكيف مع البيئة السلبية المحيطة به تمامًا كما قد يتكيف مع البيئة الإيجابية.

النَّماء العاطفي

اسأل المشاركين عن كيفية قيام الآباء برعاية أطفالهم المواليد من أجل نَمائهم العاطفي. استمع إلى إجاباتهم، ثم أكِّد على أن العناية من أجل النماء العاطفي قد تقي من سوء المعاملة والإهمال. واشرح دور ملامسة جلد الأم لجلد الطفل،

والرضاعة، والاستجابة الفورية للطفل عندما يبكي، على النحو التالي:

تُعزز ملامسة جلد الأم لجلد الطفل الرابطة بين الأم والطفل، ويشعر الطفل بالحماية والأمن.

فالرضاعة لا تعني فقط أن الأم تُقدم أفضل غذاء لطفلها، إذ إن الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن يَمِلن إلى الاستجابة لأطفالهن بطريقة أكثر عاطفية. كما تشتكي هؤلاء الأمهات بصورة أقل من حاجة الطفل إلى العناية والتغذية ليلاً، وتقل احتمالات قيامهن بالتخلي عن أطفالهن أو إساءة معاملتهم.

وعندما تستجيب الأم سريعًا لتهدئة طفلها الذي يبكي، سيبكي الطفل بصورةٍ أقل بشكل عام. ولا بأس من حمل الطفل عندما يبكي، إذ إن ذلك يُشعر الطفل بالأمان وبأن لديه أمًا ترعاه وتستجيب له. ويؤثر ذلك إيجابيًا على النَّماء العاطفي للطفل.

الصحة

تتضمن الرعاية في مجال الصحة ما يلي:

- تمنيع الطفل لوقايته من المرض؛
- طلب الرعاية الصحية المبكرة عندما لا يكون الطفل على ما يرام من أحد المرافق الصحية، أو أحد العاملين الصحيين المجتمعيين المُدرَّبين؛
- استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد، أي إعطاء المضادات الحيوية التي يصفها أحد مُقدمي الرعاية الصحية المُدرَّبين فقط، وليس أي مضاد حيوي قد يكون في متناول اليد؛
- الاهتمام بالنظافة الشخصية - إذا كان الطفل نظيفًا، ويرتدي ملابس نظيفة ولديه ألعاب نظيفة، فإن ذلك يدل على أن الأم تعتني به بصورة جيدة.

التغذية

يعني الاعتناء بتغذية المواليد والرضَّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر الاقتصار على الرضاعة المطلقة فقط.

التنشئة وتوفير المسكن والأحوال المعيشية الآمنة

- يجب أن يحافظ الآباء على سلامة أطفالهم من أي ضرر، وأن يقدموا لهم الحب، والاهتمام، وفرص التعلُّم.
- في حالة إساءة معاملة الأم والطفل، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على نَماء الطفل الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
- يجب ألا يكون هناك تمييز بين البنين والبنات، أو بين مختلف الأشقاء. فيجب معاملتهم جميعًا على قدم المساواة فيما يتعلق بالتغذية وطلب الرعاية الصحية واللعب والتواصل. ويؤثر التمييز سلبًا على نَماء الطفل ونفسيته في المستقبل.
- قد تُرزَق بعض الأسر بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي حين أن هؤلاء الأطفال يتطلبون مزيدًا من الرعاية والاهتمام، إلا أنه يجب على الوالدين ضمان ألا يكون ذلك على حساب باقي الأطفال، وإلا سيعاني الأشقاء من الإهمال غير المتعمَّد. وعلى الوالدين الموازنة بشأن العناية المُقدَّمة لجميع الأطفال.



2.10.4 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 31: الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف، في الصفحة 38 من دليل المشاركين، والرجوع إلى الصفحتين 72 و73 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.10.4 لعبة: التحرك خُطوة إلى الأمام 3، لمراجعة الوقاية من الحوادث والإصابات، والوقاية من سوء المعاملة والإهمال والعنف

ستحتاج إلى: أصبع من الطباشير

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون الآن لعبة "التحرك خُطوة إلى الأمام" لمراجعة الوقاية من الحوادث والإصابات.

استخدم أصبعًا من الطباشير لرسم خط البداية وخط النهاية. ويجب أن تكون المسافة بين الخطين أربع خطوات أو أكثر.

قسِّم المشاركين إلى فريقين، وأعطِ كل فرد رقمًا بين 1و4. اطلب منهم أن يتذكروا أرقامهم. ثم، نادِ على أحد الأرقام، وليكن رقم 2 على سبيل المثال. فيبدأ الشخص الذي يحمل رقم 2 من كل فريق في التحرك تجاه خط البداية. وأخبرهما أنك ستسأل كل واحد منهما سؤالاً. وعلى المشارك الذي يجيب إجابة صحيحة أن يتحرك خطوة إلى الأمام. أما المشارك الذي يجيب إجابة خاطئة، فيرجع إلى الخلف، ويحاول باقي أفراد الفريق الإجابة عن السؤال حتى يصلوا إلى الإجابة الصحيحة. واستمر في اللعبة حتى يصل أحد المشاركين إلى خط النهاية. وأعلن عن الفريق الفائز، واطلب من الفريق الآخر التصفيق له.

وفيما يلي الأسئلة والإجابات الخاصة بهذا التمرين:

السؤال 1: ما هي أنواع الحوادث التي قد تحدث للأطفال وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟
الإجابة 1: الشَّرَق، والاختناق، والجروح، والسقوط، والحروق، والغرق.

السؤال 2: ما الذي يمكن أن يُسبب الشَّرَق والاختناق للمواليد والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟
الإجابة 2: وضعية الطفل الخاطئة أثناء الرضاعة، والتدخين داخل المنزل، وتدخين أفراد الأسرة بالقرب من الطفل، والنوم في نفس السرير الذي ينام فيه الوالدان، وربط المرايل حول العنق، والنوم بالقرب من الوسائد والألعاب المحشوَّة.

السؤال 3: ما الذي يمكن أن يُسبب الجروح والإصابات في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟
الإجابة 3: قيام الأشخاص بحمل الطفل على أرضيات زَلِقَة، أو الأرضيات المنتشر على سطحها أشياء يمكن أن تتسبب في انزلاق الشخص الذي يحمل الطفل، والدبابيس المُثبتة بالملابس، وترك الطفل دون رقابة على سطح مرتفع، والأظافر الطويلة التي يُمكن أن تُسبب جروحًا وخدوشًا.

السؤال 4: ما هي أكثر الأسباب شيوعًا للحروق التي قد تحدث للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟
الإجابة 4: الحرق من ماء الاستحمام الساخن جدًا، أو قيام مقدِّم الرعاية بحمل الطفل أثناء الطهي أو تناول مشروب ساخن.

السؤال 5: ما هي الحوادث الأخرى التي يمكن أن تقع؟
الإجابة 5: الغرق.

السؤال 6: ما هي نواحي الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف بالنسبة للأطفال؟
الإجابة 6: النَّماء العاطفي، والصحة، والتغذية، والتنشئة، والمسكن والأحوال المعيشية الآمنة.

السؤال 7: ما هي التدابير التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر فيما يتعلق بالنَّماء العاطفي؟
الإجابة 7: ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، والرضاعة، والاستجابة السريعة لبكاء الطفل.

السؤال 8: ما هي التدابير التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالصحة؟

الإجابة 8: التطعيم، وطلب الرعاية الصحية المبكرة، واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد.

السؤال 9: ما الذي يمكن عمله لتوفير مأوى آمن وأحوال معيشية آمنة؟

الإجابة 9: يجب أن يكون الوالدان على وفاق، وألا يميزا بين البنين والبنات. ويجب عليهما الحفاظ على سلامة أطفالهما من الأذى، ومنحهم الحب، والاهتمام، وفرص التعلُّم.

الزيارات المنزلية للمواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين

أخبر المشاركين أنه يتعين عليهم التخطيط لثلاث زيارات لهذه الفئة العمرية.

ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون الزيارة الأولى أثناء الوضع. فعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يبذلوا قصارى جهدهم لحضور عملية الوضع. ويجب عليهم أن يشرحوا للأسرة مدى أهمية هذه الزيارة، ويحصلوا على موافقة الأسرة لحضور عملية الوضع. كما يجب، إن أمكن، أن يأخذوا رقم الهاتف حتى يستطيعوا متابعة الولادة. ويجب عليهم أيضًا أن يتخذوا الترتيبات اللازمة مع القابلة لحضور عملية الوضع.

أما الزيارة الثانية، فتكون بعد ولادة الطفل بثلاثة أيام. وعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يغتنموا هذه الفرصة للتحقُّق مما إذا كانت النصائح التي قُدمت خلال الزيارة الأولى تُتبع أم لا، وللتحقق من وجود أي علامات خطورة، وتقديم المشورة إذا لزم الأمر بشأن أمور أخرى لم تُذكَر أثناء الزيارة السابقة.

ويجب أن تكون الزيارة الثالثة عند بلوغ الطفل ستة أسابيع.

وعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يتوجهوا إلى الزيارات وهم مزوَّدون بمجموعة الأدوات التي يحددها البلد، بالإضافة إلى استمارة التسجيل والكتاب القلاب. ويجب عليهم دائمًا أن يستخدموا مهارات التواصل الجيد التي تمرنوا عليها، وأن يتبعوا الخطوات المذكورة في استمارة التسجيل. وقد صُممت الاستمارة لمساعدة العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد علامات الخطورة التي تشير إلى وجود حالات خطيرة تستلزم إحالةً عاجلة. ويجب أن يتحقق العاملون الصحيون المجتمعيون أولاً من وجود هذه العلامات. وإذا وُجدت أي منها فيجب تخطي جميع المهام الأخرى وتقديم المشورة حول الإحالة. ثم، توجد أقسام لجمع المعلومات لفهم الوضع فيما يتعلق بمكونات الرعاية الأخرى.

ويجب استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة بالموقف. ومن المهم أن يفهم العاملون الصحيون المجتمعيون أنه لا يجب وحسب ترديد/ قراءة محتويات الكتاب القلاب، بل يجب تكييف المعلومات التي يحتوي عليها مع احتياجات الأسرة التي يزورونها.

ذكِّر المشاركين أنهم مسؤولون أيضًا عن التحقق من صحة الأم (التفاصيل واردة في الفصل 9، أدناه).

اطلب من المشاركين الاطلاع على الإطار 32 للتعرف على ما جاء فيه، كيفية إجراء زيارة منزلية لهذه الفئة العمرية، في الصفحة 38، من دليل المشاركين.

الوحدة الخامسة

العناية بصحة ونماء الرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر في المنزل

مقدمة

أخبر المشاركين أنهم سيتعلمون الآن أشياء بشأن الفئة العمرية الثانية، وهم الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (الرضّع الذين أتموا الشهر الثاني من أعمارهم، ولكنهم لم يبلغوا ستة أشهر بعد). وهم يحتاجون إلى التغذية الجيدة حتى ينموا بشكل صحي، كما يجب ملاحظة النَّماء القوي عن كَثَب وتحفيزه. ويجب الحفاظ على نظافتهم، وعلى عيشهم في بيئة آمنة. كما يحتاجون إلى الحب، والمودة، والتقدير، ويحتاجون أيضًا إلى أن يقضي آباؤهم الوقت معهم في اللعب والتواصل.

وهم يحتاجون إلى حمايتهم من الأمراض والإصابات، بينما يستكشفون العالم من حولهم. وعندما يمرضون، يحتاجون إلى الحصول على رعاية طبية جيدة.

وبالنسبة لهذه الفئة العمرية، توجد سبعة مكونات للرعاية تُقدّم المشورة حولها، ألا وهي:

- ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية
- التغذية (الرضاعة)
- النظافة الشخصية
- معالم النَّماء الرئيسية
- العناية من أجل النماء
- الوقاية من الحوادث/ الإصابات
- الوقاية من سوء المعاملة، والعنف، والإهمال.





الجلسة 15:
المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر

مدة الجلسة
ساعتان

جهِّز

- مقطع الفيديو 17، علامات الخطورة: الطفل ضعيف جدًا لا يقدر على الرضاعة، والتشنجات، وتقيؤ الطفل لكل ما يتناوله، والتنفس السريع، وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل
- استمارة تسجيل مُكبّرة للمواليد والرضّع حتى أقل من ستة أشهر
- قلمًا
- شاشة، وحاسوبًا محمولاً، وجهاز عرض البيانات
- طباشير
- أربعة مواقف لتمثيل الأدوار حول تقديم المشورة بشأن علامات الخطورة
- مذكرة إحالة (واحدة لكل مشارك)
- استمارة تسجيل (واحدة لكل مشارك)
- مستلزمات غسل اليدين:
  - صابون
  - إبريق ماء
  - إناء ماء كبير
  - مِنْشَفة

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- التعرف على علامات الخطورة بالنسبة لهذه الفئة العمرية؛
- تعليم الأسر كيفية تحديد علامات الخطورة؛
- دعم الإحالات؛
- استخدام الأدوات اللازمة لتقديم المشورة بشأن ممارسات طلب الرعاية الصحية؛
- تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية؛
- التدرب على كيفية تعليم الأمهات غسل اليدين.

1.1.5 مقدمة. الأدوات التي ستُستخدم لتقديم المشورة حول رعاية الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر

أخبر المشاركين أنهم سيستخدمون ما يلي:

- استمارة التسجيل للرضّع حتى أقل من ستة أشهر لتسجيل ملاحظاتهم والمعلومات التي يحصلون عليها من إجابات الأم لفهم الوضع.

- الكتاب القلاب لتقديم المعلومات ذات الصلة والدعم العملي، إذا لزم الأمر، بناءً على تقييمهم للوضع.
- كما أنهم سيواصلون الرجوع إلى دليل المشاركين أثناء الدورة التدريبية وبعدها.



2.1.5 عرض توضيحي. استمارة التسجيل

ستحتاج إلى استمارة تسجيل مُكبّرة

ضع النسخة المُكبرة لاستمارة التسجيل حيث يمكن رؤيتها، وراجع مكوناتها مع المشاركين. أكِّد على أن المشاركين سيستخدمون هذه الاستمارة لفهم الوضع.

اقرأ سريعًا مكونات الاستمارة وعموديها والصفوف الخاصة بمختلف مكونات الرعاية. والفت انتباههم إلى القسم الخاص بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرضع في هذه الفئة العمرية، وأخبرهم بأنهم سيتعلمون في هذه الجلسة علامات الخطورة التي تنطبق على الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

اسأل المشاركين عن الطريقة التي تعلموها لملء القسم الخاص بعلامات الخطورة. استمع إليهم، ثم أخبرهم أنه يجب عليهم الحصول على إذن لملاحظة الطفل. ويجب عليهم غسل أيديهم قبل لمس الطفل. وعليهم أن يضعوا علامة في المربع المتعلق بالعلامة التي حددوها. وفي حالة وجود أي علامة خطورة، عليهم أن يتخطوا باقي المهام الأخرى، ويحيلوا الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية. وإذا لم تكن هناك أي علامة خطورة، فيجب ألا يضعوا علامة في أي مربع.



3.1.5 عرض توضيحي: الكتاب القلاب

ذكِّر المشاركين بتصميم الكتاب القلاب.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على القسم الخاص بالرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر. والفت انتباههم إلى العلامات السبعة لمكونات الرعاية لهذه الفئة العمرية، ولخص بشكل موجز كيفية استخدام الكتاب القلاب. وذكِّرهم بأنه أثناء تقديم المشورة، تكون الصفحات المصورة مواجهة لمقدم الرعاية، بينما تكون الصفحات التي تحتوي على النصائح المكتوبة مواجهة للعامل الصحي المجتمعي.



4.1.5 مناقشة جماعية: المكون 1: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لصغار الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

أولاً. ممارسات طلب الرعاية الصحية. متى يجب طلب الرعاية الصحية؟ (التحقق من وجود علامات الخطورة)

اسأل المشاركين عن المكونين الرئيسيين لممارسات رعاية الصحة. استمع إلى إجاباتهم، ثم أخبرهم أنهما لا يختلفان عن تلك الخاصة بالمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين:

1. ممارسات طلب الرعاية الصحية
   - متى يجب طلب الرعاية الصحية؟ (التحقق من وجود علامات الخطورة)
   - من الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟
2. ممارسات الوقاية

- التطعيم
- غسل اليدين
- النوم تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات حشرية
- استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد
- غلي الماء وتنظيف الأكواب والملاعق

وأكِّد مرةً أخرى أنه يجب عليهم التحقق من علامات الخطورة، وتقديم المشورة إلى أفراد الأسرة بشأن كيفية تحديد علامات الخطورة بأنفسهم. ولاحظ أنه على الرغم من عدم اختلاف ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، إلا أن تفاصيل علامات الخطورة مختلفة.

اسأل المشاركين عن أهمية علامات الخطورة. واستمع إلى إجاباتهم، ثم أكِّد على أن وجود أي علامة خطورة يدل على حالة صحية خطيرة، ويستوجب إحالة الطفل فورًا إلى أحد مرافق الرعاية الصحية.

راجع مع المشاركين علامات الخطورة في الفئة العمرية السابقة.

وأكِّد على تباين بعض علامات الخطورة في الفئة العمرية التي تتراوح بين شهرين وأقل من ستة أشهر.

واشرح علامات الخطورة التي تنطبق على هذه الفئة العمرية.

• الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة أو توقف عن الرضاعة بشكل جيد

اسأل المشاركين عن معنى هذه العلامة. استمع إليهم وأكِّد على أن الطفل يُصبح أضعف من أن يكون قادرًا على الرضاعة، وحتى إذا وُضعت قطرات من اللبن في فم الطفل، لن يستطيع بلعها.

وتحقق من أن المشاركين لا يخلِطون بين عدم القدرة على الرضاعة ورفضها. وإذا قالت الأم إن رضيعها غير قادر على الرضاعة، فعلى العاملين الصحيين المجتمعيين أن يطلبوا ملاحظة عملية الرضاعة. فإذا لاحظوا أن الطفل غير قادر تمامًا على الرضاعة، فهذا معناه وجود علامة خطورة لدى هذا الطفل، وتجب إحالته فورًا إلى أحد المرافق الصحية. وإذا قالت الأم إنه غير قادر على الرضاعة، فعليهم التحقق من ذلك بمحاولة تقديم الماء للطفل. فإذا تبين أن الطفل غير قادر على البلع على الإطلاق، تجب إحالته فورًا.

ملاحظة: إذا كان الطفل لا يرضع لأسباب قهرية، تحقَّق من قدرته على البَلْع بتقديم بعض الماء له، وتأكد مما إذا كان قادرًا على الشرب أو البلع أم لا.

• التشنجات

اسأل المشاركين عن معنى هذه العلامة. واستمع إلى إجاباتهم، وذكِّرهم أنه أثناء التشنجات، تتعرض ذراعا الطفل وساقاه للتيبّس، وقد يتوقف أحيانًا عن التنفس، كما قد يفقد الوعي لفترة قصيرة. وذكِّرهم أيضًا أنه يجب عليهم استخدام المصطلح الأكثر شيوعًا في المجتمع المحلي عندما يتحدثون مع الأسرة عن التشنجات.

وأخبر المشاركين أنه يتعين عليهم أولاً أن يشرحوا للأم ما هي التشنجات، ثم يسألوها إذا ظهر على الطفل أي علامة من علامات التشنجات أم لا. ثم، تحقق من وجود التشنجات: انظر إذا كان الطفل مصابًا الآن بالتشنجات أم لا.

إذا قالت الأم إن طفلها سبق أن أصيب بالتشنجات، أو إذا رأيتَ أنت ذلك بنفسك، فهذا يدل على أن هذا الطفل لديه إحدى علامات الخطورة. وتجب إحالته فورًا إلى أحد المرافق الصحية.

• تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله

وضح أن هذه العلامة من علامات الخطورة لا تنطبق على المواليد. ولكنها تنطبق على الرُّضَّع الذين لا يستطيعون الاحتفاظ بأي شيء في معدتهم، بما في ذلك الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، فهم يتقيؤون كل شيء وما يبتلعونه

يتقيؤونه فورًا. وهذه علامة خطورة. أما الطفل الذي يتقيأ عدة مرات، ولكنه يستطيع الاحتفاظ ببعض اللبن، فلا توجد لديه علامة خطورة.

وإذا أخبرت الأم العامل الصحي المجتمعي أن رضيعها يتقيأ كل ما يتناوله، يُطلَب من الأم إرضاع طفلهاوملاحظة ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا. وإذا كان الطفل يتقيأ كل ما يتناوله، فتجب إحالته على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

• **انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل**

راجع مع المشاركين كيفية الكشف عن علامة انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، ووضح أن انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل يوجد عادةً في الفئة العمرية السابقة بسبب لين جدار الصدر لديهم. فإذا تحوَّل ذلك إلى انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، فهذه علامة خطورة.

وبالنسبة للرضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، يُعتبر انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل علامة خطورة، مهما كانت درجته. ويجب أن يُحال الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

• **التنفس السريع**

راجع ما تعلَّمه المشاركون بشأن حساب معدل سرعة التنفس في المواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين. وأكِّد على ضرورة عدّ الأنفاس على مدار دقيقة كاملة لتحديد معدل التنفس، وعلى ضرورة القيام بذلك عندما يكون الطفل هادئًا. أما إذا كان الطفل يبكي أو غاضبًا، فإن العدد لن يكون دقيقًا.

وأكِّد على ضرورة إخبار الأم بأنه سيُجرَى حساب معدل سرعة تنفس رضيعها. ويُطلَب منها الحفاظ على هدوء الطفل. وإذا كان الطفل نائمًا، فلا يجب إيقاظه.

ولحساب عدد أنفاس الطفل في الدقيقة الواحدة:

- استخدم مؤقِّتًا أو ساعة. انظر إلى صدر الطفل أو بطنه، إذ يمكنك عادةً رؤية حركات التنفس حتى إذا كان الطفل مرتديًا ملابسه.
- إذا كنت لا تستطيع رؤية الحركات بسهولة، اطلب من الأم أن ترفع قميص الطفل، وإذا بدأ الرضيع في البكاء، يُطلَب من الأم تهدئته قبل بدء العدّ.
- إذا كنت غير متأكد بشأن العدّ (على سبيل المثال، إذا كان الرضيع يتحرك بنشاط، مما يجعل من الصعب رؤية الصدر، أو إذا كان الرضيع منزعجًا أو يبكي)، كرر عدّ الأنفاس.

وقد يتباين عدد الأنفاس أثناء التنفس السريع حسب عُمر الطفل.

اسأل المشاركين عن معدل التنفس السريع للمواليد وصغار الرُّضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

واستمع إلى إجاباتهم قبل أن تذكر في النهاية أن معدل سرعة التنفس هو 60 نَفَسًا أو أكثر في الدقيقة. ولكن يجب التأكيد على أنه نظرًا لأن التنفس لدى المواليد يكون عادةً غير منتظم، فمن الضروري عدّ الأنفاس مرتين، ويجب أن يكون معدل التنفس في المرتين 60 نَفَسًا أو أكثر لتأكيد التنفس السريع.

ووضح أن معدلات التنفس الطبيعي تكون أقل لدى الأطفال الأكبر سنًا.

إذا كان عمر الطفل:	يكون الطفل لديه سرعة تنفس، إذا كان العدد:
أقل من شهرين (لم يُتم شهرين بعد)	60 نَفَسًا/ الدقيقة أو أكثر (في المرتين)
شهرين إلى أقل من ستة أشهر (أتم الشهرين، إلا أنه لم يُتم ستة أشهر)	50 نَفَسًا/ الدقيقة أو أكثر

وأكِّد على أن الرضيع الذي أتم شهرين ولم يبلغ ستة أشهر بعد يكون لديه تنفس سريع إذا عددت 50 نَفَسًا في الدقيقة أو أكثر من المرة الأولى.

أكِّد على ضرورة عدّ الأنفاس على مدار دقيقة كاملة.

راجع مع المشاركين كيفية استخدام المؤقِّت لعدّ الأنفاس.



5.1.5 فيديو توضيحي: علامات الخطورة لدى الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر

جهز أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 17 حول علامات الخطورة بالنسبة للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (12:10.53 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول علامات الخطورة بالنسبة للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (عدم القدرة على الشرب أو الرضاعة، وتقيؤ الطفل لكل ما يتناوله، والتشنجات، والتنفس السريع، وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل).

اعرض الفيديو، والفت انتباه المشاهدين إلى أهم جوانب كل علامة من علامات الخطورة. وأكِّد على النقاط المهمة المرتبطة بكل علامة من علامات الخطورة. وذكِّرهم بأنه بالنسبة للتشنجات، عليهم أن يسألوا الأم عن العلامة الدالة على ذلك مع استخدام المصطلح المحلي، وأن يلاحظوا هذه العلامة.

وكرر عرض الفيديو إذا كان ذلك ضروريًا، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



6.1.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 33: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للرضع في هذه الفئة العمرية، في الصفحة 40 من دليل المشاركين. ثم اطلب منهم أيضًا قراءة الصفحات من 74 إلى 79 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم للاسترشاد بها في عملهم.



7.1.5 تدريب الأسئلة السريعة 2. مراجعة علامات الخطورة

أخبر المشاركين أنك ستراجع معهم علامات الخطورة الخاصة بهذه الفئة العمرية.

اشرح التمرين: ستطرح سؤالاً على كل مشارك، كلٌّ في دوره. وسيُمنح كل منهم وقتًا قليلاً للرد، فإذا لم يجب، انتقل إلى مشارك آخر. اختر مشاركًا لبدء التمرين واطرح عليه السؤال الأول. واستمر في ذلك حتى يُجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح.

وفيما يلي جدول بالأسئلة والإجابات الصحيحة.

ما هي علامات الخطورة بالنسبة لرضيع عمره سبعة أيام؟	ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة، أو التوقف عن الرضاعة على نحو جيد، والتشنجات، وانسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، والتنفس السريع، واصفرار راحة اليدين وباطن القدمين، وانخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو علامات العدوى الموضعية، وقلة الوزن .
ما هي علامات الخطورة بالنسبة لرضيع عمره ثلاثة أشهر؟	ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة أو التوقف عن الرضاعة بشكل جيد والتشنجات، وتقيؤ الطفل لكل ما يتناوله، وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، والتنفس السريع.
كيف تقرر أن الرضيع ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة؟	اسأل الأم، فإذا قالت إن طفلها غير قادر على الرضاعة، لاحظ الأم أثناء عملية الرضاعة. فإذا كان الرضيع أضعف من أن يرضع أو يبتلع، حتى لو وضعت الأم اللبن في فمه، فذلك معناه أن علامة الخطورة موجودة.
كيف يمكن أن تقرر ما إذا كان الطفل يتقيأ كل ما يتناوله أم لا؟	اسأل الأم، فإذا أجابت بنعم، اطلب منها إرضاع الطفل. لاحظ الأم أثناء عملية الرضاعة. إذا تقيأ الطفل كل اللبن الذي تناوله، فذلك معناه أنه يتقيأ بالفعل كل ما يتناوله.
ما هي الشروط التي يجب توافرها للتحقق من وجود انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل؟	يجب أن يكون الطفل هادئًا، وألا يكون ذلك أثناء الرضاعة، ويجب ألا يكون جسمه مثنيًا عند الوسط، مع ملاحظة انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل طوال الوقت.
ما هي علامات التشنجات؟	تيبس ذراعي الطفل وساقيه، والتوقف أحيانًا عن التنفس، واحتمال فقدان الوعي لفترة وجيزة.



8.1.5 لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام 3. مراجعة التنفس السريع

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون الآن لعبة "التحرك خُطوة إلى الأمام".

استخدم أصبعًا من الطباشير لرسم خط البداية وخط النهاية. ويجب ألا تقل المسافة بين الخطين عن أربع خُطوات أو أكثر.

قسّم المشاركين إلى فريقين، وأعط كل فرد رقمًا بين 1و4. واطلب منهم أن يتذكروا أرقامهم. ثم، نادِ على أحد الأرقام، وليكن رقم 2 على سبيل المثال. فيبدأ الشخص الذي يحمل رقم 2 من كل فريق في التحرك تجاه خط البداية. وأخبرهما أنك ستسأل كلَّ واحد منهما سؤالاً. وعلى المشارك الذي يجيب إجابة صحيحة أن يتحرك خطوة إلى الأمام. أما المشارك الذي يجيب إجابة خاطئة، فيرجع إلى الخلف، ويحاول باقي أفراد الفريق الإجابة عن السؤال حتى يصلوا إلى الإجابة الصحيحة. واستمر في اللعبة حتى يصل أحد المشاركين إلى خط النهاية. وأعلن عن الفريق الفائز، واطلب من الفريق الآخر التصفيق له.

وفيما يلي الأسئلة والإجابات الخاصة بهذا التمرين:

السؤال 1: ما هو التنفس السريع بالنسبة لرضيع عمره سبعة أسابيع؟
الإجابة 1: ستون نَفَسًا في الدقيقة أو أكثر في العد الثاني.

السؤال 2: ما هو التنفس السريع بالنسبة لرضيع عمره خمسة أشهر؟
الإجابة 2: خمسون نَفَسًا في الدقيقة، في العد الأول.

السؤال 3: رضيع عمره شهران، ومعدل التنفس لديه 53 نَفَسًا في الدقيقة. فهل يُعتبر هذا الرضيع لديه تنفس سريع؟
الإجابة 3: نعم (لا حاجة لتكرار العد).

السؤال 4: رضيع عمره خمسة أشهر، ومعدل التنفس لديه 46 نَفَسًا في الدقيقة. فهل يُعتبر هذا الرضيع لديه تنفس سريع؟
الإجابة 4: لا.

السؤال 5: رضيع عمره ستة أسابيع، ومعدل التنفس لديه 65 نَفَسًا في الدقيقة في العد الأول. فهل يُعتبر هذا الرضيع لديه تنفس سريع؟
الإجابة 5: كرِّر العد. إذا كان لا يزال 60 أو أكثر، فإنه يُعتبر تنفسًا سريعًا.

السؤال 6: رضيع عمره أربعة أشهر، ومعدل التنفس لديه 62 نَفَسًا في الدقيقة. فهل يُعتبر هذا تنفسًا سريعًا؟
الإجابة 6: نعم (لا حاجة إلى تكرار العد في هذه السن).

السؤال 7: رضيع عمره شهران ونصف، ومعدل التنفس لديه 48 نَفَسًا في الدقيقة. فهل يُعتبر هذا تنفسًا سريعًا؟
الإجابة 7: لا

السؤال 8: رضيع عمره خمسة أشهر ونصف، ومعدل التنفس لديه 58 نَفَسًا في الدقيقة. فهل يُعتبر هذا الرضيع لديه تنفس سريع؟
الإجابة 8: نعم (لا حاجة إلى تكرار العد).



9.1.5 مناقشة جماعية: مَن الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟

اسأل المشاركين عن المكون الثاني لتقديم المشورة حول ممارسات طلب الرعاية الصحية للرضع في هذه الفئة العمرية. إلى أين يجب أن تتوجه الأسر عند طلب الرعاية الصحية لأطفالها؟ استمع إلى إجاباتهم قبل التأكيد على ضرورة طلب الرعاية الصحية دائمًا من مقدمي الرعاية الصحية المُدرَّبين. وأكِّد على أن التصرف بطريقة مغايرة لا يُهدد فقط بإيذاء الأطفال، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى وفاتهم.



10.1.5 مناقشة جماعية: تقديم المشورة والمساعدة في الإحالة

أكِّد على أنه في حالة وجود أي علامة خطورة تدل على مرض خطير، تجب إحالة الطفل على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية. وأكِّد مُجددًا للمشاركين على أن العامل الصحي المجتمعي يسجل المعلومات أثناء الزيارات المنزلية على استمارة التسجيل. وراجع معهم، وأَرِهم كيفية ملء القسم الخاص بعلامات الخطورة في استمارة التسجيل.

واسأل المشاركين عما سيفعلونه إذا اكتشفوا وجود علامة خطورة أثناء ملء استمارة التسجيل. استمع إلى إجاباتهم قبل أن تخبرهم أنه يتعين عليهم تخطي جميع المهام الأخرى، والتركيز على إحالة الطفل إلى أحد المرافق الصحية. وعليهم أن

يملؤوا مذكرة الإحالة والمساعدة في هذا الشأن. واطلب منهم الرجوع إلى مذكرة الإحالة في الصفحتين 25 و26 من دليل المشاركين، وأن يطّلعوا مرة أخرى على محتواها. وذكِّرهم بأنه يجب عليهم عند الإحالة أن ينصحوا الأم بالحفاظ على دِفء طفلها، وإذا كان الطفل يستطيع الرضاعة، فعلى الأم إرضاعه بصورة متكررة في الطريق إلى المستشفى.



11.1.5 مناقشة جماعية: الصعوبات المتعلقة بإحالة الرُّضَّع الصغار

استعرض مع المشاركين الصعوبات التي قد تظهر عندما تقرر إحالة مولود لديه علامات خطورة، وأكِّد على أن نفس الصعوبات قد تنطبق على الرضَّع الأكبر سنًا (ارجع إلى الصفحة 83 من الكتاب القلاب).



12.1.5 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحات من 80 إلى 83 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



13.1.5 تدريب تمثيل الأدوار . 4. تقديم المشورة حول علامات الخطورة بالنسبة لصغار الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر

ستحتاج إلى: أربعة مواقف مكتوبة على ورق مطوي؛

استمارات تسجيل؛

مذكرات إحالة.

أخبر المشاركين أنهم سيُؤَدُّون الآن تمثيلا للأدوار حول كيفية تقديم المشورة بشأن علامات الخطورة، وبشأن إحالة رضيع يتراوح عمره بين شهرين وستة أشهر.

ستؤدي دور الأم، وحسب الموقف، سيؤدي الميسِّر المشارك دور الأب أو الحماة. وسيؤدي مشارك مختلف دور العامل الصحي المجتمعي في كل سيناريو من السيناريوهات.

وسيملأ العامل الصحي المجتمعي القسم الخاص بعلامات الخطورة في استمارة التسجيل، وسيستخدم الكتاب القلاب لتقديم المشورة إلى الأسرة، وسيستكمل مذكرة الإحالة.

أعطِ المشارك الذي يؤدي دور العامل الصحي المجتمعي الجزء الأول من السيناريو. واطلب منه سحب إحدى الأوراق المطوية. اطلب من المشاركين ذكر الخطوات بصوت عالٍ أثناء القيام بها. ويجب ألا يتجاوز وقت التدريبات التمثيلية 15 دقيقة. وفي النهاية، اطلب من المشارك أن يعيد إليك الورقة.

الموقف 1

العامل الصحي المجتمعي: أنت أحد العاملين الصحيين المجتمعيين، وفي زيارة روتينية لإحدى الأسر التي رُزقت بطفل ذكر عمره 4 أشهر. وتستخدم استمارة التسجيل للتحقق من وجود علامات الخطورة، وتجد أن الطفل يتقيأ كل ما يتناوله. استخدم أدواتك لتفهم الوضع، وقدِّم المشورة إلى الأم.

الموقف 1

الأم: رضيعك الصغير علي عمره 4 أشهر. وهو يتقيأ كل ما يتناوله. واسمكِ حسناء.

ولا تستطيعين التوجه إلى المستشفى، ولا تعتقدين أن التقيؤ من العلامات التي تستوجب الإحالة إلى مرفق صحي.

والأب يشاطرك الرأي نفسه. واسمه طارق.

الموقف 2

العامل الصحي المجتمعي: أنت أحد العاملين الصحيين المجتمعيين في قرية زونت، وفي زيارة روتينية لإحدى الأسر التي رُزقت بطفلة عمرها ستة أسابيع. وتستخدم استمارة التسجيل للتحقق من وجود علامات الخطورة، وتجد أن درجة حرارة الطفلة 38 درجة مئوية. استخدم أدواتك لتفهم الوضع، وقدِّم المشورة إلى الأم.

الموقف 2

الأم: رضيعتكِ الصغيرة قمر عمرها شهر ونصف. واسمكِ ماجدة. ولن تتوجهي إلى المستشفى، إذ تعتقدين أن الحمى لا تستوجب الإحالة إلى مرفق صحي. وتستدعين أحد المعالجين التقليديين لإعطائها شيئًا لخفض درجة الحرارة بالطريقة التي عالج بها ابنة الجيران.

الحماة، بدرية، تدفعك للاستعانة بالمعالج التقليدي وعدم الذهاب إلى مرفق صحي.

الموقف 3

العامل الصحي المجتمعي: أنت أحد العاملين الصحيين المجتمعيين في قرية الروضة، وفي زيارة روتينية لإحدى الأسر التي رُزقت بطفل ذكر عمره خمسة أشهر. وتستخدم استمارة التسجيل للتحقق من وجود علامات الخطورة. استخدم أدواتك لتفهم الوضع، وقدِّم المشورة إلى الأم.

الموقف 3

الأم: أنتِ زينب، أم محمود، وهو يبلغ من العمر 5 أشهر، وأصابته تشنجات في الصباح. لا تستطيعين التوجه إلى المستشفى دون إذن زوجك، وهو حاليًا في العمل.

الزوج (إذا اتصل بك العامل الصحي المجتمعي): أنت حسن، زوج زينب. ولن تسمح لزوجتك بالتوجه وحدها إلى المستشفى. عليها أن تنتظر حتى ترجع إلى المنزل، وتقرر ما ستفعل.

الموقف 4

العامل الصحي المجتمعي: أنت أحد العاملين الصحيين المجتمعيين في قرية أمانة. وأنت في زيارة روتينية لإحدى الأسر التي رُزقت برضيع عمره شهران. وتستخدم استمارة التسجيل للتحقق من وجود علامات الخطورة. وترى أن الطفل ضعيف جدًا لا يقدر على الرضاعة. استخدم أدواتك لتفهم الوضع، وقدِّم المشورة إلى الأم.

الموقف 4

الأم: أنتِ فريدة. وابنتكِ البالغة من العمر شهرين قد توقفت عن الرضاعة هذا الصباح، ويبدو أنها ضعيفة جدًا. ولا تعتقدين أن الأمر خطير، وترين أن ابنتك قررت أنها لم تعد تحب لبنك. وقررتِ استخدام اللبن الاصطناعي.

الزوج: أنت رشيد، زوج فريدة. وتعتقد أن لبن زوجتك لم يناسب الطفلة، وأنها ستكون أفضل حال استخدام اللبن الاصطناعي. ولا ترغب في التوجه إلى المستشفى لأن الأمر نفسه قد حدث لابنة أختك التي أخذها والداها إلى المستشفى وتُوفيت هناك.

كرِّر المواقف بحيث تُتاح لكل مشارك فرصة تمثيل دور العامل العامل الصحي المجتمعي. وفي نهاية كل تدريب تمثيلي، افتح باب المناقشة ليجيب المشاركون عن الأسئلة التالية:

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي أدواته؟
- هل ملأ العامل الصحي المجتمعي استمارة التسجيل على نحو صحيح؟ (اطلب من العامل الصحي المجتمعي أن يريك كيف ملأ استمارة التسجيل).
- هل اتبع العامل الصحي المجتمعي الخطوات الأربع للتواصل الجيد؟
- هل استخدم العامل مهارات التواصل الجيد؟
- هل حدد العامل الصحي المجتمعي المشكلة، وفهم الوضع؟
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي المعلومات ذات الصلة بعلامة الخطورة؟
- هل قدم العامل الصحي المجتمعي المعلومات ذات الصلة بأهمية التوجه إلى المرفق الصحي؟
- هل تعتقد أن الأسرة قد اقتنعت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا؟



14.1.5 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية

راجع مع المشاركين ممارسات الوقاية التي تعلموها بالنسبة للمواليد والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، وأخبرهم أن الممارسات نفسها تنطبق على الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

واستعرض أهمية التطعيم، مع ذكر الجرعات الثلاث التي يجب إعطاؤها لهذه الفئة العمرية.

بالنسبة لغسل اليدين، اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 86 و87 من الكتاب القلاب، وراجع أهمية غسل اليدين، وكيفية القيام بذلك.

ناقش مع المشاركين أسباب نوم الأمهات والأطفال تحت الناموسيات المُعالَجة بمبيدات حشرية في المناطق التي تنتشر بها الملاريا، ثم راجع استعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد.

وراجع أسباب أهمية غلي الماء المستعمل في تنظيف الأكواب والملاعق، عندما يكون الأطفال لا يرضعون. اسأل المشاركين عن أسباب أهمية غلي الماء وغسل الأكواب والملاعق جيدًا عند إعداد اللبن الاصطناعي للأطفال الذين لا يَرضعون. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أن الماء المغلي يقتل المكروبات، مثل الجراثيم، والفيروسات، والأوالي التي تسبب الأمراض، ويجعل ماء الصنبور آمنًا من الناحية الميكروبيولوجية. وأكِّد على ضرورة غلي الماء حتى الفَوَران لمدة دقيقة واحدة، وضرورة تبريد الأكواب والملاعق قبل استخدامها.

وإذا كان الطفل لا يرضع، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن يقدموا مشورةً إلى الأم حول الرضاعة، وتشجيعها على القيام بذلك. وإذا كانت هناك أسباب تحول دون القيام بالرضاعة، فعليهم أن ينصحوا الأم بإطعام طفلها باستعمال كوب وملعقة بدلاً من استعمال زجاجة.

وأضف أنه في المناطق التي لا يوجد فيها مصدر آمن للماء الصالح للشرب، يُعتبر غلي الماء قبل الاستخدام ضرورة ملحة لصحة الأسرة بأكملها.



15.1.5 ممارسةعملية: غسل اليدين

ستحتاج إلى ما يلي:

- صابون
- إبريق ماء
- إناء كبير

اطلب من اثنين من المشاركين التمرُّن على تقديم المشورة حول غسل اليدين، واطلب من باقي المشاركين التعليق على ما يقومان به (ويمكنهم الرجوع إلى الكتاب القلاب في هذا الصدد).



16.1.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 84 إلى 91 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.

تذكر أن تشرح الإطار الأحمر الذي يُسترشد به في عمل العاملين الصحيين المجتمعيين.



الجلسة 16:
المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية (الرضاعة)

مدة الجلسة
ساعتان

جهِّز
- كرة
- أسطوانة مدمجة (CD)/ وحدة تخزين محمولة (USB) لمقطع الفيديو 18، كيفية اعتصار لبن الثدي
- شاشة، وجهاز عرض البيانات، وحاسوبًا محمولاً
- نسختين من السيناريوهات الأربعة لتمرين "لعب الأدوار" 5، تقديم المشورة حول الرضاعة

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قد:
- راجعوا المعلومات السابقة حول الرضاعة؛
- تعرفوا على كيفية تغذية الرضيع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛
- أصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأمهات حول الرضاعة، باستخدام المهارات الجيدة؛
- أصبحوا قادرين على تحديد المشاكل الشائعة التي قد تتعارض مع الرضاعة المطلقة وحلها؛
- تمرنوا على تقديم المشورة حول الرضاعة باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب.

1.2.5 مناقشة جماعية: المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية: مزايا الرضاعة

أكِّد على أهمية التغذية من أجل صحة الطفل، مع لفت الانتباه إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لا ينمون بشكل جيد. فغالبًا ما يكونون أقصر طولاً من الأطفال الآخرين في أعمارهم نفسها، وأقل نشاطًا عندما يلعبون، وأقل اهتمامًا بالاستكشاف والتعلُّم، ويكونون أكثر عُرضة للمرض بوتيرة أكبر.

وأضف أنه بالنسبة للمواليد، يُعتبر لبن الأم أفضل غذاء للرضَّع حتى سن ستة أشهر. واطلب من المشاركين أن يخبروك بسبب ذلك، بناءً على ما سبق أن تعلموه بالفعل. استمع إلى إجاباتهم، قبل أن تراجع معهم مزايا الرضاعة ومخاطر اللبن الاصطناعي.

2.2.5 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 92 و93 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



3.2.5 لعبة الكرة (1). مزايا الرضاعة وعيوب اللبن الاصطناعي وزجاجات بدائل لبن الأم

ستحتاج إلى كرة

أخبر المشاركين أنهم سيلعبون لعبة لمراجعة مزايا الرضاعة وعيوب اللبن الاصطناعي وزجاجات بدائل لبن الأم.

اطلب من المشاركين الوقوف في دائرة، واشرح لهم اللعبة. مرِّر الكرة إلى أحد المشاركين، واطلب منه أن يذكر إحدى مزايا الرضاعة. وعندما تعود إليك الكرة مرة أخرى، مررها إلى مشارك آخر. واستمر على هذا النحو حتى تُذكر جميع مزايا الرضاعة، ثم كرر تمرير الكرة مرةً أخرى على أن تطلب من المشاركين هذه المرة ذكر عيوب اللبن الاصطناعي.



4.2.5 مناقشة جماعية: الرضاعة المطلقة

أكِّد للمشاركين أن لبن الأم وحدَه هو أفضل غذاء للرضَّع حتى يُكملوا ستة أشهر من العُمر.

واسأل المشاركين عن المقصود بالرضاعة المطلقة، واستمع إلى إجاباتهم، ثم لخِّص أن المقصود بالرضاعة المطلقة هي أن يتناول الطفل لبن الأم فقط دون أي أغذية أو سوائل أخرى، ولا حتى الماء، حتى يكمل الطفل ستة أشهر، والاستثناء الوحيد هو محاليل الإمهاء الفموي والأدوية، عند الحاجة.

راجع مزايا الرضاعة المطلقة.

- تساعد الرضاعة على إدرار مزيدٍ من اللبن. في حين أن إعطاء الطفل أغذية وسوائل أخرى يقلل من كمية لبن الأم الذي يتناوله الطفل، مما يقلل من رضاعته. وقلة الرَّضاعة تعني قلة إدرار اللبن: إذ إن عدم إفراغ الثدي من اللبن يؤدي إلى خفض كمية اللبن الذي تنتجه الأم.
- يقلل لبن الأم من خطر العدوى. فلبن الأم هو أنظف غذاء للأطفال. وعندما يُقدَّم إلى الطفل لبن اصطناعي أو أي سوائل أخرى، مثل الماء، فإن زجاجات التغذية والأدوات المُستخدَمة في إعدادها قد تنقل المكروبات إلى الرضيع.
- يحتوي لبن الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل.
- كما أن لبن الأم لا يتطلب أي تجهيزات. ومع اللبن الاصطناعي، يوجد دائمًا احتمال تحضيره بطريقة خاطئة. وفي بعض الأحيان، لا تستطيع الأسر تحمل تكلفة اللبن الاصطناعي، وبالتالي يخففون اللبن الذي يُقدَّم إلى الطفل أكثر من اللازم.
- يوفر لبن الأم الحديد الذي يحتاجه الأطفال حتى سن ستة أشهر، ويمتصه الجسم على نحو أسهل من اللبن الاصطناعي أو حليب البقر أو الماعز الذي يصعب على الجسم امتصاصه. ويُعتبر الحديد عنصرًا مهمًا من أجل نمو المخ.
- قد يعاني الرُّضَّع من صعوبات في هضم الحليب الحيواني، مما قد يُسبِّب لهم الحساسية ويؤدي إلى إصابتهم بالإسهال وسوء التغذية.

اسأل متى يجب أن تُرضع الأم طفلها. استمع إلى إجابات المشاركين ثم اذكر في النهاية أنه: يجب إرضاع الأطفال نهارًا وليلاً، وعند الطلب، بما يصل إلى ثماني مرات على الأقل كل 24 ساعة. ويرجع ذلك إلى أن معدة الطفل صغيرة: وتسمح الرضاعة المتكررة للطفل بتناول الكمية التي يحتاج إليها من الغذاء اللازم لضمان نموه ونَمائه على نحو صحي.

5.2.5 مناقشة جماعية: مراجعة المعلومات المهمة حول الرضاعة

راجع تعريفَي لبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة، وكيفية ملاحظة وضعية الطفل وتعلقه بالثدي. وارجع إلى الأقسام ذات الصلة من الكتاب القلاب -مثل الأقسام الخاصة بالبدء المبكر في الرضاعة والتغذية في الوحدة الرابعة- لتعزيز النقاط التي تذكرها.

6.2.5 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 94 إلى 101 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم. واشرح أيضًا التعليمات الواردة في الإطار الأحمر، والتي يُسترشَد بها في عمل العاملين الصحيين المجتمعيين أثناء الزيارات المنزلية.

7.2.5 مناقشة جماعية: استعراض المشاكل الشائعة للرضاعة

استعرض مع المشاركين المشاكل الشائعة للرضاعة، وكيفية تقديم المشورة إلى الأمهات بشأنها.

وأضف أنه عندما يصل الطفل إلى هذه السن، قد ترغب بعض الأمهات في العودة إلى العمل بعد انتهاء إجازة الوضع وقبل أن يكمل الطفل شهره السادس، مما يتعارض مع الجدول الزمني للرضاعة. ولا توفر مجالات عمل عديدة للأم إمكانية إرضاع طفلها. ولهذا السبب، تقرر أمهات كثيرة وقف الرضاعة، وإعطاء أطفالهن لبنًا اصطناعيًا.

أحد الحلول للمشكلة التي يمثلها ذلك هو اعتصار لبن الثدي.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحة 106 من الكتاب القلّاب، واشرح خطوات اعتصار لبن الثدي.

ثم اشرح كيفية تخزين لبن الثدي، وكيفية تغذية الرضيع به. أكِّد على أنه سيكون من الأفضل تخزين اللبن بعد اعتصاره من الثدي في الثلاجة، إذا كان الجو حارًا.

وأضف إلى ذلك أن الرضاعة أثناء الحمل تعدُّ في حد ذاتها مشكلة أخرى من مشاكل الرضاعة؛ فالأمهات اللاتي يحملن مرة أخرى قبل بلوغ أطفالهن سن ستة أشهر قد يساورهن القلق من الآثار الصحية المترتبة على استمرارهن في الرضاعة. لذا، أخبر المشاركين بأنه في مثل تلك الحالات يجب طمأنة الأم أنه بالرغم من أن الرضاعة قد تسبب انقباضات خفيفة في الرحم، فإن تلك الانقباضات لا تدعو للقلق إذا كان الحمل يمر دون مشكلات صحية. وتنتج تلك الانقباضات عن هرمون الأوكسيتوسين الذي يُحفِّز الانقباضات، ويُفرَز بكميات صغيرة أثناء الرضاعة. ولا تسبب الانقباضات ضررًا للجنين، كما أنها نادرًا ما تزيد من احتمالاتالإجهاض.

أضف إلى ذلك أن نسبة هرمونات الحمل البسيطة التي تنتقل إلى لبن الثدي لا تشكل أي خطر على الطفل.

ويعاني ما يقرب من 75% من الأمهات من تقرُّح الحَلَمات أثناء الحمل.

كما يساور العديد من النساء مخاوف من أن الرضاعة أثناء الحمل تُسهم في الشعور بالتعب. وفي مثل تلك الحالات، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين طمأنة الأم بأن الرضاعة في حد ذاتها لا تُسبِّب التعب، ولكن إذا قررت الأمهات الحوامل أن يُرضعن أطفالهن بصورة طبيعية، فمن الضروري أن يتناولن طعامًا صحيًا من أجل صحة أطفالهن وصحة أجنتهن.

كما يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين طمأنة الأم بأنها عندما تستمر في الرضاعة أثناء الحمل، فإن طفلها الذي لم يُولَد بعد سيحصل على جميع المُغذِّيات التي يحتاج إليها من جسمها. وهذا سبب آخر يُلزمها باتباع نظام غذائي صحي وشرب الكثير من السوائل، كي تتجنب حدوث نقص في عناصر الجسم الأساسية لديها.

وبالرغم من أن لبن الثدي يظل سليمًا من الناحية التغذوية طوال فترة الحمل، فإن محتواه، وبالتالي مذاقه، سيتغير. وقد يجد بعض الأطفال أن الطعم لم يعد مقبولاً (غير مستساغ). ومن المُرجَّح أن يقل إفراز اللبن مع تقدُّم الحمل. وقد تدفع تلك العوامل الطفل الذي يرضع إلى أن يَفْطِم نفسَه بنفسه، قبل أن يُولد الطفل الجديد.

غير أن هناك ظروفًا ينصح فيها الأطباء الأمهات بفطام الطفل عن لبن الثدي. وتشمل تلك الظروف ما يلي:

- عندما يشكل الحَمْل خطرًا كبيرًا، أو تكون الأم مُعرَّضة لخطر الإجهاض؛
- عندما تكون الأم حاملاً بتوأم أو توائم متعددة؛
- عندما تعاني الأم من ألم أو نزيف في الرحم؛
- عندما تُنصح الأم بتجنب ممارسة الجنس أثناء الحمل.

استعرض مع المشاركين القائمة التي يشتمل عليها الكتاب القلّاب لأكثر مشكلات الرضاعة شيوعًا، وكيفية تقديم المشورة حولها، وضرورة إسداء النصح للأمهات حول المشكلات التي تم التعرُّف عليها وحسب باستخدام استمارة التسجيل. وشدِّد على ضرورة عدم تقديم المشاركين لمعلومات لا تهم الأم لتجنب الالتباس.

8.2.5 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 102 حتى 109 من الكتاب القلّاب. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين والواردة في الإطار الأحمر. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

9.2.5 فيديو توضيحي: اعتصار لبن الثدي

جهِّز مقطع فيديو 18 على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) حول كيفية اعتصار لبن الثدي (07:29 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول كيفية اعتصار لبن الثدي. اعرض مقطع الفيديو، ووضح أهم النقاط بعد انتهائه، وأجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين. وإذا لزم الأمر، كرّر عرض الفيديو.

10.2.5 تمرين الأسئلة السريعة (3): مراجعة المعلومات الخاصة بالرضاعة

أخبر المشاركين بأنك ستُجري تمرينًا لمراجعة المعلومات الخاصة بالرضاعة، والتعرُّف على كيفية استخدام القسم المقابل لها في استمارة التسجيل والكتاب القلّاب.

أخبر المشاركين بأنك ستطرح على كل واحد منهم سؤالاً عندما يحين دوره حول كيفية استخدام استمارة التسجيل لتقييم الوضع فيما يتعلق بالرضاعة، وكيفية تقديم المشورة باستخدام الكتاب القلاب. وسيكون بإمكانهم البحث في استمارة التسجيل واستخدام الكتاب القلاب أثناء الإجابة، وسوف تمنحهم مهلة قصيرة للقيام بذلك، وإذا لم يتمكن المشارك من الإجابة، فعليك الانتقال إلى المشارك التالي.

* فيما يلي الجدول الذي يحتوي على الأسئلة والإجابات الصحيحة.

السؤال	الإجابة
1. باستخدام استمارة التسجيل، ماذا تفعل بعد إلقاء التحية على الأم، والتعريف بنفسك، والسؤال عن الطفل، عندما تُقدِّم المشورة حول الرضاعة؟	اسأل الأم عمّا إذا كانت تُرضع طفلها أم لا.
2. ماذا تفعل بعد ذلك؟	إذا أجابت بـنعم، أضع علامةً على المربع المجاور لكلمة «نعم» في استمارة التسجيل، وأثنِي عليها، ثم أُكمِل الأسئلة. أما إذا قالت (لا)، فسأضع علامة أمام المربع المجاور لكلمة «لا»، وأنتقل إلى الأسئلة المُشار إليها في الاستمارة عند الإجابة بالنفي.
3. إذا أجابت الأم بنعم، فماذا يجب أن تلاحظ؟	كيفية تعلق الطفل بثدي أمه ووضعيته، لأقرر ما إذا كانت صحيحة أم لا.
4. إذا وجدتَ أن الأم تُرضع طفلها ثلاث مرات في اليوم، فأين ستجد في الكتاب القلاب النصيحة المرتبطة بذلك؟ وماذا ستقول لها؟	تتناول الصفحتان 104 و105 عدم توفير الرضاعة للأطفال عند الطلب، وقلة عدد مرات الرضاعة. يحصل الأطفال الذين يتغذون عند الطلب على جميع المُغذِّيات التي يحتاجون إليها، كما يؤدي ذلك إلى إدرار المزيد من اللبن. وقد يصاب الأطفال الذين لا يحصلون على كفايتهم من لبن الثدي بسوء التغذية والأمراض. قد تظن الأم أن الطفل ليس جائعًا. لذا، يجب أن يساعد العامل الصحي المجتمعي الأم على تحديد علامات الجوع، بخلاف البكاء، وتشجيع الأم على توفير الرضاعة كلما كان الطفل جائعًا.
5. ما المقصود بالرضاعة المطلقة؟	اقتصار تغذية الطفل على لبن الثدي وعدم إعطائه أغذية أو سوائل أخرى، ومن ذلك الماء، حتى يبلغ من العمر ستة أشهر.
6. كيف تستخدم استمارة التسجيل لتحديد ما إذا كانت الأم توفر الرضاعة المطلقة أم لا؟	يمكنك مراجعة الأسئلة الواردة في الاستمارة، وسؤال الأم عما إذا كانت تُعطي الطفل أي طعام أو سوائل أخرى. فإذا أجابت الأم بـلا، فإن الرضيع يرضع رَضاعة مطلقة، أما إذا قالت إنها تعطي الرضيع الماء أيضًا، فهي بذلك لا تُرضع رضاعة مطلقة.
7. ماذا لو قالت الأم إنها لا تعطي الرضيع أي طعام أو سوائل ولكنها تعطيه الماء فقط لأن الطقس حار، فهل يُعدُّ ذلك رضاعة مطلقة؟	لا، ليست كذلك. فالرضاعة المطلقة تعني عدم إعطاء الرضيع أي طعام أو سائل آخر، ومن ذلك الماء، حتى وإن كان الطقس حارًا.
8. أين يوجد في الكتاب القلاب القسم الخاص بالمشكلات المتعلقة بالرضاعة المطلقة؟ وكيف يمكنك تقديم المشورة للأم؟	في الصفحات 98 و99، و104 و105. سأقدم المشورة إلى الأم بأن أشرح لها أن الرضاعة المطلقة توفر جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الرضيع ونمائه صحيًا، وأن لبن الثدي يحتوي على كل ما يحتاج إليه الطفل، وأن ملء المعدة بالأطعمة/ السوائل الأخرى أو الماء يعني أن الطفل لا يتناول جميع المُغذِّيات التي يحتاج إليها. سأقدم النصيحة أيضًا بشأن الفوائد الإضافية للرضاعة المطلقة الواردة في الصفحتين 98 و99.
9. ماذا يجب أن تقول أو كيف ستتصرف إذا لاحظت أن تعلق الرضيع بالثدي لا يتم بشكل جيد؟	استخدم الصفحات 100، و101، و102، و103، من الكتاب القلاب لشرح التعلق الجيد، وكيفية اتخاذ الوضعية المناسبة، والآثار السيئة المترتبة على سوء التعلق بالثدي. إذ إن سوء التعلق بالثدي وعدم فعالية المص يعني عدم إفراغ الثدي وانخفاض إدرار اللبن. كما قد يؤدي سوء التعلق أيضًا إلى احتقان الثدي وآلام بالحَلَمة. سأطلب الإذن أولاً من الأم كي أساعدها في تصحيح وضعية الرضيع وتعلقه بالثدي، ثم أقوم بذلك.



11.2.5 مناقشات جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الرضاعة:

ذكِّر المشاركين بأنه يجب عليهم دائمًا بدء الزيارة المنزلية بتحية الأم، ومن ثمَّ تقديم أنفسهم، وشرح الغرض من زيارتهم. ويجب أن يغسل المشاركون أيديهم قبل لمس الطفل، وعند تفهُّم الوضع، يجب دائماً اتباع استمارة التسجيل واستخدام ما بها من أسئلة.

كما يجب التأكيد على أنهم إذا رأوا الأم تُرضِع طفلها، فيجب أن يثنوا عليها، وألا يوجهوا إليها سؤالاً عما إذا كانت تُرضع أم لا. في هذه المناقشة، راجع مع المشاركين القسم الوارد في استمارة التسجيل حول الرضاعة: وضِّح أن الاستمارة لا تحتوي على سطر منفصل بشأن الرضاعة لحديثي الولادة والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، بخلاف البدء المبكر في الرضاعة، لأن التفاصيل هي نفسها لجميع الأطفال حتى سن ستة أشهر.

أخبر المشاركين بأنه بعد تقييم الوضع وتحديد أي مشاكل، إن وُجدت، سيتعين عليهم أن يستخدموا مهارات التواصل الجيد، وأن يتذكروا أهمية أن تُظهِر إجاباتهم تقبُّلهم لما تقوله الأم، وأن يثنوا على أفعالها الجيدة، ثم يجب عليهم بعد ذلك استخدام الكتاب القلاب للحصول على المعلومات اللازمة، وتقديم المساعدة العملية في مجالات مثل التعلق بالثدي، ووضعية الرضيع، واعتصار لبن الثدي.

ذكِّر المشاركين بأنه من الضروري أن يتحققوا من فهم الأم التام لأي نصيحة قُدِّمت إليها.



12.2.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 34 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأم حول التغذية (الرضاعة)، الوارد في الصفحة 41 من دليل المشارك. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



13.2.5 تمثيل الأدوار (5): تقديم المشورة حول الرضاعة للرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر

تحتاج إلى تحضير سيناريوهات الحالات الأربعة في أوراق مطوية.

أبلغ المشاركين أنهم سيقومون بتمثيل أدوار بشأن كيفية تقديم المشورة حول الرضاعة، باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب.

أخبرهم بأنك ستقوم بدور الأم، وأنهم سيقومون بدور العامل الصحي المجتمعي بالتناوب.

يجب ألا يرى المشاركون المواقف الأربعة مُسبقًا. ويجب أن يختاروا إحدى الأوراق المطوية التي قدمتها إليهم، ثم يعيدوها إليك على الفور. ستقوم أنت بعد ذلك بدور الأم بناء على الموقف الذي اختاروه.

اطلب من كل مشارك أن يتحدث بصوت عالٍ ومسموع عما سيقوم به دون أن يخاطب بقية المشاركين.

يجب ألا يتجاوز تمثيل الأدوار 15 دقيقة، وسيكون من الواجب تكراره حتى تتوافر لدى كل مشارك الفرصة للمشاركة. وبنهاية كل تمثيل للأدوار، تأكد من أن المشارك الذي يقوم بدور العامل الصحي المجتمعي قد استكمل استمارة التسجيل بصورة صحيحة. ثم اطلب من باقي المشاركين:

- توضيح ما إذا كان المشارك قد استخدم مهارات التواصل الجيد؛

- ما إذا كان العامل الصحي المجتمعي قد استخدم استمارة التسجيل؛
- ما إذا كانت استمارة التسجيل قد مُلئت بصورة صحيحة؛
- ما إذا كان العامل الصحي المجتمعي قادرًا على تحديد أي مشكلة تتعلق بالرضاعة؛
- ما إذا كان العامل الصحي المجتمعي قد استخدم الكتاب القلاب؛
- كيف استُخدم الكتاب القلاب لتقديم المشورة للأم (هل بصورة صحيحة أم لا؟)؛
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي معلومات مرتبطة بالموقف؛
- هل اقتنعت الأم، وبِناءً على ذلك ستعمل بالنصيحة التي قدمها إليها العامل الصحي المجتمعي

الموقف 1

أنت أم للطفل أحمد الذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر. ويرضع الطفل أربع مرات في اليوم. ولا تقومين بإرضاعه طوال اليوم. ولا تعطينه أطعمةً أخرى، ولكنك تعطينه الماء لأنك تعتقدين أن لبن الثدي هو طعام وليس شرابًا. وأنتِ غير راضية عن نمو أحمد. وبالرغم من أنه لا يبدو جائعًا، فأنت تطلبين النصيحة من العامل الصحي المجتمعي عمّا إذا كنت ستضيفين اللبن الاصطناعي إلى نظامه الغذائي.

الموقف 2

أنت أم الطفلة سارة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر. أنت لا تُرضعينها، وتعطينها اللبن الاصطناعي بدلاً من ذلك. وتظنين أن سارة تنمو بصورة جيدة، بالرغم من إصابتها بالإسهال من وقت لآخر.

الموقف 3

أنت أم سالم الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر. وتعتقدين أنه يتعين عليك الانتقال إلى أغذية أخرى، والتوقف عن الرضاعة لأن الرضاعة ليست كافية لنموه في هذا العمر.

الموقف 4

أنت أم الطفلة أمنية التي تبلغ من العمر شهرين. ودائمًا ما تشعر أمنية بالجوع بعد الرضاعة. وعندما تعطينها ثديك تتركينها من 5 إلى 6 دقائق، ثم تنقلينها إلى الثدي الآخر كي تتمكن من الحصول على كل اللبن الموجود في الثديين.



الجلسة 17:
المكون 3: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- نسختين من الموقفين المذكورَين في تمرين لعب الأدوار 6 الخاص بتقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية للأطفال الرضَّع

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- أساسيات النظافة الشخصية للرضَّع من عُمر شهرين وحتى أقل من ستة أشهر؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن ممارسات العناية بالنظافة الشخصية

1.3.5 مناقشة جماعية: العناية بنظافة الرضيع الشخصية

أخبر المشاركين بأنهم سيناقشون المكون الثالث من الرعاية المُقدَّمة لهذه الفئة العمرية.

استعرض مع المشاركين ما تعلموه حول العناية بالنظافة الشخصية للمواليد والرضع ممن تقل أعمارهم عن شهرين: العناصر والأهمية. أكِّد على أن النظافة الشخصية الجيدة ضرورية للغاية إذا ما أردنا الإبقاء على الطفل معافى وسعيدًا، وخاليًا من العدوى الجلدية وغير ذلك من الأمراض. ووضِّح ضرورة القيام بتدابير النظافة الشخصية بلطف وعناية.

وبعد ذلك، أبلغ المشاركين بأنهم سوف يتعاملون مع تسعة عناصر للعناية بالنظافة الشخصية للرضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر:

العنصر 1: الاستحمام
العنصر 2: الحفاظ على نظافة مناطق الوجه، والرقبة، واليدين، والحفاض
العنصر 3: تقليم الأظافر
العنصر 4: الحفاظ على عدم انسداد الأنف
العنصر 5: تنظيف عيني الطفل
العنصر 6: تنظيف أُذني الطفل
العنصر 7: الحفاظ على نظافة ملابس الطفل
العنصر 8: الحفاظ على نظافة ألعاب الطفل
العنصر 9: تنظيف المنزل.

2.3.5 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

العنصر 1: تحميم الطفل

استعرض مع المشاركين ما تعلموه بالفعل عن تحميم الرُّضَّع، ثم اشرح لهم أن طريقة التحميم بالإسفنجة المُستخدَمة

مـع المواليـد قبـل سـقوط الجـزء المتبقـي مـن الحبـل السُّري (عنـد بلـوغ 2 - 4 أسـابيع مـن العمـر) تُسـتَبدل بالاسـتحمام في حـوض للأطفـال الأكبر سـنًا.

أكِّد على أهمية التحميم للحفاظ على نظافة الرُّضَّع، وسعادتهم، وصحتهم.

ولأن بعـض مقدمـي الرعايـة قـد يرغبـون في تحميـم أطفالهـم يوميًـا، أكِّـد للمشـاركين على أن هـذا قـد يسـبب جفـاف الجلـد، وأن تحميـم الطفـل مـرتين أو ثلاث مـرات في الأسـبوع، أو عندمـا يكـون حفاضـه شـديد الاتسـاخ، سـيكون كافيًـا. ولا تحتـاج الأم إلى غسـل شـعر الطفـل أكثر مـن مـرة أو مـرتين في الأسـبوع. ومـا دامـت الأم سريعـة ودقيقـة في تغـيير حفاضـات الطفـل وتنظيفـه بعـد تجشـئته، فإنهـا بالفعـل تقـوم بغسـل الأجـزاء التـي تحتـاج إلى أكبر قـدر مـن الاهـتمام، وهـي الوجـه واليـدان والرقبـة ومنطقـة الحفـاض.

الفـت انتبـاه الأم إلى أنـه كلما كان الطفـل أكبر سـنًا، زاد اسـتمتاعه بالاسـتحمام. أضِـف إلى ذلـك أيضًـا أن وقـت الاسـتحمام، مـهما كان عُمـر الطفـل، يمكـن أن يكـون وقتًـا للمـرح وفرصـة خاصـة للوالديـن كي يغنـوا ويتحدثـوا إلى أطفالهـم لزيـادة الترابـط وبنـاء الثقـة. اختيـاري: اجمـع بعـض الألعـاب ليلهـو بهـا الطفـل في وقـت الاسـتحمام.

يجـب على الأمهـات توخـي الحـذر باتبـاع خطـوات بسـيطة، وذلـك لتجنـب تعـرُّض الطفـل للحَـرق والغَـرَق، وهما الخطـران الرئيسـيان اللـذان قـد يقعـان وقـت الاسـتحمام، فلا بـد أن:

- تختبر الأم درجة حرارة المياه قبل وضع الطفل في حوض الاستحمام عن طريق وضع مِرفقها في الماء للتأكد من أنه دافئ (ما بين 37 و38 درجة مئوية)، وليس ساخنًا.
- تبقى الأم مع الطفل طيلة وقت الاستحمام، وأن تتجنب أي مصدر للإلهاء، وتتأكد من أن الصابون ومستحضرات غسل الشعر أبعد من متناول الطفل.
- لا تترك الطفل دون إشراف مهما كان عُمق الماء. فقد يتعثر الرضَّع ويغرقوا في كمية قليلة جدا من الماء قد يقل عمقه عن بوصة واحدة. لذا، يجب على الوالدين التأكد من وجود كل ما يحتاجون إليه في متناول أيديهم قبل أن يبدؤوا تحميم أطفالهم.

اطلـب مـن المشـاركين أن يفتحـوا الصفحـتين 110 و111 مـن الكتـاب الـقلّاب، وراجـع خطـوات تحميـم الأطفـال الصغـار. أكِّـد على النقـاط التاليـة:

- حمِّمي الطفل قبل إطعامه لتجنب احتمال ارتجاع الطعام في حوض الاستحمام.
- إذا شعر الطفل بالاسترخاء نتيجة الاستحمام، فاجعلي ذلك ضمن روتين النوم اليومي.
- يجب عدم استخدام حوض البالغين لتحميم الرضع؛ فتلك الأحواض عميقة للغاية، ومن الصعب ضمان عدم انزلاق الطفل فيها.
- سكبي كمية صغيرة من الماء الدافئ في الحوض، ولا يجب مطلقًا غمر الرضّع بالماء.
- ضعي الطفل في الحوض ابتداءً بقدميه.
- يجب استخدام كرات القطن لمسح عيني الرضيع وأذنيه، ويجب أن تتأكد الأم من المسح فيما بين الثنيات الصغيرة خلف الأذنين وحول العنق حيث تتجمع الرطوبة وبصقات الطفل.
- استخدمي بعضًا من صابون الأطفال على ليفة الاستحمام لغسل يدي الطفل وقدميه. واغسلي المنطقة التناسلية للطفل في النهاية. عند تحميم طفلة، بلّلي كرة من القطن وباعدي بين الساقين وامسحي بين حافتي المهبل بكرة القطن. وابدئي من الأمام وامسحي للخلف بلطف. وبالنسبة للبنين: اشطفي المنطقة التناسلية بالماء برفق أثناء الاستحمام.
- جفِّفي الطفل بمنشفة، بدءًا من الجسم، وتأكدي من التجفيف بلطف وراء الأذنين وفي طيات الجلد حتى لا تتركي فيها رطوبة زائدة. وجفِّفي الشعر بالمِنشفة قدر الإمكان. تذكري، شعر الطفل الخفيف يجف بسرعة.
- ضعي للطفل حفاضًا نظيفًا، ثم أسرعي إلى إلباسه ثيابًا نظيفة.

ملاحظة للميسر:

خلافًا للبالغين، يُفرِز جلد طفلك قدرًا ضئيلاً للغاية من الزيت، ولذا، فإن شعره الرقيق الناعم لن يصبح دُهنيًا، وسيكون من الجيد غسل الشعر سريعًا مرةً أو مرتين في الأسبوع.

وقد يؤدي غسل الشعر بشكل متكرر إلى التخلص من الزيوت الضرورية التي تحتاج إليها فروة الرأس للحفاظ على صحتها. وفي بعض الأحيان، قد يكون مجرد استخدام إسفنجة مغمورة في الماء كافيًا لتنظيف الشعر. وإذا كان الطقس رطبا أو كنت قد سافرت لمدة طويلة بصحبة طفلك، فيمكن التوصية بغسيل الشعر في تلك الحالة.



3.3.5 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 110 و111 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



4.3.5 مناقشة جماعية. تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

العنصر 2 - العنصر 9

العنصر 2: تنظيف الوجه، والرقبة، واليدين

استعرض مع المشاركين أهمية تنظيف وجه الطفل، ورقبته، ويديه. ثم بيِّن في النهاية ضرورة تنظيف وجه الطفل، ورقبته، ويديه بشكل منتظم ومتكرر كلَّ يوم باستخدام قطعة قماش قطنية ناعمة أو كرة قطنية، مع تجفيفها بقطعة قماش قطنية جافة وناعمة، أو بمنديل ورقي ناعم. وذكِّر المشاركين بأن الرضع غالبًا ما يضعون أصابعهم في أفواههم، لذا من المهم جدًا بشكل خاص غسل أيدي الأطفال بانتظام طوال اليوم. ومن الضروري أيضًا تنظيف رقبة الطفل، حيث تتراكم الرطوبة والبصقات.

العنصر 3: التغيير المنتظم للحفاضات

اسأل المشاركين عن أهمية تغيير الحفاضات على فترات منتظمة، واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضِّح في النهاية أنه من الضروري الوقاية من الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات.

استعرض مع المشاركين الخطوات المُتَّبعة لتغيير الحفاضات والواردة في الصفحتين 112 و113 من الكتاب القلاب. وذكِّر المشاركين بأنه أثناء تغيير الحفاضات يجب تنظيف الطفل بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، وتركه كي يجف في الهواء للوقاية من الطفح الجلدي الناجم عن الحفاضات. ويجب على الأمهات دائمًا التخلص من الحفاضات القذرة في سلة المهملات، وغسل أيديهن بعد تغيير الحفاضات.

العنصر 4: تقليم أظافر الرضيع، وتنظيف الأذنين، والحفاظ على عدم انسداد الأنف

راجع مع المشاركين ما تعلموه بشأن تلك النقاط في قسم المواليد. وأكِّد على ضرورة عدم وضع قطع القطن في أذن الطفل مطلقًا.

العنصر 5: الحفاظ على عدم انسداد أنف الرضيع

راجع مع المشاركين ما تعلموه حول تلك النقطة. أكِّد على ضرورة ألا تضع الأمهات أي شيء في أنف الطفل مطلقًا. ويجب التخلص من رَشْح الأنف، أو المخاط، أو القشور المتكونة حول الأنف باستخدام كرة قطن مبللة بالماء الدافئ. وامسحي

الفضلات بعناية. وإذا كانت هناك قشور أسفل المخاط، فرطبي المنطقة بكرة قطن مبللة قبل إزالتها. وسيساعد ذلك في تقليل شعور الطفل بعدم الراحة. واحرصي على مسح الأنف إلى الخارج وليس إلى الداخل.

العنصر 6: تنظيف عيني الرضيع

من جديد، راجع مع المشاركين ما تعلموه حول تنظيف العيون في قسم المواليد، وأكد على أن الأم يجب أن تغسل يديها قبل البدء في ذلك، وأن تستخدم قطعة من القطن لكل عين على حدة.

العنصر 7: الحفاظ على نظافة ألعاب الرضيع:

اسأل المشاركين عن أهمية ذلك، واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضِّح أن الأطفال سيصلون غالبًا إلى الألعاب ويضعونها في أفواههم. لذا، يجب تنظيف الألعاب بالماء العادي وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة أو منديل ورقي.

العنصر 8: الحفاظ على نظافة ملابس الرضيع

راجع مع المشاركين ما تعلموه حول أهمية نظافة الملابس.

العنصر 9. تنظيف المنزل

راجع مع المشاركين ما تعلموه بالفعل حول أهمية تنظيم المنزل.

5.3.5 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 112 حتى 115 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد يطرحها المشاركون.

6.3.5 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية للرضَّع

راجع بسرعة خطوات التواصل الجيد مع المشاركين، وأخبرهم أنهم سيستخدمون استمارة التسجيل والكتاب القلاب لفهم الوضع، وتقديم المشورة حول العناية بنظافة الرضيع الشخصية، كما فعلوا مع الرضاعة.

اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على استمارة التسجيل، بينما تقوم بتوضيح كيفية ملء قسم النظافة الشخصية خُطوة بخطوة. أكِّد أنه يتعين على العامل الصحي المجتمعي أن يلاحظ أولاً:

- نظافة الوجه، والرقبة، واليدين، والعينين، والأنف، والأذنين؛
- انبعاث رائحة من الحفاض؛
- نظافة الأظافر وتقليمها؛
- نظافة ألعاب الرضيع؛
- نظافة ملابس الرضيع؛
- نظافة المنزل وترتيبه بشكل جيد ومنمق.

إذا بدا كل شيء على ما يرام، أثنِ على الأم، واسألها مستخدمًا استمارة التسجيل عن توقيت وكيفية:

- تحميم الطفل؛

- تنظيف وجه الطفل، وعينيه، ورقبته، ويديه، وأنفه، وأذنيه؛
- تغيير الحفاضات؛
- تقليم أظافر الطفل؛
- تنظيف ألعاب الطفل؛
- تنظيف ملابس الطفل؛
- تطهير المنزل.

أثنِ على الأم في كل ما تقوم به بشكل جيد، وقدِّم النصح فقط في الأمور التي لا تفعلها أو التي لا تعرفها، أو لا تعرف كيفية القيام بها. ذكِّر المشاركين بأن تقديم المشورة لا يعني الاكتفاء بقراءة/ترديد ما هو مذكور في الكتاب القلاب. إذ يجب أن تُقدَّم المشورة بحيث تتلاءم مع تقييمك للوضع، ويجب أن تقتصر على حل المشاكل التي حددها العامل الصحي المجتمعي .

وإذا رأى العامل الصحي المجتمعي إهمال الأم لنظافة طفلها الشخصية، فيجب تقديم المشورة لها حول أهمية النظافة الشخصية، وعناصرها التسعة.

7.3.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 35 الخاصب بعناصر العناية بالنظافة الشخصية، الوارد في الصفحة 42، والمربع 36، هـ عن "كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن العناية بالنظافة الشخصية"، الوارد في الصفحة 43، من دليل المشارك.

8.3.5 لعب الأدوار 6: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

ستحتاج إلى: نسختين من الأجزاء المتعلقة بالعامل الصحي المجتمعي الواردة في الموقفين المذكورين ضمن لعب الأدوار 6، في ورق مطوي.

أخبر المشاركين بأنهم سيمثلون دور العامل الصحي المجتمعي بغرض التدرُّب على تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية للرضَّع، باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب. وستقوم أنت بدور الأم. واطلب من مشاركين اثنين سحب ورقة واحدة مطوية. ووضِّح للمشاركَين اللذين اختارا الورقة أن ما لاحظاه مكتوب على الأوراق، وأنه يتعين عليهم تقديم المشورة بناءً على ذلك. ثم سيتناوب الاثنان على تنفيذ لعب الأدوار. اطلب من المشاركين الآخرين مشاهدة تمارين لعب الأدوار ومتابعتها باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب. وفي نهاية كل تمرين من تمارين لعب للأدوار، اسأل المشاركين الذين تابعوا التمرين عما إذا كان:

- العامل الصحي المجتمعي استخدم مهارات تواصُل جيدة؛
- استخدم استمارة التسجيل بشكل صائب، وملأها بصورة صحيحة؛
- حدَّد المشاكل المتعلقة بالنظافة الشخصية بشكل صحيح؛
- استخدم الكتاب القلاب في تقديم المشورة للأم؛
- قدَّم معلومات مهمة إلى الأم؛
- يعتقد أن الأم اقتنعت وستعمل بالنصيحة التي قُدِّمت إليها.

الموقف 1

العامل الصحي المجتمعي: لاحظت أن أظافر الرضيع طويلة ومتسخة، وأن رائحةً تنبعث من الحفاض، وأن ملابسه وألعابه متسخة، وأن المنزل يملؤه الغبار وغير مرتَّب. وتنتشر الملاريا في المنطقة. استخدم استمارة التسجيل لفهم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات اللازمة.

الموقف 1

الأم: أنت أم الطفل حسن الذي يبلغ من العمر شهرين. وأنت خائفة من أن يصاب بالبرد، لذا تقومين بتحميمه مرة كل 10 أيام. وتقومين بذلك في حوض المطبخ. ولا تقومين بتقليم أظافره لأنه صغير جدًا، ولا تغسلين ألعابه لأنه الوحيد الذي يلعب بها.

وتقومين بغسل ملابسه في اليوم المخصص للغسيل في البيت. كما تغسلين وجهه، ويديه مرة واحدة في اليوم، ولكن لا تغسلين رقبته لأنك تنظفينها في أيام الاستحمام. كما أنك لا تستخدمين ناموسية مُعالَجة بمبيدات الحشرات.

الموقف 2

العامل الصحي المجتمعي: تلاحظ أن أصابع الرضيع نظيفة، وأن أظافره مُقلَّمة، وأن ملابسه وألعابه نظيفة، ولا تنبعث رائحة من حفاضه. والمنزل منظَّم للغاية ونظيف، ولا يتواجد في منطقة تشكل فيها الملاريا خطرًا. استخدم استمارة التسجيل لتقييم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات اللازمة.

الموقف 2

الأم: أنت أم الطفلة راوية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر. وهي طفلتك الأولى. وتقومين بتحميم الطفلة في حوض الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع (يومًا بعد يوم)، في حوض استحمام للأطفال، للحفاظ على صحتها وسعادتها. وتقلمين أظافرها بشكل منتظم لأنها قد تنقل الجراثيم، وتغيرين ملابسها لأنك تريدينها نظيفة ومرتبة، وتغسلين وجهها ويديها عدة مرات في اليوم لأنها تضع يديها في فمها. ولكنك لا تنظفين رقبتها لأنك لم تكوني تعلمين أنه يتعين عليك ذلك. وتنظفين عيني راوية فقط عندما ترين بعض الإفرازات، وتقومين بذلك من خارج العين إلى داخلها. وتنظفين الأنف عندما يكون به مخاط، وتُدخلين قطعة قطن في الأذنين لتنظيفهما. وتغسلين الألعاب يوميًا لأنها قد تنقل الجراثيم. وتعتنين بمنزلك جيدًا لأنك لا تريدين أن يلحق ضرر بطفلتك جرّاء الغبار أو الأوساخ.



الجلسة 18:
المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النّماء الرئيسية

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- دمية لتوضيح كيفية تخفيف آلام المغص
- مجموعتين من البطاقات الخاصة بلعبة مطابقة المعلومات 2 حول معالم النَّماء الرئيسية

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
- معرفة أهمية متابعة معالم النَّماء الرئيسية للرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛
- التعرُّف على معالم النَّماء الرئيسية للرضع في تلك الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للآباء والأمهات حول معالم النَّماء الرئيسية لأطفالهم الرضع.

1.4.5 مناقشة جماعية: معالم النَّماء الرئيسية

استعرض ما تعلَّمه المشاركون بالفعل عن تقديم المشورة حول نَماء الطفل بشكل عام: الأهمية والمعالم الرئيسية. ثم أكِّد بعد ذلك على أن النَّماء يعكس نمو المخ وأجهزة الجسم الأخرى. وتعني معالم النَّماء الرئيسية كيف يلعب الطفل، ويتعلم، ويتحدث، ويتصرف، ويتحرك، وكل ذلك يقدم أفكارًا مهمة حول النَّماء بمفهومه الواسع. لذا، يُوصَى الآباء والأمهات بفهم الصورة النمطية لنماء أطفالهم، وأن يلاحظوا أية مشاكل مُحتمَلة قد تطرأ عليهم أثناء ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تابعت الأُسر نماء أطفالها، فستكون قادرة على تحفيزهم.

2.4.5 مناقشة جماعية: معالم النَّماء الرئيسية

أخبر المشاركين بأن الأطفال بدءًا من صغار الرُّضع، ومع تقدمهم في السن، يُظهرون بعض معالم النَّماء الرئيسية: لذا، يحتاج الآباء والأمهات إلى تعلُّم كيفية التحقُّق من المعالم الرئيسية في مختلف المراحل.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحة 116، واستعرض معهم معالم النَّماء الرئيسية التي تنطبق على الأطفال من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، مقارنةً بمعالم النَّماء الرئيسية لدى المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

وضِّح أن الأعمار المختارة من بين الفئات العمرية هي الأعمار التي تشهد ظهور مَعْلَم رئيسي جديد من معالم النَّماء الرئيسية (تغيرات نمائية).

وعند الضرورة، استخدم الدمية لتوضيح ذلك.

وعندما يبلغ الرُّضع سن الشهرين، تبدأ ساعات النوم لديهم في التراجع عما كانت عليه وقت الولادة.

ذكّر المشاركين بأن المواليد لا يستطيعون رفع رؤوسهم إلى أعلى، وقارن ذلك بالطريقة التي يبدأ بها الأطفال في عمر شهرين في دفع الجسم إلى أعلى عند الاستلقاء على بطونهم. وعلى الرغم من أن المواليد يقومون بحركات متشنجة لا يمكنهم التحكم فيها، فإن حركات الأطفال عند بلوغ سن الشهرين تصبح أكثر سلاسة، وقد يبدؤون في مص أيديهم. كما يبدؤون في القرقرة وإصدار أصوات تشبه صوت الغرغرة.

ذكّر المشاركين بأن المواليد يعانون من تغيُّم الرؤية، على الرغم من أنهم يستطيعون رؤية الوجوه والتحديق فيها من على مسافة 25 سم. وعند بلوغ شهرين، يبدأ الرُّضع في متابعة الأشياء بعيونهم، والتعرُّف على الناس، والابتسام لهم من مسافة قريبة.

ويتطور السمع بشكل جيد منذ الولادة. فعند بلوغ شهرين، سيحوِّل الأطفال رؤوسهم نحو الأصوات، وستفزعهم الأصوات الصاخبة.

وعند بلوغ أربعة أشهر، ستظهر على الرُّضَّع معالم نَماء رئيسية جديدة، مثل:

- تثبيت رؤوسهم دون مساعدة؛
- الدفع بأرجلهم إلى أسفل عندما تلامس سطحًا صلبًا؛
- وضع أيديهم في أفواههم؛
- الوصول إلى الألعاب بيد واحدة؛
- مسك أقدامهم وأصابع أقدامهم ووضعها في أفواههم عند الاستلقاء على ظهورهم؛
- البدء في إصدار صوت غمغمة.

وسيكون بإمكانهم:

- رؤية الألعاب ومد أيديهم للوصول إليها؛
- تتبُّع الأشياء وهي تتحرك من جانب إلى آخر بأعينهم؛
- مراقبة الوجوه عن كَثَب؛
- التعرُّف على الأشخاص المألوفين لهم؛
- الابتسام للوجوه المألوفة.

وفيما يتعلق بالمعالم الرئيسية للسمع، سيكون لديهم نفس مستوى سمع الرضيع الذي يبلغ شهرين، حيث:

يتجهون برؤوسهم نحو الأصوات

يفزعون عند سماع أصوات صاخبة

ويجب على العاملين الصحيين المجتمعيين تقديم المشورة للآباء والأمهات حول معالم النَّماء الرئيسية وَفقًا لأعمار أطفالهم، حتى تتمكن الأسرة من متابعة النَّماء وتحفيزه من خلال اللعب والتواصل، وتحريك الأشياء أمام الطفل، وما إلى ذلك. أكِّد على أنه إذا تأخر الرُّضع عن بلوغ معالم النَّماء الرئيسية المحددة لأعمارهم، فيجب على العامل الصحي المجتمعي تقديم النصح للأسرة من أجل زيارة الطبيب.

اسأل المشاركين عن معالم النَّماء الرئيسية لطفل عمره شهر واحد. استمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أن الأطفال في هذا العمر يتشاركون مع الرُّضع في وصف المعالم النمائية.

اسأل عن الرُّضع الذين تبلغ أعمارهم ثلاثة أشهر، ووضِّح أن معالم النَّماء الرئيسية تنطبق على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم شهرين.

ثم اسأل عن الرضيع الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر، ووضِّح أنه يجب أن يكون لديه نفس معالم النَّماء الرئيسية التي يُظهرها طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر.

اسأل المشاركين عمّا يجب أن تقوم به الأسرة في حال لم يكن الأمر كذلك، ولم يصل الطفل بعد إلى معالم النَّماء الرئيسية. استمع إلى إجاباتهم، ثم وضِّح أنه يتعين على الأسرة أن تستشير طبيبًا.



3.4.5 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 116 و117 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



4.4.5 مناقشة جماعية

تحتاج إلى إحضار دمية

استعرِض مع المشاركين كيف يمكنهم مساعدة رضيع صغير مصاب بالمغص، مع الإشارة إلى الصفحتين 118 و119 من الكتاب القلاب. واستخدم الدمية للتوضيح. وبالرجوع إلى الصفحتين 120 و121 من الكتاب القلاب، افعل الشيء نفسه عند تجشئة الطفل. لاحظ أن المغص يصبح أقل مع تقدم الطفل في السن، وكذلك الحاجة إلى تجشئة الطفل.

5.4.5 تطبيق عملي: مساعدة رضيع صغير مصاب بالمغص وتجشئته

تحتاج إلى إحضار دمية

اسأل المشاركين واحدًا تلو الآخر عن كيفية تقديم المشورة حول المساعدة في علاج المغص وتجشئة رضيع صغير. قم بدور الأم. اطلب منهم استخدام الكتاب القلاب للشرح، والتوضيح باستخدام الدمية.



6.4.5 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحات من 118 حتى 121 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



7.4.5 مناقشة جماعية: تأثير النشاط البدني، والنوم الجيد، والحد من أوقات الخمول على نمو الرضيع الصغير ونمائه على نحو صحي

أخبر المشاركين بأن من بين العوامل التي تؤثر على نمو الطفل ونمائه يأتي النشاط البدني، والنوم الجيد، والحد من أوقات الخمول إلى أقصى درجة.

استعرض مع المشاركين ما تعلموه عن تلك العوامل، ثم أكد ما يلي:

النشاط البدني

تُعدُّ ممارسة ثلاثين دقيقة من اللعب النشط الآمن، موزَّعة على مدار اليوم، أمرًا حيويًا لنماء الأطفال في هذا العمر بدنيًا، وعاطفيًا، ومعرفيًا. ويجب مساعدة الرضّع على ممارسة النشاط البدني عدة مرات في اليوم، وبطُرق مختلفة. كما

يجب أن يمضي الرُّضع 30 دقيقة على الأقل، موزَّعة على مدار اليوم، في وضعية الانبطاح (وقت الاستلقاء على البطن) أثناء يقظتهم.

النوم الجيد

حتى سن ثلاثة أشهر، يحتاج الأطفال ما بين 14 و17 ساعة من النوم الجيد يوميًا، متضمنةً أوقات القيلولة. وفيما بين ثلاثة وستة أشهر، يحتاج الرضع من 12 إلى 16 ساعة من النوم الجيد، متضمنةً أوقات القيلولة. ويحتاج الرضع إلى النوم الجيد كي يحصلوا على الطاقة اللازمة للبقاء في حالة نشاط. فالطفل النشط هو الذي ينال قسطًا جيدًا من الراحة.

تقليل أوقات الخمول إلى الحد الأدنى

يجب عدم تقييد الأطفال الرضع لأكثر من ساعة في المرة الواحدة بوضعهم في عربات الأطفال أو المشايات، أو ربطهم على ظهر أحد الوالدين، أو الإفراط في لفِّهم. فعندما يُترك الرضع مقيدين لفترة أطول، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض التواصل مع بقية أفراد الأسرة ونقص النشاط. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخُّر الكلام وضعف الانتباه. لذا، يجب تقليل أوقات الخمول إلى أدنى حد عن طريق التحدث إلى الطفل، والغناء له، وملامسته.

8.4.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 122 و123 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

9.4.5 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية

أخبر المشاركين بأنه من الضروري أن يدرك الآباء أهمية متابعة نَماء أطفالهم من خلال مراقبة معالم النَّماء الرئيسية. وأكِّد على أن هذا لا يتيح وحسب التعرُّف على أي مظاهر للتأخُّر في الوقت المناسب، بل يتيح للآباء فرصة القيام بدور في تحفيز نَماء أطفالهم عندما يفهمون ماهية معالم النَّماء الرئيسية.

اسأل المشاركين، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، عن كيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أن أهم خطوة تتمثل في الملاحظة الفعالة لمعالم النَّماء الرئيسية في الأوقات الصحيحة. ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين الحصول على إذن الوالدين لتفقد علامات النماء: على سبيل المثال، يمكنهم وضع الرضيع مستلقيًا على بطنه، ومن ثمَّ وضع لعبة في متناول يده، وملاحظة ما إذا كان الطفل سيصل إليها.

كما أنه من المهم للغاية أن يُعلِّموا الوالدين المقصود بمعالم النَّماء الرئيسية حتى يتسنى للأم والأب متابعة التقدم الذي يحرزه طفلهما.

10.4.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 37 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، الوارد في الصفحة 44 من دليل المشارك.

11.4.5 لعبة بطاقات مطابقة المعلومات (2): معالم النَّماء الرئيسية لدى المواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين، والرضع من سن شهرين حتى أقل من ستة أشهر

ستحتاج إلى ما يلي:

طاولة، ومجموعتين من البطاقات.

أخبر المشاركين بأنهم سيلعبون لعبة مطابقة المعلومات الخاصة بمعالم النَّماء الرئيسية للفئتين العمريتين اللتين تعلماها حتى الآن.

قسِّم المشاركين إلى فريقين، وامنح كل فريق مجموعة من البطاقات. تنقسم البطاقات إلى نوعين، نوع يصف المعالم الرئيسية، والآخر يحمل عُمر الطفل. ومهمة الفريقين هي المطابقة بين النوعين. أخبر المشاركين بأن لديهم 15 دقيقة لمطابقة البطاقات. المطابقات الصحيحة ترد أدناه.

في نهاية اللعبة، أحصِ المطابقات الصحيحة لكل فريق وصفِّق للفريق الفائز.

المواليد من سن أسبوع إلى أربع أسابيع	عضلات الرقبة ضعيفة ولا يمكنه تثبيت رأسه
الرضيع الذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر	يمكنه رفع رأسه والدفع بجسمه عند الاستلقاء على البطن
الرضيع الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر	يرفع رأسه بثبات دون مساعدة من أحد
الرضيع الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر	يرى لعبة ويمد يدًا واحدة للوصول إليها
الرضيع الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر ونصفًا	يمسك بأصابع قدمه ويضعها في فمه عند الاستلقاء على الظهر
الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرين ونصفًا	يبدأ بمتابعة الأشياء بعينيه
المواليد من سن أسبوع إلى أربع أسابيع	عند الاستلقاء، يأخذ وضعية الجنين في الرحم
الرضيع الذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ونصفًا	يحتاج إلى النوم الجيد لفترة تتراوح بين 12 و16 ساعة في اليوم، تشمل أوقات القيلولة



الجلسة 19:
المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- مقطع فيديو 19، العب وتواصل: من سن شهرين حتى أقل من ستة أشهر (03:15 دقيقة)
- الألعاب

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- تقييم كيفية لعب الوالدين، وتواصلهم مع أطفالهم من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛
- تقديم النصيحة للوالدين حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)؛
- مساعدة الوالدين على تعزيز المهارات الأساسية لمقدِّمي الرعاية، وتحسين قدراتهم على الاستجابة لمصالح الطفل واحتياجاته.

1.5.5 مناقشة جماعية: ما المقصود بالعناية من أجل النماء؟

ذكّر المشاركين أنهم قد تعلموا بالفعل أن الأطفال تزداد قدراتهم مع تقدمهم في السن. فهم يتعلمون الكلام، والمشي، والجري، والتفكير، وحل المشاكل. وهذه التغييرات ما هي إلا أمثلة على نَماء الطفل. ويجب أن يسهم جميع أفراد الأسرة في تحفيز نماء الطفل. ويمكنهم القيام بذلك من خلال اللعب والتواصل مع الطفل.

ويصبح الرُّضع قريبين بشكل خاص من مقدمي الرعاية الذين يقومون بإطعامهم، ويقضون الوقت في التواصل معهم، ويمنحونهم الحب والود. ويجب أن تبدأ الأمهات في التحدث والغناء لأطفالهن، ولمسهم منذ الولادة. وبطبيعة الحال، يرغب الأطفال في التواصل مع شخص آخر منذ ولادتهم.

اطلب من المشاركين أن يذكروا وقتين يمكن أن تكون الأم فيهما قريبة جدًا من طفلها، وتستفيد منهما في اللعب والتواصل معه. استمع إلى المشاركين، ثم وضِّح بعد ذلك أن هذين الوقتين هما: وقت الرضاعة ووقت الاستحمام.

أضف أنه يجب على الأمهات اللعب والتواصل مع أطفالهن أثناء الرضاعة، وإلباسهم الملابس والقيام بالمهام اليومية الأخرى.

العناية من أجل النماء تعني مشاركة الوالدين وبقية أفراد الأسرة في النماء النفسي والاجتماعي للطفل

أخبر المشاركين بأن طريقة لعب الوالدين وتواصلهم مع طفلهما ستختلف وفقًا لحالة نَمائه وعمره.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 124 و125. واشرح كيفية اللعب والتواصل مع تلك الفئة العمرية عن طريق الرسم والنصائح المكتوبة.

2.5.5 فيديو توضيحي: كيفية اللعب والتواصل مع الأطفال من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛

ضع مقطع فيديو 20 (03:15 دقيقة) على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) لبيان كيفية اللعب والتواصل مع الأطفال من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول كيفية اللعب والتواصل مع هذه الفئة العمرية. اعرض الفيديو، وبعد انتهاء العرض، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

3.5.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 124 و125 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

4.5.5 مناقشة جماعية: مقدمة: كيفية تقديم المشورة حول الرعاية من أجل نماء الرُّضع في هذه الفئة العمرية

يمكن أن يساعد العاملون الصحيون المجتمعيون الأمهات وسائر مقدمي الرعاية على الاستجابة بعناية لأطفالهم الرضع حين يبدؤون التواصل. اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة للوالدين حول العناية من أجل النماء، وذلك في ضوء ما تعلموه بالفعل. واستمع إلى أقوالهم، ثم وضِّح لهم أن العاملين الصحيين المجتمعيين يمكنهم مساعدة مقدمي الرعاية على تشجيع جهود أطفالهم للتعلُّم من خلال الاستجابة لكلماتهم وأفعالهم عبر إصدار الأصوات، والإيماءات، واللمسات، والكلمات.

وسيقدم المشاركون، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، المشورة حول العناية من أجل النماء باستخدام استمارة التسجيل للتقييم، والكتاب القلاب كمصدر للمعلومات المهمة في هذا الشأن. وسيستخدمون استمارة التسجيل لفهم كيفية لعب الأسرة وتواصلها مع الطفل. راجع قسم اللعب والتواصل في استمارة التسجيل مع المشاركين، واشرح لهم كيفية ملء الاستمارة وتحديد المشكلات. وذكِّرهم بأنهم سيستخدمون الكتاب القلاب لتقديم المشورة حول أي مشاكل يتعرفون عليها، وأنه يتعين عليهم دائمًا التحقق من فهم الأم لما قالوه.

5.5.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 38 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)، الوارد في الصفحة 45 من دليل المشارك، وتقديم المشورة حول اللعب والتواصل، في دليل المشارك. وعند انتهائهم من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لديهم.



الجلسة 20:
المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات

مدة الجلسة
30 دقيقة

المُعدَّات
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:

- أشهر الحوادث المنزلية التي تصيب الرُّضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؛
- كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من مثل تلك الحوادث.

1.6.5 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات:

ذكِّر المشاركين بأنهم قد تعلموا بالفعل أن الحوادث والإصابات المنزلية هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. واسأل المشاركين عن أنواع الحوادث التي يشيع حدوثها في صفوف المواليد والأطفال دون سن الشهرين. استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي:

- الشَّرَق والاختناق؛
- الجروح والسقوط؛
- الحروق؛
- الغرق؛

أضف أن الحوادث الأربعة ذاتها تمثل خطرًا على الأطفال من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، إلى جانب نوع خامس من الحوادث وهو التسمم.

راجع مع المشاركين ما تعلموه بالفعل عن الشَّرَق وأسبابه، واذكر في النهاية أنه يُعدُّ سببًا شائعًا للإصابة والوفاة في صفوف صغار الأطفال، حيث تتعرض مسالكهم الهوائية الصغيرة للانسداد بسهولة. أضف إلى ذلك أنه في حين أن جميع الحالات الخاصة بالمواليد والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين تنطبق على الأطفال في الفئة العمرية من شهرين حتى أقل من ستة أشهر، فإن الخطر الذي يواجه الفئة الأخيرة يتفاقم بسبب قدرة الأطفال على الوصول إلى الأشياء الصغيرة، واعتيادهم على وضع تلك الأشياء في أفواههم. اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة للأمهات بشأن منع الرضع من ابتلاع الأشياء الصغيرة. واستمع إلى أقوالهم، ثم أكد على أنه يجب إبلاغ الأمهات بضرورة إبقاء جميع الأشياء الضارة بعيدًا عن متناول أطفالهن وترتيب تلك الأشياء في مكان مناسب.

ثم اسأل المشاركين عن الأسباب الأكثر شيوعًا لتعرُّض المواليد للجروح والسقوط. واستمع إلى أقوالهم قبل أن تُذكِّر بأن نفس الأسباب تنطبق على الرضع حتى أقل من ستة أشهر. كرر السؤال نفسه حول الحروق ثم اذكر أنها نفس الأسباب في الفئتين العمريتين.

راجع ما تعلَّمه المشاركون بالفعل عن الغرق، وأكد على أنه يجب ألا يُترك الرضيع دون مراقبة أثناء الاستحمام. ويجب على المشاركين، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، أن يوضِّحوا للأم أنه يتعين عليها تحضير كل ما تحتاج إليه مقدمًا، وألا تسمح بتشتيت انتباهها أثناء تحميم طفلها.

أخبر المشاركين أن هناك نوعاً آخر من الحوادث لهذه الفئة العمرية وهو التسمم، لأن الرضع، بمجرد تمكنهم من الوصول إلى الأشياء، قد يتعرضو ن لخطر الإمساك بمواد سامة.



2.6.5 قراءة

اطلب من المشاركين أن يفتحوا الكتاب القلاب على الصفحات من 126 حتى 133. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



3.6.5 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات

راجع قسم الوقاية من الحوادث/ الإصابات في استمارة التسجيل، واشرح كيفية ملء هذا القسم. وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون. وذكِّرهم بخطوات تطبيق مهارات التواصل الجيد التي سيحتاجون إليها عند التحدث مع الأسر، وكيفية استخدام استمارة التسجيل ليتمكنوا من ترتيب فهمهم للوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات اللازمة، وتقديم المساعدة العملية إذا لزم الأمر. ووضح لهم أيضًا أنه سيتعين عليهم التدقيق بعناية خلال الزيارات المنزلية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مواد تشكِّل خطرًا على الرضَّع متواجدة في أي مكان في المنزل.

اشرح قسم الوقاية من الحوادث/ الإصابات، ووضح كيفية ملء هذا الجزء.



4.6.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 39 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأم حول الوقاية من الحوادث والإصابات، الوارد في الصفحة 46 من دليل المشارك.

الجلسة 21:
المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- نسختين من الموقفين المذكورين في تدريب لعب الأدوار 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- مظاهر سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- كيفية الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات حول الوقاية من ذلك.

1.7.5 مناقشة جماعية: ما المقصود بسوء المعاملة، والإهمال، والعنف؟

اسأل المشاركين عن رأيهم في المقصود بسوء معاملة الرضع وإهمالهم، وما هي الآثار المترتبة على ذلك. استمع إلى أقوالهم، ثم وضِّح أن سوء المعاملة والإهمال يتضمنان سوء المعاملة بدنيًا وعاطفيًا.

ثم اسألهم عن رأيهم في الأثر المترتب على سوء المعاملة. استمع إلى آرائهم، ثم وضح أنه يترتب عليها أثرٌ سلبي على نَماء المخ في مرحلة الرَّضاعة والطفولة المبكرة. وهناك مؤشرات على أن استمرار سوء المعاملة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في المخ، بما يضر بالنمو البدني، والمعرفي، والعاطفي، والاجتماعي للطفل. وعند بلوغ الطفل سن الثالثة من العمر، يكون حجم المخ قد وصل إلى 90% من حجمه لدى البالغين. وفي غياب التحفيز والتربية، قد يتعرض نماء المخ للقصور. وسيتكيف المخ مع البيئة السلبية المحيطة به تمامًا كما قد يتكيف مع البيئة الإيجابية.

راجع مع المشاركين مجالات سوء المعاملة والإهمال، وكيفية الوقاية منهما.

2.7.5 قراءة

اطلب من المشاركين أن يفتحوا الكتاب القلاب على الصفحات من 134 حتى 137. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.

3.7.5 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

راجع القسم الخاص بالوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف في استمارة التسجيل، واسأل المشاركين عما إذا كانت لديهم أي أسئلة. وذكِّرهم بأنهم سيحتاجون عند تقديم المشورة للأسر إلى تطبيق مهارات التواصل التي تعلموها، وعليهم استخدام استمارة التسجيل لمساعدتهم على تقييم الوضع. وسيقدم الكتاب القلاب المعلومات الضرورية، وسيوجههم نحو

تقديم المساعدة العملية إذا لزم الأمر.

وضِّح لهم أنه عند تقييم الوضع، سيتعين عليهم أيضًا أن يراقبوا عن كَثَب ما يلي:

- نظافة الرضيع؛
- كيفية استجابة الأسرة لبكاء الطفل؛
- كيفية نظر الأم إلى الطفل أثناء حمله.



4.7.5 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 40 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف، الوارد في الصفحة 47 من دليل المشارك.



5.7.5 لعب الأدوار (7): تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف في صفوف صغار الرضع من عمر شهرين حتى ستة أشهر

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بتمرين لعب الأدوار للتدرُّب على تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف في صفوف الأطفال في هذه الفئة العمرية.

وسيقوم أحد المشاركين بدور العامل الصحي المجتمعي في كلا الموقفين، وستقوم أنت بدور الأم، وسيقوم المُيسِّر المشارك بدور الأب. أعط المشاركين الذين يؤدون دور العامل الصحي المجتمعي الجزء الخاص بهم فقط. اطوِ الأوراق، واطلب من كل واحد سحب ورقة. في نهاية كل تمرين من تمارين لعب الأدوار، اطلب من المشاركين الذين تابعوا التمرين التعليق على ما يلي:

- مهارات التواصل الجيد التي طبقها العامل الصحي المجتمعي؛
- استخدام استمارة التسجيل، وهل مُلئت بشكل صحيح؛
- قدرة العامل الصحي المجتمعي على تحديد المشاكل المتعلقة بالنظافة الشخصية؛
- استخدام الكتاب القلاب في تقديم المشورة للأم؛
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي معلومات مهمة إلى الأم؛
- هل يعتقد أن الأم اقتنعت وستعمل تبعًا للنصيحة التي قدمت لها.

الموقف 1

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور عائلة هالة التي تبلغ من العمر شهرين. وصلت إلى المنزل ووجدت هالة موضوعة على حصيرة على الأرض. وتبدو ملابسها متسخة. كما أنها تبكي ويبدو عليها الجوع. ولا أحد يستجيب لها بخلاف والدها. ولكنه يصرخ فيها ويأمرها بأن تصمت.

الموقف 1

الأم: أنت أم الطفلة هالة التي تبلغ من العمر شهرين. وأنت مثقلة بالأعمال المنزلية، ورعاية طفل يبلغ من العمر عامين، وتحضرين الطعام للأسرة بأكملها. وتُرضعين هالة ثلاث مرات في اليوم وتظنين أن ذلك يكفي.

الأب: يحتاج ابنك إلى قدر كبير من الرعاية. وعندما يكبر سيكون سندًا لك. ولم تقم بتطعيم هالة لأنه لم يكن لديك الوقت، بالرغم من أن ابنك حصل على جميع اللقاحات. وعندما مرضت هالة، أعطيتها ما تبقى من المضادات الحيوية التي وصفها الطبيب لأخيها.

الموقف 2

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور عائلة سلمى التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر ونصفًا. وعندما تصل تجد الأب يحمل سلمى ويتحدث معها، وينتظر حتى تأتي أمها لترضعها. وملابس الطفلة نظيفة للغاية. وعندما تأتي الأم تأخذ الطفلة وتُرضعها بينما تتحدث معها وتغني لها.

الموقف 2

الأم: أنت ترضعين سلمى رضاعة مطلقة، وتطعمينها ثماني مرات في اليوم. وقد حصلت على جميع لقاحاتها. كما تقومين بتحميمها ثلاث مرات في الأسبوع، وتنظفين وجهها، ويديها، ورقبتها بانتظام، وتقلمين أظافرها. وتغيرين ملابسها يوميًا، وإذا أصابها الاتساخ لأي سبب، تغيرينها من جديد. كما تغيرين حفاضها بانتظام.

الأب: أنت سعيد لأن لديك ابنة. يقولون إن الفتاة دائمًا صديقة والدها وأنت بالفعل لديك ولدان. وإذا مرضت ابنتك ستأخذها إلى مرفق صحي. وأنت لا تعطي أطفالك المضادات الحيوية ما لم يصفها لهم الطبيب.

الزيارات المنزلية للمواليد وصغار الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة شهور

أخبر المشاركين بأنه يجب عليهم التخطيط لزيارة هذه الفئة العمرية كل شهرين لمتابعة صحة الطفل، ونموه، ونَمائه.

كما يجب عليهم التخطيط للزيارات مقدمًا، باستخدام قاعدة البيانات المتاحة للعاملين الصحيين المجتمعيين لتحديد المنازل التي يتواجد بها أطفال. وإذا تواجد أكثر من طفل في المنزل، أو إذا كانت الأم حاملاً مرة أخرى، فيمكن للعاملين الجمع بين الرعاية المقدَّمة للأمهات ورعاية الأطفال الآخرين في زيارة واحدة.

ويجب أن يتوجه العاملون الصحيون المجتمعيون إلى الزيارات مُصطحبين معهم مجموعة الأدوات التي حددها البلد لهذا الغرض، بالإضافة إلى استمارة التسجيل والكتاب القلاب. ويجب عليهم دائمًا استخدام مهارات التواصل التي تدربوا عليها، واتباع الخطوات المشار إليها في استمارة التسجيل. وقد صُمِّمت الاستمارة لمساعدة العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد علامات الخطورة التي تشير إلى وجود حالات خطيرة تتطلب إحالة عاجلة. ويجب أن يتحقق العامل الصحي المجتمعي أولاً من وجود تلك العلامات، فإذا وجد أيًا منها، فيجب أن يتخطى سائر المهام، ويقدم المشورة حول الإحالة.

ويجب استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات المتعلقة بالوضع. ومن المهم أن يفهم العاملون الصحيون المجتمعيون أنه لا يجب عليهم وحسب قراءة محتويات الكتاب، بل عليهم أيضاً تكييف المعلومات التي يشملها حسب احتياجات الأسرة التي يزورونها.

أخبر المشاركين بأنه من المهم الاحتفاظ بسجل لجميع الأطفال الذين يعيشون في المنزل.

اطلب منهم الاطلاع على الإطار 41، الوارد في الصفحة 48، حول كيفية إجراء الزيارات المنزلية للرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، والمذكور في دليل المشارك.

الوحدة السادسة

العناية بصحة ونماء الرضّع من سن ستة أشهر حتى أقل من عام واحد في المنزل



مقدمة

أخبر المشاركين بأنهم سينتقلون الآن إلى الفئة العمرية الثالثة، أي الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد (أي أكملوا ستة أشهر ولكنهم لم يكملوا سنة واحدة بعد).

ستتألف عملية تقديم الرعاية لهذه الفئة العمرية من سبعة مكونات:

1. تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية: ممارسات طلب الرعاية الصحية والوقاية
2. تقديم المشورة حول التغذية
3. تقديم المشورة حول النظافة الشخصية
4. تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية
5. تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)
6. تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات
7. تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف.

أدوات للعاملين الصحيين المجتمعيين بغرض تقديم المشورة حول رعاية الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد:

أخبر المشاركين بأنهم سيستخدمون:

- استمارة تسجيل مختلفة مخصَّصة للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات، لفهم الوضع.
- الاستمرار في استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية.
- دليل المشارك كوثيقة مرجعية.

عرض توضيحي: استمارة التسجيل

اطلب من المشاركين فتح دليل المشارك على استمارة التسجيل للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات. وضِّح أن تصميم الاستمارة مشابه لتصميم الاستمارة الخاصة بالأطفال الأصغر سنًا: فالجزء العلوي الذي يحتوي على معلومات عامة -مثل اسم الطفل، واسم الأم، وتاريخ الميلاد، واسم العامل الصحي المجتمعي، واسم القرية، وما إلى ذلك- هو نفس الجزء في الاستمارة الأخرى، ثم يليه سطر يُذكِّرهم بتحية الأسرة، وتقديم أنفسهم، وشرح الغرض من زيارتهم.

وكما هو الحال بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يجب أن يحاول العاملون الصحيون المجتمعيون التأكد من وجود أفراد آخرين في الأسرة عند زيارتهم للمعاونة في تقديم الدعم والمساعدة للأم. وبعد ذلك، يمكنهم السؤال عن أحوال الطفل. ويجب تدوين ما تقوله الأم.

وكما هو الحال في الاستمارة الأولى، تنقسم استمارة التسجيل الجديدة إلى عمودين، مع وجود مساحة على اليسار للأسئلة التي يجب أن يطرحها العاملون الصحيون المجتمعيون لمساعدتهم على فهم الوضع، ومساحة على اليمين لتسجيل ملاحظاتهم.

ويتبع القسم المتعلق بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية نفس التصميم تقريبًا، وسيُستخدَم في إنجاز المهمة الحيوية المتمثلة في التحقق من وجود علامات الخطورة. استعرض مع المشاركين كيفية ملء هذا القسم للأطفال الأصغر سنًا، وأخبرهم بأنهم يجب أن يفعلوا نفس الشيء مع الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد. ويجب

التحقق من كل علامة خطورة على حدة، وإذا كانت موجودة، فيجب التأشير على المربع الموجود بجوار العلامة.

أوقف العرض التوضيحي عند هذا الحد، وأخبر المشاركين بأنه في كل مرة تتناول فيها الجلسة مكونًا جديدًا من مكونات الرعاية سوف توضح لهم كيف يجب تسجيله في الاستمارة.



عرض توضيحي: الكتاب القلاب

ذكِّر المشاركين بأن كل فصل من الفصول الخمسة الأولى من الكتاب القلاب يتناول فئة عمرية مختلفة، بينما يركز الفصل السادس على العناية بصحة الأمهات. ويُميَّز كل فصل من فصول الكتاب القلاب من الجانب بلون خاص يدل على الفئة العمرية. اطلب من المشاركين استخدام العلامات الدالة على الفئات العمرية في الجانب لفتح القسم الخاص بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أشهر حتى أقل من عام واحد، واشرح مجددًا كيف يتعين استخدام الكتاب، بحيث تكون الصفحة المصوَّرة في مواجهة الأم، والصفحة التي تتضمن النصائح المكتوبة في مواجهة العاملين في مجال صحة المجتمع.



الجلسة 22:
المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام

مدة الجلسة
90 دقيقة

المُعدَّات

- مقطع فيديو 17، علامات الخطورة: الطفل ضعيف جدا ولا يقدر على الرضاعة، والتشنجات، وتقيؤ الطفل لكل شيء، والتنفس السريع، وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.
- مستلزمات غسل اليدين:
  - صابون
  - إبريق ماء
  - إناء كبير
- طباشير
- مذكرة الإحالة

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:

- ملاحظة علامات الخطورة لدى الرضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنة واحدة؛
- تقديم المشورة للأسر بشأن علامات الخطورة ودعم الإحالة؛
- تقديم المشورة حول سائر ممارسات طلب الرعاية الصحية

1.1.6 مناقشة جماعية: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية المتعلقة بالرضع من سن 6 أشهر حتى أقل من عام واحد: أولاً: ممارسات طلب الرعاية الصحية

راجع مع المشاركين ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية التي تعلموها في الفئتين العُمريتين الأولى والثانية. الفت الانتباه إلى كيفية تقسيم تلك الممارسات إلى ممارسات طلب الرعاية الصحية (أي متى وأين يجب طلب الرعاية الصحية؟)، وممارسات الوقاية (أي التطعيم، وغسل اليدين، والنوم تحت ناموسية، واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد، ومبادئ نظافة الغذاء – أي استخدام الماء المغلي لتنظيف الأكواب، والملاعق، والأواني الأخرى، وغير ذلك).

متى يتعين طلب الرعاية الصحية؟ التحقق من وجود علامات خطورة

قبل ذكر علامات الخطورة التي تنطبق على هذه الفئة العمرية، أكِّد على نقطة حاسمة تتمثل في أن وجود أي علامة خطورة قد يشير إلى احتمال وجود حالة صحية خطيرة، لذا، يجب إحالة الطفل إلى مرفق صحي على وجه السرعة. اغتنم هذه الفرصة كي تتحقق مع المشاركين من علامات الخطورة التي تنطبق على الفئتين العُمريتين الأصغر (يمكنك القيام بذلك بالتفصيل، فذلك تمرين مفيد لمراجعة ما سبق تعلُّمه). بعد ذلك، أخبر المشاركين أن علامات الخطورة لدى الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد هي العلامات نفسها عند الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، مع بعض التعديلات الطفيفة.

اذكر علامات الخطورة التي تنطبق على هذه الفئة العمرية:

- الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الشرب أو الرضاعة؛
- تشنجات؛
- تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله؛
- التنفس السريع؛
- انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.

راجع كيف سيتحقق المشاركون من تلك العلامات، والفت الانتباه بشكل خاص إلى النقاط التالية.

- بالنسبة لهذه الفئة العمرية، التي يبدأ الأطفال فيها في الحصول على التغذية التكميلية، فإن علامة "ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة" تشمل عدم القدرة على الشرب. ويبدأ الأطفال في هذا العُمر بشرب الماء وعصائر أخرى.
- فإذا قالت الأم إن الرضيع لا يقدر على الشرب أو الرَّضاعة، أو إذا كنت غير متأكد من إجابتها، فاطلب منها تقديم سائل لطفلها أو إرضاعه للتأكد من وجود العلامة.
- إذا قالت الأم إن الرضيع يتقيأ كل شيء، فاطلب منها أن تقدم له سائلاً أو ترضعه للتأكد من وجود العلامة.
- للتحقق من التشنجات، ابدأ بسؤال الأم عما إذا كان الطفل مصابًا بتشنجات، وتحقَّق مما إذا كان الطفل يعاني من تشنجات حالية.
- لتحديد ما إذا كان الرضيع يعاني من سرعة التنفس، عدّ أنفاسه لدقيقة واحدة عندما يكون هادئًا ولا يرضع. إذا كان العد الأول هو 50 نَفَسًا/ دقيقة أو أكثر، فإن الرضيع يتنفس بسرعة.
- أي انسحاب في جدار الصدر إلى الداخل (سواء كان انسحاباً شديداً أو غير شديد) يمثل علامة خطورة.

إذا كان عمر الطفل:	يعاني من سرعة التنفس إذا حسبت:
من الولادة حتى أقل من شهرين:	**60 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر (في العد الثاني).**
من شهرين حتى أقل من ستة أشهر (لم يُكمل ستة أشهر):	**50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.**
من ستة أشهر حتى أقل من سنة واحدة (لم يُكمل سنة واحدة):	**50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.**

أكِّد على أن الحد الفاصل للتنفس السريع لدى الرضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد (لم يُكملوا سنة واحدة) هو 50 نفسًا في الدقيقة أو أكثر عند العد الأول.

2.1.6 فيديو توضيحي: علامات الخطورة لدى الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

ضع مقطع الفيديو رقم 17 على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) لبيان علامات الخطورة: الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الشرب أو الرضاعة، التشنجات، تقيؤ الطفل لكل ما تناوله، التنفس السريع، وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل (12:10.53 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول علامات الخطورة لدى الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد.

اعرض مقاطع الفيديو، وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون، وكرِّر عرض الفيديو إذا لزم الأمر.

3.1.6 مناقشة جماعية: من الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟

اسأل المشاركين عن الأماكن التي يجب أن تتوجه إليها الأسر طلبا للرعاية الصحية لأطفالهم الرضع. استمع إلى إجاباتهم، ثم أكّد على أنه يجب أن يمثل مهنيو الرعاية الصحية المُدرَّبون مصدر الرعاية الطبية للجميع. انصح الأسر بألا تطلب الرعاية الصحية من مصادر أخرى لأنهم قد يسببون الضرر للطفل بدلاً من أن يحققوا منفعته. بل قد يصل الأمر إلى أن يتوفى الطفل جرّاء ذلك.

4.1.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 42 الخاص بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، الوارد في الصفحة 52 من دليل المشارك. وعند الانتهاء من ذلك، اطلب منهم قراءة الصفحات من 138 حتى 143 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أيةأسئلة يطرحها المشاركون. وناقش أيضًا الإطار الأحمر الخاص بالتعليمات المقدمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين بشأن التحقق من علامات الخطورة.

5.1.6 لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام 4: راجع علامات الخطورة عند الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

أخبر المشاركين بأنهم سوف يراجعون علامات الخطورة من خلال لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام. ذكِّر المشاركين بقواعد لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام. واستخدم قطعة من الطباشير لرسم خط البداية والنهاية –ويجب أن تكون المسافة بين الخطوط أربع خطوات أو أكثر– ثم قسِّم المشاركين إلى فريقين.

قسِّم المشاركين إلى فريقين، وأعطِ كلاً منهما رقمًا (1، 2، 3، وما إلى ذلك). واطلب منهم تذكُّر تلك الأرقام أثناء اللعبة. ثم نادِ على أرقامهم.

وفيما يلي الأسئلة والأجوبة الخاصة بهذه اللعبة.

السؤال 1: ما هي علامات الخطورة عند المواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين؟
الإجابة 1: الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة، أو توقف عن التغذية مُطلقًا؛ عدم التحرك سوى عند التنبيه، أو عدم التحرك حتى بعد التنبيه، التشنجات، اصفرار راحتي اليد والأخمصين، التنفس السريع، انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، علامات العدوى الموضعية (خروج قيح من السُّرَّة، احمرار الجلد حول السُّرَّة، دمامل الجلد، خروج قيح من العينين)، ونقص وزن الرُّضع.

السؤال 2: ما هي علامات الخطورة عند الرضَّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؟
الإجابة 2: الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الرضاعة، التشنجات، تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله، سرعة التنفس، انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.

السؤال 3: ما هي علامات الخطورة عند الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؟
الإجابة 3: الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الشرب أو الرضاعة، التشنجات، تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله، سرعة التنفس، انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.

السؤال 4: لماذا تشمل علامة الضعف الشديد وعدم القدرة على الرضاعة أيضًا عدم القدرة على الشرب عند الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؟
الإجابة 4: لأن الرضع في هذا العمر يبدؤون في الشرب والأكل.

السؤال 5: ما هو عدد الأنفاس الذي نقرر عنده أن التنفس سريع لدى المواليد وصغار الرُّضَّع الأقل من شهرين؟
الإجابة 5: ستون نفسًا أو أكثر في العد الثاني.

السؤال 6: ما هو عدد الأنفاس الذي نقرر عنده أن التنفس سريع لدى الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؟
الإجابة 6: عدد 50 نفسًا في الدقيقة أو أكثر، في العدّ الأول.

السؤال 7: ما هو عدد الأنفاس الذي نقرر عنده أن التنفس سريع لدى الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر؟
الإجابة 7: عدد 50 نفسًا في الدقيقة أو أكثر، في العدّ الأول.

السؤال 8: ما المقصود بعلامة تقيؤ الطفل لكل شيء؟
الإجابة 8: لا يستطيع الرضيع استبقاء أي شيء على الإطلاق في جوفه.

السؤال 9: إذا بلغ الرضيع شهرين من العمر وكنت تعد له 56 نفسًا في الدقيقة، فهل هذا التنفس سريع؟
الإجابة 9: نعم

السؤال 10: ما هو الفرق بين انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل في المواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين وانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل في الأطفال من سن 6 أشهر حتى أقل من عام واحد؟
الإجابة 10: في المواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين هناك انسحاب طبيعي وطفيف في جدار الصدر للداخل لأن جدار الصدر لينٌ. ولكي يكون انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل علامة خطورة لابد أن يكون شديدًا. أما في الأطفال من سن 6 أشهر حتى أقل من عام واحد، فإن أي انسحاب في جدار الصدر للداخل يعدُّ علامة خطورة (بمعنى أن حدوث انسحاب في جدار الصدر للداخل ليس أمرًا طبيعيًا).



6.1.6 مناقشة جماعية: تقديم المشورة والمساعدة حول الإحالة

أكِّد على أن أي علامة خطورة تشير إلى احتمال وجود حالة صحية خطيرة، وأنه يتعين إحالة الرضيع على وجه السرعة إلى المرفق الصحي. وانتقل إلى استمارة التسجيل ووضح كيفية ملء القسم الخاص بعلامات الخطورة، ثم اسأل المشاركين عما يجب عليهم فعله في حالة وجود علامة خطورة. استمع إلى أقوالهم، ثم أكد أنه يجب عليهم إخبار الأسرة بأن حياة الطفل قد تكون معرَّضة للخطر، وأنه يحتاج إلى إحالة عاجلة إلى مرفق صحي.

وضِّح كيفية ملء مذكرة الإحالة، وذكِّر المشاركين بنُصح الأم بإبقاء الطفل دافئًا أثناء التوجه به إلى المستشفى. إذا كان الطفل يستطيع تناول الطعام، فيجب على الأم أن ترضعه أكثر من مرة أثناء التوجه إلى المستشفى، أو أن تعطيه رشفات من الماء أو أية سوائل أخرى.

7.1.6 مناقشة جماعية: صعوبات تواجه إحالة الطفل، وكيفية تقديم المشورة حول الإحالة

استعرض مع المشاركين الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عند إحالة مولود إلى مرفق صحي، وأبلغهم بأن المشاكل نفسها قد تظهر مع الأطفال الأكبر سنًّا. ناقش معهم كيفية تقديم المشورة حول الإحالة، وتذليل الصعوبات.

8.1.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 43 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول علامات الخطورة وإحالة الطفل، الوارد في الصفحة 53 من دليل المشارك. وعند الانتهاء من ذلك، اطلب منهم قراءة الصفحات من 144 حتى 147 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين والواردة في الإطار الأحمر.

9.1.6 لعب الأدوار 8 تقديم المشورة حول علامات الخطورة في الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بلعب الأدوار للتدرُّب على كيفية تعليم والدي الطفل الذي لا يظهر عليه أي علامة خطورة كيفية تحديد علامات الخطورة عند ظهورها. أخبر المشاركين بأنك ستقوم بدور الأم لطفل لا تظهر عليه أي علامة خطورة، بينما سيقوم الميسر المشارك بدور الأب. وسيتناوب المشاركون القيام بدور العامل الصحي المجتمعي الذي سيملأ استمارة التسجيل في البداية، ثم يقدم المشورة للوالدين بشأن كيفية تحديد علامات الخطورة التي تنطبق على الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد باستخدام الكتاب القلاب. في نهاية كل تمرين من تمارين لعب الأدوار، قم بإجراء مناقشة جماعية.

- هل قام العامل الصحي المجتمعي بملء استمارة التسجيل بشكل صحيح؟ كيف ذلك؟
- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي الكتاب القلاب بفعالية؟ كيف ذلك؟
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي معلومات مهمة، وشرح للأسرة كيفية تحديد علامات الخطورة؟
- هل تعتقد أن العائلة فهمت كيفية تحديد علامات الخطورة؟ وضح كيف عرفت ذلك؟

10.1.6 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية

استعرض مع المشاركين ممارسات الوقاية التي تعلموها، وقل لهم إن الممارسات نفسها تنطبق على الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد. واستعرض أهمية التطعيم، مع عرض قائمة بالجرعات الثلاث التي يجب إعطاؤها، وضرورة نوم الأمهات والأطفال تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات الحشرات، واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد.

وفيما يتعلق بغسل اليدين، اطلب من المشاركين الرجوع إلى الكتاب القلاب.

إذا لم يرضع الطفل، فيجب للعاملين الصحيين المجتمعيين تشجيع الأم على القيام بذلك، ولكن إذا كان ذلك لأسباب قهرية،

فيجب عليهم تقديم المشورة للأم حول كيفية إعداد اللبن الاصطناعي. راجع المعلومات الخاصة بغلي الماء لتنظيف الأكواب والملاعق عندما لا يكون في الإمكان إرضاع الأطفال. واسأل المشاركين عن سبب الأهمية البالغة لغلي الماء وتنظيف الأكواب والملاعق بعناية عند إعداد اللبن الاصطناعي للرضع الذين لا يرضعون. استمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أن الماء المغلي يقتل المكروبات والجراثيم التي تسبب الأمراض، ويجعل ماء الصنبور آمنًا. وأكد على ضرورة غلي الماء حتى الفَوَران لمدة دقيقة واحدة، وضرورة تبريد الماء وأي أدوات أخرى قبل استخدامها. كما يجب أن ينصح العاملون الأم بإطعام الطفل باستخدام كوب وملعقة بدلاً من الزجاجة. وأضف أنه في المناطق التي لا يتوافر فيها مصدر آمن للمياه الصالحة للشرب، يُعتبر غلي الماء قبل الاستخدام ضرورة ملحة لصحة الأسرة بأكملها.



11.1.6 تدريب عملي على غسل اليدين

ستحتاج إلى ما يلي:
صابون؛
إبريق ماء؛
إناء كبير.

اطلب من اثنين من المشاركين ممارسة غسل اليدين، واطلب من باقي المشاركين التعليق على هذه الممارسة. يمكنهم الرجوع إلى كتاب القلاب.



12.1.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 148 حتى 155 من الكتاب القلاب. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المحتمعيين والواردة في الإطار الأحمر.



الجلسة 23:
المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية

مدة الجلسة
ساعتان

جهِّز
- لوازم لتوضيح أنواع قوام الطعام:
- ست ملاعق مائدة من الدقيق
- كوبين
- ملعقة
- إبريقًا مملوءًا بالماء
- لوحًا ورقيًا قلابًا
- نسخًا مطوية من السيناريوهات السبعة الخاصة بتمرين لعب الأدوار 9
- استمارة تسجيل مُكبَّرة للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيعرف المشاركون:
- أهمية استمرار الرضاعة لهذه الفئة العمرية؛
- توقيت إدخال الأغذية التكميلية؛
- الأغذية التكميلية المُغذِّية للرضع في هذه الفئة العمرية، وكيفية إعدادها؛
- كيفية إطعام الرضيع، وعدد مرات ذلك؛
- كيفية تقديم الأغذية، وتشجيع الرضَّع على تناولها (التغذية الفعّالة)؛ وسوف يتدرب المشاركون على؛
- كيفية تقديم المشورة حول التغذية التكميلية.

1.2.6 مناقشة جماعية: تغذية الرضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

اسأل المشاركين عن أفضل الأطعمة للمواليد والرضَّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر. أصغِ إلى إجاباتهم قبل أن تذكر في النهاية أنه يجب على الأمهات الاكتفاء بالرضاعة. وأضف أنه يجب عليهم الاستمرار في الرضاعة لما بعد عمر ستة أشهر. في هذا العمر، يوفر لبن الأم نصف الاحتياجات الغذائية للطفل (سهل الهضم والامتصاص). وستحتاج الأم إلى إضافة ما نسميه بالأغذية التكميلية لتكملة لبن الأم، بحيث يحصل الطفل على كل احتياجاته الغذائية. وهذا ما يسمى بالتغذية التكميلية. وإذا تعذر على الأم القيام بذلك، فقد ينقص وزن الأطفال ويتعثر نموهم.

أكِّد على أنه بالرغم من أن لبن الأم لا يوفر سوى نصف إجمالي احتياجات الطفل الغذائية، فإنه لا يزال يوفر الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض (عامل حماية)، كما أنه يساعد الطفل على النمو بصحة جيدة. ولهذا السبب يجب على الأمهات مواصلة إرضاع أطفالهن الرضع في هذه الفئة العمرية عند الطلب، إلى جانب إعطائهم الأغذية التكميلية.

أخبر المشاركين بأن هذا العمر هو أيضًا العمر الذي تتطور فيه الأعصاب والعضلات في الفم بما يكفي للسماح للطفل بمضغ الطعام وتفتيته. وقبل بلوغ سن الأربعة أشهر، يدفع الأطفال الطعام خارج أفواههم لأنهم لا يستطيعون التحكم

في حركة ألسنتهم بشكل تام. وعند بلوغ ستة أشهر، يصبح من السهل إطعام الطفل أغذية مسحوقة أو مهروسة بعناية. ويمكن للأطفال في هذا العُمر التحكم في ألسنتهم بشكل أفضل، والبدء في تحريكها لأعلى وأسفل بغرض «المضغ»، كما أنهم يحبون وضع الأشياء في أفواههم، ويهتمون بالمذاقات الجديدة، وينضج لديهم الجهاز الهضمي بما يكفي للتعامل مع طيف متنوع من الأطعمة.

ومن المهم بدء التغذية التكميلية في الوقت المناسب. حيث إن إعطاء الأغذية التكميلية في وقت مبكر للغاية ينطوي على خطورة، لأن:

- لبن الأم يتيح جميع المُغذِّيات التي يحتاج إليها الطفل، ولا يحتاج إلى طعام لتكميله؛
- الأغذية التكميلية قد تحل محل لبن الأم، ومع تناول الطفل لكميات أقل من لبن الأم، تنتج الأم كميات أقل من اللبن، مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل (من حيث الكمية والنوعية)؛
- الطفل يحصل على مقدار أقل من عوامل الحماية الموجودة في لبن الأم، ويزداد خطر إصابته بالأمراض؛
- خطر الإصابة بالإسهال يزداد لأن الأغذية التكميلية قد لا تكون نظيفة مثل لبن الأم؛
- الأغذية التي تُعطَى بدلاً من لبن الأم غالبًا ما تكون على هيئة عصائد خفيفة أو مائية أو أنواع من الحساء يسهل على الأطفال أكلها وملء معدتهم بها، ولكنها تحتوي على مغذيات أقل من تلك التي يحتويها لبن الأم.

عليك أيضًا إخبار المشاركين بأن الأمهات يكُنَّ أكثر عرضة للحمل مرةً أخرى كلما كان إرضاعهن بوتيرة أقل.

كما أن التأخر كثيرًا في تقديم الأغذية التكميلية للطفل ينطوي على خطورة، لأن:

- الطفل لن يحصل على الطعام الإضافي الذي يحتاج إليه كي ينمو بشكل صحي، ويسد احتياجه من الطاقة.
- هذا الأمر يزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية ونقص المُغذِّيات الزهيدة المقدار.



2.2.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 44 الخاص بالأغذية التكميلية، الوارد في الصفحة 54 من دليل المشارك، والصفحتين 156 و157 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون .



3.2.6 مناقشة جماعية: ما هي الأغذية التكميلية الجيدة؟

وضح أن الأغذية التكميلية يجب أن تكون:

- غنية بالمُغذِّيات؛
- غنية بالطاقة؛
- مجهَّزة بطريقة صحية؛
- متاحة محليًا؛
- مقبولة من الناحية الثقافية.

أخبر المشاركين بأن اللحوم والبقول غنية بالبروتين والحديد، في حين أن الحبوب، والزبد، والزيوت، هي مصادر للطاقة؛ وكل تلك العناصر ضرورية لنمو الطفل ونمائه. صف خصائص الأغذية التكميلية الجيدة بالرجوع إلى الكتاب القلاب.

1. نظام غذائي غني بالمُغذِّيات:

يحتوي على مجموعة متنوعة من الطعام، ويُعتبر كل منها مصدرًا للمغذيات الأساسية التي تضمن إمداد الطفل بجميع احتياجاته من المُغذِّيات والطاقة.

مصادر المُغذِّيات المهمة

وضِّح أن الحديد يُسهم في تقوية الدم.

واسأل المشاركين عما إذا كانوا يعرفون أفضل مصادر للحصول على الحديد. استمع إلى إجاباتهم قبل أن تخبرهم أن الأطعمة ذات المصدر الحيواني، ومنها اللحوم، والأعضاء مثل الكبد، والأسماك، هي أغنى المصادر بالحديد، تليها الخضروات الورقية الداكنة والبقول.

ثم وضِّح أن الزنك يساعد على الوقاية من الأمراض، وأن أفضل مصادره هي نفسها مصادر الحديد.

ويُسهم فيتامين (أ) في صحة العينين ونَماء المخ، كما أنه يساعد في الوقاية من الأمراض، وأفضل مصادره هي الفاكهة، والخضروات الخضراء والبرتقالية الداكنة، وأعضاء الحيوانات، ومنتجات الألبان، والبيض.

2. نظام غذائي غني بالطاقة:

وضح أن قوام الطعام مهم للإمداد بالطاقة اللازمة. لذا، يجب إعداد الطعام بقوام يظل متماسكًا على الملعقة. فالحساء الخفيف والحبوب تملأ المعدة، لكنها لا توفر الطاقة الكافية لنمو الطفل.

اسأل المشاركين لماذا تقدم بعض الأمهات الطعام السائل لأطفالهن الرضع. استمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أن تقديم أطعمة سائلة للرضيع يستغرق وقتًا وجهدًا أقل لأن الطعام السائل يمكن تقديمه في زجاجة بينما الطعام الأكثر سُمكًا يستغرق وقتًا أطول، ويجب أن يمضغه الرضيع قبل ابتلاعه.

3. أغذية مأمونة ومجهَّزة بطريقة صحية

اسأل المشاركين عن معنى إعداد الطعام بطريقة آمنة وصحية. استمع إلى أقوالهم ثم أضف أنه يتعين على الأم:

- غسل يديها قبل إعداد الطعام وقبل إطعام طفلها؛
- غسل الخضروات قبل طهيها والفواكه قبل تقديمها؛
- غسل الأواني المستخدمة في الطهي؛
- تجنب إضافة الملح، أو السكر، أو التوابل، أو المواد الحافظة إلى طعام الطفل.

يجب أن يكون الطعام:

- مُعدًا حديثًا؛
- مطبوخًا جيدًا؛
- مهروسًا جيدًا بالشوكة وليس مضروبًا في الخلاط؛
- مغطى لحمايته من الذباب.

4. مُتاحة محليًا ومقبولة لدى المجتمع

اسأل المشاركين عما سيحدث إذا نصحوا الوالدين بإطعام أطفالهم أغذية غير متوفرة محليًا. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن تخلص إلى القول إنه من غير المرجَّح أن يأخذ الوالدان تلك النصيحة على محمل الجد، وأنه من الأفضل بكثير التوصية بأغذية متوفرة بسهولة ومقبولة للمجتمع.



4.2.6 عرض توضيحي عملي لأهمية قوام الغذاء

ستحتاج إلى ما يلي:

- ست ملاعق مائدة من الدقيق
- كوبين
- ملعقة
- إبريق ماء

اطلب من المشاركين مشاهدة العرض التوضيحي العملي. واشرح ما تقوم به بصوت مرتفع. ضع ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق في كل كوب. واسكب كمية صغيرة من الماء في أول كوب واخلطه حتى يصبح القوام متجانسًا (بمعنى أن يكون ناعمًا ويظل متماسكًا على الملعقة). اسكب ضعف كمية الماء في الكوب الثاني. سيصبح الخليط سائلاً، ولا يظل متماسكًا على الملعقة. ووضِّح للمشاركين أنه لا يوجد فرق في كمية الدقيق في كل كوب، ثم اسألهم: إذا أخذنا ملعقة من كل كوب، هل ستحتوي كل ملعقة على نفس كمية المغذيات؟ استمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح أن الملعقة من الكوب الثاني سوف تحتوي على نصف مغذيات الملعقة المأخوذة من الكوب الأول.

وضِّح أنه كلما زادت كمية الطعام المخفَّفة قلت العناصر الغذائية التي تحتويها كل ملعقة. ولأن حجم المعدة لدى الرُّضع صغير -حيث يبلغ متوسط سعة معدة طفل عمره ثمانية أشهر 200 مل- فلن يتمكن الطفل من الحصول على المُغذِّيات التي يحتاج إليها إذا كان الطعام مخففًا للغاية. ولإمداد الطفل بجميع المُغذِّيات المطلوبة، يجب تناول كميات أكبر من الطعام قد تفوق حجم المعدة.



5.2.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 158 حتى 161 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون. ثم اشرح التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الموجودة في الإطار الأحمر.



6.2.6 مناقشة جماعية: تقديم

الأغذية التكميلية للرضيع

وضِّح أنه قد يكون من الصعب في البداية تقديم الأغذية التكميلية للرضيع الذي يعتمد وحسب على الرضاعة المطلقة. ويختلف كل طفل عن الآخر. إذ يبدأ الأطفال في تناول الأغذية بترتيب يتفاوت من طفل لآخر وبالمعدل المناسب لكل منهم. ويتولى الوالدان ومقدمو الرعاية مسؤولية اختيار الطعام المغذي الذي يُقدَّم إلى الطفل. ويعود الأمر إلى الطفل لتحديد مقدار الطعام الذي يحتاج إلى تناوله.

أكِّد للمشاركين على أن خيارات الطعام خلال مرحلة الطفولة والمراهقة تساعد على وضع الأساس لعادات الأكل مدى الحياة، وأن عادات الأكل والحالة التغذوية ترتبط بالأداء المدرسي، والسلوك، وتقدير الذات. وترتبط عادات تناول الطعام السيئة وسوء التغذية خلال مرحلة الطفولة والمراهقة بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة، منها أمراض القلب والسرطان والسُّكَّري.

ونظراً إلى صعوبة إدخال الأغذية التكميلية، اسأل المشاركين عمّا إذا كانوا يعتقدون أن هناك وقتًا مناسبًا للبدء في تناول أطفالهم الرضع للطعام. واستمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر في النهاية أنه يجب تقديم النصح للأمهات بعدم البدء في التغذية التكميلية أثناء فترة مرض الرضيع. ويجب أن تختار الأم وقتًا لتبدأ فيه عندما يكون طفلها سعيدًا، وعندما تكون هي هادئة ولديها من الوقت ما يُمكِّنها من التركيز على الطفل.

اسأل المشاركين عما إذا كانوا يعتقدون أنه يتعين على الأم البدء في تقديم الأغذية التكميلية قبل الرضاعة أو بعدها. استمع إلى إجاباتهم قبل أن تخبرهم ما يتعين عليهم نصح الأمهات به، وهو:

- تقديم الطعام قبل إرضاع الطفل، وعندما يكون الطفل جائعًا وأكثر ميلاً لقبول أطعمة جديدة. عندما يعتاد الرضيع الطعام المقدَّم له، يمكن للأم أن تقدم له الطعام بعد الرضاعة. أضف أنه يتعين على الأم دائمًا استخدام ملعقة لإطعام الطفل وليس زجاجة، وأنه من الطبيعي أن يرفض الأطفال أطعمة جديدة، كما يحتاج الأمر أحيانًا إلى القيام بعدة محاولات لتقديم أطعمة جديدة قبل أن يتقبلها الطفل.
- إدخال أغذية جديدة في كل مرة، والانتظار لمدة أربعة إلى خمسة أيام قبل البدء بطعام جديد آخر. بهذه الطريقة يمكن للأم التعرُّف على الأغذية التي قد تسبب مشكلات الحساسية. أما إذا قدَّمت الأم عدة أطعمة جديدة، سيكون من الصعب تحديد الطعام الذي سبب التفاعل التحسسي؛
- البدء بطعام مهروس يسهل على الطفل تناوله، مع تقديم ملعقة أو ملعقتين قبل الرضاعة، وعندما يكون الطفل جائعًا.
- البدء في تقديم الأغذية التكميلية مرة واحدة في اليوم، ثم الزيادة ببطء حتى ثلاث مرات في اليوم. ويجب تقديم المزيد من الطعام مع نمو الطفل؛
- تشجيع الطفل بلطف وعدم إجباره على تناول المزيد من الطعام. فالأطفال يعرفون متى يحصلون على كفايتهم من الطعام، ولذلك يديرون رؤوسهم بعيدًا عنه. ويجب على الأمهات تقديم الطعام في وقت لاحق بدلاً من إجبار الطفل على الاستمرار في تناول الطعام؛
- ملاحظة الطفل باستمرار أثناء تناول الطعام؛
- تجنب إضافة السكر والملح إلى أغذية الطفل لأنها قد تسبب تسوس الأسنان، وقد تُسبب مزيدًا من العبء على كليتي الطفل؛
- تجنب تقديم مشروبات الصودا وعصائر الفواكه المحلاة؛
- تجنب عصير الفاكهة، حتى الطازج منه. فالعصير يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وألياف قليلة. بينما تحتوي الفواكه الكاملة على الألياف التي تساعد على الوقاية من الإمساك. وعند عصر الفاكهة، يتركز محتوى السكر في الفاكهة ويُحرَم الطفل من الألياف. لذا، فمن الأفضل للأطفال تناول الفواكه كاملة بدلاً من شرب عصير الفاكهة. أعطِ الطفل فاكهة مهروسة بدلاً من ذلك.
- تجنب المُكسَّرات الكاملة، والبذور، ورقائق الذرة، والمصاصات الصلبة، والجزر النيئ، وقطع التفاح وما شابه ذلك. فتلك القطع صغيرة وصلبة وقد تسبب الاختناق؛
- افحص الأسماك جيدا بحثًا عن العظام قبل تقديمها للطفل؛
- تقبل الفوضى الناتجة عن إطعام الطفل وتجربته ولمسه لأطعمة مختلفة.

ذكّر المشاركين بأن لبن الأم لا يزال يمثل الغذاء الرئيسي للرضع في هذه الفئة العمرية، ويجب على الأمهات مواصلة الرضاعة وفقًا لاحتياجات الطفل، ليلاً ونهارًا.

7.2.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 45 الخاص بنصائح حول إدخال الأغذية التكميلية، الوارد في الصفحة 55، من دليل المشارك. واطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحات من 162 حتى 165 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

8.2.6 مناقشة جماعية: كميات الطعام وأنواعه

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 166 و167. وناقش معهم الأعمار التي يجب فيها تقديم الأغذية المختلفة للرضع لأول مرة، والسبب في ذلك. ومن المهم أن يتذكر المشاركون أن لبن الأم لا يزال يمثل مكونًا رئيسيًا في النظام الغذائي للطفل، ويجب أن تستمر تغذية الأطفال عند الطلب، ليلاً ونهارًا.

وفيما يتعلق بإدخال الأغذية التكميلية، الفت الانتباه إلى ما يلي:

- من المهم أن يحصل الطفل يوميًا على أغذية تمثل كل مجموعة غذائية. ومن الضروري توفير الطعام الحيواني المصدر، ويجب أن يكون موجودًا في طعام الطفل اليومي.
- يعد صفار البيض مصدرًا مفيدًا للبروتين بالنسبة للأطفال، كما يسهل تحضيره وتقديمه. ويمكن أن يكون طعامًا جيدًا يُقدَّم للطفل لأول مرة. ويمكن أن تبدأ الأم بهرس صفار البيض.
- يساعد إدخال اللحوم في وقت مبكر، أي في الوقت الذي قد يبدأ فيه مخزون الحديد لدى الطفل في النفاد، على ضمان وجود إمدادات ثابتة من الحديد والزنك، وكذلك البروتين. قومي بإعداد اللحم المهروس بإضافة قطرات من لبن الأم.
- يمكن إدخال العدس والبقول المجففة عندما يتراوح عُمر الأطفال بين ثمانية وعشرة أشهر. وهي أطعمة غنية بالبروتين، وتحتوي على الزنك، والفولات، والمنغنيز.
- يكون من الصعب قليلاً تحويل الفاصوليا الخضراء والبازلاء إلى طعام مهروس ناعم خال من الشوائب. لذا، يجب تمريرها عبر مصفاة ذات ثقوب رفيعة بعد طهيها، ومن ثمَّ مزجها جيدا لتتحول إلى هريس. وهي تُعتبر غذاء ممتازًا للأطفال. ويُوصَى بإدخال الفاصوليا الخضراء في النظام الغذائي للطفل بين الشهرين السادس والثامن. كما أنها تأتي في مرتبة متأخرة على قائمة الأغذية التي تسبب تفاعلاً تحسسيًا.
- يمكن للأمهات تقديم مهروس البطاطا المطبوخة جيدًا، أو البطاطا الحلوة، أو الكوسة، أو الجزر، أو الفواكه الناعمة مثل الموز، والبرقوق، والكمثرى الطرية، والمشمش، والمانجو، والتفاح. ويمكن إعطاء بعض تلك الفاكهة، مثل الموز والبرقوق، نيئة ومهروسة بإضافة بعض الماء أو لبن الأم، بينما يجب طهي البعض الآخر، مثل التفاح والكمثرى، قبل هرسها.

الكمية والتنوع

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحتين 168 و169 من الكتاب القلاب. ناقش كميات الطعام المُوصَى بها ونوعياته، واشرح الرسومات والنصائح المكتوبة.

نصائح بشأن إعداد الفواكه والخضروات

اغسلي جميع الفواكه والخضروات جيدًا. قشّري وأزيلي الأجزاء التي لا يستطيع الطفل مضغها أو هضمها، مثل الجلد، والنوى، والبذور، والدهن. وقطّعي الخضروات والفواكه إلى مكعبات متساوية الحجم حتى تُطهى بالتساوي.

يمكن ببساطة هرس الفواكه الناضجة مثل الموز، أو الخوخ، أو الأفوكادو بشوكة ثم خلطها مع الماء أو لبن الأم لإعداد فواكه مهروسة يمكن تقديمها على الفور، في حين يجب طهي الخضروات، وبعض أنواع الفواكه، واللحوم، والحبوب أولاً.

وضِّح أنه بالإضافة إلى الوجبات الرئيسية، يجب أن يتناول الأطفال وجبة أو وجبتين خفيفتين كل يوم. حيث تمتلئ بطون الأطفال الصغيرة بسرعة وتحرق الطاقة بسرعة، وتقدم الوجبات الخفيفة للجسم أثناء نموه المُغذِّيات والإماهة التي يحتاج إليها بين الوجبات. حدّدي وقت الوجبات الخفيفة بعناية. ويجب ألا تقدم الوجبة الخفيفة قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة. وأفضل الوجبات الخفيفة هي تلك التي تحتوي على القليل من السكر، والدهون، والملح. كما أن الفواكه والخضروات الطازجة، والأغذية التي تحتوي على الحبوب الكاملة والبروتين، تعد

خيـارات جيـدة. وإذا قُدِّمـت الأغذيـة المناسـبة في الوقـت المناسـب، يمكـن أن تـؤدي الوجبـات الخفيفـة دورًا مـهمًا في ضبـط شـعور الأطفـال بالجـوع وتعزيـز تغذيتهـم، حيـث تقـدم دفعـة مـن الطاقـة بين الوجبـات.

كيفية تحضير الطعام المهروس

أخبر المشاركين بأنك ستشرح لهم كيفية إعداد بعض الأطعمة المهروسة.

اطلب من المشاركين الانتقال إلى الصفحتين 170 و171 من الكتاب القلاب.

اشرح الخطوات التي تتطلب إعداد صفار البيض المهروس، والدجاج المهروس، والفاصوليا المهروسة.

أكِّد على:

- ضرورة سلق البيض جيدًا لتجنب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا؛
- ضرورة أن يأكل الرضيع، في هذا العمر، صفار البيض وليس بياضه؛
- ضرورة استخدام الدجاج الطازج واللحوم الطازجة، وليست المجمدة؛ لأن إذابة الثلج عن الدجاج واللحوم تضر بالأطفال؛
- ضرورة نقع البقوليات قبل طهيها للتخلص من السكريات المعقدة التي تسبب انتفاخ البطن وتكون صعبة الهضم.



9.2.6 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الصفحـات مـن 166 حتـى 171 مـن الكتـاب الـقلاب. ناقـش معهـم التعلـيمات الموجهـة إلى العامـلين الصحـيين المجتمعـيين الـواردة في الإطـار الأحمـر. وعندمـا ينتهـون مـن القـراءة، أجـب عـن أي أسـئلة.



10.2.6 مناقشة جماعية: التغذية الفعالة

اشرح أن التغذية الفعالة تعني تشجيع الرُّضَّع برفق -دون إكراه- على تناول الطعام.

وعلى الوالدين:

- الاستجابة لإشارات أو علامات الجوع بتقديم كميات كافية من الطعام المُغذي؛
- إطعام الرضَّع بأنفسهم؛
- تقديم طعام الرضيع في طبق خاص به حتى يتمكنوا من معرفة الكمية التي تم تناولها؛
- عدم إجبار الأطفال على تناول الطعام، بل تحويل وجبة الطعام إلى مناسبة مليئة بالسعادة، والحب، والمودة.

ويتعين على الوالدين العمل على تقليل مسببات تشتيت الانتباه أثناء تناول الطعام.

وإذا رفـض الرضـع بعـض الأطعمـة، يمكـن تجربـة توليفـات مـن الطعـام تكـون مختلفـة مـن حيـث المـذاق، والقـوام، وطـرق التشـجيع.

اطلـب مـن المشـاركين وصـف الطـرق التـي يشـجع بهـا الآبـاء والأمهـات في مجتمعاتهـم الرضـع على تنـاول الطعـام. قـل إن اللعـب، على غـرار «افتـح فمـك على آخـره للـسماح للطائـرة بالدخـول»، يفيـد في حمـل الأطفـال على قبـول الطعـام. كما يمكـن للآبـاء أو الأمهـات تـذوق الطعـام وإظهـار مـدى حبهـم لـه لتشـجيع الرضـع على محاكاتهـم.

وعـادة مـا يـؤدي التهديـد أو الغضـب مـن الأطفـال الذيـن يرفضـون تنـاول الطعـام إلى تنـاول الرضـع لكميـات أقـل. وعلى الوالديـن أن يجعلـوا أوقـات الطعـام فرصـة للاسـتمتاع والتعلـم، وأن يُـكثروا مـن التواصـل الـبصري.

وضـح أن التغذيـة الفعالـة تكتسـب أهميـة خاصـة عندمـا يكـون الطفـل مريضًـا. إذ نـادرًا مـا يرغـب الأطفـال في تنـاول الكـثير

من الطعام عندما يمرضون. لذا يلزم تشجيع الطفل برفق والتحلي بالصبر معه. وسوف تتحسّن شهيته عندما يتعافى. وإذا كان الرضيع يرضع، فيجب أن تقدم له الأم الرضاعة عدد مرات أكبر ولمدة أطول. كما يجب على الأسرة أن تقدم للرضيع المريض الأغذية المفضلة لديه عدد مرات أكبر وبكميات أقل إذا لزم الأمر. وعندما يستعيد الطفل شهيته، يجب أن يتناول وجبة إضافية كل يوم لمدة أسبوعين لتعويض أي فقد للوزن، وللوقاية من سوء التغذية.

11.2.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 172 و173 من الكتاب القلاب، وأجب عن أي أسئلة يطرحونها.

12.2.6 مناقشة جماعية: مشكلات الرضاعة/ التغذية:

اسأل المشاركين عن المشكلات التي يمكن أن تواجهها الأمهات المُرضِعات، وعندما يُطرح سؤال بشأن الأمهات العاملات، راجع طريقة اعتصار لبن الثدي وتخزينه على النحو الأفضل.

اسأل المشاركين عما يعتقدون أنه يشكل على الأرجح مشاكل تغذوية شائعة في صفوف الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد. اكتب إجاباتهم على اللوح الورقي القلاب قبل أن تقول إن التأخر في تقديم الأغذية التكميلية يمثل مشكلة شائعة. اسأل المشاركين عن النصائح التي سيقدمونها للأمهات حول هذه المشكلة، واستمع لإجاباتهم، ثم أضف أنه عليهم أن يوضحوا أن تقديم لبن الأم بعد سن ستة أشهر يمنح فقط نصف المُغذِّيات التي يحتاج إليها الرضع الأصحاء، وأنه من الضروري تعويض النصف الآخر من خلال تقديم طعام إضافي.

ثم أخبر المشاركين أن المرضى من الأطفال يميلون إلى فقدان الشهية وتناول كميات أقل من الطعام. لذا، يشكل إطعام الرضع أثناء اعتلال صحتهم مشكلة أخرى شائعة. اسأل المشاركين عما يجب للأمهات القيام به، ثم أكد أن التغذية الفعالة هي الحل الأفضل. أضف إلى ذلك أن إطعام الطفل المريض يتطلب الكثير من الصبر لضمان حصول الرضيع على كل احتياجاته الغذائية وللوقاية من سوء التغذية، وراجع مع المشاركين كيفية إطعام الأطفال وهم في حالة صحية متوعكة.

ناقش المشاكل الأخرى المحتمل ظهورها، ومن ذلك:

- قلة تنوع الأطعمة؛
- قلة كميات الأغذية؛
- عدم الإرضاع بصورة طبيعية؛
- إجبار الطفل على تناول الطعام؛
- عدم إعطاء ما يكفي من السوائل؛
- تقديم الطعام بقوام شديد السيولة.

أخبر المشاركين أنه بالرغم من أن نقص معرفة الأم وضعف ممارستها يمكن أن يؤديا إلى تقديم طعام غير ملائم من حيث القوام، فإن العوامل الاقتصادية يمكن أن يكون لها دور أيضًا في ذلك. فبعض الأسر مثلاً قد لا يتوافر لديها ما يكفي من الخضروات والبقول لإعداد حساء سميك. في هذه الحالة، لن يحصل الطفل على احتياجاته من الطاقة. وفي مثل تلك الظروف يمكن تحسين نوعية الغذاء بإضافة بعض البدائل مثل:

- ملعقة صغيرة من مسحوق الحليب، أو الحليب السائل؛
- الفول السوداني المُحمَّص والمطحون بنعومة، خاصة إذا كانت الوجبة مكوَّنة من الخضروات وحسب؛

- ملعقة من الزبد، أو زبد جوز الهند، أو السمن، أو الزيت؛
- إضافة مسحوق المُغذِّيات الزهيدة المقدار قبل الأكل مباشرة.

أخبر المشاركين بأنه يجب تذكير الأمهات بتجنب تقديم مشروبات الصودا، والعصائر المحلاة، والقهوة، والشاي، لأنها كلها تضر بالرضع. ويؤدي تناول الأطفال لمشروبات الصودا إلى فقد الكالسيوم الذي يحتاجون إليه لبناء العظام والأسنان، وقد يؤدي ارتفاع محتوى السكر إلى حدوث تجاويف بالأسنان، وتسوسها، وضعف صحة الفم. كما يجب تجنب الأطعمة السريعة غير الصحية، مثل رقائق البطاطس، والشوكولاتة، والحلوى. إذ يمكن أن يؤدي التناول المنتظم للأطعمة السريعة غير الصحية إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل السمنة، وما يصاحبها من مشاكل وجدانية ومشاكل تتعلق بتقدير الذات، إلى جانب مشكلات الحساسية، وفقر الدم، والإصابة بأمراض مزمنة في مراحل لاحقة من العمر. كما يؤدي ذلك أيضًا إلى الإصابة بالإمساك، ونقص الطاقة، وضعف الأداء المدرسي في المستقبل.

13.2.6 قراءة

اطلب من المشاركين أن يفتحوا الكتاب القلاب على الصفحات من 174 حتى 181. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين والواردة في الإطار الأحمر. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

14.2.6 لعب الأدوار 9: تقديم المشورة حول تغذية الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

ستحتاج إلى ما يلي:

استمارة تسجيل مُكبَّرة للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات.

أوراق مطوية تتضمن سيناريوهات الحالات السبع.

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بلعب الأدوار للتدرُّب على تقديم المشورة حول تغذية الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد.

استعرض معهم خطوات التواصل الجيد، وشدد على ضرورة استخدام مهارات التواصل الجيد في تقديم المشورة.

علّق استمارة التسجيل المكبرة، واطلب من المشاركين قراءة الإطار 46 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول تغذية الرضيع، الوارد في الصفحة 56 من دليل المشارك. وعند انتهائهم من القراءة، اشرح القسم الخاص بالتغذية في استمارة التسجيل المكبرة المُعلَّقة على الجدار، ووضِّح كيفية ملئه.

ذكِّر المشاركين بأن استمارة التسجيل مصممة لمساعدتهم على ملاحظة الموقف وفهمه. وبمجرد فهمهم للموقف، يجب أن يستخدموا الكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية والمشورة بناءً على التقييم.

وفي هذه الحالة، سيطبقون القسم الوارد في الكتاب القلاب عن الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد، مستخدمين الرسومات التوضيحية والنصائح المكتوبة المتعلقة بتقديم المشورة حول التغذية والإطعام.

أكِّد على أن تقديم المشورة حول التغذية يجب أن يشمل: تنوع الطعام وكميته، وعدد مرات تقديم الطعام. كما يجب أن يتضمن معلومات مخصصة لكل فئة عمرية وَفقًا للجدول الوارد في الكتاب القلاب.

أخبر المشاركين بأنهم سيتناوبون على القيام بدور العامل الصحي المجتمعي، بينما ستقوم أنت بدور الأم. هناك سبعة

سيناريوهات، لذلك إذا كان هناك أكثر من سبعة مشاركين، كرِّر السيناريو الذي تشعر أنه أقل نجاحًا، حتى يحظى كل مشارك بدور للمشاركة.

والمُيسِّر وحده هو مَن سيقرأ السيناريوهات. اطلب من كل مشارك أن يسحب ورقة، ثم يعيدها إليك دون أن يراها.

السيناريو 1

أنتِ أم الطفلة علا التي تبلغ من العمر ثمانية أشهر. وتحصل علا على رضاعة مطلقة. ولم تقدمي لها طعامًا آخر لأنك تعتقدين أنها أصغر من أن تأكل.

السيناريو 2

أنتِ فاطمة والدة قاسم الذي يبلغ من العمر 10 أشهر. وتريدين التوقف عن الرضاعة الآن لأن الطفل يستطيع أن يأكل. وكنتِ قد بدأتِ تقديم الطعام له عندما بلغ ستة أشهر. وتعطينه الخضروات، والدجاج، والجبن، والبيض، والفواكه، والخبز، وبعض الأرز. وتطعمينه بنفسك وتقدمين له الطعام في طبق خاص به في كل مرة. ويأكل مرتين في اليوم، وتقدمين له الطعام والرضاعة بالتناوب مرتين في اليوم. وتعطينه مقدار حوالي نصف كوب في كل وجبة، وتستخدمين زجاجة التغذية لإطعامه.

السيناريو 3

أنت أم الطفل كريم الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر. وتريدين التوقف عن الرضاعة لأنك تعملين وهو يستطيع أن يأكل الآن. وتعطينه ثلاث ملاعق طعام ثلاث مرات في اليوم. ويأكل الخضروات، والكبد، والزبادي، والفواكه، والبقول، والبيض. وتعطينه عصير الفواكه كوجبة خفيفة. وتطعمه والدتك عندما تكونين في العمل، وتقدم له طعامه في طبق خاص به.

السيناريو 4

أنت مؤمنة، أم صافي التي تبلغ من العمر تسعة أشهر، وتقومين بإرضاعها عند الطلب. وتقوم أختها، البالغة من العمر عشر سنوات، بإطعامها لأنك لا تملكين الوقت الكافي لذلك. وتأكل ثلاث مرات في اليوم. ولا تقدمين لها وجبات خفيفة. ولا تعرفين بالتحديد الكمية التي تتناولها.

السيناريو 5

أنت سناء، أم ياسمين البالغة من العمر 11 شهرًا. وأنت ترضعينها بقدر ما تريد. وتطعمينها بنفسك وتقدمين لها طعامها في طبق خاص بها. وتعطينها مقدار ثلثي كوب ثلاث مرات في اليوم، ووجبتين خفيفتين (زبادي وعصير فاكهة). وتعطينها الخضروات، والفواكه، والبقول، والجبن، والأسماك، واللحوم في بعض الأحيان. وترفض ياسمين تناول الكثير من أنواع الخضروات، ولا تعرفين كيف تتصرفين معها.

السيناريو 6

أنت ليلى، أم الطفل أحمد الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر. وأنت ترضعينه بقدر ما يريد. وتطعمينه بنفسك في طبق خاص به، وتعطينه مقدار نصف كوب من الطعام ثلاث مرات يوميًا. وتطعمينه الخضروات، والبقول، ولا تعطينه وجبات خفيفة.

السيناريو 7

أنتِ رقية، أم الطفل عمر الذي يبلغ من العمر 10 أشهر. وتوقفت عن إرضاعه عندما بلغ ستة أشهر وهو الوقت الذي بدأ فيه تناول الطعام. وتطعمينه بنفسك عندما تشعرين بأنه جائع. وتعطينه البسكويت والحليب مع الشاي مضافًا إليه الكثير من السكر لإمداده بالطاقة. ولا تقيسين الكميات التي تعطينها له.

ملاحظة للسيناريو 7

في نهايـة تدريـب لعـب الأدوار، أخبر المشـاركين أن هـذه الأم توقفـت عـن الرضاعـة منـذ أربعـة أشـهر، لـذا سـيكون مـن غير المرجَّـح أن تكـون قـادرة على اسـتئناف الرضاعـة (إعـادة الإرضـاع). ومـع ذلـك، سـتحتاج إلى تقديـم المشـورة لهـا حـول أهميـة الرضاعـة لأنهـا قـد تنجـب طـفلاً آخـر في المسـتقبل وستسـتفيد مـن المعلومـات.

في نهايـة كل تدريـب مـن تدريبـات لعـب الأدوار، اطلـب مـن المشـاركين مناقشـة مـا إذا كان زميلهـم الـذي قـام بـدور العامـل الصحـي المجتمعـي قـد:

- استخدم مهارات التواصُل الجيد، وإذا كان الأمر كذلك، كيف فعل ذلك؛
- استخدم استمارة التسجيل بشكل صحيح؛
- ملأ استمارة التسجيل بشكل صحيح (سيحتاج المشاركون إلى إظهار كيفية ملئهم الاستمارة)؛
- تعرَّف على مشاكل التغذية؛
- استخدم الكتاب القلاب بشكل صحيح؛
- قدَّم معلومات ملائمة للموقف؛
- هل من المحتمل أن تتبع الأم النصيحة التي أسداها العامل الصحي المجتمعي إليها (هل فَهِمَت ما قاله أم لا، وهل كان العامل مقنعًا؟) (التحقق من فهم الأم).



الجلسة 24:
تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم عناصر النظافة الأساسية للرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- تقديم المشورة للأمهات بشأن النظافة الصحية لهذه الفئة العمرية.

1.3.6 مناقشة جماعية: الاعتناء بنظافة الرضيع الشخصية

استعرض مع المشاركين ما تعلموه بشأن العناية بالنظافة الشخصية للرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر (أهمية النظافة الشخصية الأساسية وعناصرها). وأكِّد على أن النظافة الشخصية الجيدة ضرورية للغاية إذا ما أردنا الإبقاء على الرضع معافين وسعداء، وخالين من العدوى الجلدية وغير ذلك من أمراض. ووضِّح ضرورة القيام بتدابير النظافة الشخصية بلطف وعناية.

أخبر المشاركين بأن العناصر التسعة للنظافة الشخصية التي تعلموها للرضع الأصغر سنًا تنطبق على هذه الفئة العمرية أيضا، ولكن يُضاف إليها عنصر عاشر يتعلق بنظافة الفم. اذكر العناصر.

1. الاستحمام
2. الحفاظ على نظافة مناطق الوجه، والرقبة، واليدين، والحفاض
3. تقليم الأظافر
4. الحفاظ على عدم انسداد الأنف
5. تنظيف عيني الطفل
6. تنظيف أُذني الطفل
7. الحفاظ على نظافة ملابس الطفل
8. الحفاظ على نظافة ألعاب الطفل
9. تنظيف المنزل
10. العناية بصحة الفم/ الأسنان.

استعرض كل عنصر بالتفصيل، مشيرًا إلى الصفحات من 182 حتى 187 من الكتاب القلاب. وعند استعراض العنصر الأول، قل إنه بالرغم من أن الحوض المُستخدَم للاستحمام يكون أكبر لإتاحة مكان إضافي للألعاب، فإن الأطفال في هذا العمر ليسوا مستعدين بعد للاستحمام في حوض استحمام الكبار.

وعندما تنتهي من استعراض العناصر التسعة الأولى، اطلب من المشاركين الانتقال إلى الصفحتين 188 و189 من الكتاب القلاب

اللـتين تتنـاولان نظافـة الفـم والأسـنان. اشرح خطـوات العنايـة بنظافـة الفـم والأسـنان بينما يتابـع المشـاركون الرسـوم التوضيحية.

سـتظهر السِّـنُّ الأولى عنـد معظـم الأطفـال عندمـا تتراوح أعمارهـم بين سـتة وثمانيـة أشـهر، بالرغـم مـن ظهورهـا لـدى البعـض في وقـت سـابق، ولـدى البعـض الآخـر في وقـت لاحـق. أخبر المشـاركين بأنـه يجـب على الأمهـات عـدم الانتظـار حتـى ظهـور السـن الأولى حتـى يبـدأن في تنظيـف لثـة أطفالهـن. وسـوف يسـاعد الاعـتماد المبكـر لهـذه الممارسـة الصحيـة على الوقايـة مـن تسـوُّس الأسـنان في المسـتقبل. وعنـد ظهـور أول سـن، يجـب ألا تسـتخدم الأمهـات فرشـاة الأسـنان لتنظيفهـا.

2.3.6 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الإطـار 47 الخـاص بعنـاصر العنايـة بالنظافـة الشـخصية 1، والإطـار 48 الخـاص بعنـاصر العنايـة بالنظافـة الشـخصية 2، الواردَيـن في الصفحـتين 57 و 58، مـن دليـل المشـارك، والصفحـات مـن 182 حتـى 189 مـن الكتـاب الـقلاب. وناقـش الرسـوم التوضيحيـة والنصائـح المقدَّمـة، وكيفيـة توظيفهـا عنـد تقديـم المشـورة. وعنـد الانتهـاء مـن القـراءة، أجـب عـن أي أسـئلة يطرحهـا المشـاركون.

3.3.6 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية للرضع

راجـع الخطـوات الأربـع للتواصـل الجيـد والمهـارات المقابلـة لـكل خطـوة، ثـم ذكّـر المشـاركين بأنهـم كي يقدمـوا المشـورة حـول النظافـة الشـخصية يجـب أن يتفهمـوا الموقـف مـن خلال الملاحظـة واسـتخدام اسـتمارة التسـجيل لتوجيـه الأسـئلة، ومـن ثـمَّ تقديـم النصـح اسـتنادًا للمعلومـات الـواردة في الكتـاب الـقلاب.

اطلـب منهـم إلقـاء نظـرة على اسـتمارة التسـجيل، واشرح لهـم كيفيـة مـلء القسـم الخـاص بالنظافـة الشـخصية. اسـتعرض معهـم العمـود المذكـور فيـه مـا يجـب ملاحظتـه:

- ما إذا كان وجه الطفل، وعيناه، وأنفه، وأذناه نظيفة؛
- ما إذا كانت هناك رائحة تنبعث من الحفاض؛
- حالة أظافر الطفل؛
- ما إذا كانت ملابسه متسخة؛
- ما إذا كانت الألعاب تبدو نظيفة أم لا؛
- ما إذا كان المنزل يبدو أنيقًا ومرتبًا.

إذا بـدا كل شيء على مـا يـرام، فيجـب أن يثنـوا على الأم قبـل اسـتخدام اسـتمارة التسـجيل مـرةً أخـرى، وتوجيـه أسـئلة لهـا حـول كيفيـة وتوقيـت:

- تحميم الطفل؛
- تنظيف وجه الطفل، وعينيه، وأنفه، وأذنيه؛
- تقليم الأظافر
- تغيير الحفاضات؛
- تنظيف ملابس الطفل؛
- تنظيف الألعاب؛
- تنظيف المنزل؛
- الاهتمام بنظافة فم الطفل وأسنانه.

ويتيح السؤال عن توقيت وكيفية اعتناء الأم بالنظافة الشخصية للرضيع فرصة للثناء عليها، وإضافة المزيد إلى معلوماتها، وزيادة ثقتها بنفسها. كما يتيح للعاملين الصحيين المجتمعيين سد أي ثغرات لاحظوها أثناء فهمهم للموقف، واستخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية.

وإذا لاحظ العامل الصحي المجتمعي أن الأم لا تعتني بالنظافة الشخصية لطفلها، فيجب أن يقدم لها المشورة حول أهمية العناية بالنظافة الشخصية، ويستعرض معها العناصر الأحد عشر التي تتضمنها.

ذكِّر المشاركين بأن المشورة لا تعني مجرد قراءة/ ترديد محتويات الكتاب القلاب، ولكنها تتطلب منهم تقييم الموقف، وتقديم المعلومات المتعلقة بالمشكلات التي حددوها وحسب.

4.3.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 49 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن العناية بالنظافة الشخصية، الوارد في الصفحة 59 من دليل المشارك. وعند انتهائهم من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحونها.

5.3.6 تمرين الأسئلة السريعة (4): مراجعة كيفية تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية للرضيع

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بإجراء تدريب لمراجعة كيفية تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية لهذه الفئة العُمرية. أخبر المشاركين بأنك ستقرأ عليهم عبارة ما وسيتبادلون الأدوار لبيان ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة. وسيُعطى كل منهم مدة قصيرة للرد. وإذا كان المشارك غير قادر على الإجابة، انتقل إلى المشارك التالي. وترد الأسئلة والإجابات في الجدول المبين أدناه.

السؤال	«صواب» أم «خطأ»
تحميم الرضَّع يوميًا يقي من جفاف البشرة	خطأ
الشامبو مفيد لغسل شعر الأطفال	خطأ
تنظيف الألعاب بانتظام يمنع انتقال الجراثيم إلى الرضع	صواب
الملابس المتسخة لا تؤذي الرضع لأنها تغطي الجسم وحسب	خطأ
لا يجب تقليم الأظافر بانتظام لتجنب إيذاء الطفل	خطأ
يجب البدء في تنظيف الفم عند ظهور أول سن	خطأ
الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد كبار بما يكفي لتركهم بمفردهم في الحمام	خطأ
يجب تغيير الحفاضات بانتظام لتجنب الطفح الجلدي الناتج عن استخدامها	صواب
نظافة الرضيع هي ما يهم وليس نظافة المنزل	خطأ
يجب تنظيف الأسنان دائمًا بفرشاة الأسنان	خطأ
يجب ألا يُترك الأطفال مطلقًا دون مراقبة في الحمام	صواب
غسل أيدي الأطفال أمر مهم لأنهم يضعون أيديهم في فمهم، وهو ما قد ينقل إليهم الجراثيم	صواب



الجلسة 25:
تقديم المشورة حول معالم النماء الرئيسية

مدة الجلسة
ساعتان

جهِّز
- نسخًا مطوية من السيناريوهات الأربعة لتدريب لعب الأدوار 10 حول تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية
- دُمية

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم أهمية متابعة معالم النَّماء الرئيسية لدى الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- التعرف على معالم النَّماء الرئيسية للرضع التي تنطبق على تلك الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للآباء بشأن تلك المعالم.

1.4.6 مناقشة جماعية: أهمية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية لدى الطفل

استعرض مع المشاركين أهمية إلمام الآباء بمعالم النَّماء الرئيسية التي يتعين عليهم ملاحظتها على الطفل، والوقت المناسب لذلك، وكيفية تعرفهم عليها. والفت الانتباه إلى أن هذه الفئة العمرية تنقسم إلى مجموعتين، من عمر ستة إلى تسعة أشهر، ومن عمر تسعة أشهر إلى 12 شهرًا، أي عند ظهور معالم نماء رئيسية جديدة.

2.4.6 مناقشة جماعية: معالم النَّماء الرئيسية

اطلب من المشاركين أن يفتحوا الصفحتين 190 و191 من الكتاب القلّاب، وراجع معهم المعالم الرئيسية. وعند الضرورة، استخدم الدمية للتوضيح. أكِّد على أن هذه الفئة العمرية تشمل الرضع الذين أكملوا ستة أشهر ولم يكملوا سنة واحدة بعد، ووضح أنه يجب على العامل الصحي المجتمعي تقديم المشورة للآباء والأمهات حول المعالم الرئيسية التي يجب عليهم ملاحظتها أثناء نمو طفلهم حتى يتمكنوا من تقديم التحفيز المناسب أثناء اللعب مع الرضيع. وإذا حدث تأخير في وصول الطفل إلى المعالم الرئيسية المشار إليها، فيجب حينئذٍ أن يَنْصح العامل الصحي المجتمعي الأسرة باستشارة الطبيب.

اسأل المشاركين عن المعالم الرئيسية التي تنطبق على مختلف المراحل: على سبيل المثال، اسأل عن المعالم الرئيسية التي يجب ملاحظتها على رضيع يبلغ من العمر عشرة أشهر. استمع إليهم، وقل لهم إنهم يجب أن يتحققوا من المعالم الرئيسية لطفل عمره تسعة أشهر.

ثم اسأل عما سيلاحظونه على طفل عمره ثمانية أشهر. استمع إليهم، ثم قل إنهم يجب أن يبحثوا عن المعالم الرئيسية لطفل عمره سبعة أشهر.

ويُعتبر التسنين أحد معالم النَّماء التي يمر بها الأطفال في هذه الفئة العمرية، وغالبًا ما تظهر عليهم علامات الضيق بسبب الألم الذي يحدث في الأيام الثلاثة إلى الخمسة السابقة لشق السن. اسأل المشاركين عن أعراض التسنين التي لاحظوها لدى الرضع. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن تذكر في النهاية أن البكاء، والتهيج، وفقدان الشهية، وفرك الأذنين،

والمضغ المفرط، وسيلان اللعاب، والحرارة الطفيفة كثيرًا ما تصاحب ظهور السن. وبصرف النظر عن درجة الحرارة، التي من المرجَّح أن تكون بسبب العدوى وليس التسنين، فإن ذلك كله يُعد استجابة للألم الذي يسببه التسنين.

اطلب من المشاركين الانتقال إلى الصفحة 192 من الكتاب القلاب، التي توضح طرق تخفيف آلام التسنين.

استعرض مع المشاركين تأثير النشاط البدني، والنوم الجيد، والحد من أوقات الخمول على النمو والنماء بأسلوب صحي. وأخبرهم أن النشاط البدني يمكن أن يأخذ شكل الزحف والوقوف استنادًا إلى شيء ما.

يجب أن ينام الأطفال في هذا العمر ما بين 12 و16 ساعة يوميًا، متضمنة أوقات القيلولة. أضف أنه يجب على الوالدين اللعب والتواصل مع الطفل كلما أمكن، والحد من أوقات الخمول إلى أقصى حد ممكن.

3.4.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 190 حتى 195 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون. ووضِّح أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر.

4.4.6 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول نماء الرضَّع

أخبر المشاركين بأنه من الضروري أن يدرك الوالدان أهمية متابعة نماء أطفالهم من خلال رصد معالم النَّماء الرئيسية والتعرف على حالات التأخر.

اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية. استمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح ضرورة ملاحظة ما يمكن للطفل القيام به: على سبيل المثال، يمكن للمشاركين أن يطلبوا إذن الوالدين لوضع الرضيع في وضعية الجلوس، أو معرفة ما إذا كان يمكنه الوقوف مستندًا إلى شيء ما، أو مداعبته عن طريق إخفاء الوجه ثم إظهاره فجأة (بِخّ). وذكِّرهم بأنه يجب تسجيل ملاحظاتهم في القسم المناسب في استمارة التسجيل.

وعندما يقدمون المشورة للأسر بشأن علامات النَّماء الرئيسية، سيتناولون الآتي:

- أهمية نماء الطفل؛
- المقصود بمعالم النَّماء الرئيسية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- ما هي معالم النَّماء الرئيسية لهذا العمر، ولماذا يجب على الوالدين استشارة الطبيب إذا كان هناك تأخر في ظهورها؛
- ساعات النوم؛
- التمارين البدنية؛
- عدد ساعات الخمول التي يمضيها الطفل كل يوم.

يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين استخدام الكتاب القلاب لتعليم الوالدين كيفية تحديد تلك المعالم الرئيسية.

5.4.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 50 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، الوارد في الصفحة 60 من دليل المشارك.



6.4.6 لعب الأدوار 10: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للرضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

ستحتاج إلى النسخ المطوية من سيناريوهات الحالات الأربع لتدريب لعب الأدوار رقم 10.

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بلعب الأدوار للتدرُّب على تقديم المشورة للوالدين حول معالم النَّماء الرئيسية.

وسيتناوب المشاركون الأدوار لتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي. هناك أربعة سيناريوهات، فإذا كان هناك ثمانية أعضاء في المجموعة سيتم تمثيل كل دور مرتين. أعطِ ورقة السيناريو لكل مشارك على حدة قبل أن يحين عليه الدور لتمثيل دور العامل الصحي المجتمعي. وأخبر المشاركين بأن لديهم المعلومات اللازمة لتقديم المشورة للأم حول معالم النَّماء الرئيسية في الورقة المطوية. ويتعين عليهم قراءتها بعناية، وأن يستخدموا الكتاب القلاب لتقديم المشورة للأم. ستقوم أنت بدور الأم طوال لعب الأدوار.

وأكِّد على ضرورة استخدام مهارات التواصل الجيدة والكتاب القلاب أثناء تقديم المشورة.

وبعد كل سيناريو، يتعين إدراج النقاط التي كان على العامل الصحي المجتمعي تقديم المشورة حولها، والأسئلة التي يجب للمشاركين الملاحظين للمشهد أن يجيبوا عنها. ومن النقاط المهمة التي يتعين على المُيسِّر التحقق منها ما إذا كان المشارك الذي يؤدي دور العامل الصحي المجتمعي قد قدَّم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية المتناسبة مع العمر.

سيناريو الحالة 1. رباب

رباب طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر. ولاحظت عليها معالم النماء الرئيسية، وخلصت إلى أنها حققت جميع المعالم الرئيسية المتفقة مع عمرها.

قدِّم المشورة للوالدين حول أهمية متابعة تلك المعالم، وماهية تلك المعالم بالنسبة لطفلة في عمر ابنتهم. وقدِّم المشورة حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول، وتأثير ذلك على نماء الطفلة.

ملاحظات للميسر: كان يتعين على العامل الصحي المجتمعي ملاحظة معالم النَّماء الرئيسية لسن سبعة أشهر،

وكان يجب عليه تقديم المشورة حول ما يلي:

- أهمية نماء الطفل؛
- ما هي معالم النَّماء الرئيسية التي تتفق مع هذه المرحلة العمرية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- أهمية النشاط البدني بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية ساعات النوم بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية تقليل وقت الخمول إلى أدنى حد.

في نهاية تدريب لعب الأدوار، وجِّه الأسئلة التالية إلى المشاركين الذين تابعوا التدريب:

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات تواصل جيدة؟
- هل قيَّم الوضع بدقة وقدَّم المعلومات اللازمة؟
- هل قدم المشورة حول أهمية نماء الطفل؟
- هل شرح معالم النَّماء الرئيسية المقابلة لهذه الفئة العمرية؟
- هل لاحظ أي مشاكل؟

- هل قدم المشورة حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول؟
- هل قدم النصائح والمعلومات اللازمة والصحيحة؟
- هل تحقق من فهم الوالدين؟
- هل كان مقنعًا؟ وهل سيتبع الوالدان معلوماته ونصائحه؟

سيناريو الحالة 2. منير

منير طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر. ولاحظت أنه يجلس دون الاستناد لشيء، ولكنه لا يزحف، ولا يستطيع الوقوف مستندًا لشيء يدعمه. قدِّم المشورة للوالدين حول تأخر تلك المعالم الرئيسية. وقدم المشورة كذلك حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول، وتأثير ذلك على نماء الطفل.

ملاحظات للميسر: كان يجب على العامل الصحي المجتمعي أن يلاحظ معالم النَّماء الرئيسية الخاصة بسن تسعة أشهر.

وكان يجب عليه تقديم المشورة حول ما يلي:

- أهمية نماء الطفل؛
- معالم النَّماء الرئيسية التي تتفق مع هذه المرحلة العمرية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- أهمية النشاط البدني بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية ساعات النوم بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية تقليل وقت الخمول إلى أدنى حد؛
- لماذا يجب على الأسرة استشارة الطبيب.

في نهاية لعب الأدوار، وجِّه الأسئلة التالية للمشاركين الذين تابعوا التدريب:

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات تواصل جيدة؟
- هل قيَّم الوضع بدقة وقدَّم المعلومات اللازمة؟
- هل قدم المشورة حول أهمية نماء الطفل؟
- هل شرح معالم النَّماء الرئيسية المقابلة لتلك الفئة العمرية؟
- هل لاحظ أي مشاكل؟
- هل قدم المشورة حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول؟
- هل قدم النصائح والمعلومات اللازمة والصحيحة؟
- هل تحقق من فهم الوالدين؟
- هل كان مقنعًا، وهل سيقبل الوالدان استشارة الطبيب؟

سيناريو الحالة 3: فايزة

فايزة طفلة عمرها سبعة أشهر. ولاحظت وجود معالم النماء الرئيسية لديها، وخلصت إلى أنها حققت جميع المعالم الرئيسية المتفقة مع عمرها. قدِّم المشورة للوالدين وَفقًا لذلك.

ملاحظات للميسر: كان يجب على العامل الصحي المجتمعي أن يلاحظ معالم النَّماء الرئيسية لسن سبعة أشهر،

وكان يجب عليه تقديم المشورة حول ما يلي:

- أهمية نماء الطفل؛

- معالم النَّماء الرئيسية التي تتفق مع هذه المرحلة العمرية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- أهمية النشاط البدني بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية ساعات النوم بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية تقليل وقت الخمول إلى أدنى حد.

في نهاية لعب الأدوار، وجِّه الأسئلة التالية للمشاركين الذين تابعوا التدريب:

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات تواصل جيدة؟
- هل قيّم الوضع بدقة وقدم المعلومات اللازمة؟
- هل قدم المشورة حول أهمية نماء الطفل؟
- هل شرح معالم النَّماء الرئيسية المقابلة لتلك الفئة العمرية؟
- هل قدم المشورة حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول؟
- هل تحقق من فهم الوالدين؟

سيناريو 4: زين الدين

زين الدين طفل عمره تسعة أشهر. ولاحظته ووجدت أنه لا يزحف، ولا يمكنه الوقوف مستندًا لشيء. ويحب أن يلعب لعبة "إخفاء الوجه ثم إظهاره فجأة" (بِخّ)، ويشير إلى الأشياء بإصبعه. قدم المشورة للوالدين حول معالم النماء الرئيسية.

ملاحظات للميسر: كان يجب على العامل الصحي المجتمعي أن يلاحظ معالم النَّماء الرئيسية لسن تسعة أشهر.

وكان يجب عليه تقديم المشورة حول ما يلي:

- أهمية نماء الطفل؛
- معالم النَّماء الرئيسية التي تتفق مع هذه المرحلة العمرية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- أهمية النشاط البدني بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية ساعات النوم بالنسبة لنماء الطفل؛
- أهمية تقليل وقت الخمول إلى أدنى حد؛
- لماذا يجب على الأسرة استشارة الطبيب.

في نهاية لعب الأدوار، وجِّه الأسئلة التالية للمشاركين الذين تابعوا التدريب:

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات تواصل جيدة؟
- هل قيّم الوضع بدقة وقدم المعلومات اللازمة؟
- هل قدم المشورة حول أهمية نماء الطفل؟
- هل شرح معالم النَّماء الرئيسية المقابلة لتلك الفئة العمرية؟
- هل لاحظ أي مشاكل؟
- هل قدم المشورة حول أهمية النشاط البدني، وساعات النوم، وتقليل وقت الخمول؟
- هل قدم النصائح والمعلومات اللازمة والصحيحة؟
- هل تحقق من فهم الوالدين؟
- هل كان مقنعًا، وهل سيقبل الوالدان استشارة الطبيب؟



الجلسة 26:
المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز

- عينة من ألعاب مأخوذة من الأغراض المنزلية المعتادة الآمنة والنظيفة التي يمكن للأطفال اللعب بها بأمان، بالإضافة إلى أشياء أخرى من المعتاد وجودها في المنازل، وغير ذلك من ألعاب بسيطة.
- نسخًا مطوية من سيناريوهات الحالات الثلاث لتدريب لعب الأدوار رقم 11.
- مقطع فيديو رقم 20: اللعب والتواصل مع الأطفال من عُمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد.
- مقطع فيديو 21: تاندي: تمرين الفيديو.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- تقييم كيفية لعب الوالدين وتواصلهم مع أطفالهم من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- تحديد المشكلات في لعبهم وتواصلهم مع أطفالهم الرضع؛
- تقديم المشورة للآباء والأمهات حول كيفية اللعب والتواصل؛
- مساعدة الوالدين على تعزيز المهارات الأساسية لمقدمي الرعاية، وتحسين قدراتهم على الاستجابة لاحتياجات الطفل.

1.5.6 مناقشة جماعية: ما المقصود بالعناية من أجل النماء؟

اسأل المشاركين عن المقصود بالعناية من أجل النماء. واستمع لآرائهم قبل إبلاغهم بأن العناية من أجل النماء تعني مشاركة الأسرة في تحفيز النَّماء النفسي لأطفالهم. اسأل عن الشكل الذي يجب أن تتخذه تلك المشاركة، واستمع مرة أخرى لإجاباتهم، ثم اذكر في النهاية أن ذلك يشمل اللعب والتواصل مع الأطفال منذ الولادة. ويجب أن يكون هذا هو دور جميع أفراد الأسرة.

أكد للمشاركين بأن طريقة لعب الوالدين وتواصلهم مع طفلهم ستختلف وَفقًا لمرحلة النَّماء وعُمر الطفل.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 196 و197 ثم تابع وأنت توضح الرسومات والنصائح المكتوبة.

الرُّضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أشهر

اللعب: في هذا العُمر، يستمتع الأطفال بإحداث ضوضاء عن طريق ضرب الأشياء أو الدق عليها. وقد يمررون الأشياء من يد إلى يد وإلى أفراد الأسرة الآخرين، ويسقطونها من أيديهم ليروا أين تسقط، وما الأصوات التي تصدر عنها، وإذا كان أحدهم سيلتقطها، قد يسبب ذلك إحباطًا للآباء المنشغلين. لذلك، يجب أن يتحلى مقدمو الرعاية بمزيد من الصبر إذا وضح لهم أن الطفل يتعلم من خلال اللعب، فهو يقوم بتجربة كيفية إسقاط الأشياء، وما هي الضوضاء الصادرة عن ذلك، وكيف يمكنه استخدام ذراعيه لدفع الأشياء من على الطاولة.

التواصل: يستطيع الرضع أن يتعلموا مما يقوله لهم أفراد الأسرة، حتى قبل أن ينطقوا الكلمات. فهم يلاحظون متى يكون الناس غاضبين، وقد يشعرون بالضيق جرّاء ذلك. ويحاكي الرضع أصوات وتصرفات الأشقاء الأكبر سنًا والبالغين. كما أنهم يحبون أن يستجيب الآخرون للأصوات التي يصدرونها، وأن يظهروا اهتمامًا بالأشياء التي تهمهم. ويتعرف الأطفال الصغار على أسمائهم قبل أن يتمكنوا من قولها، ويساعد سماعهم لأسمائهم على تحديد مكانهم داخل الأسرة. وعندما يسمع الأطفال أسماءهم، يستديرون إلى مصدر الصوت، ويحاولون الوصول إلى الشخص الذي يناديهم.

الرضّع من عمر تسعة أشهر حتى عام واحد

اللعب: هو الطريقة التي يبدأ بها الأطفال استكشاف أنفسهم والعالم من حولهم. حيث يكتشفون أصابع أقدامهم، ويمضون أوقاتهم في التعلق بها. وينبهرون عندما يُخفي الوالدان الأشياء - تحت قطعة قماش على سبيل المثال - ويظهرونها لهم مرة أخرى بكشف القماش عنها. وعندما يختفي أحد الوالدين خلف شجرة، يفرحون لرؤيته من جديد، ويستمتعون بألعاب مثل لعبة "بِخّ"، ويبتهجون بلعبة «الاختباء» (حيث يتساءل الوالدان «أين ذهبت؟») ثم يتم «العثور على» الطفل.

التواصل: على الرغم من أن الرضع لا يستطيعون التحدث بعد، فإنهم يفهمون شيئًا مما يقال حولهم، ويسمعون أسماء الأشياء ويبتهجون لمعرفة ماهيتها، ويبدؤون في ربط كلمة «طائر» بالطائر الموجود على الشجرة، وكلمة «أنف» بأنوفهم. ويجب على جميع أفراد الأسرة اللعب مع الرضيع حيث يمكنهم مشاركته في ألعاب يدوية بسيطة، مثل لعبة التلويح باليدين وقول «وداعًا»، والتصفيق على إيقاع الموسيقى.



2.5.6 فيديو توضيحي: اللعب والتواصل مع الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

ضع مقطع فيديو 20 (01:55 دقيقة) على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة(CD)، لبيان اللعب والتواصل مع الأطفال من عُمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد.

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول اللعب والتواصل مع الرضع في هذه الفئة العمرية.

اعرض الفيديو، وبعد انتهاء عرض الفيلم، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.



3.5.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 51 الخاص بالعناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)، الوارد في الصفحة 61 من دليل المشارك، والصفحتين 196 و197 من الكتاب القلاب. وعندما ينتهون من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحونها.



4.5.6 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء

وضِّح ما يلي: يمكن أن يساعد العاملون الصحيون المجتمعيون الأمهات وسائر مقدمي الرعاية على الاستجابة بعناية لأطفالهم الرضع حين يبدؤون التواصل. اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة للوالدين بشأن العناية من أجل النماء، وذلك في ضوء ما تعلموه بالفعل. استمع إلى أقوالهم، ثم وضِّح لهم أن العاملين الصحيين المجتمعيين يمكنهم مساعدة مقدمي الرعاية على تشجيع الجهود التي يبذلها أطفالهم للتعلُّم من خلال الاستجابة لكلماتهم وأفعالهم عبر إصدار الأصوات، والإيماءات، واللمسات، والكلمات. كما يجب أن يتحلوا بالصبر، وألا يغضبوا بسبب الضوضاء التي قد يسببها الطفل.

وسيقدم المشاركون، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، المشورة حول العناية من أجل النماء باستخدام استمارة التسجيل لفهم الموقف (السؤال والملاحظة)، والكتاب القلاب كمصدر للمعلومات المهمة في هذا الشأن. وخلال الزيارات المنزلية سيتمكنون من استخدام الألعاب الخاصة بالطفل لتوضيح أساليب اللعب.



5.5.6 تمرين الفيديو: تاندي، دراسة حالة

ضع مقطع الفيديو 21 (05:31 دقيقة) على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة(CD)، تاندي: دراسة حالة.

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون دراسة حالة عن تاندي البالغة من العمر 5 أشهر. ويجب أن يحددوا المشكلات المتعلقة باللعب والتواصل التي شاهدوها في مقطع الفيديو. عند انتهاء الفيديو، أجرِ مناقشة جماعية حول ما شاهدوه.



6.5.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 52 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء، الوارد في الصفحة 62 من دليل المشارك.



7.5.6 لعب الأدوار (11): تقديم المشورة حول الرعاية من أجل نَماء الرضَّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد

ستحتاج إلى ما يلي:

مجموعة مختارة من الأغراض المنزلية الشائعة التي يمكن للأطفال اللعب بها بأمان؛

ألعاب أخرى بسيطة؛

نسخ مطوية من سيناريوهات الحالات الثلاثة للعب الأدوار رقم 11.

أخبر المشاركين بأنهم سيقومون بلعب الأدوار لتدريب الوالدين على كيفية اللعب والتواصل مع أطفالهم الرضع. وكالمعتاد، سوف يستخدمون استمارة التسجيل لمساعدتهم في فهم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية حسب الحاجة. راجع القسم الخاص بالعناية من أجل النماء في استمارة التسجيل، وأضف أنه في أثناء تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء، يجب أن توضح للوالدين ما يلي:

- أهمية اللعب والتواصل مع الأطفال لتحفيز نمائهم النفسي والاجتماعي؛
- كيفية القيام بذلك؛
- كيف تختلف فعالية اللعب والتواصل بحسب عُمر الطفل.

ذكِّر المشاركين باستخدام مهارات التواصل الجيدة لتقديم المشورة للوالدين.

اطلب من المشارك المختار سحب نسخة مطوية وإعادتها لك دون رؤيتها. وفي كل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة الواردة أدناه، سيؤدي المشارك دور العامل الصحي المجتمعي، وسيؤدي المُيسِّر دور الأم. كرر السيناريوهات مع مشارك آخر يؤدي دور العامل الصحي المجتمعي إذا رأيتَ ضرورةً لذلك. وفي نهاية كل تدريب من تدريبات لعب الأدوار، اطلب من المشاركين مناقشة ما إذا كان زميلهم الذي قام بدور العامل الصحي المجتمعي قد:

- استخدم مهارات تواصُل جيدة، وإذا كان الأمر كذلك، كيف فعل ذلك؛

- استخدم استمارة التسجيل بشكل صحيح؛
- قيَّم الوضع بدقة وحدَّد المشاكل؛
- استخدم الكتاب القلاب بشكل صحيح؛
- قدَّم المشورة حول أهمية العناية من أجل النماء؛
- قدَّم معلومات ملائمة للموقف؛

هل من المحتمل أن تتبع الأم النصيحة التي أسداها العامل الصحي المجتمعي إليها؟ (هل فَهِمَت ما قاله أم لا؟ وهل كان العامل مقنعًا؟)

سيناريو 1. بلال

أنتِ أم بلال، الصبي الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر. وأنتِ منشغلة للغاية لدرجة أنك لا تلعبين مع ابنك. وهو يصدر الكثير من الضوضاء التي تثير إحباطك. وأثناء زيارة العامل الصحي المجتمعي، يدق بلال على صندوق معدني وتصرخين في وجهه. وعندما تطعمينه لا تحاولين التواصل معه لأنه صغير جدًا. وتعتقد أن مجهود اللعب والتواصل معه سيكون مضيعة للوقت.

سيناريو 2. حبيبة

أنتِ أم حبيبة، الفتاة البالغة من العمر ستة أشهر. أنت تغنين لحبيبة، وكثيرًا ما تلعبين معها برمي الكرة. وبالرغم من أنكِ تحبين اللعب مع ابنتك، لكنك لا تعرفين ألعابًا أخرى. وتغنين بانتظام لحبيبة حتى تغط في النوم.

سيناريو 3. روضة

أنتِ أم روضة، الفتاة البالغة من العمر تسعة أشهر. أنتِ تتكلمين مع روضة وتعلمينها أسماء الأشياء حتى بدأت تشير إليها. وتلعبين معها أيضًا لعبة "بِخّ"، التي تستمتع بها كثيرًا. وفي الآونة الأخيرة، بدأت روضة تدق على الأشياء وتُسبب الكثير من الضوضاء، وهو ما يثير انزعاجك.



الجلسة 27:
المكون 5: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات

مدة الجلسة
30 دقيقة

المُعدَّات
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:

- أنواع الحوادث التي تشكل خطرًا على الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- كيفية تقديم النصح للوالدين للوقاية من وقوع مثل تلك الحوادث في المنزل.

1.6.6 مناقشة جماعية: الوقاية من الحوادث/ الإصابات

ذكِّر المشاركين بأنهم تعلموا بالفعل أن الإصابات المنزلية هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. اسأل المشاركين عن أنواع الحوادث التي يشيع حدوثها في صفوف المواليد. استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي:

- الشَّرَق والاختناق
- الجروح والسقوط
- الحروق
- الغرق
- التسمم

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 198 حتى 207 من الكتاب القلاب. وراجع كل نوع من أنواع الحوادث بالترتيب، مرورًا بالرسومات التوضيحية، واحدةً تلو الأخرى، واسأل المشاركين عن كيفية تقديم المشورة للأسر بشأن الوقاية منها. وعندما تصل إلى القسم الخاص بالتسمم، اسأل المشاركين عن المواد السامة التي غالبًا ما يتم الاحتفاظ بها في المنازل. واستمع إلى أقوالهم قبل أن تسرد قائمة بالأدوية، والمنظفات، والمبيدات الحشرية، ومبيدات الآفات.

ذكِّر المشاركين بأن الرضع في هذا العمر يمكنهم الزحف والوصول إلى الأشياء، لذلك يكون من الضروري أن تضع الأسر المواد السامة بعيدًا عن متناول أيديهم.

2.6.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 198 حتى 207 من الكتاب القلاب، ودراستها بعناية. وعند انتهائهم من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحونها.

3.6.6 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات

راجع مهارات التواصل التي تعلمها المشاركون، وطريقة استخدام استمارة التسجيل للمساعدة في فهم الموقف (لاحظ واسأل)، وطريقة استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية والمساعدة العملية إذا لزم الأمر. وذكِّر المشاركين بأن تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث يتطلب منهم ملاحظة البيئة المنزلية عن كَثَب أثناء الزيارات المنزلية.

4.6.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 53 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأم بشأن الوقاية من الحوادث والإصابات، الوارد في الصفحة 63، وتقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات، في دليل المشارك.

5.6.6 تمرين مصور (3) تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات للرضع من عُمر ستة أشهر حتى عام واحد

اطلب من المشاركين الانتقال إلى التمرين المصور 3: الوقاية من الحوادث والإصابات، الموجود في الصفحة 64، من دليل المشارك. اطلب من المشاركين دراسة الرسومات والاستعداد للمناقشة، والإجابة عن الأسئلة الثلاث المدوَّنة أسفل الصور.

أجرِ المناقشة، مستعينًا بالأسئلة الموضحة أدناه، واطلب منهم الإجابة عن الأسئلة الواردة تحت الصور، كل منهم في دوره.

الرسم التوضيحي 1

السؤال 1: ماذا ترى في الصورة؟

الإجابة 1: الأم تُحمِّم طفلها، والرضيع يستمتع بالاستحمام. كلاهما يبتسم.
وهناك لعبة في الحوض. ولم تترك الأم طفلها بدون رقابة.

السؤال 2: هل هذه ممارسة جيدة أم سيئة؟ ولماذا؟

الإجابة 2: تُظهر هذه الصورة ممارسة جيدة. فالأم تجعل وقت الاستحمام مناسبة ممتعة
تُظهر من خلالها الحب لطفلها، كما أنها لم تتركه دون رقابة في حوض الاستحمام.

السؤال 3: هل ستثني على هذه الأم؟ ولماذا؟

الإجابة 3: يجب الثناء على هذه الأم لأنها تستخدم وقت الاستحمام للعب والتواصل مع طفلها وتحفيز نمائه، ولإبقاء طفلها تحت إشرافها طوال وقت الاستحمام.

السؤال 4: هل ستقدم المشورة للأم؟ وكيف؟

الإجابة 4: في مثل تلك الحالة لا حاجة لذلك.

الرسم التوضيحي 2

السؤال 1: ماذا ترى في الصورة؟

الإجابة 1: يعود الأب إلى المنزل وهو يدخن. وتمنعه الأم من الدخول بسيجارته.

السؤال 2: هل هذه ممارسة جيدة أم سيئة؟ ولماذا؟

الإجابة 2: هذه ممارسة سيئة، لأن التدخين سيضر بالطفل. وسيؤدي الدخان إلى تهيُّج رئتي الطفل وقد يسبب له الاختناق.

السؤال 3: هل ستثني على الأب أو الأم؟ ولماذا؟

الإجابة 3: لا يجب مدح الأب، بينما يتعين الثناء على الأم لأنها تعلم أن التدخين سيهيج رئة طفلها، وقد يسبب له الاختناق.

السؤال 4: هل ستقدم المشورة للأب؟ وكيف؟

الإجابة 4: في هذه الحالة، يحتاج الأب إلى المشورة. حيث يجب نصحه بالإقلاع عن التدخين أو على الأقل مطالبته بالتدخين خارج المنزل. ونظرًا لأن رائحة الدخان تبقى في الملابس، فيجب أن يُنصَح أيضًا بالاستحمام وتغيير ملابسه قبل لمس طفله.

الرسم التوضيحي 3

السؤال 1: ماذا ترى في الصورة؟

الإجابة 1: طفل غير مُراقَب يزحف ويسحب حافة مفرش المائدة. وهناك شمعة على المائدة.

السؤال 2: هل هذه ممارسة جيدة أم سيئة؟ ولماذا؟

الإجابة 2: تُظهر هذه الصورة ممارسة سيئة. فقد تُرك الطفل دون رقابة. ومفرش المائدة ليس بعيدًا عن متناوله، ويوجد شيء خطير موضوع على الطاولة. والطفل مُعرَّض لخطر الاحتراق.

السؤال 3: هل ستثني على هذه الأم؟ ولماذا؟

الإجابة 3: لا يجب الثناء على الأم لهذه الممارسة.

السؤال 4: هل ستقدم المشورة للأم؟ وكيف؟

الإجابة 4: تحتاج الأم إلى المشورة: حيث يجب ألا تترك رضيعها دون رقابة، ويجب أن تتأكد من عدم وجود شيء ضار في متناول يده. كما يجب ألا تُوضَع قطعة قماش طويلة على الطاولة حيث يمكن للطفل الوصول إليها، ويجب ألا تُترك شمعة مضيئة تحترق حيث يمكن أن تسبب ضررًا للطفل.



الجلسة 28:
المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

مدة الجلسة
30 دقيقة

المُعدَّات
لا يوجد

الأهداف

خلال هذه الجلسة، سيراجع المشاركون ما يلي:

- مظاهر سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- لمجالات الرئيسية لسوء المعاملة والإهمال؛
- كيفية الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف.

1.7.6 مناقشة جماعية: سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

استعرض مع المشاركين معنى وتأثير إساءة معاملة الأطفال، وإهمالهم، وممارسة العنف تجاههم، وكيفية الوقاية من ذلك.

2.7.6 قراءة

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 208 حتى 211 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وعندما ينتهون من القراءة أجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

3.7.6 مناقشات جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

ذكِّر المشاركين بأنهم سيحتاجون عند تقديم المشورة للأسر إلى تطبيق مهارات التواصل التي تعلموها، ويجب عليهم استخدام استمارة التسجيل لمساعدتهم على تقييم الوضع. وسيتيح الكتاب القلاب المعلومات الضرورية، وسيوجههم نحو تقديم المساعدة العملية بحسب الحاجة.

وضِّح لهم أنه عند فهم الوضع، سيتعين عليهم أن يراقبوا عن كَثَب ما يلي:

- نظافة الرضيع؛
- كيف تستجيب الأسرة عندما يبكي الطفل؛
- كيف تنظر الأم إلى الطفل وهي تحمله؛
- كيف تغذي الأم الطفل، وما هي الأغذية التي تقدمها له؛

- إذا كان هناك إخوة آخرون، فهل يميز الوالدان بينهم؛
- إذا كان لدى الرضيع ألعاب، فهل هي نظيفة؛
- كيف يتفاعل الوالدان مع الطفل عندما يلعب ويثير ضجة؛
- هل المنزل خالٍ من الأوضاع والأشياء التي قد تضر بالطفل.



4.7.6 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 54 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف، الوارد في الصفحة 65 من دليل المشارك، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

الزيارات المنزلية للرضّع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وعام واحد

أخبر المشاركين بأنه يجب عليهم التخطيط لزيارة هذه الفئة العمرية كل شهرين لمتابعة صحة الطفل، ونموه، ونمائه.

كما يجب عليهم التخطيط للزيارات مقدمًا، باستخدام قاعدة البيانات المتاحة للعاملين الصحيين المجتمعيين لتحديد المنازل التي يتواجد بها أطفال. وإذا تواجد أكثر من طفل في المنزل، أو إذا كانت الأم حاملاً مرةً أخرى، فيمكن للعاملين الجمع بين الرعاية المقدمة للأمهات ورعاية الأطفال الآخرين في زيارة واحدة.

يجب أن يتوجه العاملون الصحيون المجتمعيون إلى الزيارات مُصطحبين معهم مجموعة الأدوات التي أقرها كل بلد لهم ، بالإضافة إلى استمارة التسجيل والكتاب القلاب. ويجب عليهم دائمًا استخدام مهارات التواصل التي تدربوا عليها، واتباع الخطوات المشار إليها في استمارة التسجيل. وقد صُمِّمت الاستمارة لمساعدة العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد علامات الخطورة التي تشير إلى وجود حالات خطيرة تتطلب إحالة عاجلة. ويجب أن يتحقق العامل الصحي المجتمعي أولاً من وجود تلك العلامات، فإذا وجد أيًا منها، فيجب أن يتخطى سائر المهام، ويقدم المشورة حول الإحالة. كما تساعد الاستمارة أيضًا على فهم الوضع.

ويجب استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات المتعلقة بالوضع. ومن المهم أن يفهم العاملون الصحيون المجتمعيون أنه لا يجب عليهم وحسب قراءة محتويات الكتاب، بل عليهم أيضاً تكييف المعلومات التي يتضمنها حسب احتياجات الأسرة التي يقومون بزيارتها.

أخبر المشاركين بأنه من المهم الاحتفاظ بسجل لجميع الأطفال الذين يعيشون في المنازل الواقعة في المناطق المستهدفة بالخدمات. اطلب منهم الاطلاع على الإطار 55 بشأن الزيارات المنزلية للرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد، الوارد في الصفحة 66 من دليل المشارك.

الوحدة 7

العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين في المنزل

مقدمة

أخبر المشاركين أنهم خلال هذه الجلسة سيتعرفون على الفئة العمرية الثالثة، وهي الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين، أيْ قد أكمل هؤلاء الأطفال عاماً واحداً ولكنهم لم يُكملوا بعد عامين من العمر.

وتتألف عملية تقديم الرعاية لهذه الفئة العمرية من سبعة مكونات:

1. تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية: ممارسات طلب الرعاية الصحية والوقاية
2. تقديم المشورة حول التغذية
3. تقديم المشورة حول النظافة الشخصية
4. تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية
5. تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)
6. تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات
7. تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف.



أخبر المشاركين بأنهم سيستخدمون استمارة التسجيل التي تشمل الأطفال من ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات، وأنهم سيواصلون استخدام الكتاب القلاب للحصول على المعلومات الضرورية، واستخدام دليل المشارك كوثيقة مرجعية.اطلب من المشاركين الرجوع إلى قسم الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين في الكتاب القلاب.



الجلسة 29:
المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- طاولة لاستخدامها في لعبة البطاقات
- مجموعتين من البطاقات للعبة مطابقة المعلومات: مراجعةالتنفس السريع
- مجموعتين من البطاقات للعبة مطابقة المعلومات: الوقاية من الحوادث والإصابات

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- التعرُّف على علامات الخطورة التي تنطبق على هذه الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للأسر بشأن علامات الخطورة تلك، ودعم الإحالة باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب؛
- تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية.

بالإضافة إلى ذلك، سيراجعون خطوات غسل اليدين.

1.1.7 مناقشات جماعية: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية: أولاً: ممارسات طلب الرعاية الصحية

راجع مع المشاركين باختصار ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية التي تعلموها في الفئتين العمريتين الأولى والثانية. الفت الانتباه إلى كيفية تقسيم تلك الممارسات إلى ممارسات طلب الرعاية الصحية (أي متى وأين يجب طلب الرعاية الصحية؟)، وممارسات الوقاية (أي التطعيم، وغسل اليدين، والنوم تحت ناموسية، واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد، ومبادئ نظافة الغذاء – أي استخدام الماء المغلي لتنظيف الأكواب، والملاعق، والأواني الأخرى، وغير ذلك).

أكِّد على أهمية تحقُّق العاملين الصحيين المجتمعيين من وجود علامات الخطورة. وذكر المشاركين بأن وجود علامة خطورة من أي نوع يشير إلى احتمال وجود حالة خطيرة، ويتطلب إحالة عاجلة إلى مرفق صحي. أخبرهم بأن علامات الخطورة لدى الرضع من عمر عام واحد حتى أقل من عامين هي نفسها لدى الرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد، باستثناء عدد الأنفاس في حالة التنفس السريع.

اذكر علامات الخطورة التي تنطبق على تلك الفئة العمرية:
- الطفل ضعيف جدا لا يقدر على الشرب أو الرضاعة؛
- تشنجات؛
- تقيؤ الطفل لكل ما يتناوله؛
- التنفس السريع؛
- انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل.

راجع كل علامة من علامات الخطورة، وعندما تصل إلى سرعة التنفس السريع راجع مع المشاركين كيفية عدّ معدل سرعة التنفس. ووضح أن معدل سرعة التنفس يتباطأ مع تقدم الطفل في العمر، وأن التنفس السريع لدى الأطفال من عمر عام حتى أقل من عامين تبلغ 40 نفسًا في الدقيقة أو أكثر.

إذا كان الطفل:	الرضيع يتنفس بسرعة عندما تعد:
من الولادة حتى أقل من شهرين	60 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر (في العد الثاني)
من شهرين حتى أقل من ستة أشهر	50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.
من ستة أشهر حتى أقل من عام واحد	50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.
عام واحد حتى أقل من عامين	40 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.

راجع مع المشاركين كيفية ملاحظة انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل، مع التأكيد على أن أي انسحاب في جدار الصدر للداخل في هذا العمر يمثل علامة خطورة.

2.1.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 212 حتى 217 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

ناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الموضَّحة في الإطار الأحمر.

3.1.7 مناقشة جماعية: مَن الذي يجب طلب الرعاية الصحية منه؟

اسأل المشاركين عن الأماكن التي يجب أن تتوجه إليها الأسر طلبًا للرعاية الصحية لأطفالهم الرضع. استمع إلى إجاباتهم، ثم أكّد على أنه يجب أن يكون مهنيو الرعاية الصحية المُدرَّبون مصدرًا لتقديم الرعاية الطبية للجميع. انصح الأسر بألا تطلب الرعاية الصحية من مصادر أخرى. فبدلاً من أن يحققوا المنفعة للطفل، فقد يسببون له الضرر. بل قد يصل الأمر إلى أن يتوفى الطفل جرّاء ذلك.

4.1.7 مناقشة جماعية: تقديم المشورة والمساعدة بشأن الإحالة

أكّد على أن أي علامة خطورة تشير إلى احتمال وجود حالة صحية خطيرة وأنه يتعين إحالة الرضيع على وجه السرعة إلى المرفق الصحي. انتقل إلى استمارة التسجيل، ووضح كيفية ملء القسم الخاص بعلامات الخطورة، ثم اسأل المشاركين عما يجب عليهم فعله في حالة وجود علامة خطورة. استمع إلى أقوالهم، ثم أكد أنه يجب عليهم إخبار الأسرة بأن حياة الطفل قد تكون معرَّضة للخطر، وأنه يحتاج إلى إحالة عاجلة إلى مرفق صحي.

وضِّح كيفية ملء مذكرة الإحالة، وذكِّر المشاركين بتقديم النصح للأم بإرضاع الطفل أثناء التوجه إلى المستشفى، في

حال كان لا يزال يرضع. وإذا لم يكن الأمر كذلك، وكان الطفل قادرًا على الشرب، فيجب على الأم إعطاء السوائل لتجنب انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم.



5.1.7 مناقشة جماعية: صعوبات تواجه إحالة الطفل

استعرض مع المشاركين الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عند إحالة الأطفال إلى مرفق صحي. ناقش معهم كيفية تقديم المشورة حول الإحالة وتذليل الصعوبات.



6.1.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 56 الخاص بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية، الوارد في الصفحة 68 من دليل المشارك، ثم قراءة الصفحات من 218 حتى 221 من الكتاب القلاب، ومناقشة التعليمات المقدمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. ويُرجى أيضًا الرجوع إلى مذكرة الإحالة الواردة في الصفحتين 25 و26 من أدلة المشاركين.



7.1.7 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية

راجع مع المشاركين ممارسات الوقاية التي تعلموها مسبقًا، وأخبرهم بأن نفس تلك الممارسات تنطبق على الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين.

تحدث عن أهمية التطعيم، واذكر اللقاحات التي يجب إعطاؤها لتلك الفئة العمرية، والجرعات المُنشِّطة، بالإضافة إلى لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.

وفيما يتعلق بغسل اليدين، اطلب من المشاركين الرجوع إلى الكتاب القلاب، وتحديدًا الصفحتين 224 و 225. وراجع معهم أهمية غلي الماء لتنظيف الأكواب والملاعق، وأضف أنه في المناطق التي لا يوجد بها مصدر آمن للمياه الصالحة للشرب، يُعتبر غلي الماء قبل الاستخدام ضرورة ملحة لصحة الأسرة بأكملها. ووضِّح أهمية النوم تحت الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، واستعمال المضادات الحيوية على نحو رشيد.



8.1.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 222 حتى 229 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

9.1.7 لعبة بطاقات مطابقة المعلومات (3): مراجعة التنفُّس السريع

ستحتاج إلى ما يلي:

طاولة.

مجموعتين من بطاقات لعبة التنفس السريع.

أخبر المشاركين بأنهم سيراجعون سرعة التنفس من خلال لعبة البطاقات. قسِّم المشاركين إلى فريقين. سيحصل كل فريق على مجموعة من البطاقات تتضمن معلومات عن سرعة التنفس. ويجب عليهم أن يجدوا البطاقات ذات المعلومات المتطابقة. أخبرهم بأن لديهم 15 دقيقة لإتمام المطابقات. اخلط البطاقات ولا تناولها للمشاركين بالترتيب.

في نهاية اللعبة، أحصِ المطابقات الصحيحة لكل فريق، وصفق للفريق الفائز.

التنفس السريع لدى المولود	60 نفسًا في الدقيقة أو أكثر، في العدّ الأول. خلال العد الثاني، يبقى العدد كما هو 60 نفسًا في الدقيقة أو أكثر.
يجب أن نعدّ معدل التنفس	لأكثر من دقيقة كاملة، وعندما يكون الطفل هادئًا
يكون عدد الأنفاس لدى رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر طبيعيًا إذا كان	أقل من 50 نفسًا في الدقيقة
يكون التنفس لدى الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين سريعًا إذا كان عدد الأنفاس	40 نفسًا في الدقيقة أو أكثر
عدد 46 نفسًا في الدقيقة لدى رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر	طبيعي
إذا كان معدل سرعة التنفس للمولود 50 نفسًا في الدقيقة	يجب ألا نكرر العد
رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر يعاني من سرعة التنفُّس	إذا كان العدد 50 نفسًا في الدقيقة أو أكثر
إذا بكى الطفل أو كان هائجًا	انتظر حتى يهدأ الطفل، ثم احسب معدل سرعة التنفس



الجلسة 30:
المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:

- أهمية استمرار الرضاعة؛
- الأطعمة التكميلية المغذية؛
- كيفية إعداد الأطعمة التكميلية المغذية؛
- كمية الطعام وعدد مرات تقديمه للأطفال؛
- كيفية تشجيع الأطفال على تناول الطعام (التغذية الفعالة)؛

كيفية تقديم المشورة إلى الأسر حول إطعام الأطفال وتشجيع الأطفال على تناول الطعام (التغذية الفعالة).

1.2.7 مناقشة جماعية: تغذية الأطفال من عمر عام حتى أقل من عامين

أخبر المشاركين بأن لبن الأم يمكن أن يوفر جميع المُغذِّيات اللازمة للمواليد وصغار الرضع الأقل من شهرين، أي نصف المُغذِّيات اللازمة للرضع الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر حتى أقل من عام واحد. وبالنسبة للأطفال من عُمر عام حتى أقل من عامين، فيمكن أن يوفر لبن الأم ثلث الاحتياجات الغذائية. كما أنه يواصل توفير الحماية للطفل من المرض. لذا، يجب تشجيع الأمهات على مواصلة الرضاعة عند الطلب. ويجب استكمال الثلثين الباقيين من الاحتياجات الغذائية عن طريق الأغذية التكميلية.

2.2.7 مناقشة جماعية: ما هي الأغذية التكميلية الجيدة؟

اسأل المشاركين عن الأغذية التكميلية الجيدة التي يجب تقديمها للأطفال، واستمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر في النهاية أن أفضل الأغذية التكميلية هي التي تكون:

- غنية بالمُغذِّيات؛
- غنية بالطاقة؛
- مأمونة ومجهَّزة بطريقة صحية؛
- متاحة محليًا ومقبولة ثقافيًا.

ناقش مع المشاركين ما تعنيه تلك المصطلحات، مع إيلاء اهتمام خاص لأهمية تقديم نظام غذائي متنوع.

3.2.7 قراءة:

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 57 الخاص بتغذية الأطفال من عُمر عام واحد حتى أقل من عامين، الوارد في الصفحة 69 من دليل المشارك، والصفحات من 230 حتى 235 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة.

وضِّح التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر.

4.2.7 مناقشة جماعية: تقديم الطعام للطفل

ابدأ مناقشة حول أفضل الطرق لإطعام الأطفال في هذا العمر.

توصَّلْ للاستنتاجات التالية:

- يجب أن تستمر الأمهات في تقديم الرضاعة عند الطلب.
- يمكن للأطفال البدء بتناول نفس الطعام الذي يتناوله باقي أفراد الأسرة طالما أنه مفروم بشكل ناعم، أو مهروس، إذا لزم الأمر.
- يجب توسيع نوعية الطعام لتشمل المزيد من الخضروات والفواكه، وغيرهما.
- يجب على الأسر الاستمرار في تجنب إعطاء عصائر الفواكه، حتى الطازجة منها.
- يجب إطعام الأطفال الصغار بملعقة. ويجب على الأمهات تجنب استخدام زجاجات التغذية.
- يجب السماح للأطفال بتناول الطعام بأصابعهم، ولكن يجب غسل أيديهم بينما تقوم الأم بإطعامهم بنفسها.
- يجب عدم إجبار الأطفال على تناول الطعام.

يجب ألا يقدم الوالدان وجبات سريعة غير صحية أو مشروبات غازية لأطفالهم. فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم، والتحسس، ومشاكل صحية مزمنة على المدى الطويل، بما في ذلك السمنة وما يصاحبها من مشكلات وجدانية وأخرى متعلقة بتقدير الذات.

5.2.7 قراءة:

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 236 و237 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات معهم، وكيفية استخدامها لتقديم المشورة.

6.2.7 مناقشة جماعية: كميات الطعام وأنواعه

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 238 و 239. وناقش تنوع الطعام وكمياته التي يجب تقديمها إلى الأطفال في هذا العمر، وشدد على أنه كلما تقدم الطفل في العمر يجب زيادة التنوع والكمية.

وأكِّد على أن كميات الطعام وأنواعه تزداد مع تقدم الطفل في العمر.

وضح أن الفواكه هي أفضل وجبة خفيفة تُقدَّم إلى الأطفال نظرًا لقيمتها الغذائية ومحتواها من الألياف التي تمنع الإمساك، ولأنها ستساعد الطفل على تنمية مهارات المضغ لديه. ولا تنسَ أن تضيف أن الفواكه الكاملة تحتوي على سكريات طبيعية تصبح مركَّزة عند تحويلها إلى عصير. ويجب تشجيع الأطفال على أكل الفواكه وشرب الماء والحليب. وبهذه الطريقة يساعد الوالدان أطفالهم على اتباع عادات غذائية جيدة. كما يمكن أيضًا إعطاء الأطفال دقيق الشوفان أو الزبادي كوجبة خفيفة.

7.2.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 238 و239 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات معهم، وكيفية استخدامها لتقديم المشورة. وناقش التعليمات الموجَّهة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر.

8.2.7 مناقشة جماعية: التغذية الفعالة

راجع مع المشاركين التغذية الفعالة، التي تغطي النقاط التالية.

- ما المقصود بالتغذية الفعالة؟
- كيف يمكن تحويل أوقات تناول الطعام إلى فترات للحب والمودة؟
- لماذا يجب أن يأكل الأطفال من صحن أو وعاء خاص بهم؟
- لماذا يجب تجنب تشتيت الانتباه أثناء أوقات التغذية؟ وكيف؟
- لماذا يجب أن يتحلى الوالدان بالصبر إذا رفض طفلهما الطعام ولا يحاولان إجباره على تناول الطعام؟
- ما هي البدائل المتاحة بدلاً من إبداء الغضب (ممارسة لعبة معروفة محليًا، تذوق الطعام)؟

9.2.7 قراءة

اطلب من المشاركين الانتقال إلى الصفحتين 240 و241 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

10.2.7 مناقشة جماعية: مشكلات الرضاعة/ التغذية

ابدأ مناقشة حول المشكلات الشائعة في التغذية في صفوف الأطفال. وجِّه المحادثة حول كيفية تقديم العامل الصحي المجتمعي المشورة للأسر في الحالات التالية:

- إطعام الطفل كمية غير كافية من الأطعمة؛
- إعطاء الطعام كميات صغيرة للغاية/ وجبات قليلة؛
- عدم تقديم ما يكفي من السوائل؛
- إعطاء الطفل عصائر الفاكهة المحلّاة، ومشروبات الصودا، والشاي، والقهوة، والأطعمة السريعة غير الصحية؛
- إجبار الطفل على تناول الطعام؛
- لأغذية المقدمة قوامها خفيف للغاية؛

- عدم تقديم وجبات خفيفة، أو تقديمها في توقيت سيئ؛
- توقف الأم عن الرضاعة (اشرح كيفية اعتصار لبن الأم، وتخزينه).

وضح أن الأطفال المرضى غالبًا ما يفقدون شهيتهم، ويتطلب إطعامهم الكثير من الصبر. اسأل المشاركين عن كيفية القيام بذلك. استمع إليهم، ثم اذكر في النهاية أن التغذية الفعالة يمكن أن تساعد الأمهات على التغلب على هذه المشكلة.

راجع أيضًا التدابير التي يمكن اتخاذها لتعويض أي فقدان للوزن عندما يتعافى الطفل.



11.2.7 مناقشة جماعية. كيفية تقديم المشورة حول تغذية الأطفال

أخبر المشاركين بأنهم يجب أن يتبعوا الخطوات نفسها وأن يستخدموا الأدوات نفسها لتقديم المشورة حول التغذية.

ويتعين عليهم استخدام مهارات التواصل الجيد، واستمارة التسجيل لمساعدتهم في فهم الوضع، وتقديم المعلومات الضرورية، باستخدام الكتاب القلاب.

ناقش مع المشاركين قسم التغذية الوارد في استمارة التسجيل بالنسبة للأطفال من عُمر الولادة حتى أقل من خمس سنوات.

ذكّر المشاركين بالثناء على الأم في كل مرة تقوم فيها بشيء جيد من أجل طفلها، ويجب عليهم التحقق من فهم الأمهات لما هو مطلوب منهن.



12.2.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 58 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأم حول التغذية، الوارد في الصفحة 70 من دليل المشارك، والصفحات من 242 حتى 249 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين.



13.2.7 التدريب 5: تقديم المشورة حول تغذية صغار الأطفال

أبلغ المشاركين بأنهم سيراجعون المعلومات الخاصة بتقديم المشورة حول تغذية الأطفال. ستطرح أسئلة حول تغذية الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين، وسيتناوبون الأدوار للإجابة عنها. وسيُعطَى كل منهم مدة قصيرة للرد. فإذا كان المشارك غير قادر على الإجابة، انتقل إلى المتدرب التالي.

وترد الأسئلة والإجابات في الجدول المبين أدناه.

السؤال	الإجابة
س1: ما هي التغذية المناسبة لأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؟	الرضاعة والتغذية التكميلية.

السؤال	الإجابة
س 2: ما هو الطعام الذي يجب تقديمه لأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؟	يمكن للطفل تناول طعام الأسرة وهو مفروم جيدًا ومهروس إذا لزم الأمر.
س 3: ما هي المكونات اللازم وجودها في الوجبة المقدمة لأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؟	الأطعمة الحيوانية المصدر، والخضروات والفواكه الخضراء والبرتقالية.
س 4: كيف تُقدّم المشورة للأم التي تعطي طفلها حساءً خفيفًا وسائلاً؟	الحساء السائل لن يمنح الطاقة الكافية. يحتاج الطفل إلى طعام بقوام أكثر سُمكًا. إذا لم يكن لدى الأم ما يكفي من اللحوم أو الخضروات وغيرهما، فيمكنها إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الحليب، أو الحليب، أو الزبد، أو الزيت، أو الفول السوداني المطحون بعناية.
س 5: كيف تُقدم المشورة للأم التي تعطي طفلها أنواع محدودة من الأطعمة؟	يوفر كل نوع من أنواع الطعام مغذيات مهمة يحتاجها الطفل. وتوفر الأغذية الحيوانية المصدر البروتين والحديد الذي يجعل الطفل أقوى، والزنك الذي يحمي من العدوى. ويحتوي البيض على فيتامين «د»، كما تحتوي الخضروات الخضراء والبرتقالية على فيتامينات «ج» و «أ» التي تساعد المخ والعينين على النمو.
س 6: كيف تنصح الأم التي تعطي طفلها الذي تتراوح سنه من عام واحد حتى أقل من عامين نصف كوب في كل وجبة، من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم؟	يحتاج الأطفال إلى الحصول على ما يكفي من المُغذِّيات للنمو بشكل صحي وبناء أجسامهم. ويحتاج الأطفال في هذا العمر ما يعادل كوبًا كاملاً من الطعام من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.
س 7: ماذا تقول للأم التي تجبر طفلها على الأكل؟	إجبار الطفل على تناول الطعام قد يؤدي إلى تناوله بكميات أقل، وقد ينمو وهو يكره أوقات الطعام. وسيكون من المفيد للغاية تحويل أوقات التغذية إلى مناسبة سعيدة. فبدلاً من إجبار الطفل على الأكل، العبي معه ألعابًا لتشجيعه برفق على تناول الطعام.
س 8: ماذا تقول للأم التي تعطي مشروبات الصودا لطفلها؟	هذه المشروبات غير مناسبة. وسيخسر طفلك الكالسيوم الذي يحتاج إليه لبناء العظام والأسنان، وسيؤدي ارتفاع محتوى السكر إلى تسوس الأسنان وسوء صحة الفم.



الجلسة 31:
المكون 3: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- دمية

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- مبادئ النظافة الشخصية للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية.

1.3.7 مناقشة جماعية: العناية بالنظافة الشخصية للطفل

راجع مع المشاركين ما تعلموه بالفعل حول العناية بالنظافة الشخصية للرضع. وأكِّد على أن النظافة الشخصية الجيدة ضرورية للغاية إذا ما أردنا الإبقاء على الرضع معافين وسعداء، وخالين من العدوى الجلدية وغير ذلك من أمراض.

أخبر المشاركين بأن العناصر العشرة للنظافة الشخصية التي تعلموها للرضع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد ما زالت منطبقة على هذه الفئة العمرية.

1. الاستحمام
2. الحفاظ على نظافة مناطق الوجه، والرقبة، واليدين، والحفاض
3. تقليم الأظافر
4. الحفاظ على عدم انسداد الأنف
5. تنظيف عيني الطفل
6. تنظيف أُذني الطفل
7. الحفاظ على نظافة ملابس الطفل
8. الحفاظ على نظافة ألعاب الطفل
9. تنظيف المنزل
10. العناية بصحة الفم/ الأسنان

راجع كل عنصر بالتفصيل، مشيرًا إلى الصفحات من 250 حتى 257 من الكتاب القلاب. وعندما يتعلق الأمر بالاستحمام، وضح أن الوقت الآن مناسب لنقل حوض استحمام الطفل إلى حوض استحمام الكبار. سيبدو حوض الاستحمام ضخمًا بالنسبة للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين، ولكن مع وضع حوض استحمام الطفل في الحمام أولاً، ثم نقله إلى حوض استحمام الكبار قبل أن يستحم الطفل، فأنت بذلك تقوم بتجهيزه للانتقال إلى حوض استحمام الكبار. وذكِّر المشاركين بأنه يجب ألا يُترك الأطفال دون إشراف مطلقًا.

عند غسل شعر الطفل، قم بإمالة رأسه إلى الخلف، واطلب منه أن ينظر إلى السقف حتى لا يدخل الصابون إلى عينيه.

وعلى الوالدين التأكد من أن الماء المُستخدَم في الاستحمام يُجنِّب الطفل أي ضرر.

ومن المهم بوجه خاص تنظيف الوجه، والرقبة، والعينين، واليدين، وتنظيف أظافر الأطفال في هذا العمر. فالأطفال سيلعبون بأي شيء –مثل الرمل أو الطين أو الأشياء القذرة– وغالبًا ما يضعون أيديهم في أفواههم.

وتساعد العناية بأسنان الأطفال على ضمان صحة الأسنان في مرحلة البلوغ. ويجب على الأمهات استخدام فرشاة أسنان ناعمة ولكن ليس معجون الأسنان. ويمكن أن تسبب المشروبات المحلاة بالسكر تسوس الأسنان. والماء واللبن هما أفضل المشروبات للحفاظ على صحة أسنان الأطفال.

2.3.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 250 حتى 257 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

3.3.7 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية لصغار الأطفال

راجع الخطوات الأربع للتواصل الجيد، والمهارات المقابلة لكل خطوة، ثم ذكّر المشاركين بأنهم كي يقدموا المشورة حول النظافة الشخصية يجب أن يقيِّموا الموقف من خلال الملاحظة واستخدام استمارة التسجيل –الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات– لتوجيه الأسئلة، ومن ثمَّ تقديم النصح استنادًا إلى المعلومات الواردة في الكتاب القلاب.

اطلب منهم إلقاء نظرة على استمارة التسجيل، واشرح لهم كيفية ملء القسم الخاص بالنظافة الشخصية. واستعرض معهم العمود المذكور فيه ما يجب ملاحظته:

- إذا كان وجه الطفل، وعيناه، وأنفه، وأذناه نظيفة؛
- إذا كانت هناك رائحة تنبعث من الحفاض؛
- حالة أظافر الطفل؛
- إذا كانت ملابسه متسخة؛
- إذا كانت الألعاب تبدو نظيفة أم لا؛
- إذا كان المنزل يبدو أنيقًا ومرتبًا.

إذا بدا كل شيء على ما يرام، فيجب أن يثنوا على الأم قبل استخدام استمارة التسجيل مرةً أخرى وتوجيه أسئلة لها حول كيفية وتوقيت:

- تحميم الطفل؛
- تنظيف وجه الطفل، وعينيه، وأنفه، وأذنيه؛
- تغيير الحفاضات؛
- تنظيف ملابس الطفل؛
- تنظيف الألعاب؛
- تنظيف المنزل؛

- الاهتمام بصحة فم الطفل.

ويتيح السؤال عن توقيت وكيفية عناية الأم بالنظافة الشخصية للرضيع فرصةً للثناء عليها، وإضافة المزيد إلى مخزون معلوماتها، وزيادة ثقتها بنفسها. كما يتيح للعاملين الصحيين المجتمعيين سد أي ثغرات لاحظوها أثناء تقييمهم للموقف، واستخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات اللازمة.

ذكِّر المشاركين بأن المشورة لا تعني مجرد قراءة/ ترديد محتويات الكتاب القلاب، ولكنها تتطلب منهم تقييم الموقف، وتقديم المعلومات التي تساعد على علاج المشكلات التي حددوها وحسب.



4.3.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 59 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية، الوارد في الصفحة 71 من دليل المشارك.



الجلسة 32:
المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النماء الرئيسية

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- دمية
- قطعة من الطباشير

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم أهمية متابعة معالم النَّماء الرئيسية لدى الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- التعرف على معالم النَّماء الرئيسية للرضع التي تنطبق على تلك الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للآباء حول تلك المعالم.

1.4.7 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية

ابدأ بالتأكيد على أهمية إلمام الوالدين بمعالم النَّماء الرئيسية التي يتعين عليهم ملاحظتها على الطفل، ومتى وكيف يتعرفون عليها. ووضِّح أن هذه الفئة العمرية تُقسَّم إلى عدة أعمار وفقًا لظهور معالم نماء رئيسية جديدة.

وضح للمشاركين أنه يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين تقديم المشورة للوالدين حول المعالم الرئيسية التي يجب عليهم ملاحظتها أثناء نمو أطفالهم حتى يتمكنوا من تقديم التشجيع المناسب أثناء اللعب مع الطفل، وضرورة استشارة الطبيب إذا حدث تأخير. أكِّد للمشاركين أن معالم النَّماء الرئيسية تختلف باختلاف المرحلة، أي أن ما يجب أن يلاحظوه على طفل يبلغ من العمر شهرين يختلف عما يجب أن يلاحظوه على طفل عمره 15 شهرًا، وما يجب أن يلاحظوه على طفل عمره 18 شهرًا.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحات من 258 حتى 261، وناقش معهم المعالم الرئيسية الموضَّحة لهم. وعند الضرورة، استخدم الدمية لتوضيح ذلك. عند مناقشة معالم النَّماء الرئيسية، يجب إعطاء اهتمام خاص ليفهم المشاركون متى يتعين عليهم ملاحظة معالم نماء محددة. واستعرض مع المشاركين تأثير النشاط البدني، والنوم الجيد، والحد من أوقات الخمول على النمو والنماء بأسلوب صحي.

يشمل النشاط البدني لهذه الفئة العمرية إشراك الطفل في اللعب النشط (مثل رمي الكرة، أو لعبة إخفاء الوجه ثم إظهاره فجأة "بِخّ"، أو لعبة التصفيق الإيقاعي "لاعبني وألاعبك"، وغير ذلك من الألعاب) لمدة 180 دقيقة على الأقل في اليوم. ويحتاج الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين إلى ما يتراوح بين 11 و14 ساعة من النوم الجيد يوميًا، ويتضمن ذلك أوقات القيلولة، ويجب على الوالدين التأكد من حصول الطفل على أوقات نوم منتظمة، وأن الجو العام يساعد على النوم الهادئ. كما يجب تقليل عدد ساعات الخمول إلى الحد الأدنى، وعلى الوالدين التواصل مع أطفالهم من خلال سرد القصص والنظر إلى الكتب المصوَّرة معًا. وحتى إذا كان الطفل يمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا، ولكنه يجلس لساعات طويلة أيضًا، فإنه يعتبر في هذه الحالة خاملاً ولا يزال يحتاج إلى أن يكون أكثر نشاطًا بمشاركة الوالدين على مدار اليوم.

ويستمر التسنين لهذه الفئة العمرية، ويمكن أن تصاحبه آلام وأعراض أخرى.

اطلب من المشاركين فتح كتابهم القلاب على الصفحتين 264 و265 لمعرفة المزيد حول كيفية المساعدة في تخفيف أعراض التسنين.

التدريب على استخدام المرحاض

مع بلوغ الأطفال سن 18 شهرًا يصبح العديد منهم جاهزًا بدنيًا وعاطفيًا لبدء التدريب على استخدام المرحاض. قدِّم للموضوع عن طريق توجيه المشاركين للاطلاع على الصفحتين 266 و267 من الكتاب القلاب. واذكر أن الفتيات بصفة عامة يسبقن الفتيان ببضعة أشهر فيما يتعلق بالتعرُّف على استخدام نونية/ قصرية الأطفال.

سيحتاج الأطفال إلى تعلُّم بعض الكلمات والعبارات للذهاب إلى المرحاض (مثل «بي بي» و«حمام»). ولمساعدة الطفل على فهم الغرض من النونية/ القصرية، يمكن أن تضع الأم الحفاض المتسخ في النونية/ القصرية بعد تغييره للطفل. ولتشجيع طفلها، يمكن أن تحاول الأم وضع لعبة مفضلة على النونية/ القصرية، وأن تمدحها (لعبة التمثيل)، أو أن تحدد أشياء أخرى تحفز طفلها، مثل الأغذية والمشروبات المفضلة لديه.

ملاحظات حول التدريب على النونية/ القصرية:

- تعتبر أشهر الصيف هي الأفضل للتدريب على استخدام المرحاض، نظرًا لقلة الملابس التي يرتديها الأطفال، فضلاً عن قلة احتياجهم للذهاب إلى المرحاض في الأجواء الدافئة.
- لا يجب إعطاء الطفل سوائل أو وجبات خفيفة بعد وجبة العشاء.
- يجب على الأم أن تأخذ طفلها إلى النونية/ القصرية كل 15 دقيقة لمدة ثلاثة أيام.
- يجب على الأم أن تجرب أخذ طفلها إلي النونية/ القصرية قبل النوم، كما يجب أن تأخذ في الاعتبار إيقاظ الطفل في منتصف الليل لإعادة محاولة ذلك.
- إذا لم يتبول الطفل أو يتغوط بعد 5 دقائق من الجلوس على النونية/ القصرية، فيجب رفعه عنها. قد يشعر الطفل عند حمله على الجلوس على المرحاض لفترات طويلة بأنه مُعاقب.
- إذا لم ينجح التدريب الأوَّلي، لا تُظهري خيبة الأمل. توقفي، ثم حاولي مرة أخرى.
- لتجنب الإمساك، احرصي على أن يحتوي الطفل على الكثير من الألياف في نظامه الغذائي، وأن يشرب كمية كافية من الماء.



2.4.7 قراءة

اطلب من المشاركين إعادة قراءة الصفحات من 258 حتى 267 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.



3.4.7 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول معالم النَّماء الرئيسية

أكد على أنه من الضروري أن يدرك الوالدان أهمية متابعة نَماء أطفالهم من خلال رصد معالم النَّماء الرئيسية، والتعرف على حالات التأخر.

اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح ضرورة أن يلاحظوا ما يمكن للطفل القيام به: على سبيل المثال، يمكنهم أن يطلبوا إذن الوالدين لوضع الرضيع في وضعية الجلوس، أو ملاحظة ما إذا كان يمكنه الوقوف أثناء الاستناد إلى شيء ما، أو ملاحظته أثناء المشي، ولعب الألعاب مع الطفل. وذكِّر المشاركين بأنه يجب تسجيل ملاحظاتهم في القسم المناسب في استمارة التسجيل.

وعندما يقدمون المشورة للأسر بشأن علامات النَّماء الرئيسية، سيتناولون الآتي:

- أهمية نماء الطفل؛
- المقصود بمعالم النَّماء الرئيسية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- ما هي معالم النَّماء الرئيسية لهذا العمر، ولماذا يجب مراجعة الطبيب إذا كان هناك تأخر في ظهورها؛
- ساعات النوم؛
- التمارين البدنية؛
- عدد ساعات الخمول التي يمضيها الطفل كل يوم.

يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين استخدام الكتاب القلاب لتعليم الوالدين كيفية تحديد المعالم الرئيسية، وشرح ما يتعين عليهم ملاحظته خلال الأشهر المقبلة. إذا كان الطفل يبلغ من العمر 18 شهرًا أو أكثر، أكِّد للمشاركين أنه سيتعين عليهم أيضًا تقديم المشورة حول التدريب على استخدام المرحاض، إن لم يكونوا قد بدأوا في ذلك بالفعل.



4.4.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 60 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأم بشأن معالم النَّماء الرئيسية، الوارد في الصفحة 72 من دليل المشارك.



5.4.7 لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام (5): مراجعة تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية

ستحتاج إلى: قطعة طباشير

أخبر المشاركين بأنهم سيلعبون لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام لمراجعة معالم النَّماء الرئيسية لدى الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين. وذكِّر المشاركين بقواعد لعبة التحرك خُطوة إلى الأمام. واستخدم قطعة من الطباشير لرسم خط البداية والنهاية -ويجب أن تكون المسافة بين الخطوط أربع خطوات أو أكثر- ثم قسِّم المشاركين إلى فريقين. وأعطِ كل مشارك رقمًا واطلب منه أن يتذكره. وفي نهاية اللعبة صفِّق للفائز. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة الخاصة بهذه اللعبة.

س1: لماذا من المهم التحقق من معالم النَّماء الرئيسية؟

ج 1: يحتاج الآباء إلى فهم الشكل المعتاد لنماء الأطفال حتى يتمكنوا من متابعة نَماء أطفالهم، وتحفيزهم، ومراقبة أي مشكلات تؤثر على ذلك.

س 2: إذا لم يحقق الطفل معالم النَّماء الرئيسية لفئته العمرية، فماذا يجب على العامل الصحي المجتمعي أن يفعل؟

ج 2: يجب على العامل الصحي المجتمعي ملاحظة معالم النَّماء الرئيسية لدى الأطفال الصغار للمساعدة في تقييم مرحلة النَّماء التي بلغها الطفل. وفي حالة حدوث أي تأخير، يجب أن ينصح العامل الصحي المجتمعي الأسرة باستشارة الطبيب.

س 3: كيف يمكنك التحقق مما إذا كان الطفل الصغير يرى بوضوح؟

ج 3: أراقب الطفل وهو يضع الأشياء في وعاء ويُخرجها منه، وكيف يشير بإصبعه السبابة، وألاحظ هل يستطيع أن يحاكي الإيماءات أم لا.

س 4: كيف يمكنك الحكم على الطفل الصغير إذا كان يسمع أم لا؟

ج 4: ألاحظ إذا كان الطفل يحاول تكرار الكلمات التي تقولها الأم، وإذا كان يعرف أسماء الأشياء التي يستخدمها يوميًا.

س 5: أخبرني عن الطرق الأربعة لتخفيف ألم الأسنان؟

ج 5: تدليك اللثة بشاش أو إصبع نظيف، والضغط على اللثة بشيء بارد، وتقديم طعام بارد للطفل، وإعطائه لعبة تسنين نظيفة، وعرض الرضاعة عليه، والغناء لتهدئته.

س 6: في أي سن يمكن أن يبدأ التدريب على استخدام المرحاض؟

ج 6: بدءًا من سن 18 شهرًا تقريبًا، عندما يكون الطفل جاهزًا من الناحيتين البدينة والعاطفية.

س 7: عند تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، ما هي الموضوعات التي يجب أن تتناولها؟

ج 7: أهمية النماء، والمقصود بمعالم النَّماء الرئيسية، وأهمية متابعتها، وأهمية معالم النَّماء عند الأطفال في هذا العمر، وأهمية التمرين البدني، والنوم، وتقليل أوقات الخمول إلى الحد الأدنى، وأثر ذلك على النماء، وما يجب على الأسرة ملاحظته بالنسبة لمعالم النَّماء المنتظرة، وضرورة استشارة الطبيب في حال حدوث أي تأخير.



الجلسة 33:
المكون 5: تقديم المشورة حول «العناية من أجل النماء» (اللعب والتواصل مع الطفل)

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- مجموعة مختارة من الألعاب الشائع توافرها، مثل الكتل الخشبية، والكرات المُلوَّنة، والحاويات، وكتاب مصور.
- مقطع فيديو 22، العب وتواصل: من سن عام إلى عامين.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- تقييم كيفية لعب الوالدين وتواصلهم مع الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- تقديم النصيحة للوالدين بشأن العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)؛
- مساعدة الوالدين في تعزيز مهارات تقديم الرعاية الأساسية، والاستجابة لاحتياجات طفلهم.

1.5.7 مناقشة جماعية: ما المقصود بالرعاية من أجل نماء الطفل؟

راجع المقصود بالعناية من أجل النماء، وكيف يمكن للأسر أن تشارك في تحفيز النمو النفسي والاجتماعي لأطفالهم. وذكِّر المشاركين بأن جميع أفراد الأسرة يجب أن يساهموا في الرعاية من أجل نَماء الطفل.

وأخبر المشاركين بأن طريقة لعب الوالدين وتواصلهم مع طفلهم ستختلف وفقًا لمرحلة نَمائه وعُمره. اطلب منهم فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 268 و269، وباستخدام الرسومات والنصائح المكتوبة اشرح لهم كيف يمكن للوالدين اللعب والتواصل مع طفلهم.

2.5.7 فيديو توضيحي: اللعب والتواصل مع الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين

جهِّز مقطع فيديو 22 (05:31 دقيقة) على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD)

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول كيفية اللعب والتواصل مع الأطفال في هذه الفئة العمرية. اعرض الفيديو، وبعد انتهاء عرضه، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

3.5.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 268 و269 من الكتاب القلاب.



4.5.7 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (العب وتواصل)

وضِّح أن العاملين الصحيين المجتمعيين يمكنهم مساعدة الأمهات وسائر مقدمي الرعاية على الاستجابة بعناية لأطفالهم الرضع حين يبدؤون التواصل. واسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة للوالدين حول العناية من أجل النماء، وذلك في ضوء ما تعلموه بالفعل. استمع إلى أقوالهم، ثم وضِّح لهم أن العاملين الصحيين المجتمعيين يمكنهم مساعدة القائمين على رعاية الأطفال على تشجيع الجهود التي يبذلها أطفالهم للتعلُّم من خلال الاستجابة لكلماتهم وأفعالهم عبر إصدار الأصوات، والإيماءات، واللمسات، والكلمات.

سيقدم المشاركون، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، المشورة حول العناية من أجل النماء باستخدام استمارة التسجيل لفهم الوضع، والكتاب القلاب كمصدر للمعلومات المهمة في هذا الشأن. وخلال الزيارات المنزلية سيتمكنون من استخدام الألعاب الخاصة بالطفل لتوضيح أساليب اللعب.



5.5.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 61 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء، والوارد في الصفحة 73 من دليل المشارك.



6.5.7 تدريب الأسئلة السريعة: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء

أخبر المشاركين بأنهم سوف يراجعون كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء عن طريق القيام بتدريب الأسئلة السريعة. وستقرأ عليهم عبارةً ما، وسيتبادلون الأدوار لبيان ما إذا كانت تلك العبارة صحيحة أم خاطئة. وسيُعطى كل منهم مدة قصيرة للرد. فإذا كان المشارك غير قادر على الإجابة، انتقل إلى المتدرب التالي. وترد الأسئلة والإجابات في الجدول المبين أدناه.

السؤال	«صواب» أم «خطأ»
اللعب والتواصل مع الطفل أمر مهم من أجل تحفيز نمائه	صواب
تكرار نفس اللعبة مرارًا وتكرارًا أمر ممل، ويجب على الوالدين منع الطفل من القيام بذلك	خطأ. يجب على الوالدين إبداء الاهتمام والسعادة بما يتعلمه الطفل من مهارات جديدة
على الوالدين شراء ألعاب لأطفالهم	خطأ. يمكن أن يلعب الطفل وهو سعيد بأغراض المنزل المأمونة
أطفال هذا العمر أصغر من أن تُعرض عليهم صور في كتاب	خطأ. يمكن للأطفال النظر إلى الصور والتحدث مع والديهم حول ما يرونه
يمكن للوالدين لعب ألعاب بكلمات بسيطة مع الأطفال في هذا العمر	صواب
التغذية والاستحمام من الفرص الجيدة للتحدث مع الطفل	صواب

السؤال	«صواب» أم «خطأ»
يمكن للوالدين إعطاء أطفالهم أشياء بسيطة للعب بها، ومن ثمَّ متابعة مهامهم الأخرى	خطأ. يجب على الأسر البقاء مع أبنائها وتشجيعهم من خلال مراقبة ما يقومون به وإعطائه مسميات
يجب أن يجد الآباء الوقت للاستجابة لأطفالهم بينما يحاولون التحدث	صواب



7.5.7 لعب الأدوار (12): تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء

تحتاج إلى: ألعاب أو أغراض منزلية؛

نسخ مطوية من سيناريوهات الحالات الثلاث.

أخبر المشاركين بأنهم سوف يقومون بلعب أدوار للتدرب على كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء.

وفي السيناريوهات الواردة أدناه، سيلعب المُيسِّر دور الأم، وسيلعب أحد المشاركين دور العامل الصحي المجتمعي.

أخبر المشاركين الثلاثة الذين سيلعبون دور العاملين الصحيين المجتمعيين أنه يجب عليهم أولاً فهم الوضع من خلال استمارة التسجيل، ثم تقديم المشورة وَفقًا لتقييمهم باستخدام الكتاب القلاب حتى يتمكنوا من تقديم المعلومات اللازمة، واستخدام الألعاب لتوضيح كيفية اللعب مع الطفل. ذكِّرهم بأن عليهم استخدام مهارات تواصل جيدة.

اسمح للمشارك الأول باختيار أحد السيناريوهات الثلاثة المطوية، ومن ثمَّ إعادتها إليك.

أخبرهم بأن عليهم تقديم المشورة للآباء بشأن اللعب والتواصل مع الطفل.

سيناريو الحالة 1

أنتِ هادية، والدة سها البالغة من العمر 14 شهرًا. وأنت تغنين لها، وقد علمتِها أسماء الأشياء مثل القطط والطيور. لديك الكثير من الأعمال المنزلية ولا تملكين الوقت للقيام بأكثر من ذلك.

ولا تلعبين معها لأنك لا تملكين ألعابًا.

سيناريو الحالة 2

أنتِ محاسن، والدة عبد الفتاح البالغ من العمر 18 شهرًا. وهو يقوم بالكثير من الحركات، وبالرغم من أنك تعتقدين أنه صغير جدًا على التواصل، تعطينه شُخشيخة للعب بها.

سيناريو الحالة 3

أنتِ درة، والدة ريهام البالغة من العمر 20 شهرًا. أنتِ تكرسين الوقت للعب معها، وأعطيتها مشابك ملابس لتضعها في وعاء ثم تخرجها منه. وكنتِ حريصة في البداية على أن تكون المشابك آمنة ولا تستطيع جرحها. وتعطينها صناديق بلاستيكية بأحجام مختلفة لترصها فوق بعضها البعض. كما أنك تغنين لها، ولكنك لا تعرفين ما يمكنك القيام به أيضًا.



الجلسة 34:
المكون 6: تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- مجموعتين من بطاقات لعبة الوقاية من الحوادث والإصابات
- طاولة

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- أنواع الحوادث التي تشكل خطرًا على الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- كيفية تقديم النصح للوالدين للوقاية من وقوع مثل تلك الحوادث في المنزل.

1.6.7 مناقشة جماعية: الوقاية من الحوادث والإصابات

ذكِّر المشاركين أنهم تعلموا بالفعل أن الإصابات المنزلية هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. واسأل المشاركين عن أنواع الحوادث التي يشيع حدوثها في صفوف الأطفال. استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي:

1. الشَّرَق والاختناق
2. الجروح والسقوط
3. الحروق
4. الغرق
5. التسمم

واطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 270 حتى 279 من الكتاب القلاب. وراجع كل نوع من أنواع الحوادث بالترتيب، مرورًا بالرسومات، واحدةً تلو الأخرى، واسأل المشاركين عن كيفية تقديم المشورة للأسر بشأن الوقاية منها.

أخبر المشاركين بأن الأطفال في هذا العمر يمكنهم المشي والوصول إلى الأشياء. ويجب على الوالدين أن يكونا أكثر يقظة، وألا يتركا طفلهما دون مراقبة، وأن يتأكدا من عدم وصوله لأي أغراض أو مواد ضارة.

الفت الانتباه إلى أنه بالرغم من تشابه أسباب الحوادث بشكل عام فيما بين الفئات العمرية، فهناك أخطار جديدة تظهر مع تزايد نمو الطفل وحركته. ففي هذا العمر، يمكن للأطفال الانزلاق أو التعثر أثناء المشي وإصابة أنفسهم. كما يمكن أن يسقطوا من النوافذ المفتوحة، ويلعبوا بأعواد الثقاب ويصلوا إلى مصادر النار والكهرباء، ولأنهم يتحركون، فيمكنهم التجول في الحمامات حيث يواجهون خطر الغرق في المرحاض.

2.6.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 270 حتى 279 من الكتاب القلاب. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين والواردة في الإطار الأحمر. وعند انتهائهم من القراءة، أجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

3.6.7 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث/ الإصابات

راجع مهارات التواصل التي تعلمها المشاركون، وطريقة استخدام استمارة التسجيل للمساعدة في فهم الموقف، وطريقة استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات الضرورية والمساعدة العملية إذا لزم الأمر. وذكِّر المشاركين بأن تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث يتطلب منهم ملاحظة البيئة المنزلية عن كَثَب أثناء الزيارات المنزلية. وإذا كان كل شيء على ما يُرام، فيجب عليهم أن يفكروا في تقديم بعض المعلومات عن الاحتياطات التي يتعين على الوالدين اتخاذها بينما يكبر أطفالهم. ويجب ألا يضيفوا الكثير من المعلومات دفعة واحدة.

4.6.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 62 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات، الوارد في الصفحة 74 من دليل المشارك.

5.6.7 لعبة بطاقات "صواب وخطأ" (2): تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات في الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين

ستحتاج إلى ما يلي:

- مجموعتين من لعبة بطاقات "صواب وخطأ " الخاصة بالوقاية من حوادث/ إصابات الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين؛
- طاولة

قسِّم المشاركين إلى فريقين. على أحد جانبي الطاولة ضع البطاقة المكتوب عليها «صواب»، وضع البطاقة المكتوب عليها «خطأ» إلى جوارها. ووزِّع مجموعة من البطاقات على كل فريق. وتتضمن البطاقات عبارات عن الوقاية من الحوادث والإصابات. وضِّح لهم أن عليهم قراءة العبارة. ومن ثَمَّ، يجب أن يضعوا العبارات الصحيحة أسفل بطاقة «صواب» ذات اللون الأخضر، والعبارات الخاطئة أسفل بطاقة «خطأ» ذات اللون الأحمر. أمهلهم 10 دقائق لترتيب البطاقات. وبعد انقضاء الدقائق العشرة، ناقش معهم أين وضع كل فريق بطاقاته، واشرح العبارة الواردة في كل بطاقة، وما إذا كانت صحيحة أم خطأ، مع ذكر السبب. ثم عِدّ البطاقات التي وُضعت على الجانب الصحيح من الطاولة وأعلن عن الفريق الفائز، وصفق له.

صواب	خطأ
يجب على الأم تحضير كل ما تحتاج إليه مسبقًا لتحميم طفلها	الطفل الآن كبير بما فيه الكفاية ليُترك دون إشراف
يجب عدم ترك حبال في أي مكان لتجنب قيام الأطفال بخنق أنفسهم	الأطفال الصغار لا يستطيعون الوصول إلى أواني الطبخ الموضوعة بالقرب من حافة الموقد
يجب على الأم عدم ترك أكياس بلاستيكية في مكان يستطيع الأطفال الوصول إليه، لتجنب الاختناق	يمكن للأمهات الطبخ مع أطفالهن في المطبخ
يجب على الأم إغلاق باب الحمام لمنع غرق الأطفال في المرحاض	الآن كبر الطفل ويمكنه النوم مع والديه دون أي خطر

صواب	خطأ
يجب وضع الأدوية، والمنظفات، ومبيدات الحشرات في مكان يتعذر على الأطفال الوصول إليه	يمكن ترك أدوات إصلاح الآلات (المسامير وغير ذلك) على الأرض
وضع مصدات للأطفال أعلى السلم وأسفله تُعد من احتياطات السلامة الضرورية	لا بأس أن ترد الأم على مكالمة هاتفية بينما تحمم طفلها



الجلسة 35:
تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
لا يوجد

الأهداف

خلال هذه الجلسة، سيراجع المشاركون ما يلي:

- مظاهر سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- المجالات الرئيسية لسوء المعاملة والإهمال؛
- كيفية الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن ذلك.

1.7.7 مناقشة جماعية: سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

استعرض مع المشاركين معنى وتأثير إساءة معاملة الأطفال، وإهمالهم، وممارسة العنف تجاههم، وكيفية الوقاية من ذلك.

2.7.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 280 حتى 287 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وعند الانتهاء من القراءة، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

3.7.7 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأسرة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

ذكِّر المشاركين بأنهم سيحتاجون عند تقديم المشورة للأسر إلى تطبيق مهارات الاتصال التي تعلموها، ويجب عليهم استخدام استمارة التسجيل لمساعدتهم على فهم الوضع. وسيتيح الكتاب القلاب المعلومات الضرورية، وسيوجههم نحو تقديم المساعدة العملية بحسب الحاجة.

وضِّح لهم أنه عند تقييم الموقف، سيتعين عليهم أن يراقبوا عن كَثَب ما يلي:

- نظافة الرضيع؛
- كيف تستجيب الأسرة عندما يبكي الطفل؛
- كيف تنظر الأم إلى الطفل وهي تحمله؛

- إذا ضرب أي شخص الطفل أو صاح به؛
- إذا كان هناك توتر بين الوالدين؛
- إذا كان لدى الرضيع ألعاب، بما في ذلك الأدوات المنزلية، وما إذا كانت نظيفة ومأمونة؛
- إذا كان هناك أي تمييز بين الأشقاء.



4.7.7 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 63 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف، الوارد في الصفحة 75 من دليل المشارك، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

زيارات منزلية لأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين
زيارة أطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين

أخبر المشاركين بأنه يجب عليهم التخطيط لزيارة هذه الفئة العمرية كل شهرين لمتابعة صحة الطفل ونموه ونمائه.

كما يجب عليهم التخطيط للزيارات مقدمًا، باستخدام قاعدة البيانات المتاحة للعاملين الصحيين المجتمعيين لتحديد المنازل التي يتواجد بها أطفال. وإذا تواجد أكثر من طفل في المنزل، أو إذا كانت الأم حاملاً مرةً أخرى، فيمكن للعاملين الجمع بين الرعاية المقدَّمة للأمهات ورعاية الأطفال الآخرين في زيارة واحدة.

ويجب أن يتوجه العاملون الصحيون المجتمعيون للزيارات مُصطحبين معهم مجموعة الأدوات التي حددها البلد لهذا الغرض، بالإضافة إلى استمارة التسجيل والكتاب القلاب. ويجب عليهم دائمًا استخدام مهارات التواصل التي تعلموها، واتباع الخطوات المشار إليها في استمارة التسجيل. وقد صُمِّمت الاستمارة لمساعدة العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد علامات الخطورة التي تشير إلى وجود حالات خطيرة تتطلب إحالة عاجلة. ويجب أن يتحقق العامل الصحي المجتمعي أولاً من وجود تلك العلامات، فإذا وجد أيًّا منها، فيجب أن يتخطى سائر المهام، ويقدم المشورة حول الإحالة.

ويجب استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات المتعلقة بالوضع. ومن المهم أن يفهم العاملون الصحيون المجتمعيون أنه لا يجب عليهم وحسب قراءة/ ترديد محتويات الكتاب، بل يجب عليهم أيضاً تكييف المعلومات التي يتضمنها حسب احتياجات الأسرة التي يقومون بزيارتها.

أخبر المشاركين بأنه من المهم الاحتفاظ بسجل لجميع الأطفال الذين يعيشون في المنازل الواقعة في المناطق المستهدفة بالخدمات، وأن يسجلوا جميع الزيارات التي قاموا بها.

اطلب منهم الاطلاع على الإطار 64 الخاص بالزيارات المنزلية لأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين، الوارد في الصفحة 76 من دليل المشارك.

الوحدة الثامنة

العناية بصحة ونماء الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام في المنزل

مقدمة

أخبر المشاركين أنهم سينتقلون الآن إلى الفئة العمرية الخامسة، أي الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام.

ستتألف عملية تقديم الرعاية لهذه الفئة العمرية من سبعة مكونات:

1. تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية: ممارسات طلب الرعاية الصحية للأطفال وممارسات الوقاية
2. تقديم المشورة حول التغذية
3. تقديم المشورة حول النظافة الشخصية
4. تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية
5. تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)
6. تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات
7. تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف



أخبر المشاركين بأنهم سيستخدمون استمارة التسجيل التي تشمل الأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمس سنوات، وأنهم سيواصلون استخدام الكتاب القلاب للحصول على المعلومات الضرورية، واستخدام دليل المشارك كوثيقة مرجعية.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى قسم الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام في الكتاب القلاب.



الجلسة 36:
المكون 1: تقديم المشورة حول ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية

مدة الجلسة
45 دقيقة

جهِّز
- مقطع الفيديو 23: تمرين مصور بشأن انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل والتنفس السريع

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- التعرُّف على علامات الخطورة التي تنطبق على هذه الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للأسر حول علامات الخطورة ودعم الإحالة؛
- تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية.

علاوة على ذلك، سيتمكنون من:
- مراجعة خطوات غسل اليدين؛
- التدرُّب على كيفية تعليم الأمهات غسل اليدين.

1.1.8 مناقشة جماعية: ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية. 1. ممارسات طلب الرعاية الصحية للأطفال

تحدث مع المشاركين حول ممارسات طلب الرعاية الصحية للأطفال التي تنطبق على الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام. وراجِع معهم علامات الخطورة التي تنطبق على تلك الفئة العمرية، وعندما يتعلق الأمر بالتنفس السريع، راجع كيفية حساب معدل سرعة التنفس والنقطة التي يبدأ عندها التنفس السريع لدى مختلف الفئات العمرية. ثم قل إنه بالنسبة للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام، تكون النقطة المحددة للتنفس السريع هي 40 نَفَسًا في الدقيقة أو أكثر.

إذا كان الطفل من:	الرضيع يعاني من تنفس سريع عندما تعد:
المواليد وصغار الرضَّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين	60 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر (في العد الثاني).
الرضع من شهرين حتى أقل من ستة أشهر	50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.
الرضّع من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد	50 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.
الأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من عامين	40 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.
الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام	40 نفَسًا/ الدقيقة أو أكثر.

2.1.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 65 الخاص بممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال في هذه الفئة العمرية، الوارد في الصفحة 78 من دليل المشارك، والصفحات من 288 حتى 293 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة.

وناقش أيضًا الإطارات الحمراء التي توجه عمل العاملين الصحيين المجتمعيين خلال الزيارات المنزلية.

3.1.8 تمرين الفيديو: انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل والتنفس السريع

أحضر مقطع الفيديو رقم 23 على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) لعرض تمرين يتعلق بانسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل والتنفس السريع (12:38 دقيقة)

راجع مع المشاركين النقطة المحددة للتنفس السريع لجميع الفئات العمرية، وتعريف انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل. وأكِّد على ضرورة الاهتمام بعمر الطفل عند اتخاذ قرار بشأن التنفس السريع .

أخبر المشاركين بأنهم سيتمرنون على عد معدل سرعة التنفس لتحديد ما إذا كان هناك تنفس سريع أم لا، وسيتمرنون على تحديد علامة انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل. اعرض تمرين الفيديو رقم 23، انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل والتنفس السريع.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحة 79 من دليل المشارك. هناك جدولان، حيث يتعلق الجدول الأعلى بالجزء الأول من التمرين على حساب معدل سرعة التنفس، واتخاذ قرار بشأن وجود تنفس سريع. وسيرى المشاركون طفلين: بحيث يمثل العمود الأول من الجدول عدد الحالات: حالة 1 وحالة 2. وفي العمود التالي سيتعين على المشاركين كتابة عمر الطفل. وفي العمود الثالث، سيكتبون عدد الأنفاس التي أحصوها. أما العمودان الأخيران فهما لقرار المشاركين بشأن ما إذا كان الطفل يتنفس بسرعة أم لا، ويجب أن يضعا علامة في العمود المقابل لقرارهم.

وعندما ينتهون من التمرين على حساب معدل التنفس، أخبرهم بأنهم سيطبقون الجزء الثاني من التمرين. اطلب منهم النظر في الجدول الآخر. وأخبرهم بأنهم سيلاحظون 7 أطفال، ويجب أن يقرروا ما إذا كانوا يعانون من انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل أم لا. وعليهم أن يضعوا علامة في العمود الذي يوافق قرارهم. فيما يلي إجابات هذا التمرين.

الجزء 1. حساب معدل التنفس

رقم الطفل	السن	عدد الأنفاس	تنفس سريع	لا يوجد تنفس سريع
1. مانو	4 سنوات	65 نفَسًا/ دقيقة	✓	
2. وومبي	ستة أشهر	66 نفَسًا/ دقيقة	✓	

الجزء 2. انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل

رقم الطفل	انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل	لا يوجد انسحاب للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل
1	✓	
2		✓
3	✓	
4	✓	
5		✓
6	✓	
7		✓



4.1.8 مناقشة جماعية: مَن الذي يجب طلب الرعاية الصحية للأطفال منه؟

اسأل المشاركين عن الأماكن التي يجب أن تتوجه إليها الأسر طلبا للرعاية الصحية لأطفالهم. واستمع إلى إجاباتهم، ثم أكّد على أنه يجب أن يكون مهنيو الرعاية الصحية المُدرَّبون مصدرًا لتقديم الرعاية الطبية للجميع. انصح الأسر بألا تطلب الرعاية الصحية من مصادر أخرى. فبدلاً من أن يحققوا المنفعة للطفل، فقد يسببون له الضرر. بل قد يصل الأمر إلى أن يتوفى الطفل جرّاء ذلك.



5.1.8 مناقشة جماعية. كيفية تقديم المشورة للأسر حول علامات الخطورة، والمساعدة في الإحالة

أكِّد على أن أي علامة خطورة تشير إلى احتمال وجود حالة صحية خطيرة، وأنه يتعين إحالة الطفل على وجه السرعة إلى المرفق الصحي.

انتقل إلى استمارة التسجيل، ووضح كيفية ملء القسم الخاص بعلامات الخطورة، ثم اسأل المشاركين عما يجب عليهم فعله في حالة وجود علامة خطورة. استمع إلى أقوالهم، ثم أكد أنه يجب عليهم إخبار الأسرة بأن حياة الطفل قد تكون معرَّضة للخطر، وأنه يحتاج إلى إحالة عاجلة إلى مرفق صحي. وسيتعين عليهم ملء مذكرة الإحالة -وضِّح لهم كيفية القيام بذلك- وتقديم المشورة للأم لإعطاء الطفل سوائل -غلوكوز، أو ماء، أو عصير فاكهة- في الطريق إلى المستشفى لتجنب انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم.



6.1.8 مناقشة جماعية: صعوبات تواجه إحالة الطفل

راجع مع المشاركين الصعوبات التي قد تنشأ عند إحالة الطفل إلى المستشفى، وكيف يمكن التغلب عليها.



7.1.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 294 حتى 297 من الكتاب القلاب، وراجع مرةً أخرى مذكرة الإحالة الموجودة في الصفحتين 27 و28 من دليل المشارك. ناقش معهم التعليمات الموجهة إلى العاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر.



8.1.8 مناقشة جماعية: ثانيًا: ممارسات الوقاية

راجع مع المشاركين ممارسات الوقاية التي تعلموها من قبل. وأبلغ المشاركين بأن ممارسات الوقاية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام هي نفس ممارسات الوقاية للأطفال الأصغر سنًا، وراجع الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لتقديم المشورة للأسر.



9.1.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 298 حتى 303 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المُقدَّمة للعاملين الصحيين المجتمعيين والواردة في الإطار الأحمر. وأجِب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



الجلسة 37:
المكون 2: تقديم المشورة حول التغذية

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- نسختين من سيناريوهات الحالات الست لتمرين لعب الأدوار رقم 13
- نسخًا من استمارتي التسجيل لكل مشترك ومُيسِّر

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- ماهية الطعام المغذي للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام؛
- كيفية إعداد الطعام المغذي للأطفال في هذه الفئة العمرية؛
- كمية الطعام وعدد مرات تقديمه للأطفال.
- كما سيتدربون على:
- كيفية تشجيع الأطفال على تناول الطعام (التغذية الفعالة)؛
- كيفية تقديم المشورة إلى الأسر بشأن إطعام الأطفال وتشجيعهم على تناول الطعام (التغذية الفعالة).

كما سيقومون أيضًا بـ:

مراجعة كيفية تقديم المشورة حول الممارسات التغذوية للأطفال في جميع الفئات العمرية.

1.2.8 مناقشة جماعية: تغذية الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام

ابدأ مناقشة حول ممارسات التغذية التي تعلَّمها المشاركون بالفعل. ووجِّه الحديث حول النقاط التالية:
- لبن الأم هو أفضل غذاء للمواليد؛
- يجب على الأمهات الاستمرار في إرضاع أطفالهن حتى يبلغوا الثانية من العمر. يستمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أشهر حتى أقل من عامين في الاستفادة من الرضاعة؛
- يوفر لبن الأم نصف الاحتياجات التغذوية للأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من عام واحد؛
- يوفر لبن الأم نصف الاحتياجات التغذوية للأطفال من عمر عام حتى أقل من عامين؛
- يساعد لبن الأم في حماية الأطفال من الإصابة بالمرض حتى أقل من سن عامين.

وعند الاقتراب من نهاية النقاش، أكِّد للمشاركين على ضرورة تلبية جميع الاحتياجات التغذوية للأطفال الذين يبلغون من العمر عامين فأكثر من خلال الطعام المقدّم لهم.

2.2.8 مناقشة جماعية. ما هي الأغذية التكميلية الجيدة؟

اسأل المشاركين عن خصائص الأغذية التكميلية الجيدة التي يجب تقديمها إلى الأطفال، واستمع إلى إجاباتهم، واذكر في النهاية أن تلك الأغذية تكون:

- غنية بالمُغذِّيات؛
- غنية بالطاقة؛
- مأمونة ومجهَّزة بطريقة صحية؛
- متاحة محليًا ومقبولة ثقافيًا.

ناقش مع المشاركين ما تعنيه تلك المصطلحات، مع إيلاء اهتمام خاص لأهمية تقديم نظام غذائي متنوع. وراجع أهمية العناصر الغذائية المختلفة ومصادرها، وأفضل طريقة لتقديم الطعام للأطفال.



3.2.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 304 حتى 309 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



4.2.8 مناقشة جماعية: تقديم الطعام للطفل

أكد على أن الأمهات لن يُرضعن أطفالهن بعد بلوغ سن الثانية. وسوف يبدأ الأطفال في تناول مجموعة أكثر تنوعًا من الأغذية - وببلوغ تلك المرحلة، يجب أن يأكلوا بصورة أساسية مما يأكله باقي أفراد الأسرة. ويجب تشجيعهم على تناول الطعام بأنفسهم، ومن طبقهم الخاص، وتحت إشراف الأهل.

ويجب أن تستمر التغذية المستجيبة للاحتياجات. وإذا لزم الأمر، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن يُخبروا الآباء والأمهات بأن محاولة إجبار الطفل على تناول الطعام ستأتي بنتائج عكسية.



5.2.8 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 310 و311 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



6.2.8 مناقشة جماعية: كميات الطعام وأنواعه

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 312 و313. وخذ الوقت الكافي لتوضيح أصناف الطعام، وكمياته، وقوامه، والوجبات الخفيفة المقدَّمة للأطفال، وعدد مرات تقديمها. ووضح أن الفاكهة الكاملة تظل وجبة خفيفة مثالية نظرًا لقيمتها الغذائية ومحتواها من الألياف. وتساعد الفاكهة على الوقاية من الإمساك، وتشجع الأطفال على تطوير مهارات المضغ. ومن خلال تشجيع الأطفال على تناول الفاكهة وشرب الماء والحليب، يُرسي الآباء أساس العادات الغذائية الصحية مدى الحياة.

كما أن دقيق الشوفان والزبادي يعدان من الأطعمة الخفيفة الممتازة.

أكد على ضرورة زيادة كمية الطعام وتنوعه مع تقدم الطفل في العمر.

7.2.8 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 312 و313 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة قديطرحونها.

8.2.8 مناقشة جماعية: التغذية الفعالة

ابدأ نقاشًا حول التغذية الفعالة. وعندما تتأكد من استيعاب المشاركين للمفهوم، وضِّح لهم:

- كيف يمكن تحويل أوقات تناول الطعام إلى فترات للتعبير عن الحب والمودة؛
- لماذا يجب أن يأكل الأطفال من صحن أو وعاء خاص بهم؛
- أسباب أهمية تجنب تشتيت الانتباه في أوقات تناول الوجبات؛
- لماذا يجب أن يتحلى الوالدان بالصبر إذا رفض طفلهما الطعام وألا يحاولا إجباره على تناول الطعام؛
- ما البدائل المتاحة للتنفيس عن الغضب؛

ما هو التأثير السلبي لإجبار الطفل على تناول الطعام

9.2.8 قراءة .

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 314 و315 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

10.2.8 مناقشة جماعية: مشكلات التغذية

اسأل المشاركين عما تعلموه بالفعل عن مشكلات التغذية، وكيفية تقديم المشورة للآباء والأمهات بشأنها. وأكِّد على أنه في هذا العمر يجب أن يستمر الأطفال في تجنب الوجبات السريعة ومشروبات الصودا. ثم ناقش مع المشاركين المشكلات التي تسببها تلك الوجبات والمشروبات لصحة الأطفال، خاصة إذا كانت مصحوبة بنقص في النشاط البدني.

11.2.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 316 حتى 321 من الكتاب القلاب، والإطار 66 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول التغذية، الوارد في الصفحة 80 عن تقديم المشورة حول التغذية من دليل المشارك. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



12.2.8 تمرين لعب الأدوار رقم 13: تقديم المشورة حول تغذية الأطفال حتى خمسة أعوام

ستحتاج إلى:

- استمارتي التسجيل

- كُتُب قلابة

- نسخ مطوية من سيناريوهات الحالات الست للعاملين الصحيين المجتمعيين

أخبر المشاركين أنهم سيتدربون على تقديم المشورة حول التغذية في جميع الفئات العمرية، باستخدام نموذج التسجيل المناسب والأقسام المناسبة من الكتاب القلاب.

وزع نسخًا من استمارتي التسجيل، كل على حدة (من عُمر الولادة - ستة أشهر، ومن ستة أشهر - خمسة أعوام) على المشاركين، وأخبرهم بأنهم سيتدربون الآن على تقديم المشورة حول تغذية الأطفال في جميع الفئات العمرية.

ووزِّع أجزاء سيناريوهات العاملين الصحيين المجتمعيين على المشاركين. وإذا كان هناك أكثر من ستة مشاركين، كرِّر السيناريوهات إلى أن يحين دور كل مشارك ليؤدي دور العامل الصحي المجتمعي. ويقوم المُيسِّر بدور الأم. وبعد كل تمرين من تمارين لعب الأدوار، افتح باب المناقشة ليجيب المشاركون عن الأسئلة التالية:

- هل اختار العامل الصحي المجتمعي استمارة التسجيل المناسبة، وملأها بشكل صحيح؟
- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي القِسم الصحيح من الكتاب القلاب؟
- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات التواصل الجيد؟ كيف ذلك؟
- هل قيَّم العامل الصحي المجتمعي الوضعَ بدقة؟
- هل نجح العاملون الصحيون المجتمعيون في تحديد المشكلة المتعلقة بالتغذية؟ وماذا كانت؟
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي المعلومات اللازمة؟
- هل هناك أي خطأ في المعلومات المقدمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يجب تصحيحها؟
- هل قدم العامل الصحي المجتمعي أي مساعدة عملية؟ وكيف كان ذلك؟
- هل كانت المساعدة العملية ضرورية؟
- هل تعتقد أن الأم اقتنعت بدرجة كافية للأخذ بنصيحة العامل الصحي المجتمعي؟
- إذا كانت الإجابة نعم، فكيف عرفت؟
- إذا كانت الإجابة لا، فكيف عرفت؟
- ما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟

سيناريو الحالة 1

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً حيث ولدت الأم منذ يومين. حلّل الموقف وقدم المشورة حول التغذية وفقاً لذلك مستخدمًا أدواتك. ومع تقييم مدى التقام الطفل ثدي أمه، وجدت أنه ضعيف.

سيناريو الحالة 1

الأم: لقد أنجبتِ ولدًا، اسمه رشيد، منذ يومين. وقمتِ بإرضاعه بعد نصف ساعة من مولده وتستمرين في إرضاعه ست مرات في اليوم. ولكنكِ لا ترضعينه ليلاً، وعندما تقومين بذلك، تتركين الطفل على كل ثدي لمدة خمس دقائق. تشعرين بأن الطفل جائع دائمًا وتريدين إعطاءه لبنًا اصطناعيًا حتى يصبح قويًا.

سيناريو الحالة 2

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً حيث يتواجد طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر. ومهمتك الرئيسية هي تقديم المشورة حول التغذية. وعندما قيَّمْت وضعية الطفل وتعلقه بالثدي، وجدت أنهما مناسبان.

سيناريو الحالة 2

الأم: أنتِ ترضعين ابنتك غالية البالغة من العمر ثلاثة أشهر ثلاث مرات في اليوم، وتعطينها اللبن الاصطناعي نفس العدد من المرات. وتعطينها اللبن الاصطناعي لأنك تشعرين بأن لبن الثدي ضعيف.

سيناريو الحالة 3

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً حيث يتواجد طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر. ومهمتك الرئيسية هي تقديم المشورة حول التغذية. وتجد أن تعلق الرضيع بالثدي مناسبًا.

سيناريو الحالة 3

الأم: أنتِ ترضعين ابنك ناصر ذا الثمانية أشهر نهارًا وليلاً عند الطلب. ولا تعطينه أي طعام آخر لأنك تعلمين أن لبن الأم يحتوي على جميع المغذيات التي يحتاج إليها.

سيناريو الحالة 4

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلًا حيث يتواجد طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا. ومهمتك الرئيسية هي تقديم المشورة حول التغذية.

سيناريو الحالة 4

الأم: أنتِ والدة عبد الرحمن البالغ من العمر 18 شهرًا. وتوقفت عن الرضاعة أمس لأنك تعتقدين أن الوقت قد حان لذلك. وتعطينه نصف كوب من البطاطا المهروسة مرتين في اليوم. وتغسلين يديك والأواني قبل إعداد البطاطس. وتقومين بهرسها في الخلاط وإضافة الحساء لتحويلها إلى سائل حتى يسهل على الطفل تناولها. وأحياناً تعطينه الأرز والخبز المهروسين. وفي كثير من الأحيان لا تغسلين الفواكه والخضروات لأنها ستوضع على النار وتتعرض للغليان. ويحصل الطفل على الحصة الخاصة به. وتجبرينه على إنهاء طعامه لأنك لا تملكين الوقت.

سيناريو الحالة 5

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلًا حيث يتواجد طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر. ومهمتك الرئيسية هي تقديم المشورة حول التغذية.

سيناريو الحالة 5

الأم: أنت والدة الطفلة حورية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر. وتعطينها كوبًا كاملاً من طعام العائلة أربع مرات في اليوم. وتحب عائلتك الطعام مضافًا إليه الكثير من الملح والتوابل. وأنت تغسلين يديك، والأواني، والخضروات قبل إعداد الطعام. وتعطين حورية وجبتين خفيفتين في اليوم، تكونان عادة عصير فاكهة وحلوى من تلك التي تشترينها من السوبر ماركت. وأحياناً تحب حورية شرب الصودا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تخرجين مع زوجك وابنتك التي تأكل شطيرة لحم. وفي اليوم الذي تذهبين فيه إلى المطعم لا تطبخين في المنزل.

ولا تسمحين لحورية بإطعام نفسها لأنها صغيرة جدًا. ولديها طبق خاص بحصتها من الطعام وقد اخترعت لها الألعاب لتشجيعها على تناول طعامها كله.

سيناريو الحالة 6

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً حيث يتواجد طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام ونصفًا. ومهمتك الرئيسية هي تقديم المشورة حول التغذية.

سيناريو الحالة 6

الأم: أنتِ والدة ياسين الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ونصفًا. وتعطينه من طعام العائلة. وتطعمينه اللحم، والدجاج، والفول، والبيض، والبطاطس، والسبانخ وخضروات أخرى، بالإضافة إلى الخبز. وتعطينه كوبًا كاملًا أربع مرات في اليوم. وتعطينه وجبتين خفيفتين يوميًا، بالإضافة إلى عصير الفاكهة. ولديه طبق خاص به وتسمحين له بإطعام نفسه بينما تقومين بالأعمال المنزلية. وتغسلين يديك، والخضروات، والأواني قبل إعداد الطعام، وتغسلين أيضًا يدي ابنك لأنه يُطعم نفسه.



الجلسة 38:
المكون 3: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- نُسختين من سيناريوهات الحالات الخمس لتمرين لعب الأدوار رقم 14 بشأن تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- مبادئ النظافة الشخصية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات حول النظافة الصحية للأطفال في هذه الفئة العمرية.

1.3.8 مناقشة جماعية: العناية بالنظافة الشخصية للطفل

راجع مع المشاركين ما تعلموه بالفعل حول العناية بالنظافة الشخصية للرضع. وأكِّد على أن النظافة الشخصية الجيدة ضرورية للغاية إذا ما أردنا الإبقاء على الرضع معافين وسعداء، وخالين من العدوى الجلدية وغير ذلك من أمراض.

أخبر المشاركين بأن العناصر العشرة للنظافة الشخصية التي تعلموها للرضع من عمر عام واحد حتى أقل من عامين ما زالت منطبقة على هذه الفئة العمرية.

1. الاستحمام
2. الحفاظ على نظافة مناطق الوجه، والرقبة، واليدين، والحفاض وتغيير الحفاضات إذا كان الطفل لا يزال يرتديها
3. تقليم الأظافر
4. الحفاظ على عدم انسداد الأنف
5. تنظيف عيني الطفل
6. تنظيف أذني الطفل
7. الحفاظ على نظافة ملابس الطفل
8. الحفاظ على نظافة ألعاب الطفل
9. تعقيم المنزل
10. العناية بصحة الفم/ الأسنان

    ويضاف إليها الآن عنصر جديد.
11. العناية بنظافة القدم.

استعرض كل عنصر بالتفصيل، مشيرًا إلى الصفحات من 322 حتى 331 من الكتاب القلاب.

ووضح أن العناية بأسنان الأطفال تساعد على ضمان صحة الأسنان في مرحلة البلوغ. وتستخدم الأمهات فرشاة ناعمة لتنظيف أسنان الرضيع، لكن يجب ألا يُستخدم معجون الأسنان قبل بلوغ سن الثالثة.

نظافة القدمين

في هـذا العمـر، يبـدأ الأطفـال انتعـال الأحذيـة. وعندمـا ينتعـل الطفـل الحـذاء طـوال اليـوم، خاصـة دون جـوارب، يتجمـع العـرق على القـدمين، وتتراكـم البكتيريـا، وتنبعـث مـن القـدمين رائحـة كريهـة.

لـذا، يجـب على الأمهـات غسـل أقـدام أطفالهـن بشـكل منتظـم، والحفـاظ على نظافتهـا مـن خلال فركهـا بـالماء والصابـون، مـع التنظيـف الدائـم بين أصابـع القـدمين وعلى الجوانـب الداخليـة مـن كل قـدم. ويجـب الحفـاظ على أظافـر القـدم نظيفـة ومُقلمـة.

2.3.8 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الصفحـات مـن 322 حتـى 331 مـن الكتـاب الـقلاب. وناقـش الرسـوم التوضيحيـة والنصائـح المقدَّمـة، وكيـف سـيتم اسـتخدامها في تقديـم المشـورة، وأجـب عـن أي أسـئلة قـد يطرحونهـا.

3.3.8 مناقشة جماعية: تعليم الطفل ممارسات النظافة الشخصية الجيدة

لا يتـعين على الوالديـن الاهـتمام بالنظافـة الشـخصية لطفلهـم فحسـب، بـل يجـب في هـذا العمـر أن يبـدؤوا تعليمـه ممارسـات النظافـة الشـخصية الجيـدة. ولـن يسـاعد ذلـك وحسـب على حمايـة الطفـل مـن الإصابـة بالأمـراض، بـل سيسـهم أيضًـا في جعلـه سـعيدًا وواثقًا بنفسـه.

اطلـب مـن المشـاركين الرجـوع إلى الصفحـات مـن 332 حتـى 335 مـن الكتـاب الـقلاب. واشرح ممارسـات النظافـة الشـخصية الجيـدة وطـرق تعليمهـا للأطفـال. وناقـش الصـور، وكيـف يمكـن اسـتخدامها لتقديـم المشـورة للوالديـن.

4.3.8 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الصفحـات مـن 332 حتـى 335 مـن الكتـاب الـقلاب. وعندمـا ينتهـون مـن القـراءة، أجـب عـن أي أسـئلة قـد يطرحونهـا.

5.3.8 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية للأطفال

راجـع الخطـوات الأربـع للتواصـل الجيـد والمهـارات المناسـبة لـكل خطـوة. وذكّـر المشـاركين بأنهـم كي يقدمـوا المشـورة حـول النظافـة الشـخصية يجـب أن يفهمـوا الوضـع مـن خلال الملاحظـة، واسـتخدام اسـتمارة التسـجيل - للأطفـال مـن عمـر ستة أشـهر حتـى أقـل مـن خمسـة أعـوام - لتوجيـه الأسـئلة، ومـن ثـمَّ تقديـم النصـح اسـتنادًا إلى المعلومـات الـواردة في الكتـاب الـقلاب.

اطلـب منهـم إلقـاء نظـرة على اسـتمارة التسـجيل، واشرح لهـم كيفيـة مـلء القسـم الخـاص بالنظافـة الشـخصية. اسـتعرض معهـم العمـود المذكـور فيـه مـا يجـب ملاحظتـه:

- إذا كان وجه الطفل، وعيناه، وأنفه، وأذناه نظيفة؛
- هل هناك رائحة تنبعث من الحفاض (إذا كان الطفل لا يزال يرتدي الحفاضات)؛
- هل أظافر الطفل قصيرة ونظيفة؛

- هل قدما الطفل نظيفتان؛
- هل ملابسه متسخة؛
- هل تبدو الألعاب نظيفة؛
- هل يبدو المنزل أنيقًا ومرتبًا.

إذا بدا كل شيء على ما يرام، فيجب أن يثنوا على الأم قبل استخدام استمارة التسجيل مرةً أخرى، وتوجيه أسئلة لها حول كيفية وتوقيت:

- تحميم الطفل؛
- تنظيف وجه الطفل، وعينيه، وأنفه، وأذنيه؛
- تغيير الحفاضات؛
- تقليم أظافر الطفل؛
- تنظيف ملابس الطفل؛
- تنظيف الألعاب؛
- تنظيف المنزل؛
- الاهتمام بصحة فم الطفل؛
- غسل قدمي الطفل.

ويتيح السؤال عن توقيت وكيفية اعتناء الأم بالنظافة الشخصية فرصةً للعامل الصحي المجتمعي كي يثني عليها، ويضيف المزيد إلى معلوماتها، ويزيد من ثقتها بنفسها. كما يتيح ذلك للعاملين الصحيين المجتمعيين سد أي ثغرات لاحظوها أثناء تقييمهم للوضع، واستخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات اللازمة. وذكِّر المشاركين بأن المشورة لا تعني مجرد قراءة/ ترديد محتويات الكتاب القلاب، ولكنها تتطلب منهم تقييم الوضع، وتقديم المعلومات التي تساعد على علاج المشكلات التي حددوها وحسب.

6.3.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 67 الخاص بكيفية تقديم المشورة للأمهات حول العناية بالنظافة الشخصية، الوارد في الصفحة 81 من دليل المشارك.

7.3.8 تمرين لعب الأدوار رقم 14: تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية للأطفال في جميع الفئات العمرية.

ستحتاج إلى ما يلي:

نُسخ من استمارتي التسجيل

نُسخ من سيناريو الحالات الخمس لتمرين لعب الأدوار رقم 14

أخبر المشاركين بأنهم سوف يقومون بلعب الأدوار للتدرب على كيفية تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية للطفل.

وزِّع سيناريوهات قسم العاملين الصحيين المجتمعيين، ونسخًا من استمارة التسجيل للمواليد والرضع حتى أقل من ستة أشهر، والأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمسة أعوام، على المشاركين الذين سيؤدون دور العاملين الصحيين

المجتمعيين. سيقوم المُيسِّر بدور الأم. وإذا كان هناك أكثر من خمسة مشاركين في المجموعة، كرِّر السيناريوهات إلى أن يحصل كل مشارك على فرصة للقيام بدور العامل الصحي المجتمعي. اطلب من المشاركين مراقبة لعب الأدوار بعناية والاستعداد للمناقشة. لا بد أن يعقب كل تمرين من تمارين لعب الأدوار نقاش يمكن للمشاركين الإجابة من خلاله عن الأسئلة المذكورة أدناه.

- هل اختار العامل الصحي المجتمعي استمارة التسجيل الصائبة، وملأها بشكل صحيح؟
- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي القِسم الصحيح من الكتاب القلاب؟
- هل استخدم مهارات التواصل الجيد؟ إذا كانت الإجابة (نعم)، فكيف قام بذلك؟ إذا كانت الإجابة (لا)، ما الذي يحتاج إليه العامل الصحي المجتمعي لتحسين تواصله؟
- هل قيَّم الوضع بدقة؟
- هل نجح في تحديد الأشياء التي أبلت الأم فيها بلاءً حسنًا، وأثنى عليها؟
- هل حدد أي ممارسات سيئة تتعلق بالنظافة الشخصية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا كانت؟
- هل استخدم الكتاب القلاب بشكل صحيح؟
- هل هناك أي خطأ في المعلومات المقدمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يجب تصحيحها؟
- هل قدَّم العامل الصحي المجتمعي أي مساعدة عملية؟ وكيف كان ذلك؟
- هل كانت المساعدة العملية ضرورية؟
- هل نصح الأم بتوجيه طفلها نحو اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الحاجة؟
- هل تعتقد أن الأم اقتنعت بدرجة كافية للأخذ بنصيحة العامل الصحي المجتمعي؟
- إذا كانت الإجابة (نعم)، فكيف عرفت؟
- إذا كانت الإجابة (لا)، فكيف عرفت؟
- ما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟

سيناريو الحالة 1

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً يوجد فيه طفل يبلغ من العمر يومين. ويجب أن تقيم الوضع وتقدم المشورة حول النظافة الشخصية للمواليد. وتخلو المنطقة من الملاريا.

وعندما تلاحظ المولود تجد أن وجهه، ويديه، ورقبته، وملابسه، وأظافره نظيفة. ولا تنبعث رائحة كريهة من حفاضه. والبيت نظيف ومرتَّب للغاية: فلا غبار، ولا بعوض، ولا ذباب، وكل شيء في مكانه.

سيناريو الحالة 1

الأم: أنتِ والدة الطفلة نيللي التي تبلغ من العمر يومين. وقد حممتها باستخدام الإسفنجة، كما أنك تنظفين وجهها، وعينيها، وأذنيها، ويديها بانتظام. وتنظفين الجزء المتبقي من الحبل السُّري باستخدام الكلورهيكسيدين. وتنظفين عينيها باستخدام كرة من القطن؛ من الداخل إلى الخارج، كما تنظفين أذنيها من الخارج. ولا تضعين أي شيء داخل أذنيها، وتحافظين على ملابسها نظيفة، وتغيّرين لها الحفاض بانتظام لتجنب عدوى الجلد والتهيج. وتقلمين أظافرها لتجنب الخدوش، وتحافظين على نظافة منزلك، ولا يوجد غبار، أو ذباب، أو بعوض (هذه ليست منطقة انتشار ملاريا).

سيناريو الحالة 2

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً يوجد فيه رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر. ويجب أن تقيِّم الوضع وتقدم المشورة حول النظافة الشخصية. وتجد أن الرضيع غير نظيف، وأظافره طويلة وقذرة، وملابسه متسخة، والرائحة تنبعث من حفاضه، وكان المنزل أنيقًا ومرتبًا.

سيناريو الحالة 2

الأم: أنتِ والدة الطفل سميح الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر. وتحممين طفلك بالإسفنجة مرة كل أسبوع. وتغيرين ملابسه وحفاضه في نهاية اليوم حتى يتوجه للنوم نظيفًا. ولأنه لا يجلس ولا يمشي تعتقدين أنه لا داعي لغسل يديه، وتفعلين ذلك عندما يستحم، وهو نفس الوقت الذي تنظفين فيه أيضًا عينيه وأذنيه. وأنتِ تنتظرين أن ينمو قليلاً قبل أن تبدئي في تقليم أظافره.

سيناريو الحالة 3

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً يوجد فيه رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر. ويجب أن تقيم الوضع وتقدم المشورة حول النظافة الشخصية. وقد لاحظت أن ملابس الطفل، ووجهه، وأذنيه، وعينيه نظيفة، وأظافره طويلة ومتسخة، وكان المنزل نظيفًا ومرتبًا بشكل جيد.

سيناريو الحالة 3

الأم: أنتِ والدة الطفل زياد الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر. أنتِ تحممينه في حوض الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع، وتنظفين وجهه، وأذنيه، وعينيه. وقد قيل لكِ إنكِ يجب أن تنتظري حتى يكبر قبل أن تقلمي أظافره. ولا تنظفين فمه لأنه ليس لديه أسنان بعد.

سيناريو الحالة 4

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً يوجد فيه رضيع يبلغ من العمر 18 شهرًا، ويجب أن تقيّم الوضع وتقدم المشورة حول النظافة الشخصية. وقد لاحظتَ أن ملابس الطفل، ووجهه، ويديه، وأظافره متسخة، وكذلك ألعابه، والبيت تعمه الفوضى. وكانت الأم تصرخ في زينب عند قدومك لأنها كانت ترمي الأشياء.

سيناريو الحالة 4

الأم: أنتِ والدة زينب البالغة من العمر 18 شهرًا. وتحممينها مرة واحدة في الأسبوع في حوض استحمام البالغين. كما أنك تشكين من أنها أصبحت غير مطيعة منذ أن تعلمت المشي وأصبحت تتعبك كثيرًا، وليس لديك الوقت لتغيير ملابسها أو غسل يديها بانتظام، ولا تفرشين أسنانها لأنها صغيرة للغاية.

سيناريو الحالة 5

العامل الصحي المجتمعي: أنت تزور منزلاً به طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام. ويجب أن تقيّم الوضع وتقدم المشورة حول النظافة الشخصية.
وقد لاحظت أن ملابس الطفلة ووجهها ويديها وأظافرها نظيفة. كما لاحظت أيضًا أن ألعاب الطفلة نظيفة، وكان المنزل نظيفًا ومرتبًا بشكل جيد، وكانت الطفلة تنتعل في قدميها حذاءً تفوح منه رائحة كريهة.

سيناريو الحالة 5

الأم: أنتِ والدة الطفلة فرحة التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام. وأنت تحممينها في حوض استحمام الكبار مرة في الأسبوع. وتجعلينها تشارك في وقت الاستحمام بأن تختار الألعاب التي ستأخذها معها للحمام، ومناشفها، وملابس نومها.
وتغيرين ملابسها بانتظام وتنظفين وجهها، وعينيها، ويديها، وألعابها. وتفرشين أسنانها مرتين في اليوم باستخدام فرشاة أسنان ناعمة والماء، لكنكِ لا تستخدمين معجون الأسنان لأنكِ سمعت أنه غير مناسب لها، ولا تعلمين أن عليك غسل قدميها كل يوم.



الجلسة 39:
المكون 4: تقديم المشورة حول معالم النماء الرئيسية

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- فهم أهمية متابعة معالم النَّماء الرئيسية لدى الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام؛
- التعرُّف على معالم النَّماء الرئيسية للرضع التي تنطبق على تلك الفئة العمرية؛
- تقديم المشورة للآباء حول تلك المعالم.

1.4.8 مناقشة جماعية: معالم النَّماء الرئيسية

ابدأ بالتأكيد على أهمية معرفة الوالدين بمعالم النَّماء الرئيسية التي يجب عليهم ملاحظتها على الطفل، ومتى وكيف يتعرفون عليها. ووضِّح أن هذه الفئة العمرية تُقسم إلى عدة أعمار وَفقًا لظهور معالم نماء رئيسية جديدة. وضِّح أنه يتعين على العامل الصحي المجتمعي تقديم المشورة للوالدين حول المراحل التي يجب عليهم ملاحظتها أثناء نمو طفلهم، واستشارة الطبيب إذا حدث أي تأخير.

اطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحات من 336 حتى 341. باستخدام الرسوم التوضيحية، واشرح المعالم الرئيسية، والأعمار التي تنطبق عليها، بدءًا بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام، ثم انتقل إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام، واختم بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة وخمسة أعوام.

سيحتاج العامل الصحي المجتمعي إلى مراجعة التدريب على استخدام المرحاض، وتقديم المشورة والمساعدة العملية إذا لزم الأمر.

2.4.8 مناقشة جماعية: تأثير التمارين البدنية، وساعات النوم، وتقليل أوقات الخمول على نماء الطفل

استعرض مع المشاركين تأثير النشاط البدني، وساعات النوم، والحد من أوقات الخمول على النمو والنماء بأسلوب صحي. يجب على الأطفال في هذا العُمر ممارسة الأنشطة البدنية –مثل الركض، والرقص، ولعب الكرة وما إلى ذلك– لمدة 180 دقيقة على الأقل في اليوم. ويحتاج الأطفال ما بين 10 و13 ساعة من النوم يوميًا، متضمنة أوقات القيلولة، ويجب أن يوضع لهم روتين للنوم المنتظم. ويجب على الآباء التأكُّد من هدوء الجو العام عند النوم.

ويجب الحد من أوقات الخمول إلى القدر الأدنى، فحتى إذا مارس الطفل نشاطًا بدنيًا كافيًا، فهو لا يزال بحاجة إلى مشاركة الوالدين له بصورة فعالة على مدار اليوم.

3.4.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 336 حتى 345 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المقدمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

4.4.8 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة للأمهات حول معالم النَّماء الرئيسية

من الضروري أن يدرك الوالدان أهمية متابعة نماء أطفالهم من خلال رصد معالم النَّماء الرئيسية، والتعرف على حالات التأخر. اسأل المشاركين عن كيفية تقديمهم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية. واستمع إلى إجاباتهم قبل أن توضح لهم أنه يجب أن يلاحظوا أولاً ما يمكن للطفل القيام به: يمكنهم مثلاً تقديم قلم رصاص وورقة وملاحظة الطفل وهو يرسم، ومشاهدته أثناء اللعب لمعرفة ما إذا كان يستطيع اللحاق بالكرة، أو القفز، أو تسلق الأثاث، أو غناء أغنية يعرفها. ويجب عليهم ملاحظة الطفل جالسًا، وواقفًا، وماشيًا، مع تدوين الملاحظات في القسم المناسب من استمارة التسجيل.

وعندما يقدمون المشورة للأسر بشأن علامات النَّماء الرئيسية، سيتناولون الآتي:

- السبب في أهمية معالم النَّماء الرئيسية؛
- أهمية متابعة تلك المعالم؛
- ماذا تعني معالم النَّماء الرئيسية للطفل، ولماذا يجب على الأسرة استشارة الطبيب إذا كان هناك تأخر في ظهورها؛
- ساعات النوم؛
- التمارين البدنية؛
- عدد ساعات الخمول التي يمضيها الطفل كل يوم.

من الضروري تعليم أفراد الأسرة معالم النَّماء التي يتعين عليهم ملاحظتها على طفلهم، وأوان ظهورها. تحقق من أن المشاركين قد فهموا بالكامل المعالم الرئيسية التي تنطبق على مختلف المراحل في تلك الفئة العمرية.

5.4.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 68 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية، الوارد في الصفحة 82 من دليل المشارك.



الجلسة 40:
المكون 5: تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)

مدة الجلسة
30 دقيقة

جهِّز
- الألعاب
- مقطع الفيديو رقم 24، العب وتواصل: من سن عامين إلى خمسة أعوام.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- تقييم كيفية لعب الوالدين وتواصلهم مع أطفالهم من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام؛
- تقديم النصح للوالدين بشأن اللعب والتواصل؛
- مساعدة الوالدين على تعزيز المهارات الأساسية لمقدمي الرعاية، وتحسين قدرتهم على الاستجابة لمصالح الطفل واحتياجاته.

1.5.8 مناقشة جماعية: ما المقصود بالرعاية من أجل نماء الطفل؟

راجع المقصود بالعناية من أجل النماء، وكيف يمكن للأسر أن تشارك في تحفيز النمو النفسي والاجتماعي لأطفالهم. وذكِّر المشاركين بأن جميع أفراد الأسرة يجب أن يساهموا في الرعاية من أجل نماء الطفل. وأخبر المشاركين بأن طريقة لعب الوالدين وتواصلهم مع طفلهم ستختلف وفقًا لمرحلة نمائه وعمره. واطلب من المشاركين فتح الكتاب القلاب على الصفحتين 346 و347. وباستخدام الرسومات والنصائح المكتوبة، اشرح لهم كيف يمكن للوالدين اللعب والتواصل مع طفلهم.بدءًا من عمر عامين وحتى أقل من خمسة أعوام، يتعلم الأطفال مطابقة الألوان والأشكال وكذلك العد. فهم ينصتون لما يُقال لهم ويفهمونه بشكل متزايد، ويميلون إلى تقليد أفراد الأسرة الأكبر سنًا والأشقاء الذين يجب أن يكونوا مثالاً جيدًا لهم. لذلك فإن الصبر مطلوب عندما يتعلّم الطفل. ويجب عدم توبيخ الأطفال عند ارتكابهم الأخطاء، بل يجب تصحيحهم برفق.

2.5.8 فيديو توضيحي. اللعب والتواصل مع الأطفال من عُمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام

جهِّز مقطع الفيديو رقم 24 (02:11 دقيقة) على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD)

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون مقطع فيديو حول اللعب والتواصل مع الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام.

اعرض مقطع الفيديو. وعندما ينتهي المقطع، أجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

3.5.8 قراءة

اطلب من المشاركين الاطلاع على الصفحتين 346 و347 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة تبادرت لأذهانهم.

4.5.8 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (الْعب وتواصل)

استعرض مع المشاركين كيفية تقديم المشورة للوالدين حول العناية من أجل النماء باستخدام استمارة التسجيل والكتاب القلاب.

5.5.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 69 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)، الوارد في الصفحة 83 من دليل المشارك.



الجلسة 41:
المكون 6: الوقاية من الحوادث والإصابات

مدة الجلسة
60 دقيقة

جهِّز
- مجموعتين من بطاقات لعبة «صواب وخطأ» حول الوقاية من الحوادث والإصابات
- طاولتين

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:
- أنواع الحوادث التي تشكل خطرًا على الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام؛
- كيفية تقديم المشورة للوالدين بشأن الوقاية من مثل تلك الحوادث.

1.6.8 مناقشة جماعية: الوقاية من الحوادث

ذكِّر المشاركين أنهم تعلموا بالفعل أن الإصابات التي تقع في المنزل هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في صفوف الأطفال دون سن الخامسة. اسأل المشاركين عن أنواع الحوادث التي يشيع حدوثها في صفوف الرضع. استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي:

1. الشَّرَق والاختناق
2. الجروح والسقوط
3. الحروق
4. الغرق
5. التسمم

اطلب من المشاركين الرجوع إلى الصفحات من 348 حتى 361 من الكتاب القلاب. واسألهم عن رأيهم في كل رسم، ثم استعرض أنواع الحوادث واحدًا تلو الآخر، واشرح لهم نقاط الضعف لدى الأطفال في تلك الفئة العمرية. أكِّد لهم أن الأطفال في تلك الفئة العمرية يمكنهم المشي والجري والتسلق. لذا، يجب وضع وسائل حماية عند الضرورة على النوافذ، وحواجز أمان أعلى الدرج وأدناه. ويجب إغلاق الخزائن التي تُحفَظ فيها الأغراض والمواد الخطرة. ويجب تخزين علب الكبريت، والمكاوي الساخنة، وأواني الطهي، والأشياء التي قد تكون خطيرة مثل السكاكين والمقصات، بعيدًا عن متناول الطفل، ويجب تغطية مقابس الكهرباء. وهذا يدل على ضرورة الإشراف على الطفل طوال الوقت.

شدد على أن تلك الفئة العمرية أكثر عُرضة للمخاطر من حيث التعرض للحوادث، لأن الأطفال يستطيعون المشي، وصعود السلم والنزول منه، وتسلق الأثاث، والجري. وقد تكون الحوادث في هذا العمر أكثر خطورة من مثيلتها في الفئات العمرية الأخرى.

الحوادث في الأماكن الخارجية

أبلغ المشاركين أننا بحاجة لأن نضيف إلى القائمة الواردة أعلاه فئة أخرى وهي الحوادث التي تحدث في الأماكن الخارجية. ففي هذا العمر، يهتم الأطفال باستكشاف العالم من حولهم. لذا، يحتاج الوالدان إلى التأكد من أن أبواب المنزل مغلقة بحيث لا يتمكن الأطفال من التجول بمفردهم، فحتى الأغراض التي تبدو مأمونة، مثل برميل مملوء

بـالماء، أو بئر، أو بركـة، قـد تكـون بالغـة الخطـورة بالنسـبة لطفـل فضـولي متروك دون إشراف. وقـد يتعـرض الأطفـال في الشـوارع لحـوادث السـيارات، لـذا لا يجـب الـسماح لهـم بالخـروج بمفردهـم، ويجـب أن يـسيروا وهـم ممسـكين بيـد أحـد الوالديـن. ويجـب أن يبـدأ الوالـدان في تعليـم أطفالهـم مـا يتعلـق بالسلامـة على الطـرق.

2.6.8 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الصفحـات مـن 348 حتـى 363 مـن الكتـاب الـقلاب. وناقـش الرسـوم التوضيحيـة والنصائـح المقدَّمـة، وكيـف سـيتم اسـتخدامها في تقديـم المشـورة، وأجـب عـن أي أسـئلة قـد يطرحونهـا.

3.6.8 مناقشة جماعية. كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث

راجـع مهـارات التواصـل التـي تعلَّمهـا المشـاركون، وطريقـة اسـتخدام اسـتمارة التسـجيل للمسـاعدة في تقييـم الوضـع، وطريقـة اسـتخدام الكتـاب الـقلاب لتقديـم المعلومـات الضروريـة، والمسـاعدة العمليـة إذا لـزم الأمـر.

وذكِّـر المشـاركين أن تقديـم المشـورة حـول الوقايـة مـن الحـوادث يتطلـب منهـم ملاحظـة البيئـة المنزليـة عـن كَثَـب أثنـاء الزيـارات المنزليـة. وإذا كان كل شيء على مـا يُـرام، فيجـب عليهـم أن يفكـروا في تقديـم بعـض المعلومـات عـن الاحتياطـات التـي يتـعين على الآبـاء اتخاذهـا بيـنما يتقـدم أطفالهـم في العمـر.

4.6.8 قراءة

اطلـب مـن المشـاركين قـراءة الإطـار 70 الخـاص بكيفيـة تقديـم المشـورة للأسر بشـأن الوقايـة مـن الحـوادث والإصابـات، الـوارد في الصفحـة 84 مـن دليـل المشـارك.

5.6.8 لعبة بطاقات "صواب وخطأ" 3 حول تقديم المشورة حول الوقاية من الحوادث والإصابات في صفوف الأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام

ستحتاج إلى ما يلي:

مجموعتين من لعبة بطاقات "صواب وخطأ" 3

طاولتين

أبلـغ المشـاركين أنهـم سـيلعبون لعبـة بطاقـات "صـواب وخطـأ" لمراجعـة معلوماتهـم حـول الوقايـة مـن الحـوادث والإصابـات في هـذه الفئـة العمريـة.

قسِّـم المشـاركين إلى فريـقين. على أحـد جانبـي الطاولـة ضـع البطاقـة المكتـوب عليهـا «صـواب»، ثـم ضـع البطاقـة المكتـوب عليهـا «خطـأ» إلى جوارهـا. ووزِّع مجموعـة مـن البطاقـات على كل فريـق. تتضمـن البطاقـات عبـارات عـن الوقايـة مـن الحـوادث والإصابـات. وضِّـح لهـم أن عليهـم قـراءة العبـارة. ومـن ثـمَّ، يجـب أن يضعـوا العبـارات الصحيحـة إلى جـوار بطاقـة «صـواب» ذات اللـون الأخضر، والعبـارات الخاطئـة إلى جـوار بطاقـة «خطـأ» ذات اللـون الأحمـر.

أمهلهـم 10 دقائـق لترتيـب البطاقـات. وبعـد انقضـاء الدقائـق الـعشر، ناقـش معهـم أيـن وضـع كل فريـق بطاقاتـه، واشرح

العبـارة الـواردة في كل بطاقـة، ومـا إذا كانـت صحيحـة أم خاطئـة، مـع ذكـر السـبب.

عدّ البطاقات التي وُضعت على الجانب الصحيح من الطاولة، ثم أعلن عن الفريق الفائز.

صواب	خطأ
على الوالدين تركيب حواجز على النوافذ لحماية الأطفال من السقوط	ليس هناك ضرر من ترك طفل لوحده للعب في الفناء بجانب البيت
يجب ألا يُترك الحبل في أي مكان لتجنب قيام الأطفال بخنق أنفسهم به	يمكن ترك الأطفال يعبرون الطرق بمفردهم بمجرد أن يتعلموا احتياطات السلامة على الطرق
يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة للأطفال وألا يلعبوا بأعواد الثقاب أو الشرر أو أي مصدر آخر للنار	الأطفال في هذا العمر كبار بما يكفي ليستحموا بأنفسهم دون إشراف
يجب على الأمهات إغلاق باب المطبخ ووضع أقفال على خزانات المطبخ	يمكن أن ينام الأطفال في هذا العمر مع آبائهم دون مخاطر
يجب تغطية المنافذ الكهربائية لتجنب تعرض الأطفال للصدمات الكهربائية	يجب أن يترك الوالدان أطفالهم يجربون لمس النار حتى يفهموا خطورتها
على الوالدين تعليم الأطفال عدم الاقتراب من مصادر النار والمنافذ الكهربائية	يجب على الأمهات السماح لبناتهن بتقطيع الطعام بالسكين لتعليمهن الطهي



الجلسة 42:
المكون 7: تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

مدة الجلسة
30 دقيقة

المعدات
لا يوجد

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتعرف المشاركون على:

- مظاهر سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- المجالات الرئيسية لسوء المعاملة والإهمال؛
- كيفية الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن ذلك.

1.7.8 مناقشة جماعية: الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف

راجع مع المشاركين معنى وتأثير إساءة معاملة الأطفال، وإهمالهم، وممارسة العنف ضدهم، وكيفية الوقاية من ذلك، ثم ابدأ نقاشًا حول الفرق بين الانضباط والعقاب. أدِر النقاش، مع التركيز على النقاط التالية:

- غالبًا ما يتم الخلط بين الانضباط والعقاب؛
- يستخدم بعض الآباء العقاب البدني لتصحيح سلوك أطفالهم وتغييره، في حين أن ما يجب عليهم القيام به هو تعليم الانضباط الذي يتضمن تدريب الأطفال ومساعدتهم على تكوين أحكام، والشعور بالحدود، وضبط النفس، والاكتفاء بالذات، والسلوك الاجتماعي الإيجابي؛

من الوارد أن تتضرر صحة الأطفال ونماؤهم في الأسر التي تُساء فيها معاملة أم الطفل وأشقائه. 2.7.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 364 حتى 371 من الكتاب القلاب. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

3.7.8 مناقشة جماعية: كيفية تقديم المشورة حول الوقاية من الإهمال، والعنف، وسوء المعاملة

ذكِّر المشاركين بأنهم سيحتاجون عند تقديم المشورة للأسر إلى تطبيق مهارات التواصل التي تعلموها، ويجب عليهم استخدام استمارة التسجيل لمساعدتهم على تقييم الوضع. وسيقدم الكتاب القلاب المعلومات الضرورية، وسيوجههم نحو تقديم المساعدة العملية إذا لزم الأمر.

وضِّح لهم أنه عند تقييم الموقف، سيتعين عليهم أن يراقبوا عن كَثَب ما يلي:

- نظافة الطفل؛
- كيف تستجيب الأسرة عندما يبكي الطفل؟ (هل يُترك بمفرده؟)

- هل ضرب أي شخص الطفل أو صاح به؟
- هل يوجد توتر بين الوالدين؟
- هل لدى الرضيع ألعاب؟ وهل هي نظيفة ومأمونة؟
- هل يوجد تمييز بين الأشقاء؟



4.7.8 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 71 الخاص بكيفية تقديم المشورة حول الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف، الوارد في الصفحة 85 من دليل المشارك.

الزيارات المنزلية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام

أخبر المشاركين بأنه يجب عليهم التخطيط لزيارة هذه الفئة العمرية كل شهرين لمتابعة صحة الطفل، ونموه، ونمائه.

كما يجب لهم التخطيط للزيارات مقدمًا، باستخدام قاعدة البيانات المتاحة للعاملين الصحيين المجتمعيين لتحديد المنازل التي يتواجد بها أطفال. وإذا تواجد أكثر من طفل في المنزل، أو إذا كانت الأم حاملاً مرة أخرى، فيمكن للعاملين الجمع بين الرعاية المقدمة للأمهات ورعاية الأطفال الآخرين في زيارة واحدة.

يجب أن يتوجه العاملون الصحيون المجتمعيون إلى الزيارات مُصطحبين معهم مجموعة الأدوات التي خصصها البلد، بالإضافة إلى استمارة التسجيل والكتاب القلاب. ويجب عليهم دائمًا استخدام مهارات التواصل التي تعلموها، واتباع الخطوات المشار إليها في استمارة التسجيل. وقد صُمِّمت الاستمارة لمساعدة العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد علامات الخطورة التي تشير إلى وجود حالات خطيرة تتطلب إحالةً عاجلة. ويجب أن يتحقق العامل الصحي المجتمعي أولاً من وجود تلك العلامات، فإذا وجد أيًا منها، فيجب أن يتخطى سائر المهام، ويقدم المشورة حول الإحالة.

ويجب استخدام الكتاب القلاب لتقديم المعلومات المتعلقة بالوضع. ومن المهم أن يفهم العاملون الصحيون المجتمعيون أنه لا يجب عليهم قراءة محتويات الكتاب فحسب، بل عليهم أيضًا تكييف المعلومات التي يتضمنها حسب احتياجات الأسرة التي يقومون بزيارتها.

أخبر المشاركين بأنه من المهم أن يحتفظوا بسجل لجميع الأطفال الذين يعيشون في المنازل الواقعة في المناطق المستهدفة بالخدمات، وأن يسجلوا جميع الزيارات التي قاموا بها.

اطلب منهم الاطلاع على الإطار 72 الخاص بالزيارات المنزلية للأطفال من عمر عامين حتى أقل من خمسة أعوام، الوارد في الصفحة 86 من دليل المشارك.

الوحدة التاسعة

العناية بصحة الأمهات في المنزل

مقدمة

تأتي العناية بصحة الأم في المنزل في الصميم من رعاية العاملين الصحيين المجتمعيين للمواليد والأطفال دون سن الخامسة.

اسأل المشاركين عن السبب وراء أهمية التعامل مع المشكلات المتصلة بصحة الأمهات أثناء قيامهم بزيارات منزلية للمواليد والأطفال. ووضِّح أن عافية الأم لها أثر عميق على صحة الأطفال، وخاصة صحة المواليد.

وخلال الزيارات المنزلية، ستتوقف الرعاية والمشورة التي يقدمها العامل الصحي المجتمعي للأم على ما إذا كانت الأم حاملاً، أو قد ولدت بالفعل.





الجلسة 43:
العناية بصحة النساء الحوامل

مدة الجلسة
90 دقيقة

جهِّز
- نُسخًا من استمارتي التسجيل
- مستلزمات غسل اليدين:
  - صابون
  - إبريق ماء
  - إناء كبير
  - منشفة نظيفة
- ضع على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) مقطع الفيديو رقم 2، وهو عن الحفاظ على تدفئة الطفل، ومقطع الفيديو رقم 3، وهو عن ملامسة جلد الأم لجلد الطفل، ومقطع الفيديو رقم 4، وهو عن البدء المبكر في الرضاعة
- حاسوبًا (كمبيوتر) محمولًا، وجهاز عرض البيانات
- شاشة
- المواد اللازمة لتوضيح ملامسة جلد الأم لجلد الطفل:
  - دُمية
  - غطاء للرأس
- جوارب
- حفاض
- قطعة كبيرة من القماش لربطها حول الأم
- سترة أو قميص

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قد:
- فهموا عناصر العناية بصحة النساء الحوامل؛
- تعرفوا على علامات الخطورة لدى النساء الحوامل؛
- قدَّموا المشورة للأسر بشأن علامات الخطورة، وساعدوا في الإحالة؛
- تدربوا على تقديم المشورة حول صحة المرأة الحامل.

1.1.9 مناقشة جماعية: العناية بصحة النساء الحوامل

ابدأ نقاشًا حول العناية بصحة النساء الحوامل. ووجِّه الحديث حول النقاط التالية:
- صحة الوليد تبدأ بصحة الأم؛
- كلما بدأت الرعاية مبكرًا في الحمل، زادت الفوائد التي تعود على الأم والطفل معًا.

اسأل المشاركين عن عدد الزيارات التي يعتقدون أنهم بحاجة للقيام بها للنساء الحوامل، وتوقيتها.

استمع إلى آرائهم قبل أن تخبرهم أنه خلال فترة الحمل الطبيعي يُتوقع منهم زيارة النساء الحوامل مرتين:

- المرة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أو بمجرد أن تعرف المرأة أنها حامل؛
- المرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وضِّح أن هناك ثمانية مكونات لتقديم المشورة حول صحة النساء الحوامل.

- التحقُّق من وجود علامات الخطورة (الزيارتان الأولى والثانية)
- تقديم المشورة حول رعاية ما قبل للولادة (الزيارة الأولى)
- تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية (الزيارتان الأولى والثانية)
- تقديم المشورة حول الشرب والأكل (الزيارتان الأولى والثانية)
- تقديم المشورة حول النظافة الشخصية (الزيارتان الأولى والثانية)
- تقديم المشورة حول الدعم النفسي والعاطفي للنساء الحوامل (الزيارتان الأولى والثانية)
- تقديم المشورة حول رعاية المواليد (الزيارة الثانية)
  - تقديم المشورة حول الحفاظ على تدفئة الطفل
  - تقديم المشورة حول البدء المبكر في الرضاعة
- تقديم المشورة حول الاستعداد للولادة (الزيارة الثانية).

أكِّد للمشاركين أنه من أجل الحفاظ على صحة الأمهات يجب أن يراجعن عيادة الرعاية السابقة للولادة، ويتناولن الطعام الجيد، ويشربن الكثير من السوائل، وينمن تحت ناموسية مُعالَجة بمبيد حشري إذا كن يعشن في منطقة بها خطر الإصابة بالملاريا. وأخبرهم أيضًا أنه عند تقديم المشورة للأمهات بشأن صحتهن الخاصة، فسوف يستخدمون الأدوات نفسها –استمارات التسجيل لفهم الوضع وجمع/ تسجيل البيانات، والكتاب القلاب لإعطاء المعلومات اللازمة– كما هو الحال بالنسبة لتقديم المشورة حول العناية بصحة الأطفال، كما يجب أن يستخدموا مهارات التواصل الجيد.



2.1.9 مناقشة جماعية: علامات الخطورة لدى المرأة الحامل

اطلب من المشاركين أن يفتحوا الكتاب القلاب على الصفحة 372. ناقش الرسومات التي توضح بعض علامات الخطورة التي تنطبق على النساء الحوامل مع المشاركين، ثم استعرض علامات الخطورة السبع التي يجب عليهم ملاحظتها أثناء زيارتهم النساء الحوامل. في حالة وجود أي من تلك العلامات، يجب إحالة الأم على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

1. النزيف المهبلي علامة خطورة قد تشير إلى الإجهاض.
2. الحُمَّى علامة خطورة قد تشير إلى إصابة الأم بعدوى.
3. الصداع الشديد أو نوبات عدم وضوح الرؤية علامات خطورة قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم.
4. صعوبة التنفس علامة خطورة قد تشير إلى إحدى الحالات الصحية الخطيرة.
5. الألم الشديد في البطن علامة خطورة أخرى قد تشير إلى حدوث إجهاض.
6. النزول المفاجئ للماء من المهبل في أي وقت أثناء الحمل قد يكون علامة خطورة تدل على الولادة المبكرة.
7. التورم الشديد أو المفاجئ علامة خطورة قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم. وبالرغم من أنه من الطبيعي حدوث بعض التورم في الكاحلين والقدمين أثناء الحمل، وكذلك حدوث تورم خفيف في اليدين، والوجه، وتورم شديد أو مفاجئ في القدمين واليدين، فإن ذلك يعد من علامات الخطورة.

ذكِّر المشاركين بأنه في حالة التعرف على علامة خطورة لدى الأم أو الطفل، يجب عليهم تخطي جميع المهام الأخرى والإحالة فورًا إلى مرفق صحي. ويجب عليهم أيضًا المساعدة في الإحالة.

3.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 372 و373 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

4.1.9 مناقشة جماعية (باء). تقديم المشورة حول رعاية ما قبل الولادة

ابدأ مناقشة حول رعاية ما قبل الولادة، وهو العنصر الثاني من عناصر العناية بصحة النساء الحوامل، وأكِّد على وجوب سؤال العاملين الصحيين المجتمعيين الأمهات عما إذا كن قد تلقين رعاية ما قبل الولادة في مرفق صحي أو حصلن على زيارات من مهني صحي في المنزل. إذا كانت الإجابة لا، فيجب على العاملين الصحيين المجتمعيين تسليط الضوء على أهمية رعاية ما قبل الولادة، وحث الأم على القيام بزيارات منتظمة إلى المرفق الصحي الذي سيتم فيه ما يلي:

- فحصها للتحقق من وجود أي مشاكل ومضاعفات تتعلق بحملها وتقديم النصح لها بشأن علامات الخطورة؛
- تزويدها بالحديد وحمض الفوليك؛
- قياس وزنها والحصول على المشورة حول التغذية؛
- تقديم النصح لها حول الرضاعة ورعاية الأطفال؛
- تطعيمها ضد التيتانوس، وهو مرض يمكن أن يسبب ضررًا لطفلها؛
- تقديم المشورة لها حول الاستعدادات للولادة؛
- تقديم المشورة لها حول النشاط البدني.

أخبر المشاركين بأنه يجب أيضًا للعاملين الصحيين المجتمعيين إبلاغ الأم بأنه يتعين عليها القيام بثماني زيارات للحصول على رعاية ما قبل الولادة (يجب تكييف عدد الزيارات وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية).

5.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 374 و375 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

6.1.9 مناقشة جماعية (جيم): تقديم المشورة حول ممارسات الوقاية

اسأل المشاركين عما يجب أن تتجنبه النساء أثناء الحمل، استمع إلى إجاباتهم، ثم اذكر ما يلي.

التدخين، والكحول، وغير ذلك من مخدرات

أخبر المشاركين أنه يتعين على الأمهات الحوامل تجنب التدخين سواءً كان مباشرًا أو سلبيًا. ويجب أن يقدم المشاركون المشورة لأفراد الأسرة بشأن عدم التدخين في المنزل لتجنب الإضرار بالأم وطفلها. ويضر دخان السجائر، والكحول، وغيرهما من المخدرات بالأمهات، حيث يمر عبر الدم إلى الطفل، ويمكن أن يسبب أضرارًا دائمةً لمخ الطفل وجسده.

المرضى

أخبر المشاركين بأنه يجب حماية النساء الحوامل من الإصابة بالمرض. اسأل المشاركين عن السبب في ذلك. استمع إليهم، ثم أضف أن بعض الأمراض بوجه خاص تشكل خطرًا على النساء الحوامل وأطفالهن. فالحصبة الألمانية مثلاً يمكن أن تُسبب للطفل الصَّمَم ومشاكل بالقلب.

الأدوية غير الضرورية

أخبر المشاركين بأن بعض الأدوية قد تكون مأمونة الاستخدام للبالغين ولكنها قد تُسبب عيوبًا خِلقية وأضرارًا أخرى للأطفال. لذا، يجب أن تتجنب المرأة الحامل أي دواء لم يصفه أحد العاملين الصحيين المُدرَّبين.

المواد الكيميائية المستخدَمة في التنظيف أو القضاء على الآفات

هناك الكثير من المنتجات المنزلية الشائعة التي تضر بالنساء الحوامل. إذ يمكن أن تُسبب تلك المواد الإجهاض، والعيوب الخِلقية، والسرطان.

البعوض

في مناطق انتشار الملاريا، يجب أن تنام النساء الحوامل تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات الحشرات. وتنتقل الملاريا عن طريق البعوض، وتسبب حالة خطيرة للمرأة الحامل. كما يمكنها أن تسبب فقر الدم، والإجهاض، ونقص وزن الأطفال، وفي الحالات القصوى وفاة الجنين.



7.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 376 و377 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



8.1.9 مناقشة جماعية (دال): تقديم المشورة حول تناول الطعام والمشروبات

ابدأ مناقشة حول ما يرى المشاركون أنه يتعين على النساء الحوامل تناوله من طعام وشراب. واستمع إلى ما يقولون قبل أن تخلص إلى القول بأن النساء الحوامل يجب أن يشربن الكثير من الماء كل يوم، إلى جانب عصائر الفاكهة، والحليب.

أخبر المشاركين بأنه يتعين عليهم تقديم النصح للنساء الحوامل بشأن تناول أكبر قدر ممكن من الطعام المتنوع. ويجب أن يتضمن نظامهن الغذائي مواد عالية الطاقة والبروتينات، مثل اللحوم، والحليب، والأسماك، والزيوت، والمُكسَّرات، والبذور، والحبوب، والبقول، والجبن، والخضروات الخضراء المغذية وغيرها من الخضروات والفواكه، حسب ما هو متاح محليًا.

ويجب على الحامل تناول ثلاث وجبات في اليوم، وضبط مواعيدها بحيث تسمح بتناول وجبة واحدة أو وجبتين خفيفتين، يمكن أن تحتوي على فاكهة، أو زبادي، أو أشياء مماثلة. وفي بعض المناطق قد تكون هناك ممنوعات اجتماعية متوارثة

منطبقة على بعض الأغذية التي تتناولها الحوامل. وفي بعض الحالات قد تكون الأغذية الممنوعة ذات قيمة غذائية ولا يسهل استبدالها محليًا، اسأل المشاركين عما إذا كانوا يعرفون أي ممنوعات اجتماعية متوارثة تتعلق بتغذية النساء الحوامل. استمع إليهم، ثم اخلص إلى القول بأنه يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين أن يُقدموا النصح بعدم التقيد بتلك المحظورات، وأن يخبروا الأسر بأنه لا داعي لمنع أي صنف من الأطعمة المغذية.

أخبر المشاركين بأنه من المهم التحدث إلى أفراد الأسرة، خاصة شريك المرأة الحامل و/ أو حماتها، وتشجيعهم على العمل على ضمان حصول الأم على أكبر قدر من الطعام المتنوع.



9.1.9 قراءة:

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 378 و379 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.



10.1.9 مناقشة جماعية (هاء): تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية (1)

غسل اليدين

راجع مع المشاركين:

- أهمية غسل اليدين؛
- الأوقات التي يجب فيها غسل اليدين؛
- الخطوات الواجب اتباعها عند غسل اليدين.

توجد في بعض المنازل دورات مياه مزوَّدة بمرحاض وحوض ومصدر للمياه وصابون، في حين لا يتوافر ذلك في دورات مياه أخرى. ويمكن للعاملين الصحيين المجتمعيين مساعدة الأسر في تحديد مكان مناسب لتركيب حوض، وتوفير ماء وصابون لغسل اليدين، ويجب أن ينصحوا جميع أفراد الأسرة بغسل أيديهم لمنع انتشار الأمراض داخل الأسرة.



11.1.9 ممارسة عملية: غسل اليدين

ستحتاج إلى مستلزمات غسل اليدين.

أخبر المشاركين أن اثنين منهم سيساعدان المجموعة على مراجعة كيفية تقديم المشورة حول غسل اليدين. وسيؤدي أحدهما دور العامل الصحي المجتمعي، بينما يقوم الآخر بدور الأم، وسيتابع المشاركون الباقون التدريب. وعندما ينتهي العرض التوضيحي، اطلب من المراقبين التعليق.

- هل استخدم العامل الصحي المجتمعي مهارات تواصل جيدة؟
- هل قيَّم الوضع بشكل صحيح مستخدمًا استمارة التسجيل؟
- هل استخدم الكتاب القلاب بشكل جيد؟
- ما الذي أحسن العامل الصحي المجتمعي عمله؟
- هل تعلمت الأم كيفية غسل يديها بشكل صحيح؟

ما الذي يمكن للعامل الصحي المجتمعي القيام به بشكل أفضل؟

12.1.9 قراءة:

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 380 و381 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. ناقش أيضًا التعليمات المقدمة للعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

13.1.9 مناقشة جماعية (هاء): تقديم المشورة حول العناية بالنظافة الشخصية (2)

النظافة الشخصية

أخبر المشاركين بأنه يجب على النساء، أثناء الحمل، إعطاء اهتمام خاص بالنظافة الشخصية. وتعني التغيرات الهرمونية أن المرأة الحامل تتعرق أكثر ويكون لديها إفرازات مهبلية أكثر من المرأة غير الحامل، وقد تكون أكثر عُرضة للعدوى بالجراثيم الموجودة في البيئة. ويساعد الحفاظ على نظافة الجسم على الوقاية من العدوى. ويجب أن ينصح العامل الصحي المجتمعي النساء الحوامل بغسل أجسادهن كل يوم، لا سيّما المنطقة التناسلية.

نظافة الأسنان

تكتسب نظافة الأسنان أهميةً خاصة أثناء الحمل لأن زيادة مستويات هرمون الإستروجين يمكن أن تسبب تورمًا وزيادة في حساسية أنسجة اللثة. ويجب على النساء الحوامل تنظيف أسنانهن، باستخدام أعواد الأسنان أو فرشاة الأسنان والمعجون بانتظام. فإذا كان هناك نزيف باللثة، أو كانت هناك أي مشاكل أخرى في الأسنان، مثل التسوس، أو أسنان مكسورة، أو غير ذلك، انصح المرأة بزيارة طبيب الأسنان.

يجب إعطاء عناية خاصة لنظافة الغذاء. فيجب غسل الفواكه والخضروات بعناية، وطهي جميع الأطعمة جيدًا. ويجب غسل أواني تحضير الطعام، وفي حالة ترك الفواكه والخضروات خارج الثلاجة، فيجب تغطيتها لحمايتها من الذباب.

14.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 382 و383 من الكتاب القلاب. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

15.1.9 مناقشة جماعية (واو): تقديم المشورة حول الدعم النفسي والعاطفي للنساء الحوامل

أخبر المشاركين بأن الحمل غالبًا ما يكون مصحوبًا بتغيرات في الأداء النفسي. وأضف أن المرأة الحامل يمكن أن تتعرض لتغيرات مزاجية، قد تتأرجح فيما بين القلق والتعب والإرهاق والنعاس والاكتئاب والإثارة والانتشاء. وبصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، يجب أن يُطمئِن المشاركون الأم المنتظَرة ويقدموا لها المشورة، ويتساوى ذلك في أهميته مع تقديم المشورة للأسرة حول كيفية دعم المرأة الحامل.

ناقش مع المشاركين الطرق التي يمكن بها للأسرة أن تدعم المرأة الحامل نفسيًا وعاطفيًا.

16.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 384 و385 من الكتاب القلاب. ناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيف سيتم استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

17.1.9 مناقشة جماعية (زاي): تقديم المشورة للأم حول رعاية المولود

الحفاظ على تدفئة المولود وملامسة جلد الأم لجلد الطفل

خلال الزيارة الأخيرة إلى الأم الحامل، سيقدم لها العامل الصحي المجتمعي المشورة حول رعاية المولود في المنزل. استعرِض مع المشاركين ما يعرفونه بالفعل عن الحفاظ على دفء المواليد. وتحقق من أنهم يفهمون:

- ما يعنيه الحفاظ على تدفئة المولود؛
- السبب في أهميته؛
- كيفية القيام به (يجب إعطاء اهتمام خاص بملامسة جلد الأم لجلد الطفل).

البدء المبكر في الرضاعة

طبِّق الأمر ذاته مع البدء المبكر في الرضاعة. راجع مع المشاركين ما تعلموه بالفعل عن الرضاعة، وأكِّد مرة أخرى على أن الرضاعة المطلقة هي أفضل طريقة لضمان حصول الأطفال على جميع المُغذِّيات التي يحتاجون إليها.

18.1.9 فيديو توضيحي: الحفاظ على دفء المولود والبدء المبكر في الرضاعة

حضِّر على وحدة تخزين محمولة (USB)/ أسطوانة مدمجة (CD) مقطع الفيديو رقم 2، حول الحفاظ على دفء الطفل (04:36 دقيقة)، ومقطع الفيديو رقم 3، حول ملامسة جلد الأم لجلد الطفل (05:42 دقيقة)، ومقطع الفيديو رقم 4، حول البدء المبكر في الرضاعة (07:28 دقيقة).

أخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون ثلاثة مقاطع فيديو لمراجعة الحفاظ على دفء الطفل، وملامسة جلد الأم لجلد الطفل، والبدء المبكر في الرضاعة.

اعرض مقطع الفيديو، وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.



19.1.9 ممارسة عملية: مساعدة الأم على تطبيق ملامسة جلد الأم لجلد الطفل

ستحتاج إلى: دمية، وقبعة، وجوارب، وحفاض، وقطعة قماش كبيرة وناعمة لربطها حول الأم،

وسترة أو قميص.

اطلب من أحد المشاركين أن يؤدي دور الأم، ومن مشارك آخر أن يؤدي دور العامل الصحي المجتمعي. ووضِّح للمشاركين أنهم سيشاهدون المشاركين الاثنين يتدربان على تقديم المشورة حول طرق لف الطفل وملامسة جلد الأم لجلد الطفل، مع استخدام العامل الصحي المجتمعي للكتاب القلاب من أجل تقديم المشورة.

عند انتهاء العرض التوضيحي، ناقش ما إذا كان العاملون الصحيون المجتمعيون قد:

- استخدموا مهارات التواصل الجيد؛
- وضحوا أهمية ملامسة جلد الأم لجلد الطفل في إبقاء الأطفال دافئين؛
- علَّموا الأم أساليب ملامسة جلد الأم لجلد الطفل بطريقة صحيحة؛
- تحققوا من فهم الأم.



20.1.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 386 و387 من الكتاب القلاب. ناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة وكيفية توظيفها عند تقديم المشورة. وناقش أيضًا التعليمات المقدمة للعاملين الصحيين المجتمعيين. الواردة في الإطار الأحمر، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها. وعندما يفرغون من القراءة، اطلب منهم قراءة الإطار 73 الخاص بمكونات العناية بصحة النساء الحوامل، الوارد في الصفحة 88 من دليل المشارك.



الجلسة 44:
العناية بصحة الأم بعد الولادة

مدة الجلسة
ساعتان

جهِّز
- نسخة من استمارة التسجيل لكل مشترك ومُيسِّر.
- نُسخًا من سيناريو الحالات الخمس لتمرين لعب الأدوار رقم 15.
- نسخًا من نص تمرين لعب الأدوار التوضيحي حول العناية بصحة الأم بعد الولادة.
- استمارة تسجيل مُكبّرة.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:
- فهم مكونات العناية بصحة الأمهات بعد الولادة؛
- معرفة كيفية تقديم المشورة للأمهات بشأن صحتهن بعد الولادة؛
- التعرُّف على علامات الخطورة لدى الأمهات بعد الولادة؛
- تقديم المشورة للأسر بشأن علامات الخطورة، والمساعدة في الإحالة.

1.2.9 مناقشة جماعية: مقدمة

ابدأ مناقشة حول أهمية العناية بصحة الأم بعد الولادة. استمع إلى ما يقوله المشاركون، ووضح أنه في الأيام التي تلي الولادة مباشرة تكون الأمهات عُرضة للعدوى والمضاعفات، مثل النزيف. وأكد للمشاركين أنه خلال زياراتهم الثلاث للمواليد -بعد تذكيرهم بجدول الزيارة- يجب عليهم الاهتمام أيضًا بصحة الأم.

وضِّح أنه يجب على الأمهات إما التوجه إلى عيادة رعاية ما بعد الولادة أو تلقي رعاية ما بعد الولادة في المنزل.

وخلال الزيارتين الأولى والثانية للمواليد، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين تقديم المشورة للأمهات حول:
- التحقُّق من وجود علامات الخطورة؛
- أهمية زيارات ما بعد الولادة؛
- الأكل والشرب؛
- الرضاعة؛
- المباعدة بين الولادات؛
- النظافة الشخصية؛
- الدعم النفسي؛
- النوم أسفل ناموسية مُعالَجة بمبيد حشري في المناطق التي تمثل فيها الملاريا مشكلة.

2.2.9 مناقشة جماعية (ألف): علامات الخطورة لدى الأم بعد الولادة

اسأل المشاركين عما يجب عليهم فعله إذا تعرفوا على علامة خطورة، وأكد لهم أنه يجب عليهم تخطي جميع المهام الأخرى للمساعدة في الإحالة العاجلة إلى مرفق صحي، ثم انتقل إلى مناقشة علامات الخطورة الست التي تنطبق على الأمهات بعد الولادة.

نزيف مهبلي شديد

بعض النزيف يكون طبيعيًا بعد الولادة. ثم يبدأ في الانحسار في الأيام التي تلي الولادة، وتصبح الإفرازات أقل حُمْرة. ولكن إذا كانت الأم تعاني من نزيف مهبلي شديد وتحتاج إلى تغيير الفوط الصحية عدة مرات في اليوم، فيجب إحالتها على وجه السرعة إلى مرفق صحي.

الحُمّى

إذا كانت الأم تعاني من الحمى، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى، ويجب إحالتها على وجه السرعة إلى مرفق صحي.

صداع شديد أو تغيُّم الرؤية أو نوبات

هذه مؤشرات تدل على ارتفاع ضغط الدم. قم بإحالة الأم على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

صعوبة التنفس

قم بإحالة الأم على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

ألم شديد في البطن

الألم الشديد في البطن قد يشير إلى نزيف داخل الرحم. قم بإحالة الأم على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

ألم في بطن الساق

قد يشير ألم عضلات الساق إلى تجلط غير طبيعي للدم في الأوردة. قم بإحالة الأم على وجه السرعة إلى أحد المرافق الصحية.

ذكِّر المشاركين أنه في حالة التعرف على علامة خطورة لدى الأم أو الطفل، يجب عليهم تخطي جميع المهام الأخرى، وتقديم المشورة حول الإحالة العاجلة.

3.2.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 388 و389 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة يطرحها المشاركون.

4.2.9 مناقشات جماعية. تقديم المشورة حول أهمية رعاية ما بعد الولادة

يجب على المشاركين، بصفتهم عاملين صحيين مجتمعيين، أن يسألوا الأم عما إذا كانت قد توجهت إلى عيادة رعاية ما بعد الولادة في أحد المرافق الصحية، أو ما إذا كانت قد تلقت رعاية ما بعد الولادة في المنزل. إذا كانت الإجابة لا، فأخبر المشاركين بأن عليهم تقديم المشورة للأم حول أهمية رعاية ما بعد الولادة، وحثها على التوجه إلى مرفق صحي. ابدأ مناقشة حول السبب في ذلك، والفت انتباه المشاركين إلى النقاط التالية في المرفق الصحي:

- سيفحص أحد المهنيين الصحيين كلاً من الأم والطفل لاستبعاد أي مشاكل؛
- ستُعطَى الأم أقراص الحديد وحمض الفوليك؛
- ستُقدَّم المشورة للأم حول المباعدة بين الولادات؛
- سيحصل الطفل على التطعيمات اللازمة؛
- ستُقدَّم المشورة للأم حول التغذية، والرضاعة، والنظافة الشخصية.

5.2.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 390 و391 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

6.2.9 مناقشة جماعية (جيم): تناول الطعام والشراب

اسأل المشاركين لماذا يعتقدون أن الأمهات يحتجن إلى شرب الكثير من السوائل بعد الولادة. استمع إلى آرائهم، وأضف أنه بعد الولادة تحتاج الأم إلى شرب الكثير لأنها ستفقد سوائل الجسم، بينما يختفي تورم الحمل تدريجيًا. كما أن السوائل ضرورية إذا كانت الأم ترضع. وأخبر المشاركين بأنهم يجب أن ينصحوا الأمهات بشرب الماء والحليب وعصير الفاكهة.

وخلال فترة ما بعد الولادة، تتعافى الأمهات من التغيرات الجسدية التي تطرأ على أجسامهن والتي ترتبط بالحمل. أخبِر المشاركين بأنه يجب عليهم أن ينصحوا الأم بتناول الطعام بعد الولادة مباشرة، وأن تزيد من الطعام التي تتناوله بعد ذلك بمقدار وجبة أو وجبتين في اليوم لضمان إدرار لبن الثدي، واستعادة مستويات الطاقة الطبيعية.

ويجب أن تتضمن الأنظمة الغذائية للأمهات مجموعة متنوعة من الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والأطعمة العالية الطاقة (ذكِّر المشاركين أثناء تقديمهم النصيحة بشأن النظام الغذائي أن يضعوا في اعتبارهم ما هو متاح محليًا وميسور التكلفة)، مثل اللحوم، والحليب، والأسماك، والزيوت، والعدس، والمُكسَّرات، والبذور، والحبوب، والبقول، والجبن، والخضروات الخضراء.

اسأل المشاركين عما إذا كانوا يعرفون بوجود اعتقادات متوارثة تمنع تناول بعض الأغذية بعد الولادة. استمع إليهم ثم أضف أن بعض المناطق قد ترى أن بعض الأغذية التي تتناولها النساء اللاتي ولدن للتو من الممنوعات طبقا للاعتقادات المتوارثة. وفي الحالات التي تكون فيها الأغذية الممنوعة ذات قيمة غذائية، ولا يمكن استبدالها محليًا بسهولة، يجب على العاملين الصحيين المجتمعيين تقديم النصح على نحو يحترم الثقافة المحلية برفض منع الطعام، ويجب عليهم إخبار الأسر بأنه لا داعي إلى منع أي صنف من الأطعمة المغذية.

أخبر المشاركين بأنهم سيحتاجون إلى التحدث إلى أفراد الأسرة، خاصة زوجها وحماتها، وتشجيعهم على العمل على ضمان حصول الأم على أكبر قدر من الطعام المتنوع.



7.2.9 قراءة:

اطلب من المشاركين قراءة الصفحتين 392 و393 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



8.2.9 مناقشة جماعية: تقديم المشورة حول الرضاعة، والمباعدة بين الولادات، والنظافة الشخصية

ابدأ مناقشة حول كيفية تقديم المشاركين للمشورة للأمهات حول الرضاعة، وأهمية المباعدة بين الولادات، والنظافة الشخصية. قم بإدارة المناقشة بحيث تشمل النقاط التالية.

الرضاعة

راجع ما تعلَّمه المشاركون حول البدء المبكر في الرضاعة، وأهمية اللِّبَأ، ومزايا الرضاعة مقارنةً بالحليب الاصطناعي، وتعريف الرضاعة المطلقة، ولبن أول الرضعة ولبن آخر الرضعة، والمشكلات الأكثر شيوعًا التي تنشأ مع الرضاعة.

المباعدة بين الولادات

وضِّح أن المباعدة بين الولادات لمدة سنتين على الأقل تساعد على ضمان عافية الأم وأطفالها. كما أنها تمنح مزيدًا من الوقت لرعاية كل طفل وتعليمه.

النظافة الشخصية

تكتسب النظافة الشخصية الجيدة للأم فيما بعد الولادة أهميةً من أجل الوقاية من العدوى، وتسريع عملية شفاء الجسم بعد الولادة.

اسأل المشاركين عن «الممارسات الرئيسية لنظافة الأم فيما بعد الولادة في رأيهم».

استمع إلى إجاباتهم، ثم لخص كما يلي:

- **غسل اليدين**

راجع أهمية غسل اليدين، لكل من العاملين الصحيين المجتمعيين والأسر التي لديها مولود، مع الرجوع إلى الكتاب القلاب إذا لزم الأمر لتوضيح كيفية ومواقيت غسل اليدين.

- **نظافة المنطقة التناسلية**

تميل الأمهات بعد الولادة إلى التبول بشكل متكرر أكثر من ذي قبل، مما قد يؤدي إلى العدوى في غياب التنظيف الفوري والشامل. ويجب على الأمهات تنظيف المنطقة التناسلية بالماء الدافئ، من الأمام إلى الخلف، مع تجفيف المنطقة برفق بقطعة قماش نظيفة. وهذا سيخفف أيضًا من الألم الناجم عن التمدد الذي تتسبب فيه الولادة.

ويجب على الأمهات تغيير الفوط الصحية في كل مرة يستخدمن فيها دورة المياه. ويجب تجنب استخدام السدادات القطنية لمدة ستة أسابيع بعد الولادة بسبب خطر العدوى.

ويتعين أن تحرص الأمهات على الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم خلال فترة ما بعد الولادة. ومن الضروري شرب الكثير من الماء للوقاية من خطر حدوث عدوى بالمثانة نتيجة كثرة التبول، لأن الجسم يتخلص من الماء الزائد المتراكم أثناء الحمل.

- **نظافة الغذاء**

يجب إعطاء اهتمام خاص عند إعداد الطعام. حيث يجب غسل الفواكه والخضروات بعناية، وطهي الطعام جيدًا قبل تناوله.

- **نظافة الثدي**

من الضروري أيضًا الحفاظ على نظافة الثدي. وللوقاية من احتمال حدوث العدوى التي قد تنتقل إلى الطفل أثناء الرضاعة، يجب على الأمهات شطف أثدائهن بالماء بعد الرضاعة، وتجفيفها برفق، ثم وضع قطرة من لبن الثدي على حلمة الثدي وتركه يجف في الهواء. ويساعد ذلك على تجنب العدوى، كما يحمي الحلمات من الجفاف والتشقق.

9.2.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الصفحات من 394 حتى 397 من الكتاب القلاب. وناقش الرسومات التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وناقش أيضًا التعليمات الخاصة بالعاملين الصحيين المجتمعيين الواردة في الإطار الأحمر. أجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.

10.2.9 مناقشة جماعية (زاي): تقديم المشورة حول توفير الدعم النفسي الاجتماعي والعاطفي للأم

اسأل المشاركين عن أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي، واستمع إلى إجاباتهم، ثم وضح لهم أن الولادة قد تجعل الأمهات يشعرن بالإرهاق والقلق بسبب التغيرات الهرمونية المفاجئة، وقد يشعرن بالصدمة من مدى تغير حياتهن مع قدوم الطفل، خاصة إذا كان طفلهن الأول. فقد تشعر الأم الجديدة بما يلي:

- الوحدة وفقدان الدعم؛
- بدلاً من السيطرة على حياتها، أصبحت منهمكة في تلبية المطالب المستمرة للطفل الذي يبدو أنه لن يسمح لها مطلقًا بالراحة واستعادة قوتها؛
- حياتها الاجتماعية أو العملية تبددت إلى الأبد؛
- علاقتها بشريكها وأطفالها الأكبر سنًّا ستتوتر لأنه ليس لديها الطاقة الكافية للتعامل معهم؛
- ستحتاج إلى مساعدة ودعم أكبر مما تحصل عليه، أو تستطيع المطالبة به.

قد يؤدي ذلك كله إلى اكتئاب ما بعد الولادة.

اسأل المشاركين كيف يمكنهم المساعدة في ضمان حصول الأم على الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي الذي تحتاج إليه. وجِّه النقاش بحيث يشمل النقاط التالية.

- عند قيامهم بزيارة منزلية، وباعتبارهم عاملين صحيين مجتمعيين، يجب على المشاركين التحقق من أن الأم والطفل ليسا معزولين عن باقي أفراد الأسرة، وأن الأم تحصل على الدعم الاجتماعي الكافي. حاول التحقق مما إذا كان أفراد الأسرة يتواجدون مع الأم بانتظام، وما إذا كانت على اتصال مع الأصدقاء.

- شجِّع زوج الأم أو والدتها أو أختها أو حماتها على التواجد على مقربة منها على الأقل في الأسبوع الأول من فترة ما بعد الولادة لتقديم الدعم العاطفي لها، والمساعدة في رعايتها هي والطفل، وتخفيف الأعباء المنزلية الروتينية، مثل غسل الملابس، من على كاهلها.
- قدِّم النصيحة للأمهات حول تجنب الإجهاد والتعب البدني، والخلود للراحة، والنوم بشكل جيد، وأخذ قيلولة عندما ينام الطفل.
- يجب أن تتبع الأمهات نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يتضمن الخضروات الخضراء.
- تحقق من وجود شخص في الأسرة يمكنه رعاية المولود الجديد إذا لم تستطع الأم ذلك أو تكون قادرة عليه.



11.2.9 مناقشة جماعية (حاء): النوم تحت ناموسيات مُعالَجة بمبيدات حشرية

استعرض مع المشاركين الأسباب التي تدعو الأمهات إلى النوم تحت ناموسية معالجة بمبيدات الحشرات.



12.2.9 قراءة

اطلب من المشاركين قراءة الإطار 74 الخاص بمكونات رعاية صحة الأم بعد الولادة، الوارد في الصفحة 89، من دليل المشارك، ثم الصفحتين 398 و399 من الكتاب القلاب. وناقش الرسوم التوضيحية والنصائح المقدَّمة، وكيفية استخدامها في تقديم المشورة، وأجب عن أي أسئلة قد يطرحونها.



13.2.9 عرض توضيحي: استمارة التسجيل

اطلب من المشاركين الاطلاع على استمارة التسجيل للأطفال حتى أقل من ستة أشهر. وأكد على أن القائمة المرجعية لعلامات الخطورة موجودة في بداية الاستمارة، لأنه إذا ظهرت على الأم أو طفلها علامة خطورة، فيجب تخطي جميع المهام الأخرى، ويتعين على العامل الصحي المجتمعي تقديم المشورة حول الإحالة العاجلة.

استعرض الاستمارة سطرًا تلو الآخر، ووضح للمشاركين أنه يجب عليهم وضع علامة في المربعات المقابلة للإجابات التي تقدمها الأم أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة، وملء الأقسام المشار إليها بالسطور المنقطة.

وذكِّر المشاركين أن لديهم أداتين يمكن استخدامهما أثناء الزيارات المنزلية: استمارة التسجيل والكتاب القلاب. وقد صُمِّمت استمارة التسجيل للمساعدة في تقييم الوضع، في حين يوفر الكتاب القلاب المعلومات الضرورية والمبادئ التوجيهية للدعم العملي.



14.2.9 تمرين لعب الأدوار رقم 14: تطبيق عملي على تقديم المشورة حول العناية بصحة الأم بعد الوضع

ستحتاج إلى:

نسخة مكبرة من استمارة التسجيل

نُسخ من سيناريو الحالات الخمس لتمرين لعب الأدوار رقم 14

علِّق النسخة المكبرة من استمارة التسجيل حيث يمكن رؤيتها، وأخبر المشاركين بأنهم سيشاهدون الآن سلسلة من

تمارين لعب الأدوار التي تتمحور حول أول زيارة منزلية يقومون بها لمولود.

وسيكون التمرين الأول من تمارين لعب الأوار توضيحيًا. وسيؤدي المُيسِّر دور العامل الصحي المجتمعي، بينما يؤدي المُيسِّر المشارك دور الأم. اختر ثلاثة مشاركين للقيام بدور الزوج، والأخت، والحماة. ويجب على المُيسِّر، الذي يقوم بدور العامل الصحي المجتمعي، أن يستخدم استمارة التسجيل المُعلَّقة على الحائط والكتاب القلاب بينما يشرح للأم. كما يجب تسليم استمارات التسجيل للمشاركين الذين يراقبون لعب الأدوار، والذين يجب عليهم ملء الاستمارات وفقًا للمعلومات التي يجمعونها من لعب الأدوار.

بعد انتهاء تمرين لعب الأدوار التوضيحي، اطرح على المشاركين الأسئلة التالية:

- كيف قام العامل الصحي المجتمعي بتحية سميحة؟
- هل شرح العامل الصحي المجتمعي الغرض من الزيارة؟ هل استخدم مهارات التواصل الجيد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا كانت تلك المهارات؟

(استخدِم الأسئلة المفتوحة، تقبَّل الأجوبة، قدِّم المعلومات الضرورية والدعم العملي، تحقَّق من الفهم، وأشرِك أيضًا أفرادًا آخرين من الأسرة)

- هل كان لدى الأم أي علامات خطورة؟
- هل كان لدى الطفل أي علامات خطورة؟

راجع طريقة ملء العامل الصحي المجتمعي لاستمارة التسجيل، وحلل كيفية توجيهه للأسئلة الموجودة في الاستمارة، وقارن الاستمارة التي ملأها بالاستمارة الموجودة مع المشاركين المراقبين.

في كل سيناريو من السيناريوهات الخمسة الواردة أدناه، سيؤدي أحد المشاركين دور العامل الصحي المجتمعي، وسيؤدي المُيسِّر دور الأم. وفي السيناريوهات التي تتضمن أدوارًا إضافية، سيضطلع الميسر المشارك بتلك الأدوار. كرر السيناريوهات مع مشارك آخر يؤدي دور العامل الصحي المجتمعي إذا رأيت ضرورةً لذلك، وبذلك يتمكن كل متدرب من أخذ دوره. وذكِّر المشاركين أنه يتعين عليهم استخدام مهارات التواصل الجيد، واستمارة التسجيل لمساعدتهم في فهم الوضع وتقديم المعلومات الضرورية باستخدام الكتاب القلاب. في نهاية كل تمرين مت تمارين لعب الأدوار، اطلب من المشاركين مناقشة ما إذا كان زميلهم الذي قام بدور العامل الصحي المجتمعي قد:

- استخدم مهارات تواصل جيد، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف فعل ذلك؛
- استخدم استمارة التسجيل بشكل صحيح؛
- قيَّم الوضع بدقة، وحدَّد المشاكل؛
- استخدم الكتاب القلاب بشكل صحيح؛
- قدَّم معلومات ملائمة للموقف؛
- هل من المحتمل أن تتبع الأم النصيحة التي أسداها العامل الصحي المجتمعي إليها (هل فَهِمَت ما قاله أم لا، وهل كان العامل مقنعًا).

العاملة الصحية المجتمعية: مرحبًا، أنا خديجة، العاملة الصحية المجتمعية في القرية. لقد سمعت أنكِ وضعتِ منذ بضع دقائق. جئت لأهنئكِ على الطفل الجديد، وأسألكِ عن أحوالك وأحوال الطفل.

سميحة: أنا على ما يرام ولكني متعبة. الطفل يبدو على ما يرام.

العاملة الصحية المجتمعية: أجل، من الطبيعي أن تشعري بالتعب بعد المخاض والولادة. بماذا تشعرين أيضًا؟

سميحة: أعاني من بعض النزيف، لكنه ليس شديدًا.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا أمر طبيعي بعد المخاض. هل من شيء آخر؟

سميحة: كلا، للا يوجد شيء آخر في الواقع.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا جيد. كما أوضحتُ يا سميحة، الغرض من زيارتي اليوم هو التحقق مما إذا كنتِ أنت والطفل بخير. فهل هذا الوقت مناسب؟

سميحة: نعم، تفضلي بالجلوس. يسعدني أنك تمكنتِ من القدوم بمجرد سماعك عن الولادة.

العاملة الصحية المجتمعية: شكرًا لكِ. أود أن أغسل يدي قبل أن ألمس الطفل. هل يمكن لأحدهم أن يصب الماء؟

سميحة: نعم، أختي ستساعدكِ. إنها في المطبخ تعد الطعام.

(تترك العاملة الصحية المجتمعية المكان ثم تعود بعد غسل اليدين. تلاحظ العاملة الطفل وتجده يلبس ما يكفي من الملابس لتدفئته، ولكنه ملفوف بشكل مبالغ فيه)

العاملة الصحية المجتمعية: ما اسم طفلك؟

سميحة: محمود.

العاملة الصحية المجتمعية : تهانينا! أنتِ تعتنين بمحمود بإبقائه دافئًا. ولكن يجب أن تعطيه بعض المساحة لتحريك ذراعيه وساقيه. وليس هناك ضرورة للفه كثيرًا بهذه الطريقة.

العاملة الصحية المجتمعية: هل أطعمتِ الطفل؟

سميحة: نعم، وضعت الطفل على الثدي بعد بضع دقائق فقط من الولادة، مثلما نصحتني في زيارة الشهر الماضي.

العاملة الصحية المجتمعية: ممتاز. أود أن أرى كيف يرضع محمود. إذا كان ذلك ممكنًا، هل يمكنك إطعامه الآن؟

سميحة: نعم، لكنّي قلقة. لا أعتقد أن لدي أي لبن في صدري.

العاملة الصحية المجتمعية: أرى أنكِ قلقة بشأن كمية اللبن. فخلال الأيام القليلة الأولى بعد الوضع يُفرِز الثديان أول لبن، ويسمى اللِّبَأ (لبن السرسوب). وهو مهم للغاية لنمو الطفل. وهو بالفعل يُعدُّ أول تطعيم للطفل، ويساعد على الوقاية من حالات العدوى، كما أنه مفيد للمخ والعينين. كما يُفرَز بكميات ضئيلة وحسب تكفي لمعدة الطفل الصغيرة. لذا فإن إطعام الطفل أول لبن هو أفضل شيء يمكنكِ القيام به. ومع الاستمرار في وضع الطفل على الثدي ومصه له، يزداد مخزون اللبن خلال يومين أو ثلاثة.

سميحة: شكرًا لكِ. أعتقد أن الطفل يريد أن يتغذى.

(تزيل سميحة اللفافة عن الطفل وتضع محمود على صدرها لإرضاعه)

العاملة الصحية المجتمعية: يمكنني أن أرى الطفل يرضع بشكل جيد. فهو يتعلق بالثدي بصورة جيدة ويمصه بفعالية.

كما أن درجة حرارته جيدة. أنت والطفل على ما يُرام. دعيني أسألك سؤالاً آخر. هل أصيب الطفل بتشنجات أو بنوبة منذ الولادة؟ المقصود بالنوبة هو أن يكرر الطفل حركة ما عدة مرات في بضع دقائق.

سميحة: لا، لا أظن ذلك. فهو يحرك يديه ورجليه.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا طبيعي بالنسبة للطفل.

(تنتهي سميحة من الرضاعة)

العاملة الصحية المجتمعية: هل يمكننا تدفئة الغرفة قليلاً؟ أود أن ألقي نظرة على صدر محمود.

(سميحة تدعو شقيقتها لتدفئة الغرفة ثم تكشف صدر الطفل. وتقوم العاملة الصحية المجتمعية بعد الأنفاس وتتحقق من انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل)

العاملة الصحية المجتمعية: الطفل يتنفس بصورة جيدة للغاية. هل تعرفين كيف تعتنين بثدييك؟

سميحة: سأغسلهما بالماء والصابون.

العاملة الصحية المجتمعية: من الجيد أن لديك فكرة عن نظافة الثدي. ما عليكِ القيام به هو شطف الثديين بالماء

فقط ثم وضع قطرة من لبن الثدي على الحلمات وتركها تجف في الهواء.

سميحة: فعلاً! لماذا؟

العاملة الصحية المجتمعية: لأنه يقي من جفاف الحلمة وتشققها، كما أنه يحمي من الإصابة بالعدوى.

العاملة الصحية المجتمعية: إذن هل يمكنكِ أن تخبريني ما هي أهمية اللبأ؟

(تكرر سميحة ما قالته لها العاملة الصحية المجتمعية)

العاملة الصحية المجتمعية: رائع! هل يمكنكِ إخباري بما سيزيد من إدرار اللبن؟

سميحة: عندما يمص طفلي الثدي.

العاملة الصحية المجتمعية: جيد! وماذا عن لف طفلك بشكل مبالغ فيه؟ يسعدني أن أراك تزيلين عنه تلك اللفافة.

سميحة: يجب أن أعطيه الحرية لتحريك ذراعيه وساقيه.

العاملة الصحية المجتمعية: أنت مهتمة حقًا برعاية طفلك على الوجه الأكمل. هل يمكنكِ إخباري كيف ستعتنين بثدييك؟

سميحة: سأشطفهما بالماء ثم أضع قطرة لبن على الحلمة. ولن أستخدم الصابون.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا جيد للغاية. هل يمكنك أن تخبريني ماذا فعلت بالحبل السري؟

سميحة: لقد وضعت هذا المرهم على الحبل السري

(تجد العاملة الصحية المجتمعية أن المرهم عبارة عن جل الكلورهيكسيدين 4%)

العاملة الصحية المجتمعية: رائع! لقد قمت بعمل جيد. أين وضعت المرهم؟

(توضح سميحة بشكل صحيح كيف وضعت المرهم)

العاملة الصحية المجتمعية: رائع! عليك أن تفعلي الشيء ذاته كل يوم لمدة سبعة أيام

سميحة: من الجيد أنك هنا. هل يمكنكِ مساعدتي في تحميم محمود لأول مرة؟

العاملة الصحية المجتمعية: تريدين تحميم محمود، وهذا أمر جيد، لكن دعينا نؤجل ذلك إلى الغد. فتحميم الطفل في اليوم الأول قد يعرِّضه للبرد، وهو ما سيضر بمحمود. يمكنك تحميمه بالإسفنجة غدًا، وهذه هي الطريقة التي يستحم بها الأطفال حتى سقوط الجزء المتبقي من الحبل السري. وعندما يسقط، يمكننا أن نحمِّمه في حوض الاستحمام.

سميحة: حسنًا! من الجيد أنكِ هنا لتخبريني بذلك.

العاملة الصحية المجتمعية: شكرًا لكِ. متى تخططين للذهاب إلى المرفق الصحي لزيارة ما بعد الولادة؟

سميحة: لا أعتقد أنها مهمة. أنتِ هنا الآن، وكانت القابلة هنا في وقت سابق.

العاملة الصحية المجتمعية: بالطبع، نحن هنا لمساعدتك في العناية بنفسك وبالطفل، لكن زيارة ما بعد الولادة مهمة للغاية. سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بفحصك واستبعاد أي مشاكل - لا سمح الله - تتعلق بكِ وبطفلك. سيعطونك الحديد، وحمض الفوليك لتجنب الإصابة بفقر الدم، وسيحصل طفلك على تطعيماته الأولى.

سميحة: فعلا! حسنًا، سوف أخطط مع زوجي للذهاب إلى هناك.

(تنضم حماة سميحة إليهما. تقوم العاملة الصحية المجتمعية بإلقاء التحية عليها)

العاملة الصحية المجتمعية: يجب عليك الاعتناء بمنطقة العجان جيدًا من خلال تنظيفها بالماء الدافئ. وعندما تنظفينها، افعلي ذلك من الأمام إلى الخلف. وهناك شيء آخر مهم بالنسبة لك هو أن تشربي الكثير من السوائل.

الحماة: هل يجب أن تشرب الماء؟

العاملة الصحية المجتمعية: نعم، ولهذا الأمر أهمية بالغة. كما يمكنها شرب الحليب وعصير الفاكهة. هل يمكنكِ إخباري يا «حاجّة» ما الطعام الذي تحضّرينه لها؟

الحماة: نحن نطبخ لها الدجاج والأرز حتى تستعيد قوتها.

العاملة الصحية المجتمعية: الدجاج مفيد جدًا لها، والخضروات الخضراء أيضًا. يمكنك إعطاؤها البقول، والجبن، والحليب أيضًا. وعليها أن تأكل أكثر من المعتاد، وبأسرع وقت ممكن.

الحماة: لدينا كل هذا في المنزل. سنجهزه لها.

العاملة الصحية المجتمعية: رائع! هل يمكنك أن تخبريني كيف تجهزين الطعام؟

الحماة: نغسل الأواني ثم نضع فيها الطعام لطهيه.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا عظيم. عليك أيضًا غسل الخضروات والفواكه بعناية لتجنب أي عدوى.

الحماة: سوف نفعل ذلك. سأذهب الآن لمساعدة أختها في إنهاء الطهي حتى تتناول الطعام. وسأُحضر أيضًا بعض الخضروات لإضافتها إلى الوجبة.

العاملة الصحية المجتمعية: رائع يا «حاجة»، إنك تعتنين بها على أكمل وجه.

العاملة الصحية المجتمعية: حسنًا يا سميحة، أريد أن أوضح لك أنك ستعانين من بعض النزيف، ولكنه سيزول تدريجيًا. وفي الوقت الحالي، ستحتاجين إلى استخدام فوط صحية. ولا تستخدمي السدادات القطنية لأنها قد تسبب العدوى. ويجب أن تغيري الفوطة في كل مرة تذهبين فيها إلى دورة المياه.

سميحة: فعلاً! من الجيّد أنّك أخبرتني.

العاملة الصحية المجتمعية: كما يجب عليك غسل يديك قبل لمس الطفل، وقبل الأكل، وبعد الذهاب إلى دورة المياه. سأريك كيف تغسلين يديك. هل يمكنك أن تنادي على أختك من فضلك؟

(سميحة تنادي على أختها خديجة التي تأتي مسرعة للغاية. تقوم العاملة الصحية المجتمعية بإلقاء التحية على خديجة)

خديجة: نعم، أختاه.

العاملة الصحية المجتمعية: هل يمكنك إحضار وعاء، وصابون، وإبريق مملوء بالماء؟

خديجة: نعم، بالتأكيد.

(تجلب خديجة معدات غسيل اليدين. وتوضح العاملة الصحية المجتمعية كيفية غسل اليدين، ثم تطلب من سميحة محاكاتها)

العاملة الصحية المجتمعية: رائع! هل يمكنك أن تخبريني متى ستغسلين يديك؟

سميحة: قبل أن ألمس محمود، وقبل أن آكل، وبعد الذهاب إلى دورة المياه.

العاملة الصحية المجتمعية: رائع!

(تعود الحماة ومعها الماء لتشربه سميحة. ويدخل زوج سميحة ومعه إبريق من عصير الفاكهة)

العاملة الصحية المجتمعية: أنتم جميعًا تقومون بعمل رائع. وأرى أنكم ترعون سميحة والطفل على أفضل ما يُرام.

هل لديك فكرة عن المباعدة بين الولادات؟

الزوج: نعم. وسنفعل ذلك بمجرد أن تستعيد سميحة عافيتها.

العاملة الصحية المجتمعية: هذا جيد. إذا حملت مرة أخرى قبل الأوان، فقد يؤثر ذلك على صحتها، ولن تتمكن من تقديم الرعاية الجيدة للطفل أو الأسرة. وسوف يخبرونكم بكل ما تحتاجون إلى معرفته عند ذهابكم إلى المرفق الصحي في زيارة ما بعد الولادة.

الزوج: هذا جيد. سنذهب إلى المرفق الصحي.

العاملة الصحية المجتمعية: أنا حقًا معجبة بالدعم الذي تقدمه لسميحة. فهذا مهم للغاية لصحتها وصحة الطفل. وأستطيع أن أرى أن أختها موجودة للمساعدة في الأعمال المنزلية. وهذا يعني أن سميحة ستتعافى بسرعة. أهنئكم جميعًا.

جميع الأسرة: وجزيل الشكر لكِ يا أمينة على مساعدتك.

بعد انتهاء لعب الأدوار التوضيحي، أخبر المشاركين بأنهم سيؤدون دور العاملين الصحيين المجتمعيين لتقديم المشورة حول صحة المولود والأم. هناك سيناريوهات الحالات الخمس.

وقبل أن تبدأ، ذكّر المشاركين بأنه يجب عليهم غسل أيديهم قبل لمس الطفل، وأن إعطاء النصائح لا يعني الاكتفاء بقراءة/ ترديد محتويات الكتاب القلاب.

وزِّع الجزء الخاص بالعامل الصحي المجتمعي، واطلب من المشاركين استخدام استمارة التسجيل لفهم الوضع، والكتاب القلاب لتقديم المعلومات المهمة.

الوضع 1 (العامل الصحي المجتمعي، الأم، والزوج): الحفاظ على تدفئة الطفل، وعلامات الخطورة، والبدء المبكر في الرضاعة، وزيارات ما بعد الولادة، والمباعدة بين الولادات

العاملة الصحية المجتمعية: أنت تزورين سامية التي وضعت منذ ساعتين. زوج سامية متواجد أثناء الزيارة. ولا يبدو على الأم أو طفلها أي علامات خطورة.

الأم: لقد وضعت طفلة منذ ساعتين اسمها أمنية. ولم تبدئي في إرضاعها لأن اللبن الذي يخرج في البداية ليس نظيفًا ولابد أن تعصري الثدي حتى يخرج اللبن النظيف. وإلى أن يحدث ذلك سوف ترضعينها لبنًا اصطناعيًا. ولن تقومي بزيارة ما بعد الولادة. ولا تؤمنين أنت وزوجك بالمباعدة بين الولادات، وترغبان في إنجاب الكثير من الأطفال. وأخذ زوجك إجازة من العمل ليساعدك في رعاية الطفل.

الوضع 2 (العامل الصحي المجتمعي، الأم، الحماة): الحفاظ على تدفئة الطفل، علامات الخطر، والبدء المبكر في الرضاعة، الاعتناء بالحبل السري، تحميم الطفل

العاملة الصحية المجتمعية: لقد حضرت ولادة «سيدة» التي وضعت صبيًا اسمه أحمد. وتحضر حماة «سيدة» الزيارة. ولا يبدو على الأم أو طفلها أي علامات خطورة.

الأم: لقد وضعت للتو صبيًا اسمه أحمد. وأنت تشعرين بتعب بالغ. وتريدين الخلود إلى الراحة، وتشعرين بأنك متعبة للغاية لدرجة أنك لا تستطيعين إرضاع طفلك بصورة طبيعية الآن. وليست لديك فكرة عن الاعتناء بالحبل السري. وهذا هو طفلك الأول. وطلبت من حماتك تحميم الطفل لأنه يبدو عليه الاتساخ الشديد.

الوضع 3 (العاملة الصحية المجتمعية، الأم): النظام الغذائي، النظافة الشخصية، متضمنة نظافة الثدي

العاملة الصحية المجتمعية: أنت تزورين ليلى بعد ثلاث ساعات من وضعها. ولا يبدو على الأم أو طفلها أي علامات خطورة.

الأم: لقد وضعت صبيًا، اسمه سامي، منذ ثلاث ساعات. وقد وضعت الصبي على صدرك مباشرة بعد الولادة ولامس جلده جلدك. وقد وضعت بشكل صحيح الكلوروهيكسيدين على الحبل السري، وتعرفين أنك بحاجة إلى وضعه لمدة سبعة أيام تالية. ولا ترغبين في تناول الطعام أو الشراب حاليًا. وعندما تشربين سيكون الشراب حليبًا لأن ذلك سيدر المزيد من اللبن في ثدييك. ولا ترغبين في شرب الماء لأن ذلك سيخفف اللبن في ثدييك. وتعتقدين بأنه لا يتعين عليك غسل الثديين إلا عند الاستحمام لأن ذلك سيحد من كمية لبن الثدي. وتستخدمين السدادات القطنية لامتصاص النزيف.

الوضع 4 (العاملة الصحية المجتمعية، الأم، الزوج): علامات الخطورة

العاملة الصحية المجتمعية: أنت تزورين حسناء التي وضعت منذ ساعتين. ويحضر زوج حسناء الزيارة. ويعاني الطفل من تسرُّع النفس.

الأم: لقد وضعت صبيًا اسمه حسن منذ ساعة مضت. وتحافظين على دفء الصبي بملابس خفيفة. وحاولت إرضاعه من صدرك ولكن لا يبدو أن الطفل على ما يرام. أنتِ قلقة بشأنه. ولم تنظفي الحبل السري حتى الآن. وقمت بتحميمه بمجرد ولادته.

الوضع 5 (العاملة الصحية المجتمعية، الأم، الزوج، الحماة): الدعم العاطفي

العاملة الصحية المجتمعية: أنت تزورين حورية، التي وضعت منذ أربع ساعات. ولا يبدو على الأم أو طفلها أي علامات خطورة. وبينما كنت تتحدثين إلى حورية، وصل زوجها وحماتها.

الأم: لقد وضعت منذ أربع ساعات ومنذ ذلك الحين وأنت تجعلين جلد الطفل ملامسًا لجلدك. فقد وضعته على صدرك بمجرد ولادتك له. وقمت بتنظيف الحبل السري بصورة صحيحة. وتشعرين بقلق شديد لأن حماتك طلبت منك إعداد الطعام والقيام بسائر الأعمال المنزلية لكنك تشعرين بإرهاق شديد. وليس لديك مَن يساعدك، وخرج زوجك مباشرة بعد وضعك للطفل. ولم يكن لديك الوقت لتحميم الطفل أو للاعتناء بنظافتك الشخصية. وأخبرك زوجك أنك لن تذهبي للمرفق الصحي لزيارة ما بعد الولادة. كما أنه لا يؤمن بالمباعدة بين الولادات.

الزيارات المنزلية وسير الجلسات



مناقشة جماعية. الزيارات المنزلية

أخبر المشاركين بأن العاملين الصحيين المجتمعيين يتحملون مسؤولية تعزيز الرعاية المتكاملة للمواليد والأطفال ونمائهم في المنزل، وعليهم أن يخططوا لما يلي:

- إجراء زيارتين للمرأة الحامل:
  - الأولى أثناء شهور الحمل الثلاثة الأولى.
  - الثانية أثناء شهور الحمل الثلاثة الأخيرة.
- ثلاث زيارات للمواليد و الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين:
- الأولى أثناء الولادة أو بعدها مباشرة.
- الثانية في اليوم الثالث بعد الولادة.
- الثالثة عندما يبلغ الرضيع ستة أسابيع من العمر.
- زيارة واحدة للفئات العمرية الأخرى كل شهرين.

أكِّد على أن صحة المواليد تبدأ بصحة الأمهات. إذ يعتمد بقاء المواليد على قيد الحياة وعافيتهم على صحة الأم بطرق عديدة مهمة للغاية.

- فعندما تعاني الأمهات من سوء التغذية، يؤثر ذلك على نَماء الجنين، كما يؤثر بصورة مباشرة على صحة المولود. ويُضعف ذلك من نمو الجنين في الرحم، ويزيد احتمال انخفاض وزنه عند الميلاد. ويكون الأطفال المولودون بوزن منخفض عند الميلاد أُكثر عُرضة لخطر ضعف الإدراك، ومشاكل النماء؛ مثل ضعف مدى الانتباه، وحمل عبء أعلى من المرض، والوفاة المبكرة.
- وعندما تمرض الأمهات أو يتلقين قدرًا غير كافٍ من رعاية ما قبل الولادة والرعاية عند الوضع، يصبح أطفالهن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض والوفاة المبكرة.

ويمكن أن تساعد رعاية ما قبل الولادة في الوقاية من المضاعفات وتثقيف النساء بشأن الخطوات التي يستطعن اتخاذها لحماية أطفالهن وضمان حمل صحي. علاوةً على ذلك، يمكن رعاية ما قبل الولادة أن تساعد على السيطرة على الأمراض الموجودة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السُّكَّري، والوقاية من حدوث مضاعفات خطيرة قد تؤثر على الأطفال.

وعندما يزور العاملون الصحيون المجتمعيون المواليد وصغار الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين، لا بد أن يُحسنوا الاستفادة من الفرصة للتحقق من صحة الأم.



المرفق 1: دليل الجلسات السريرية

تعزز الجلسات السريرية اكتساب المشاركين للمهارات عن طريق تعريضهم لمواقف الحياة الحقيقية.

وأثناء الجلسات النظرية يستعد المشاركون للتعامل مع الأطفال والأمهات من خلال الفيديوهات التوضيحية، وتمارين الفيديو، وتمارين لعب الأدوار، والألعاب. أما أثناء الجلسات السريرية والزيارات المنزلية، يطبِّق المشاركون المهارات التي تعلموها خلال الجلسات النظرية في مواقف الحياة الحقيقية.

وفي الوضع المثالي، يجب تنفيذ هذه الدورة التدريبية في مستشفى به عدد كافٍ من قاعات الدرس وأجنحة المستشفى الداخلية والعيادات الخارجية المناسبة لاستيعاب عدد المجموعات التي سيُقسَّم إليها المشاركون. وسيوفر العمل في مكان واحد وقت الانتقال بين قاعة الدرس، ومواقع المرضى داخل المستشفى والمرضى في العيادات الخارجية. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فاختر المواقع السريرية القريبة من بعضها البعض ومن المجتمع، وضَع في الاعتبار أوقات الانتقال بين المواقع ضمن البرنامج الخاص بالدورة التدريبية.

الجلسات الثلاث مع المرضى الذين يعالجون في أجنحة المستشفى الداخلية ستساعد المشاركين على التعرُّف على علامات الخطورة عبر مختلف الفئات العمرية. ويجب تحديد الجلسة الأولى بعد أن يكون المشاركون قد تعلموا علامات الخطورة التي تنطبق على المواليد والرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين. ويجب عقد الجلسة الثانية بعد أن يكون المشاركون قد تعلموا علامات الخطورة التي تنطبق على الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر. أما الجلسة الثالثة، فيجب عقدها بنهاية الدورة التدريبية، ويجب أن تشمل علامات الخطورة لجميع الفئات العمرية.

أما **الجلسات الأربع مع المرضى في العيادات الخارجية** فستتيح للمشاركين فرصةً لاستخدام مهارات التواصل الجيد التي تعلموها من أجل تقديم المشورة حول مختلف عناصر رعاية صحة الطفل ونمائه، إلى جانب التحقق من وجود علامات الخطورة.

التحضير للجلسات في مستشفى/ مرفق صحي

- قم بزيارة مدير المستشفى/ المرفق الصحي لشرح أهداف الدورة التدريبية ومتطلباتها، ولتعيين مسؤول تنسيق من بين موظفي المستشفى.
- قم بزيارة جناح المرضى الداخليين ونسِّق مع الموظفين بشأن تخصيص مكان يكفي المشاركين في كل مجموعة. يمكن تحديد مكان يكفي مجموعة وحيدة في كل مرة، أو مكان مناسب لمجموعتين أو ثلاث مجموعات. ومن الضروري وضع هذا الأمر في الاعتبار عند وضع برنامج الدورة التدريبية.
- أخبر الموظفين بأنك ستكون بحاجة إلى الوصول إلى أماكن تواجد المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية.

الجلسات السريرية في جناح المرضى الداخليين

وضِّح لموظفي المستشفى، ومسؤول تنسيق النشاط أعمار المرضى المطلوبين للتقييم والعلامات التي تظهر عليهم. وأخبرهم بأنك ستكون بحاجة إلى رؤية مواليد، ورضع، وأطفال، وقدم لهم قائمة بعلامات الخطورة التي يتعين على كل مجموعة ملاحظتها، وجدول جلسات المرضى الداخليين. ويجب أن يجهز مسؤولو التنسيق المرضى لرؤيتهم في اليوم التالي، وفي الوضع المثالي، يجب تخصيص مريض واحد لكل مشارك، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، اطلب منه تحضير مريض واحد لكل بضعة المشاركين.

ناقش مع مسؤول التنسيق ترتيب الجناح لضمان الحركة السلسة للمشاركين. وإذا كان من الواجب إجراء الجلسة في وحدة الرعاية المركزة، اتفق على عدد المشاركين الذين يمكنهم الدخول في المرة الواحدة، ورتِّب متطلبات تعقيمهم.

جلسات العيادات الخارجية

وضح أن جلسات العيادات الخارجية ستُستخدم في تدريب المشاركين على تقديم المشورة حول مختلف عناصر رعاية الطفل، فضلاً عن التحقق من وجود علامات الخطورة. وقدِّم لموظفي المستشفى/ المرفق الصحي جدولاً بجلسات العيادات الخارجية والفئة العمرية المستهدفة لكل جلسة. وإذا كانت هناك خدمات لمرضى العيادات الخارجية تُقدَّم للأطفال الأصحاء، فسيكون ذلك مثاليًا للغرض المنشود من الدورة التدريبية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، استخدم العيادات الخارجية المخصصة للأطفال المرضى.

وستقدم الأقسام التالية وصفًا مفصلاً حول كيفية إجراء كل نوع من أنواع الجلسات السريرية على حدة.

1. الجلسات السريرية في جناح المرضى الداخليين

الجلسة السريرية في جناح المرضى الداخليين 1

الهدف

اكتساب المهارات للتعرف على علامات الخطورة في المواليد، والرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- التعرف على علامات الخطورة
  - تشنجات؛
  - حركة أقل؛
  - انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل؛
  - تنفس سريع؛
  - عدوى مَوْضعية (خروج القَيْح من السُّرة، واحمرار الجلد حول السُّرة)؛
  - اليرقان.
- فهم خطورة الحالة الصحية التي تتطلب الإحالة؛
- استكمال قسم علامات الخطورة في استمارة التسجيل.

الإجراء

- توجَّه نحو جناح المرضى الداخليين:
  - اجمع المشاركين في مجموعتك قبل أن تتوجه بهم إلى جناح المرضى الداخليين. واطلب منهم إحضار:
    - قلم رصاص؛
    - ممحاةً؛
    - مُؤَقِّت (إذا كان مُوزَّعًا عليهم).
  - خذ معك:
    - نسخًا كافية من استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر؛
    - مؤقتات إذا لم تكن وُزِّعت من قبل.

- نظِّم الجلسة
  - ابدأ بتوضيح الأهداف من الجلسة، كما هو مذكور أعلاه. راجع التعريفات، وطريقة عد النفس السريع.
  - أخبر المشاركين بأنه لكي يلاحظوا علامات الخطورة، يجب عليهم أن يزوروا وحدة الرعاية المركزة حيث يتواجد الأطفال ذوو الحالات المرضية الشديدة. ويجب عدم إزعاج الأطفال: حيث يحظر على المشاركين لمس الأطفال أو التحدُّث بصوت عالٍ. وسيتعين على المشاركين ملاحظة العلامات المذكورة أعلاه فقط على المواليد والرضع الأقل من شهرين. ولاحظ أنه عند التحقق من الحركة، يجب على المشاركين ألا يثيروا الرضيع.
  - راجع قسم علامات الخطورة في استمارة التسجيل.
  - خصِّص مشاركين لكل رضيع على حدة. أشرِف على المشاركين لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وامنحهم عشر دقائق لإتمام مهمتهم.
  - اجمع المشاركين حول كل حالة لتوضيح علامات الخطورة، وبالتالي يكونون قد تعرضوا لجميع علامات الخطورة المهمة.
- اختتم الجلسة
  - بمجرد خروجك من الجناح، ناقش مع المشاركين ما لاحظوه، واختتم الجلسة بالتركيز على أنهم عرفوا للتو خطورة الحالات الصحية المشار إليها إذا لاحظوا علامات الخطورة عند زيارتهم للمنازل.

2. الجلسات السريرية في جناح المرضى الداخليين

الهدف

اكتساب المهارات للتعرف على علامات الخطورة لدى الرضّع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- التعرف على علامات الخطورة:
  - التشنجات؛
  - انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل؛
  - التنفس السريع.
- فهم خطورة الحالة الصحية التي تتطلب الإحالة؛
- استكمال قسم علامات الخطورة في استمارة التسجيل.

الإجراءات

- توجَّه نحو جناح المرضى الداخليين:
  - اجمع المشاركين في مجموعتك قبل أن تتوجه بهم إلى جناح المرضى الداخليين. اطلب منهم إحضار:
    - قلم رصاص؛
    - ممحاةً؛
    - مُؤَقِّت (إذا كان مُوزَّعًا عليهم).
  - خذ معك
    - نسخًا كافية من استمارة التسجيل للمواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر؛
    - مؤقتات إذا لم تكن وُزِّعت من قبل.

- نظِّم الجلسة
  - ابدأ بتوضيح الأهداف من الجلسة، كما هو مذكور أعلاه. راجع التعريفات، وطريقة عد النفس السريع.
  - أخبر المشاركين بأنه لكي يلاحظوا علامات الخطورة، يجب عليهم أن يزوروا وحدة الرعاية المركزة حيث يتواجد الأطفال ذوو الحالات المرضية الشديدة. ويجب عدم إزعاج الأطفال: حيث يحظر على المشاركين لمس الأطفال أو التحدث بصوت عالٍ. وسيتعين على المشاركين ملاحظة العلامات المذكورة أعلاه فقط على الرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر.
  - راجع قسم علامات الخطورة في استمارة التسجيل
  - حدد مشاركين لكل رضيع على حدة. أشرِف على المشاركين لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. امنحهم عشر دقائق لإتمام مهمتهم.
  - اجمع المشاركين حول كل حالة لتوضيح علامات الخطورة، وبالتالي يكونون قد تعرضوا لجميع علامات الخطورة المهمة.
- اختتم الجلسة
  - بمجرد خروجك من الجناح، ناقش مع المشاركين ما لاحظوه، واختتم الجلسة بالتركيز على أنهم عرفوا للتو خطورة الحالات الصحية المشار إليها إذا لاحظوا علامات الخطورة عند زيارتهم للمنازل.

الجلسات السريرية في جناح المرضى الداخليين 3

الهدف

اكتساب مهارات التعرف على علامات الخطورة عبر مختلف الفئات العمرية التي تتناولها الدورة التدريبية.

الأهداف

بنهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

- التعرف على علامات الخطورة:

علامات الخطورة لدى المواليد وصغار الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهرين	علامات الخطورة لدى الأطفال من عمر شهرين حتى أقل من خمسة أعوام
تشنجات	تشنجات
انسحاب شديد للجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل	انسحاب الجزء السفلي من جدار الصدر إلى الداخل
تنفس سريع	تنفس سريع
احمرار الجلد حول السُّرَّة	
اليرقان	

- فهم خطورة الحالة الصحية التي تتطلب الإحالة؛
- استكمال قسم علامات الخطورة في استمارة التسجيل المناسبة.

الإجراءات

- توجَّه نحو جناح المرضى الداخليين:
  - اجمع المشاركين في مجموعتك قبل أن تتوجه بهم إلى جناح المرضى الداخليين. اطلب منهم إحضار:
    - قلم رصاص؛
    - ممحاةً؛

- مُؤَقَّت (إذا كان مُوزَّعًا عليهم).
  - خذ معك
    - نُسخًا كافية من استمارتي التسجيل؛
    - مؤقتات إذا لم تكن وُزِّعت من قبل.
- نظِّم الجلسة
  - ابدأ بتوضيح الأهداف من الجلسة، كما هو مذكور أعلاه. راجع التعريفات، وطريقة عد النفس السريع.
  - أخبر المشاركين بأنه لكي يلاحظوا علامات الخطورة، يجب عليهم أن يزوروا وحدة الرعاية المركزة حيث يتواجد الأطفال ذوو الحالات المرضية الشديدة. ويجب عدم إزعاج الأطفال: حيث يحظر على المشاركين لمس الأطفال أو التحدث بصوت عالٍ. وسيقوم المشاركون بملاحظة علامات الخطورة المذكورة أعلاه فقط لدى الرضع والأطفال المخصصين لهم (جميع الفئات العمرية).
  - راجع قسم علامات الخطورة في استمارتي التسجيل.
  - حدد مشاركين لكل طفل على حدة. أشرِف على المشاركين لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. امنحهم عشر دقائق لإتمام مهمتهم.
  - اجمع المشاركين حول كل حالة لتوضيح علامات الخطورة، وبالتالي يكونون قد تعرضوا لجميع علامات الخطورة المهمة.
- اختتم الجلسة
  - بمجرد خروجك من الجناح، ناقش مع المشاركين ما لاحظوه، واختتم الجلسة بالتركيز على أنهم عرفوا للتو خطورة الحالات الصحية المشار إليها إذا لاحظوا علامات الخطورة عند زيارتهم للمنازل.

ملحوظة: لأسباب عملية، لا يسمح في جلسات المرضى الداخليين بإثارة الأطفال أثناء ملاحظة علامة الخطورة المتمثلة في قلة الحركة، ولا يُسمح ف هذه الجلسات بملاحظة علامتي الخطورة المتمثلتين في "الضعف الشديد وعدم القدرة على الرضاعة" و"تقيؤ الطفل لكل ما تناوله". ولن يتمكن المشاركون من لمس الأطفال، وسؤال أمهاتهم. ولن يتمكنوا من قياس درجة حرارة الأطفال، أو قياس أوزانهم، ولذا فلن يتمكنوا من التحقق من وجود علامة الخطورة المتمثلة في "انخفاض/ ارتفاع درجة الحرارة لدى صغار الأطفال"، ما لم يُعطَ لهم الوزن ودرجة الحرارة سلفًا.

جلسات العيادات الخارجية

خلال هذه الدورة التدريبية، ستُعقَدُ أربع جلسات في العيادات الخارجية.

الأهداف

بنهاية جلسات المرضى الخارجيين، سيتمكن المشاركون من:

- ممارسة مهارات التواصل الجيد من أجل تقديم المشورة حول:
  - ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال (كلاً من ممارسات طلب الرعاية الصحية للطفل والوقاية)؛
  - الحفاظ على تدفئة الطفل؛
  - العناية بالحبل السُّري؛
  - الرضاعة/ التغذية؛
  - النظافة الشخصية؛
  - معالم النَّماء الرئيسية؛

- العناية من أجل النماء؛
- الوقاية من الحوادث/ الإصابات؛
- الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- رعاية صحة الأمهات.

- استكمال استمارتي التسجيل واستخدامهما للمساعدة في تقييم الوضع؛
- تقديم المعلومات الضرورية باستخدام الكتاب القلاب.

ويتوقف محتوي الجلسات الفردية على المرحلة التي وصل إليها المشاركون في الدورة التدريبية. على سبيل المثال، إذا عُقدت أول جلسة من الجلسات الأربع للعيادات الخارجية وكان المشاركون قد أكملوا مرحلة تقديم المشورة حول معالم النَّماء الرئيسية للأطفال من عمر عام واحد حتى أقل من خمسة أعوام في الجلسات النظرية، فيمكن أن تشمل جلسة العيادة الخارجية جميع المعلومات السابقة. وإذا خُصِّص للمشاركين رضيع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، أو من عمر ستة أشهر حتى أقل من اثني عشر شهرًا، فسوف يقدمون المشورة حول جميع عناصر الرعاية. وإذا خُصِّص لهم رضيع من عمر عام واحد حتى أقل من خمسة أعوام، فسيقدمون المشورة حول عناصر الرعاية، وصولاً إلى معالم النَّماء الرئيسية.

الإعداد

- إذا نُظِّمت الدورة التدريبية في مستشفى مُلحَق به مرفق لمرضى العيادات الخارجية، وضِّح لمدير المستشفى خلال زيارتك الأولى المساحة المطلوبة لاستيعاب عدد المشاركين الحاضرين في الدورة. واطلب من المدير أن يوفر لك مسؤول تنسيق داخل مرفق العيادات الخارجية، وأن يساعدك على اختيار المرضى المطلوبين للتدريب.
- إذا لم يكن بالمستشفى قسم للعيادات الخارجية، أو إذا كنت تنظم الدورة التدريبية في مركز تدريب لا توجد به مرافق صحية، فاختر المرفق الصحي الأقرب لك الذي يشهد تدفق المرضى من الأطفال دون سن الخامسة. قم بزيارة المرفق الصحي، والتقِ بالموظف المسؤول لتوضيح أهداف الدورة التدريبية ومتطلباتها، حتى يتمكن من تخصيص مسؤول تنسيق من بين موظفي المرفق الصحي.
- نسِّق مع الموظفين، واسأل عن الفترات التي تشهد أعلى تدفُّق للمرضى. ويجب وضع هذا الأمر في الاعتبار عند إعداد برنامج الدورة التدريبية.
- اشرح لمسؤول التنسيق برنامج الدورة التدريبية، وعدد الجلسات، وأعمار الأطفال المطلوبين لكل جلسة. وخلال جلسات العيادات الخارجية، ليكون التدريب في أفضل صوره يجب أن يقدم كل مشارك على حدة المشورة لاثنتين من الأمهات، ولكن إذا لم يسمح عدد الأطفال بذلك، فيمكن لكل مشاركيْن العمل معًا. ويلزم وجود طفل للقيام بالعرض التوضيحي المبدئي، وذلك عندما يقدم الميسر مثالاً على كيفية تقديم المشورة.
- ناقش مع مسؤول التنسيق ترتيب الجناح لضمان الحركة السلسة للمشاركين.
- جهز عددًا كافيًا من استمارات التسجيل (لكل من الفئتين العمريتين) للمشاركين.
- جهز أكوابًا وملاعق نظيفة لأنها ستكون مطلوبة عند التحقق من علامة تقيؤ الطفل لكل شيء.
- خصِّص مؤقِّتًا لكل مشارك. إذا كنت قد وزعت المؤقتات بالفعل، ذكِّر المشاركين بإحضارها معهم.
- خصص مقياسًا لدرجة الحرارة لكل مشارك.

الإجراء

- اجمع المشاركين في مجموعتك قبل أن تتوجه بهم إلى جناح المرضى الخارجيين.
- اطلب منهم إحضار قلم رصاص، وممحاة، والكتاب القلاب، والمؤقت (إذا كان وُزِّع بالفعل)، ومقياس لدرجة الحرارة (إذا كان وُزِّع بالفعل).

- خذ معك نسخًا من استمارتي التسجيل، أكوابًا وملاعق، ومؤقتات ومقاييس لدرجة الحرارة (إذا لم تكن وُزعت من قبل).
- ابدأ بشرح أهداف الجلسة، كما هو موضَّح أعلاه، ثم استعرض استمارة التسجيل مع المشاركين. ثم وضح كيفية ملء استمارة التسجيل واستخدام الكتاب القلاب مع أول طفل وأول أم. وبناءً على ضغط الوقت، قد تضطر إلى إيقاف العرض التوضيحي بعد تقديم المشورة حول عنصرين اثنين من عناصر الرعاية.
- خصص المرضى للمشاركين، وقسِّم المشاركين بينك وبين المُيسِّر المشارك من أجل الإشراف عليهم أثناء وصولهم إلى المرضى. سوف يستكمل المشاركون تقييماتهم، ويملؤون استمارة التسجيل، ومن ثمَّ، يقدمون المشورة للأمهات باستخدام الكتاب القلاب. وقدِّم المساعدة عند الحاجة.
- سيلاحظ المشاركون زملاءهم أثناء تقديمهم المشورة، ويجب إجراء مناقشة جماعية - في غياب الأم - عند الانتهاء من تقديم المشورة. أما أثناء تقديم المشورة، فاطلب من المشاركين عدم إبداء تعليقاتهم.
- اختتم الجلسة باستعراض نقاط القوة ومواطن الضعف لدى كل مشارك أثناء تقديم المشورة.



المرفق 2: دليل الزيارات المنزلية

يجب على المشاركين القيام بزيارتين منزليتين خلال الدورة التدريبية. ويبلغ العدد المثالي للزيارة المنزلية مشاركيْن لكل منزل.

ويجب الترتيب لأول زيارة منزلية عندما يكون المشاركون قد استكملوا الجلسات الخاصة بالرضع من عمر شهرين حتى أقل من ستة أشهر، وتكون الزيارة الثانية بالقرب من نهاية الدورة التدريبية.

التحضير للزيارات المنزلية

قبل الدورة التدريبية، يجب أن يزور المنظِّمون المجتمع المحلي، ويشرحوا الغرض من الدورة، واحتياجات التدريب، والأهداف من الزيارات المنزلية للهياكل المجتمعية القائمة، مثل المنظمات غير الحكومية، واللجان المجتمعية، والعاملين الصحيين المجتمعيين الذين يعملون بالفعل داخل المجتمع المحلي. ويجب عليهم التأكيد على أن الزيارات المنزلية ستؤدي دورًا محوريًا في اكتساب المشاركين للمهارات الضرورية لتمكينهم من العمل في المستقبل كعاملين صحيين مجتمعيين مهمتهم التركيز على تعزيز صحة الأطفال والأمهات.ويجب أن يوضح المنظمون عدد المشاركين وعدد المنازل المتاح بها أطفال ينتمون للفئات العمرية المستهدفة.

- خلال الزيارة الأولى، سيقدم المشاركون المشورة للأمهات حول العناية بصحة ونماء المواليد والرضع الأصغر من ستة أشهر. كما سيقدمون لهن المشورة حول صحتهن.
- خلال الزيارة الثانية، سيقدمون المشورة للأمهات حول العناية بصحة ونماء الرضع والأطفال الأكبر سنًا (يمكن أن يكونوا أيضًا من المواليد والرضع الأصغر في السن إذا كانوا يعيشون معًا في نفس المنزل). وتتضمن الزيارة الثانية كذلك تقديم المشورة حول العناية بصحة الأم.

وفي حين أن العدد المثالي للزيارة المنزلية هو مشاركان لكل منزل، فيجب أن يراعي برنامج الدورة التدريبية، في حال عدم كفاية عدد المنازل، تقسيم المشاركين إلى مجموعات: مجموعة يمكنها القيام بالزيارات المنزلية، والمجموعة الأخرى تحضر جلسات العيادات الخارجية، ثم تتبادل المجموعتان الأدوار في اليوم التالي. وسينضم المُيسِّر إلى الزيارة المنزلية، بينما سينضم الآخر إلى جلسة قسم العيادات الخارجية.

الزيارة المنزلية 1

الأهداف

في سياق الزيارة، سيقدم المشاركون المشورة للأم حول:

- الحفاظ على تدفئة الطفل؛
- ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية؛
- الرضاعة؛
- العناية بالحبل السُّري؛
- النظافة الشخصية للرضيع؛
- معالم النَّماء الرئيسية؛

- العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)؛
- الوقاية من الحوادث/ الإصابات؛
- الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- العناية بصحة الأم.

الإجراء

خد معك:

- نسخًا كافية من استمارة التسجيل للأطفال حتى أقل من سن ستة أشهر؛
- أكوابًا وملاعق؛
- مؤقتات؛
- مقاييس لدرجة الحرارة (إذا لم تكن وُزعت من قبل).

يجب أن يُحضر المشاركون أقلام رصاص، ومماحي، والكتاب القلاب، والمؤقتات، ومقاييس درجة الحرارة (إذا وُزِّعت بالفعل).

قسِّم المشاركين بينك وبين المُيسِّر المشارك، وخصِّص المنازل للمشاركين. اختر المنازل الواقعة بالقرب من بعضها البعض، كلما أمكن.

ذكِّر المشاركين باستخدام مهارات التواصل التي تعلموها. ويجب على المشاركين إلقاء التحية على الأمهات، وتوضيح الغرض من الزيارة، وغسل أيديهم قبل لمس الطفل.

ويجب أن يوضح المشاركون أن الغرض من زيارتهم هو مساعدة الأمهات في رعايتهن لأطفالهن، والتحقق من صحة الأمهات. وسوف يستخدمون استمارة التسجيل لمساعدتهم في فهم الوضع وجمع المعلومات، والكتاب القلاب لتقديم النصيحة اللازمة.

يجب على المشاركين الذين يعملون في ثنائيات توزيع المهام فيما بينهما. فيمكن لأحدهما طرح الأسئلة بينما يملأ الاثنان معًا استمارة التسجيل، ويمكن للآخر إعطاء المعلومات استنادًا إلى الإجابات الواردة والمسجَّلة في الاستمارة. وفي نهاية الزيارة، يقوم المتحدث، أيًا كان، بسؤال المشارك الآخر الذي يقدم المشورة عما إذا كان يرغب في إضافة شيء آخر. ولا يجب في أي مرحلة أن يختلف المشاركون أو ينتقد بعضهم بعضاً خلال دورة تقديم المشورة، أو أن يظهروا بمظهر المتنافسين.

ويجب أن يتناوب المُيسِّرون على المنازل لملاحظة أكبر عدد ممكن من جلسات تقديم المشورة. ويجب ألا يتدخلوا في الحوار بين المشاركين ومقدمي الرعاية، ما لم يقع خطأ جسيم، وهنا يجب عليهم التدخل بلطف لتصحيحه.

ويجب أن يكتب الميسرون ملاحظاتهم.

وعند العودة إلى قاعة الدرس، يجب أن يلخِّص الميسر الجلسة وَفقًا للملاحظات التي دوَّنها. ويجب أن يناقش الميسرون كيف سارت جلسة تقديم المشورة مع المشاركين. ويتعين عليهم عدم القيام بذلك مطلقًا أمام الأسر.

الزيارة المنزلية 2

الأهداف

في سياق الزيارة، سيقدم المشاركون المشورة للأم بشأن:

- ممارسات الأسرة المتعلقة بالرعاية الصحية؛
- التغذية؛

- النظافة الشخصية للرضيع؛
- معالم النَّماء الرئيسية؛
- العناية من أجل النماء (اللعب والتواصل مع الطفل)؛
- الوقاية من الحوادث/ الإصابات؛
- الوقاية من سوء المعاملة، والإهمال، والعنف؛
- العناية بصحة الأم.

إذا تواجد مواليد وصغار رضع في نفس المنزل، يمكن للمشاركين أيضًا تقديم المشورة للأمهات بشأن صحتهم ونمائهم.

الإجراء

خد معك:

- نسخًا من استمارتي التسجيل، للأطفال حتى سن ستة أشهر، والأطفال من عمر ستة أشهر حتى أقل من خمسة أعوام؛
- أكوابًا وملاعق؛
- مؤقتات؛
- مقاييس لدرجة الحرارة (إذا لم تكن وُزعت من قبل).

يجب أن يحضر المشاركون أقلام رصاص، ومماحي، والكتاب القلاب، والمؤقتات، ومقاييس درجة الحرارة (إذا وُزِّعت بالفعل).

قسِّم المشاركين بينك وبين الميسر المشارك، وخصص المنازل للمشاركين. اختر المنازل الواقعة بالقرب من بعضها البعض، كلما أمكن.

ذكِّر المشاركين باستخدام مهارات التواصل التي تعلموها. ويجب على المشاركين إلقاء التحية على الأمهات، وتوضيح الغرض من الزيارة، وغسل أيديهم قبل لمس الطفل.

ويجب أن يوضح المشاركون أن الغرض من زيارتهم هو مساعدة الأمهات في رعايتهن لأطفالهن، والتحقق من صحة الأمهات. وسوف يستخدمون استمارة التسجيل لمساعدتهم في تقييم الوضع وجمع المعلومات، والكتاب القلاب لتقديم النصيحة اللازمة.

يجب على المشاركين الذين يعملون في ثنائيات توزيع المهام فيما بينهما. فيمكن لأحدهما طرح الأسئلة بينما يملأ الاثنان معًا استمارة التسجيل، ويمكن للآخر إعطاء المعلومات استنادًا إلى الإجابات الواردة والمسجلة في الاستمارة. وفي نهاية الزيارة، يقوم المتحدث، أيًا كان، بسؤال المشارك الآخر الذي يقدم المشورة عما إذا كان يرغب في إضافة شيء آخر. ويجب ألا يختلف المشاركون أو ينتقد بعضهم بعضًا في أي مرحلة خلال دورة تقديم المشورة، ويجب ألا يظهروا بمظهر المتنافسين.

إذا كان هناك أكثر من طفل واحد، يمكن أن يكون أحد المشاركين مسؤولاً عن أحد الأطفال، بينما يكون المشارك الآخر مسؤولاً عن طفل آخر. وسيقوم المشارك الأول بتقديم المشورة، بينما يلاحظ المشارك الآخر، والعكس صحيح.

ويجب أن يتناوب الميسرون على المنازل لملاحظة أكبر عدد ممكن من جلسات تقديم المشورة. ويجب ألا يتدخلوا في الحوار بين المشاركين ومقدمي الرعاية، ما لم يقع خطأ جسيم، وهنا يجب عليهم التدخل بلطف لتصحيحه.

ويستطيع الميسرون تدوين ملاحظاتهم.

وعند العودة إلى قاعة الدرس، يجب أن يلخص الميسر الجلسة وَفقًا للملاحظات التي دوَّنها. ويجب أن يناقش الميسرون كيف سارت جلسة تقديم المشورة مع المشاركين. ويتعين عليهم عدم القيام بذلك مطلقًا أمام الأسر.